

جامعة الجزائر-03-
دالي إبراهيم
معهد التربية البدنية والرياضية
سيدي عبد الله
تخصص : العلوم البيوطبية الرياضية

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم

في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية

الإصابات الرياضية ومدى تأثيرها على السلوك
النفسي للرياضي

دراسة متمحورة حول عوامل الضعف في مواجهة الخطر
النفسي للإصابة

تحت إشراف:
أ/د - بن عكي محمد أكلي

من إعداد الطالب:
شريط عبد الحكيم عبد القادر

السنة الجامعية: 2012-2013

شكر وعرفان

الحمد لله رب العالمين على توفيقى
لهذا العمل

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى
المشرف الأستاذ الدكتور : بن
عكي محمد أكلي على مساعدته
ونصائحه القيمة لإنجاز هذا
البحث وكذا أساتذة ودكاترة
معهد التربية البدنية
والرياضية

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر
الجزيل إلى كل من ساعدني ولو
بكلمة

من قريب أو من بعيد
شكرا للجميع .

الإهداء

إلى روح والدي الطاهرة التي
وفرت لي سبل المعرفة
أسكنه الله الجنة

إلى والدتي التي أنارت لي طريق
العلم

أطال الله في عمرها

إلى الشمعة التي أنار الله بها بيتي
إبني الحاج شريف عبد الرحمان
أنار الله دربة وأصلحه

إلى زوجتي التي تقاسمت معي عبئ
هذه الحياة مجلوها ومرها
أصلحها الله

إلى كل العائلة

إلى كل الأصدقاء

أهدي هذا العمل

الفهرس

كلمة شكر

إهداء

ملخص الدراسة

مقدمة أ

الفصل المنهجي

أ - الإشكالية: 06

ب - تحديد المشكلة: 08

ج - أهمية البحث وأهدافه : 08

د - حدود البحث : 08

هـ - تعريف المصطلحات 09

هـ -1- الفصل : 09

هـ-2- الأوتار: 09

هـ-3- الاربطة : 09

هـ-4- الغضاريف : 10

هـ-4-1. الغضاريف الزجاجة 10

هـ-4-2. الغضاريف الليفية 10

هـ-4-3. الغضاريف المطاطية 10

هـ-4-5. العضلة 10

هـ-4-6. العظم	10
و - الدراسات المشابهة :	11
و-1- دراسة وديع ياسين (1985) :	11
و-2- دراسة جمعة محمد عوض (1988)	12
و-3- دراسة مصطفى جوهر حياة (1996)	13
و-4- دراسة وديع ياسين التكريتي ونشوان محمود الصفار (1998):	14
و-5- دراسة هاشم احمد سلمان سند (1998) :	15
و-6- دراسة سميرة خليل محمد (2002) :	16
و-7- دراسة وضاح غانم الصميدعي وآخران (2004) :	17
ز - الفرضيات :	18
ح - المنهجية المتبعة في البحث :	19
ح-1 المنهج الوصفي :	19
ح-2 مجتمع البحث وعينته :	19
ح-3 وسائل جمع البيانات :	19
ح-4. التجارب الاستطلاعية :	20
ح-5. التطبيق النهائي للبحث:	20
ح-6. المعالجات الاحصائية	21

الباب الأول : الجانب النظري

الفصل الأول :الجانب التشريحي

- 1 عظام الطرف العلوي : 24
- 2- عضلات الطرف العلوي : 24
- 3- الجلد: 39
- 4- الاصابات الرياضية : 41
- 5- الفحص السريري للاصابات الرياضية : 45
- 6- انواع الاصابات : 46
- 7- اصابات العضلات : 48
- 8- اصابات العظم (الكدم) : 59
- 9- اصابات المفاصل والأربطة : 56
- 10- الخلع : 58
- 11- طرق ربط وتثبيت الإصابات الرياضية : 61

الفصل الثاني :الإصابة والسلوك النفسي

1. المظاهر الإجهاد والإصابات الرياضية 63
2. نموذج لربط التوتر مع وقوع إصابات: الإجهاد إصابة نموذج 63
- 1.2 التصرف الفردي للإجهاد و الاصابات الرياضية 66
- 2-2-التعامل والإصابات الرياضية:.....

- 2-3- البرنامج للوقاية من الإجهاد والإصابات الرياضية..... 69

3.	تأكيد نموذج للإجهاد إصابة مع وقوع الربط	70
4.	القيود المفروضة على نموذج والمنظورات البحثية	70
5-	المعتقدات السلوك المتصلة بحالات الإصابة	72
5-1-	تعريف وتوصيف السلوكيات الصحية	72
5-2-	السلوكيات الصحية في النشاط البدني و / أو رياضي	73
5-3-	التغلب على الألم: 1 القيادة الرياضية بالمخاطر	76
4-	المحددات النفسية من السلوكيات الصحية	76
5-5-	مساهمة الاجتماعية المعرفية نهج الصحة	77
5-6-	وتتمثل أهمية المعرفة الاجتماعية نماذج من الصحة	77
5-6-1-	النموذج الإيمان على الصحة	77
5-6-2-	نظرية الدافع للحماية	79
5-6-3-	نظرية السلوك المخطط	80
5-6-4-	تطبيقات النماذج المعرفية الاجتماعية	82
5-6-5-	خطورة تصور المشاكل الصحية	84
5-7-	. المعتقدات والسلوكيات	85
5-7-1-	تصور للسيطرة السلوكية	86
5-7-2-	الموضوعية المعايير للسلوك	87

الفصل الثالث: سوابق الضعف المتصور

1-	السوابق من الضعف المتصورة	94
1-1-	تأثير التجارب السابقة في الضعف المتصورة	94
1-2-	عوامل نفسية وعمليات حاسما في التنبؤ بالمخاطر	95

96	1-2-1- المعرفة من الأهداف عوامل الخطر.....
96	1-2-2- الاستدلال النفسي
97	1-2-3. التصورات الخصائص المخاطر.....
98	1-2-4. الشخصية:.....
99	2- . والمحددات تكاملية وسياقاتها من الضعف المتصورة.....
101	3- الحد من الأعمال السابقة والتشكيك
102	4. ما هي السوابق من المتصورة الضعف لدى إصابة؟.....

الباب الثاني : الفصل التطبيقي

106	الدراسة الأولى
116	الدراسة الثانية
128	الدراسة الثالثة
151	الدراسة الرابعة
165	الدراسة الخامسة
188	الخاتمة
199	المراجع

الملاحق

فهرس الأشكال

الصفحة	العنوان
25	عظم لوح الكتف
25	عظم الترقوة
26	عظم العضد
28	عظم الكعبرة
28	عظم الزند
29	عظام رسغ اليد
30	عظام مشط اليد
31	عضلات الطرف العلوي
32	مفصل الكتف
33	مفصل المرفق
35	مفصل الرسغ
36	حركة مفصل الركبة
40	مقطع عرضي في الجلد
51	التمزق العضلي
57	اللّوي
63	نموذج لربط التوتر مع وقوع إصابات: الإجهاد إصابة نموذج
79	تأثيرات المعتقد الصحة نموذج من (becker, Janz ,1984)
80	نظرية الدوافع الحماية حسب (Rogers,Prentice- Dunn,1997)

81	نظرية السلوك المخطط له من (Ajzen,1991)
107	المساهمة المرضية لسلوك فى مواجهة الألم
109	إصابة سابقة شدة الألم وسلوك فى مواجهة الألم
118	المحددات النفسية للسلوك الصحي فى مواجهة الألم
131	النموذج تكاملي والسياقى لمحددات السلوكيات الصحية الوقائية
153	محددات التأثير المتصورة من قبل الإصابة
	نموذج من عوامل الضعف والحماية ضد خطر الإصابة

قائمة الجداول :

الصفحة	العنوان
110	الوسائل، والانحرافات المعيارية ومصفوفة الارتباط بين المتغيرات في الدراسة 1 (ن = 167)
111	التنبؤ من السلوك وجه يرة ق الألم (ن = 167)
112	للتنبؤ من السلوك في التعامل مع الألم للرياضيين الذين تعرضوا لآلام حاد في مقابل ضعف (ن = 167)
122	متوسط، والانحراف المعياري ومصفوفة الارتباط بين متغيرات
124	تنبؤ للحفاظ على كثافة الاستثمار البدني من قبل الضعف المتصور و شدة المتصورة
136	المتوسطات والانحرافات المعيارية للمتغيرات الدراسة (ن=192)
136	المصفوفة الارتباط بين المتغيرات الدراسة 3 (ن = 192)
139	النية التنبؤ لحمل المعدات لاستخدامها من قبل نظرية السلوك المخطط (ن = 192)
140	النية التنبؤ لحمل المعدات لاستخدامها من قبل خطورة التصور (ن = 192)
141	النية التنبؤ لحمل المعدات لاستخدامها الحرف الضميرى (ن = 192)
142	النية التنبؤ لحمل المعدات لاستخدامها من قبل نظرية السلوك المخطط،التصور المخاطر الشخصية (ن = 192)
156	الوسائل، والانحرافات المعيارية ومصفوفة الارتباط بين متغيرات الدراسة4(ن = 235)
157	التنبؤ التأثير المتصور من الإصابات السابقة (ن = 235)
158	النية توقع التأثير المتصور من طرف الاصابات السابقة والعصابية (ن = 235)
158	النية توقع التأثير المتصور من طرف الاصابات السابقة، العصابية و إحترام الذات

	الكلية (ن = 235)
159	النية توقع التأثير المتصور من طرف الاصابات السابقة و إحترام الذات الكلية (ن = 235)
172	متوسط والانحرافات المعيارية للمتغيرات الدراسة 5 (ن=211)
173	الارتباط بين متغيرات الدراسة 5 (ن=211)
175	التنبؤ الضعف وإدراك المخاطر من الخصائص إصابة (ن = 235)
176	التنبؤ الضعف ينظر اليها من قبل الاستدلال المعرفي (ن = 211)
178	التنبؤ الضعف ينظر اليها من قبل الشخصية (ن = 211)
180	التنبؤ الضعف التي يدركها إدراك المخاطر من الاصابة المميزة من الاستدلال المعرفية والشخصية.(ن=211)

ملخص الدراسة

هدفنا من هذا البحث التعرف على الاصابات الأكثر شيوعا التي تصيب مختلف الاطراف من الجسم في الألعاب الرياضية المختلفة وفقا لـ (أنواعها ، مناطق حدوثها ، أسبابها ، شدتها).

- التعرف على نسب الاصابات الرياضية للاعبين وفق متغيرات (الطول، الوزن، العمر التدريبي).

- التعرف على نسب الاصابات وأنواعها في ألعاب رياضية مختلفة وحسب خصوصية كل لعبة.

- الفرضيات :

ز - 1 الفرضية الأساسية :

نظرا لكثرة تعرض الرياضيين بالعاصمة الى انواع مختلفة من الاصابات الرياضية في مختلف اطراف الجسم وقد أثار ذلك الموضوع اهتمام الباحث في محاولة معرفة ماهي انواع تلك الاصابات واسبابها وشدتها ومناطق حدوثها ومدى تأثيرها في أداء الرياضيين في الألعاب المختلفة ونسبة وجودها في كل لعبة .

ز - 2 الفرضيات الفرعية :

ز - 2-1 الفرضية الأولى : اسهام السلوك الرياضي في تحمل الآلام

ز - 2-2 الفرضية الثانية : دراسة المحددات النفسية للسلوك نحو اعتماد تجربة الألم

ز - 2-3 الفرضية الثالثة : علاقة الشخصية بالمعرفة الإجتماعية لاعتماد السلوكيات الوقائية

ز - 2-4 الفرضية الرابعة : العلاقة بين الشخصية والضعف المتصور

ز - 2-5 الفرضية الخامسة : هناك علاقة المحددات النفسية والتأثير المتصور من الإصابة

وتوصلنا إلى النتائج التالية :

إلى حد أن ينظر إلى الضعف هو 1) عنصرا محوريا من النماذج المعرفة الاجتماعية للصحة، على سبيل المثال نموذج من الإيمان في نظرية الحافز الصحة، لحماية النماذج الإضافية التي لم تكن مقررا في الأصل كأحد محددات السلوكيات الصحية، على سبيل المثال نظرية السلوك الاجتماعي . (Abraham et al., 1999) ، وتحديد تاريخ من الضعف النفسي يمكن أن ينظر إليها على حد سواء تعزيز هذه النماذج والسماح لتعميق معرفة نقاط الضعف والحماية ضد خطر الإصابة. ولذلك، فقد اقترحت الدراسات 4 و 5 لتحديد كيفية قياس شخصية يمكن أن يكون محتمل التفسيرية في التدريب والتلوين لضعف ينظر أبعد من مساهمة الخبرات الإصابة في الماضي. وقد أجريت هذه الدراسة 4 خصوصية يجري في الرياضة (مثل لعبة الركبي) يطلب فيها من الممارسين للتغاضي عن الإصابات وللنظر فيها باعتبارها المعيار المقبول ه (Flint, 1998). فقد بينت النتائج أن في مثل هذا السياق، فإن جذور الضعف الملحوظ في العوامل إصابة مستقرة جدا، أي العصبية (Costa & McCrae , 1992)، وقالت انها غير رغبة في تغيير مع مرور الوقت، حتى أثناء التجربة من الإصابة. للاهتمام بوجه خاص، العصبية يظهر في الزر كعامل وقائي بقدر ما هو حاسم للإنسان أن يتصور وجود خطر عندما ينخرط في حالات تهديد. ومع ذلك، منذ الأدب في كثير من الأحيان قد سلط الضوء على الصلة بين العصبية والسلوك الاجتماعي للخطر واستهلاك الكحول، على سبيل المثال (al., 2000) (Loukas,2000) وسيكون من المثير للاهتمام أن السؤال إلى أي مدى ويرافق هذا العامل الشخصية السلوكيات غير القادرة على التأقلم المفارقة للتعامل مع المخاطر المتوقعة بل هو أيضا من المستغرب أن نتائج الدراسة لم تظهر 5

وجود علاقة كبيرة بين العصبية والضعف المتصور للرياضيين ممارسة الجودو. هذا التناقض في النتائج تشير إلى أن طبيعة النشاط قد تؤثر على الطريقة الممارسين من خطر تعرضهم للإصابة. أنشطة ، والجودو، والتي يتم استبعادها من يهدد سلامة البناء البدني من الخصوم، قد ينظر إلى قابلية تعتمد أكثر على العوامل المرتبطة بالحالات أو الظروف، والمركز الأول في مجال البحث من تجربة الإصابات في الماضي.

في حين أن العديد من الدراسات وقد لاحظ أيضا أن تشكيل وتلوين الضعف المتصور يعتمد على عوامل والعمليات المعرفية، أي تصور خصائص المخاطر واستخدام ارشادي ثانية

(Gerend, Aiken, West, & Erchull, 2004) ; (Ree s et al., 2001)، وتعتبر تكاملها واحدة مع العوامل الشخصية (Gerend, Aiken, & West, 2004). وأكدت الدراسة (5) من هذا العمل الدكتوراه وجود نموذج متكامل ومحددات سياقاتها الضعف المتصورة، وتقاس التصورات الخصائص من خطر الإصابة، والاستدلال المعرفي وشخصية تشارك تدريب وتلويين مفهوم الضعف عندما يتم التحكم مساهمة من تجربة الماضي من الإصابة. التأكيد على التعددية الضعف تاريخ المتصورة، فإن هذه الدراسة تلقي الضوء على نقاط الضعف متعددة الأبعاد والحماية ضد خطر الإصابة. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة لا تثبت دور وساطة لإدراك خصائص مخاطر الاستدلال المعرفي في العلاقة بين الشخصية والضعف المتصورة وهذه النتيجة تشير إلى أن هذه العلاقة قد تعتمد على غيرها من العوامل دراسة الصورة في قلب هذا العمل الدكتوراه، وبينهم العوامل العاطفية التي تنشأ مساهمة (e.g. Loewenstein et al., 2001)

اعتماد و(أو تنوي اعتماد) تحدد السلوكيات الصحية الوقائية أو خطر من تأثير إضافية من العوامل النفسية: تصور الشخص من خطر الإصابة، أي ضعف وشدة من ينظر إليها يد واحدة (دراسة 2)، والمعتقدات المتصلة السلوكيات الصحية في الاعتبار، أي المواقف والمعايير الموضوعية، من ناحية أخرى (دراسة 3). شخصية أمر حاسم أيضا لأنه من شأنه أن يساعد على التأثير في كل من المواقف للشخص (دراسة 3)، وضعفها ينظر (الدراسات 4 و 5). وأخيرا، فإن النظرة إلى خطر الإصابة الخصائص واستخدام الاستدلال المعرفي وتحديد مواطن الضعف المتصورة بالتزامن مع هذه العوامل الشخصية (دراسة 5).

بنيت بطريقة استكشافية، وهذا النموذج يستحق دراسة استطلاعية والإحصائية المناسبة يحل مثل تحليل المسار باستخدام هيكلية المعادلة.

القيود المفروضة على هذا العمل الدكتوراه والمنظورات البحثية كل هذا العمل الدكتوراه لديها عدد من القيود التي ينبغي التذكير أنا.

من ناحية المنهجية، وفعلنا الدراسة فقط المحتملين للدفاع عن أطروحة لدينا. ومع ذلك، هذه المنهجية يبدو أكثر ملاءمة لتسليط الضوء على مساهمة العوامل النفسية في تبني السلوكيات

الصحية وحدثت إصابات. يمكن ان يستفيد منها خصوصا من منهجية التحقق من مدى العوامل

استخدام النفسية للتنبؤ القصير والطويل الأجل حماية المعدات. كان من الممكن أن يقدم تصميم المحتملين في الدراسة 4، بما في ذلك تدابير عدة من الضعف المتصور تدار على حد سواء قبل وبعد تجربة (جديد) الإصابات، وأكثر من حساب التأثير الدقيق لهذه الإصابات على التصور الخطر ، والتغيرات وخاصة المرتبطة حدوثها.

هذا العمل الدكتوراه يقدم أيضا نقاط الضعف المنهجية فيما يتعلق بتقييم العوامل التي تمت دراستها، والإصابات الرياضية الأولى. عدد الألياف العضلية المصاب وربما كان المعيار الأكثر موثوقية للكشف عن وجود إصابات وتحقيقا لهذه الغاية، واستخدام استكشافية من الأجهزة الطبية (مثل التصوير بالرنين المغناطيسي)، ويبدو لظهار أكثر ملاءمة. ومع ذلك، كان القليل من البحث قادرا على استخدام هذه الأجهزة للتمييز بين الرياضيين المصابين والرياضيين بالصحة الجيدة ، وخصوصا بالنظر إلى الصعوبات المادية والمالية المتعلقة بالحصول على هذه المعلومات (Flint, 1998) ، فإننا نحذ استخدام معيار آخر، أي في الوقت الضائع في تدريب / المتنافسة بسبب الإصابة (ITL)، وانخفاض مستوى القائم على صدمة حقيقية من الأعراض، وهذا دير لعواقب الصدمات إذا وهي تساهم في استكمال التعريف الطبي للإصابات، تعريف التشريحية (بالنظر إلى الجسم والإصابة الشخصية) إلى تعريف أكثر وظيفية مرتبطة بقوة لمفهوم عدم اللياقة، وهذا يمكن أن يكون المعيار ولكن إشكالية لتقييم وقوع اصابات. طبيعة المنهكة من اصابة يعتمد على خصوصية الرياضة - رياضة مع كسر في الذراع يمكن أن تلعب كرة القدم وليس كرة اليد - والعوامل الفردية مثل التسامح الألم (Suan, 1998). ومن الشائع بالنسبة للرياضيين المصابين، بمعنى للمصطلح التشريحي ، الاستمرار في ممارسة نشاطهم البدني، وبالتالي فهي لا تعتبر في تحليلاتنا باصابة في المستقبل، يبدو من الضروري النظر في البروتوكولات .

سوف يكون هناك تعاون قوي بين الباحث والجهات الفاعلة الرياضية من جهة، والعاملين في مجال الصحة المسؤولة عن هذه الجهات الفاعلة الأخرى.

أخيراً، وغالباً ما تستخدم وحدات واحد لتقييم تصورات المشاركين. هذه المنهجية يبدو بوضوح أكثر ملائمة لتحقيق تسليم المكانية، مكان التدريب، ومضاعفة المتغيرات التي شملتها الدراسة. استخدام العناصر البسيطة هي أيضاً شائعة بشكل متزايد (Kirsch et al., 2001) ; (Watkins et al., 2001) ; (Pomero y et al., 2001) ; (2001)، ودافعت عن (Robin s et al , 2002) ; (Nagy , 2002) ; (Gardner et al., 1998) (Wanous et al., 1997) ; (2001) في البحوث النفسية. ومع ذلك، يمكن استخدام عدة بنود لتقييم كل عامل في المستقبل ضمان النتائج التي حققناها من خلال زيادة الخصائص السيكمترية من كل مقياس (Nunnally, 1978).

على المستوى المعرفي من جهة أخرى، هذه الدرجة لا يهتم إلا في العمليات المعرفية والعوامل التي يمكن أن تكون حاسمة في عملية المسببة للأمراض. حتى الآن ثبت أن المخاطرة العمل كوسيلة من وسائل تنظيم عاطفي، بقدر ما أنهم متورطون في أعمال الصيانة، وبدء تعديل الاستجابات العاطفية، سواء كانت إيجابية أو سلبية. وقد وجدت بعض العوامل في الواقع وجود علاقة بين اعتماد سلوك غير حكيم ثانية، القمع العاطفي وتؤثر سلباً (Trull & Sher, 1994). ويمكن في سياق الممارسة البدنية، وقد تبين أن القفز يكون نشاط من المحتمل أن تؤثر على وضع مسافة السلبية المرتبطة رتابة (Michel, Carton, & Jouvent, 1997). وعلاوة على ذلك، ودراسة من قبل (Bonnet et al. 2003) يدل على ان تتميز الغواصين الذين يشاركون في السلوكيات الخطرة (مثل الغوص إلى أعماق كبيرة، وليس احترام تخفيف الضغط) من قبل على مستوى من المشاعر السلبية أكثر حذراً من الغواصين.

يقتصر النماذج المقترحة في هذا العمل الدكتوراه لهذه العلاقة واحدة بين تجربة تأثير سلبي، تأثير ايجابي من البحوث واعتماد السلوكيات الصحية. العواطف هي أيضاً من المحتمل أن يحدث عندما يكون الشخص يجري حالياً عملاً من أعمال الحكم. في هذا العمل الدكتوراه، وأثبتنا أن الرياضيين يستخدمون الاستدلال المعرفي عندما محاولة لتقييم احتمالات انهم يواجهون في المستقبل بسبب الإصابة. وبالتالي، أكثر من لاعب الجيدو يعتبرون أنفسهم مشابهة لتلك التي من المحتمل أن تكون إصابة (ارشادي) بقدر ما يعتبرون أنفسهم / الضعفاء

أنفسهم. ومع ذلك، هذه العملية المعرفية لا تلخص الاستدلال في العمل في التوقعات من المخاطر. مؤخرًا، وقد أكد بعض الكتاب أن الأشخاص يعتمدون على عواطفهم لتسهيل الحكم (Loewenstein et al., 2001) ; (Hanoch, 2002). ومساهمة من العواطف لتقييم المخاطر يؤدي بما في ذلك استخدام الوجدانية الاستدلال (Slovic et al., 2002). لا يزال التحقق من تورط من معالجة عاطفية في الحكم من قبل أي رياضي من الضعف نفسه، واستكشاف كيفية عمل هذه العملية يتفاعل مع التجربة عن وقوع إصابات في الماضي. بسبب (خطير) وتصاحب الإصابات

من ردود فعل عاطفية قوية (cf. Wies Bjornstalet al., 1998)، هو في الواقع المشروعة للتشكيك في تورط هذه الإصابات في الماضي شعر عاطفي في الفكر ويصاب.

يجب أن هذه الحدود لا ننسى أن هذا العمل الدكتوراه تعطي المبررات لإنهاء هيمنة نموذج الإجهاد الإصابة (Williams & Andersen , 1998) كإطار لتحليل نقاط الضعف والحماية ضد مخاطر وقوع إصابات. هذه نظرية المعرفة البديلة التي يروج المعرفي الاجتماعي النهج في النهاية يدافع عن فكرة أن الرعاية الصحية الشاملة "النتائج من العناية التي نتخذها من النفس والآخرين والقدرة على اتخاذ القرارات والسيطرة على ظروف معيشتهم (Charte d'Ottawa, 1986)

مقدمة:

الرياضي يفكر في اغلب الأحيان انه يعالج الألم ، إصلاح كسر العظم أو يمضي وقته عند أخصائي العلاج الطبيعي ، يسمح له بدخول المنافسة عندما يكون الجسم مهياً ، أحيانا تكون نفسية أو نفسية بدنية ، الأطباء ، أخصائي العلاج الطبيعي ، والمدربين مدعوون إلى إيجاد حل إلى المشكلة والشفاء ، والعلاج، ولكن هناك نقص في استشارة طبيب نفسي ، ومع ذلك أحد جوانب أساسيين كي تسمح للرياضي تجاوز الإصابة يمر عبر تعقل الجوانب النفسية مرتبطة بالإصابة لكي يتناول المشكلة بكاملها .

من الواضح وجود عديد من أنماط أو نماذج الإصابة حسب خطورتها ، نلاحظ سواء تظاهرت:

- فيزيائية (الم ، عطب ، عابر)

- عاطفي (خشية ، قلق ، انهيار عصبي)

اجتماعي (انفصال مع الآخرين ، اعتماد)

وتعد الإصابة من المشكلات الأساسية التي تواجه عملية تقدم المستويات الرياضية وانتقالها من مستوى إلى آخر، إن قلة إلمام فئة من اللاعبين والمدربين بأسباب الإصابات وكيفية تجنب حدوثها يدفع اللاعبين - أحيانا كثيرة - إلى الوقوع في أخطاء قد تكون تكنيكية أو تكنيكية أو سوء تنظيم في حمل التدريب أو قلة في تهيئة أجهزة الجسم الداخلية والخارجية وعدم استعداد الجهاز الهيكلي لتقبل الجهد الذي يقع على عاتق الرياضي ، ولا تقتصر الإصابات على المستويات العليا ولكنها تتمثل في جميع المستويات وقد تحدث الإصابة في التمرين أو في المباراة أو في الدروس العملية وحتى في ممارسة النشاط الترويحي الخفيف ، وتختلف نسبة حدوث هذه الإصابات وأنواعها ويختلف ارتباطها مع نوع الفعالية الممارسة، لذا ينبغي أن نضع في اعتبارنا دائما مبدأ سلامة اللاعب أولا ووضع كافة الإمكانيات لمنع حدوث أو تكرار الإصابات للحد من خطورتها وذلك عن طريق اتخاذ كافة التدابير اللازمة إنشاء التدريب والمباريات والاستعداد التام لتقديم الإسعافات الفورية عند حدوث الإصابة لأن إهمال وسائل الإسعاف الفوري وقت حدوث الإصابة البسيطة والتي تلعب دور حيوي وهاماً تؤدي إلى عواقب سيئة ويمكن تتضاعف خطورتها في تحديد المستقبل الرياضي للاعب

ويذكر (1981 Martens) إن منع الإصابة هو الجانب الأكثر أهمية في الطب الرياضي كما إن الاهتمام ببرامج الوقاية كفيلا بإبعاد اللاعب عن الإصابات في الميدان الرياضي (Martens , 1981 , 145).

ما وراء الألم الذي يشعر في ذلك الوقت من وقوعها (Starkey, 1999)، مثل تلك المعاملة التالية شهدت متناسقة، لعملية جراحية على سبيل المثال، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل (Tripp, 2004) Stanish, Coady, & Reardon, 2004، والبحث النوعي والكمي تبين ان الإصابة قد يكون لها أثر عميق على نفسية الرياضيين (Johnston & Carroll, 2000 ; Quinn & Fallon, 1999 ; Rose & Jevne, 1993 ; Smith, Stuart, Wiese-Bjornstal, 1997) (Milliner, & O'Fallon, 1993 ; Udry, Gould, Bridges, & Tuffey, 1997) فإنه قد يكون مسؤولا عن انخفاض في تقدير الذات، ومشاعر الخسارة (Flint, 1998)، والإحباط والغضب (Quackenbush & Crossman, 1994 ; Tracey , 2003) والخوف والضغط، أو الاكتئاب (Liddy , Lambert, & Ogles, 1994 ; Macchi & Crossman , 1996) ..

ذلك أن النشاط البدني والرياضة وتشجيع الممارسين على صحتهم، يبدو من الضروري زيادة التدخلات الفردية والجماعية التي تهدف على حد سواء لمنع السلوكيات الخطرة وزيادة السلوكيات وقائية ضد الإصابة. حيث انه من تصميم هذه التدخلات يتطلب فهما أفضل الأساسية، في الأصل، وعوامل العمليات المسببة للأمراض، أي متصلة إلى وقوع إصابات. ويركز هذا العمل الدكتوراه.

نفسية تجعله عرضة للضغط (e.g. Williams & Andersen, 1997; Williams, Tonymon, & Andersen, 1991). Andersen, 1991). وقوع إصابات، ولكن قد تكون ذات صلة فقط إلى الآثار الضارة الضغط النفسي؟ بعض النماذج المعرفة الاجتماعية من الصحة (e.g. Modèle des Croyances sur la Santé, MCS, Health-Belief Model: Becker & Maiman, 1975 ; Rosenstock, 1990 ; Théorie De la Motivation à se Protéger, TMP, Protection Motivation Theory: Prentice-Dunn & Rogers, 1986 ; Rogers, 1975 ; Théorie du Comportement Planifié, TCP, Theory of Planned Behaviour : Ajzen, 1988, 1991, 1998)

وسعى العديد من الدراسات لتحديد تفسر لماذا بعض الناس قد يصابون عند ممارسة النشاط

البدني و / أو رياضي. وتبنى هذه النماذج حول فكرتين رئيسيتين: (1) الوضع الصحي للسلوك قابل للتعديل تعتمد على اعتماد في الحياة اليومية، (2) التصورات والمعتقدات والتصورات المسبقة للشخص دور فعال في اعتماد هذه السلوكيات. تم توثيقها على نطاق واسع هذه النماذج على سبيل المثال، لمنع ظهور الأمراض المختلفة، سرطان على سبيل المثال، وأمراض القلب والأوعية الدموية (Aiken, West, Woodward, & Reno, 1994); Humphries & Krummel, 1999) الخمول البدني (Chatzisarantis & Hagger, 2005, 2008 ; Hausenblas, Carron,&Mack,1997) Johnston, Johnston, Pollard, Kinmonth, 2004) ; (e.g. Williams-Avery & Schmiede, Aiken, Sander, & Gerend, 2007) ومع ذلك، فقد كانت بعض الدراسات في مجال الوقاية من الإصابة (MacKinnon, 1996) . هذا العمل الدكتوراه تسعى لتقييم إلى أي مدى من النماذج الاجتماعية والمعرفية من الصحة تحديد مواطن الضعف وحماية من خطر الإصابة أثناء ممارسة النشاط البدني و / أو الرياضي. إلى حد ما، علاوة على ذلك، فإن معظم هذه النماذج تؤكد المعرفة الاجتماعية مركزية من الضعف الملحوظ في اعتماد السلوكيات الصحية وسعى العديد من الدراسات لتحديد. (Conner , Weinstein, 2005) .

تاريخ هذا التصور (على سبيل المثال Eibner 2004 ، و Bengel ، 2006، Aiken،Gerend ، 2004؛ Aiken ، Gerend ، و Erchull). وقد أجريت هذه الدراسات في وذات شقين: (1) نموذج الملحق الاصيل الذي لم يحدد هذه السوابق

فهم أفضل لمكونات السلوكيات الصحية نظرا لزيادة فعالية برامج الوقاية من (افضل استهداف للأشخاص المصابين، وتحسين نوعية الحملات الإعلامية). على وجه الخصوص، أثبتت أنها أحكام هذا الفرد (مثل الثقة بالنفس والتفاؤل) أو كانت مرتبطة بقوة ق حقل كبير للشخصية (على سبيل المثال العصابية، الضمير) إلى الضعف ينظر إليها (Eibner ,1999) وآخرون، (Gerend ، 2006، Aiken Knoch ، Vollrath 2004). كما لاحظوا أن الناس كانوا يستخدمون الاستدلال المعرفي (Himfriz ، Facione ، 2005) أو تمثيل للخصائص المخاطر (Gerend 1980.1982.1987، Aiken ، و Erchull 2004 Winchtein)، لتقييم احتمال أنهم يواجهون مشكلة صحية جزء من عمل هذه الرسالة، ونفحص لذلك كيف يمكن لهذه العوامل النفسية قد يفسر التناقض في الردود الفردية

عند كل شخص يقيم من خطر الإصابة. في النظر إلى أبعد من النماذج الاجتماعية والمعرفية للصحة، لذلك نقوم بتحديد نقاط ضعف جديدة والحماية ضد خطر الإصابة.

في النهاية، هذه الأسئلة العمل في الدكتوراه إمكانية تحديد مسبق للناس الذين هم أكثر عرضة للإصابة عندما يكون نشاطا بدنيا و / أو الرياضي. فهو يزعم أن يتم تحليل الأطر الصحية للنموذج الاجتماعي والمعرفي للضعف الإلكتروني والحماية من المخاطر إصابات في محسوبة حيث وقوع إصابات تعتمد على الاشتباك هل سلوك الفرد في مجال الصحة

الدفاع عن هذه الأطروحة تركز على جزئين رئيسيين. في جزء نظري الأولى، الفصل الأول يقدم استعراضا للدراسات التي سعت إلى تحديد العوامل والعمليات النفسية المرتبطة إلى وقوع إصابات في سياق الرياضي. والفصل الثاني يدل على أهمية تحديد

السلوكيات الصحية ومحدداتها، وذلك لتمييز الضعف النفسي، والحماية ضد خطر الإصابة. القدرة التفسيرية وأصناف المعرفة الاجتماعية و نماذج من الصحة. ويخصص الفصل الثالث لتاريخ الضعف فا ينظر إليه إلى حد أن هذا التصور خطوة أولى ضرورية في عملية تبني السلوكيات الصحية ، وعنصرا رئيسيا في معظم النماذج المعرفية الاجتماعية (Konzman , 2005) (Winchtein, 2000).

تفاصيل قسم الدراسات التجريبية الخمس. وهو الأول من هذه الدراسات يهدف إلى التعرف على السلوكيات الصحية في سياق الرياضي، وهذا يعني إن علاقة مباشرة لخطر الإصابة. طالما أن تجربة الألم يمكن أن (هو) الترجمة (من قبل) اضطرابات الانتباه أو مسببات الأمراض الجسدية المحتملة، فإن هذه الدراسة تركز بشكل خاص على السلوكيات الرياضيين التي تعتمد عندما يواجهون الألم. الدراسات الثانية والثالثة هي اختبار القدرة الاجتماعية والمعرفية نماذج لتفسير اعتماد السلوكيات الصحية عندما تمارس النشاط البدني أو الرياضي. في إشارة إلى نتائج الدراسة الأولى، طلب من الدراسات 2 إلى أي مدى إدراك المخاطر، أي ضعف المتصورة وحدة، قد يكون عاملا محددا للسلوك النفسي خطر لمواجهة الألم. 3 وتسعى الدراسة إلى التعرف على مساهمة نظرية السلوك المخطط له، وبالإضافة إلى ذلك، تصور خطر في اعتماد آخر للسلوك الصحي، أي ارتداء معدات الوقاية

الفصل المنهجي

تشكل الإصابة حاجزاً جسياً ونفسياً إذ يصبح عقبة للوصول إلى تحقيق انجاز أمثل والوصول الى المستويات العليا ، وفي الواقع ان حدوث الإصابة عند ممارسة الأنشطة الرياضية يعد ظاهرة لا تتفق مع الأهداف الصحية للتربية الرياضية .

في النهاية، هذه الأسئلة العمل في الدكتوراه إمكانية تحديد مسبق للناس الذين هم أكثر عرضة للإصابة عندما يكون نشاطا بدنيا و / أو الرياضي. فهو يزعم أن يتم تحليل الأطر الصحية للنموذج الاجتماعي والمعرفي للضعف الإلكتروني والحماية من المخاطر إصابات في محسوبة حيث وقوع إصابات تعتمد على الاشتباك هل سلوك الفرد في مجال الصحة

الدفاع عن هذه الأطروحة تركز على جزئين رئيسيين. في جزء نظري الأولى، الفصل الأول يقدم استعراضا للدراسات التي سعت إلى تحديد العوامل والعمليات النفسية المرتبطة إلى وقوع إصابات في سياق الرياضي. والفصل الثاني يدل على أهمية تحديد

السلوكيات الصحية ومحدداتها، وذلك لتمييز الضعف النفسي، والحماية ضد خطر الإصابة. القدرة التفسيرية واصناف المعرفة الاجتماعية و نماذج من الصحة. ويخصص الفصل الثالث لتاريخ الضعف فا ينظر اليه إلى حد أن هذا التصور خطوة أولى ضرورية في عملية تبني السلوكيات الصحية ، وعنصرا رئيسيا في معظم النماذج المعرفية الاجتماعية (Konzman, 2005) (Winchtein, 2000).

تفاصيل قسم الدراسات التجريبية الخمس. وهو الأول من هذه الدراسات يهدف إلى التعرف على السلوكيات الصحية في سياق الرياضي، وهذا يعني ان علاقة مباشرة لخطر الاصابة. طالما أن تجربة الألم يمكن أن (هو) الترجمة (من قبل) اضطرابات الإنتباه أو مسببات الأمراض الجسدية المحتملة، فإن هذه الدراسة تركز بشكل خاص على السلوكيات الرياضيين التي تعتمد عندما يواجهون الألم. الدراسات الثانية والثالثة هي اختبار القدرة الاجتماعية والمعرفية نماذج لتفسير اعتماد السلوكيات الصحية عندما تمارس النشاط البدني أو الرياضي. في إشارة إلى نتائج الدراسة الأولى، طلب من الدراسات 2 إلى أي مدى إدراك المخاطر، أي ضعف المتصورة وحدة، قد يكون عاملا محددا للسلوك النفسي خطر

الفصل التمهيدي

لمواجهة الألم. 3 وتسعى الدراسة إلى التعرف على مساهمة نظرية السلوك المخطط له، وبالإضافة إلى ذلك، تصور خطر في اعتماد آخر للسلوك الصحي، أي ارتداء معدات الوقاية

إن الطب الرياضي هو اصطلاح يستخدم لوصف الشبكة الواسعة للإدارة الطبية والعلاجية للنشاط الرياضي، وقد عرفت الكلية الأمريكية للطب الرياضي هذا المصطلح (الطب الرياضي) بأنه معرفة الدوافع والاستجابات والتكيفات وصحة الأشخاص الممارسين للنشاط الرياضي وهذا التعريف يشبه المظلة التي يقف تحتها كل الأشخاص من ذوي المهن الطبية وشبه الطبية الذين يقدمون الخبرة الهادفة لتطوير التدريب والأداء والرعاية الصحية للأشخاص.

تتعرض الاطراف الجسم الى الاصابات بسبب الاستخدام المباشر والغير المباشر في ممارسة الانشطة الرياضية مثل كرة القدم و كرة اليد والسلة والطائرة والجمناستك والاثقال ، اذ تتعرض المفاصل الى ضغوط كثيرة مما يؤدي الى التمزق العضلي او قد يتعرض اللاعب الى حوادث تؤدي الى الكسر ، من هنا تبرز اهمية تناول مختلف الاطراف باجزائها للبحث وتاتي اهمية هذا البحث كونها محاولة علمية جادة للوقوف على انواع الاصابات التي تحدث لدى اللاعبين في أندية الجزائر العاصمة و في مختلف الاطراف وفي بعض الالعاب المعتمدة من قبل اللجنة الاولمبية والاصابات الاكثر تكراراً واسباب ومناطق حدوثها وشدتها كظاهرة تستحق الدراسة والأسس الوقائية وكيفية حدوث الاصابات واسلوب المعالجة الفوري وبشكل يمكن ان يمثل اسهاماً بسيطاً في عملية تقديم المستويات الرياضية وبلوغ الأهداف الرياضية المتوخاة من إعداد الرياضيين وتدريبهم .

التدريب الرياضي يقدم مجالات واسعة للرعاية الصحية المساندة لخدمات الرياضة والتدريب الرياضي كما عرفته الجمعية الأمريكية NATA (National athlentic trainer Association) بأنه الفن والمعرفة الخاصة باللياقة والوقاية والتحفظ من الإصابات بكل مستويات التدريب الرياضي والشخص الذي يقدم التدريب الرياضي هو المدرب الرياضي athlentic trainer. إن مهنة المدرب الرياضي والتدريب الرياضي قد اتخذت مجالا واسعا متطورا مع الأيام في ميدان الطب الرياضي، وبذلك أصبح من الضروري للمدربين الرياضيين الألم الشديد والواسع بكل علوم الطب الرياضي وبما يسهل عملية التدريب ويوسع دائرة الوقاية من حدوث الإصابات، ولطالما هناك رياضيين فإنه سيكون هناك مدربين رياضيين وأخصائيي التدريب الرياضي يختلف في هذه الأيام عما كان في الأيام السالفة إذ أن المدرب الرياضي الآن يمتلك معلومات واسعة في مجال الطب الرياضي مما يؤهله للدخول في

هذا الميدان ووقاية فريقه من التعرض (قدر الإمكان) من الإصابات، فهو يجب أن يكون ملماً بعلوم التشريح الفزيولوجي، علم الحركة، علم النفس، الفلسفة الرياضية، العلوم الصحية، الفيزياء، التغذية وكذلك الاسعافات الأولية مصحوبة بمهارات تدريبية عالية وكذلك يجب أن يمتلك روح القيادة والقدرة على التواصل ويجب أن يكون الشخص القادر على إيصال معلوماته بشكل واضح وصريح مستخدماً كل أنواع وأساليب التدريب المختلفة.

وبالتالي فإن عوامل الضعف والحماية ضد خطر الإصابة. أنا نطرح السؤال الأساسي: "هل يمكن ان نحدد مسبقاً من هم أكثر عرضة للإصابة عندما تكون نشاطاً بدنياً و / أو رياضياً؟".

ب- تحديد المشكلة:

إن الإصابات الرياضية ومدى تأثيرها على اللاعب من حيث شدتها ومكانها وزمنها تؤثر مباشرة في اللياقة ومستوى اللاعب .

ونظراً لكثرة تعرض الرياضيين في العاصمة الى انواع مختلفة من الاصابات الرياضية في مختلف الاطراف من الجسم فقد اثار ذلك الموضوع اهتمام الباحث في محاولة معرفة ما هي انواع تلك الاصابات وأسبابها وشدتها ومناطق حدوثها ومدى تأثيرها في أداء الرياضيين في الألعاب المختلفة ونسبة وجودها في كل لعبة ، وذلك من اجل الوصول الى الحلول المناسبة لمعالجة مثل هذه الاصابات الرياضية التي تؤثر في مستوى الانجاز وتقدم الرياضي في العاصمة.

ج- أهمية البحث وأهدافه :

- التعرف على الاصابات الأكثر شيوعاً التي تصيب مختلف الاطراف من الجسم في الألعاب الرياضية المختلفة وفقاً لـ (أنواعها ، مناطق حدوثها ، أسبابها ، شدتها).

- التعرف على نسب الاصابات الرياضية للاعبين وفق متغيرات (الطول، الوزن، العمر التدريبي).

- التعرف على نسب الاصابات وأنواعها في ألعاب رياضية مختلفة وحسب خصوصية كل لعبة .

د- حدود البحث :

- المجال البشري : لاعبو اندية الجزائر العاصمة

الفصل التمهيدي

- المجال المكاني : المؤسسة الاستشفائية المختصة الدويرة.

- المجال الزمني : 2009/06/10 الى غاية 2012/03/10

هـ - تعريف المصطلحات

هـ -1- المفصل :

وهو اتصال بين طرفي عظمين او اكثر يفصلهما عادة غضروف ويثبتان عادة مع بعضهما بوساطة أوتار وأربطة يختلف عددها ومتانتها من مفصل لآخر .

(البصري ، 1985 ، 137)

ويعرف كذلك بأنه : عبارة عن ارتباط بين عظمين وهذا الارتباط هو الذي يشكل نظام العتلات ويربط بين مفصل وآخر نسيج ضام يسمى اربطة ، ويوجد بين كل عظمين غضاريف (محبوب ، 1978، 92) . ويذكر (قبع، 1999) انها ترابط عظم مع عظم بطريقة تسمح لهم بالحركة. وان نوع المفصل وتركيبه يعتمد على نوع ودرجة الحركة المطلوبة وتقسم المفاصل بصورة عامة الى مفاصل ليفية وغضروفية وزلائية (قبع، 1999، 118) .

هـ-2- الأوتار:

وهي عبارة عن الياف مثبتة غير مرنة تقوم بوظيفة ربط العضلات بالعظام ويتكون الوتر من عدد كبير من الالياف الكولاجينية البيضاء الموازية لبعضها البعض والتي تحصر بينها الخلايا المولدة الليفية المسماة بالخلايا الوترية في حالة الوتر (عبد القادر، 1979، 75).

ويختلف طوله باختلاف العضلات وقد يكون للعضلة اكثر من وتر واحد كما في العضلة ذات الراسين العضدية .(يوسف ، 1981 ، 5).

هـ-3- الاربطة :

وهي اشرطة قوية تتكون من النسيج الليفي الابيض تربط العظام مع بعضها . وتعرف كذلك بانها : الياف غير مطاطية تعمل فقط على تثبيت المفصل والحد من مدى حركته اكثر من المعتاد (قبع ، 1999، 127).

ه-4- الغضاريف :

وهي أنسجة رابطة تتكون من نسيج خالٍ من الاوعية الدموية ويتكون من القلب والالياف. وتشمل ثلاثة انواع :

ه-4-1. **الغضاريف الزجاجية** : مثل غضاريف القصبة الهوائية والتهابات الضلعية ونهايات العظام الطويلة وتتكون من مادة القلب الصافية مع مجموعة من الخلايا على شكل مجاميع وتعمل على تخفيف الضغط.

ه-4-2. **الغضاريف الليفيّة** : وتتكون من مادة القلب الذي يكون مدعوماً بكمية كبيرة من الالياف البيضاء تنتشر بينها خلايا . ويوجد هذا النوع في الاقراص بين الفقرات والغضاريف الهلالية في الركبة .

ه-4-3. **الغضاريف المطاطية** : وتتكون من مادة القلب مدعومة بكمية كبيرة من الالياف الصفراء المطاطية . وتوجد في صيوان الاذن والانف والحنجرة حتى تعطي مطاطية لها .

ه-4-5. العضلة :

هي مجموعة او اكثر من الالياف العضلية غير ملتصقة ببعضها البعض وكل عضلة من عضلات الجسم تتصل بعصب يصلها بالنخاع الشوكي ، ويقوم هذا العصب بوظيفة سلك التلفون او الكهرباء الذي يحمل امر المخ الى العضلة لينبهها لتنفيذ امر المخ سواء بالانقباض او الارتخاء ، وتكون بنسبة 45-50% من وزن الجسم ، وهي نوعان :

عضلات ارادية .

عضلات لا ارادية .

ولها مدغم ومنشأ ومغرز وتكون ريشية او مغزلية او متوازية او مثلثة .

ه-4-6. العظم:

وهو الجزء الصلب من جسم الانسان وهو الذي يعطي انتصاب القامة ، ان السطح الخارجي للعظم مغطى بطبقتين قويتين وكثيفتين من السمحاق الخارجي والسمحاق الداخلي ومن وظائفه :

وقاية وحفظ العظم .

تغذية العظم بواسطة اوعية دموية صغيرة تمر منها الى العظم .

المساعدة في تكوين انسجة عظمية وتحديد نمو الانسجة العظمية ويكون مناطق لاتصال الاربطة والوتر العضلي بالعظم.

ومن وظائف العظام :

1. تكون العظام دعامة قوية للجسم لاتصال العضلات والاربطة

2. يعد العظم مخزن لمادة الكالسيوم للجسم .

و - الدراسات المشابهة :

و - 1 - دراسة وديع ياسين (1985) :

"دراسة لتحديد الاصابات في رفع الاثقال واسباب حدوثها"

هدفت الدراسة الى تحديد الاصابات التي تقع من جراء ممارسة رياضة رفع الاثقال ومعرفة اهم الاسباب التي ادت الى وقوع الاصابة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وتكونت عينة البحث من (50) رباعاً من رافعي الاثقال المتقدمين وتراوح اعمار عينة البحث بين (18-35) سنة واستخدم الباحث الاستبيان وسيلة لجمع البيانات وعولجت البيانات احصائياً باستخدام النسب المئوية واستنتج الباحث ما يأتي :

ان اصابات اللوي كانت اكثر الاصابات التي تعرض لها الرباعون وكانت نسبتها 37.34% تليها اصابات التمزق العضلي بنسبة 19.51% ثم الكسور بنسبة 4.97% ثم الجروح بنسبة 4.57% ثم الخلع بنسبة 2.49% ثم الرضوض بنسبة 2.05% .

كان اكثر المناطق اصابة هي رسغ اليد بنسبة 13.69% يليه مفصل الكتف بنسبة 12.03% ثم مفصل الركبة بنسبة 59.95% ثم مفصل المرفق بنسبة 8.29% ثم العضلات الظهرية السفلى بنسبة 54.56%.

الفصل التمهيدي

ان اهم اسباب حدوث الاصابة هو القصور في فن الاداء وقلة الاحماء وعدم صلاحية النقل المستخدم والتعب والاجهاد وسوء التغذية .

و-2- دراسة جمعة محمد عوض (1988) :

"الاصابات الصغيرة المتكررة عند لاعبي الكرة الطائرة"

وهدفَت الدراسة الى :

التعرف على الاصابات الصغيرة المتكررة عند لاعبي الكرة الطائرة لاندية الدرجة الممتازة في بغداد وأسباب حدوثها .

الوقاية من الاصابات (الصغيرة) المتكررة وتقليل نسبتها وشدة حدوثها .

استخدم الباحث المنهج الوصفي وتكونت عينة البحث من اللاعبين المصابين بالاصابات المتكررة من اندية الدرجة الممتازة في مدينة بغداد (الرشيد ، الطلبة ، الشباب ، الصليخ ، الصناعة ، الجيش ، الشرطة) .

وقد اختار الباحث هذه الفرق لانها تمثل اعلى مستوى رياضي في القطر لهذه اللعبة . ولما كان البحث يقتصر على اللاعبين الذين يشكون من الاصابات الصغيرة المتكررة ، لذا تم استبعاد اللاعبين المصابين الذين لم تثبت عندهم هذه الاصابات بعد الفحص والتشخيص بواسطة الاجهزة المساعدة ومن قبل نفس الطبيب المعالج وعليه تم الحصول على عينة قوامها عشرون لاعباً تراوحت اعمارهم بين 22-33 سنة وبذلك اختيرت العينة بالطريقة العمدية بما يحقق الغرض من البحث ، وقام الباحث بالمعالجات الاحصائية الآتية : (النسبة المئوية ، الوسط الحسابي ، معامل الارتباط)

وتوصل الباحث الى الاستنتاجات الآتية :

عودة اللاعبين المصابين الى التدريب والمنافسات قبل الشفاء من هذه الاصابات مما يسبب المضاعفات يرى الباحث نسبة 30% من اللاعبين المصابين في المرحلة الثالثة تعد عالية وهذا يعني انها تستدعي التدخل الجراحي .

الفصل التمهيدي

وجد الباحث ان تكرار الاصابات الصغيرة في مفصل الكتف تركزت في مفصل الذراع الضاربة وهذا يعني ان للجهد المبذول على هذا المفصل سبباً مباشراً في حدوث الاصابة الصغيرة لاستخدامه اكثر من المفصل المقابل .

وجد الباحث ان مفصل الركبة يحتاج الى بناء قوي عن طريق بناء المجاميع العضلية العاملة عليه ، ويتم ذلك بوساطة الإعداد المتكامل للاعب (عوض ، 1988)

و-3- دراسة مصطفى جوهر حياة (1996) :

"الاصابات الشائعة لبعض لاعبي اندية التربية البدنية والرياضية في دولة الكويت"

هدفت الدراسة الى :

التعرف على الاصابات الشائعة لبعض الانشطة الرياضية قيد الدراسة .

التعرف على اماكن حدوث الاصابات بأجزاء الجسم .

التعرف على زمن حدوث الاصابة في الفترة التدريبية .

التعرف على اسباب حدوث الاصابات .

واستخدم الباحث المنهج المسحي وتكونت عينة البحث من اللاعبين المسجلين بالاندية الرياضية بدولة الكويت من خلال تردهم للعلاج والتاهيل في مركز الطب الرياضي والتاهيل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال (1987) وكان عددهم (70) لاعباً ، اما الوسائل الاحصائية فقد تكونت من النسبة المئوية لايجاد الفروق بين معامل الارتباط (ت) البحثية .

واستنتج الباحث :

التمزق الغضروفي في منطقة العمود الفقري هو أكثر الاصابات شيوعاً اما الشد العضلي فقد جاء بالمرتبة الثانية وجاءت اصابات الرضوض والكسور في المرتبتين الثالثة والرابعة يليها الخلع ثم اللوي الذي يشكل اقل الاصابات.

النصف الاول من الموسم التدريبي هو التوقيت الاكثر حدوثاً للإصابة .

الفصل التمهيدي

أكثر التوقيعات حدوثاً للإصابة هي اثناء التدريب واثناء المنافسة .

نقص اللياقة البدنية ، والاحماء الغير جيد هما اكثر الاسباب حدوثاً للإصابة .

ثبت ان اصابات الجذع تشكل اكبر نسبة من الاصابات اما اصابات الذراعين فقد احتلت المرتبة الثانية وخصوصاً الكتف واصابات الرجلين احتلت المركز الثالث .

ولم يذكر الباحث ما هي الألعاب الرياضية التي اجري البحث عليها .

(حياة ، 1996 ، 112)

و-4- دراسة وديع ياسين التكريتي ونشوان محمود الصفار (1998):

"الاصابات الرياضية التي تعرض لها طلاب كلية التربية الرياضية في جامعة الموصل"

وهدفنا الدراسة الى :

تحديد الاصابات الاكثر شيوعاً لدى طلاب التربية الرياضية .

تحديد اسباب الاصابات الرياضية لدى طلاب كلية التربية الرياضية .

تحديد اجزاء الجسم التي تعرضت للإصابة .

تحديد الدروس العملية التي تحدث فيها الاصابات بكثرة .

تحديد في أي من الاقسام الدروس يحدث اكبر عدد من الاصابات .

استخدم الباحثان المنهج الوصفي بطريقة المسح وتكونت عينة البحث من جميع طلاب السنة الرابعة بكلية التربية الرياضية بجامعة الموصل للعام الدراسي 1997-1998 والبالغ عددهم (131) طالباً .
اذ قام الباحثان بتوزيع استمارة الأسئلة (اداة البحث) على جميع طلاب المرحلة الرابعة الا انهم لم يعيدوا سوى (105) استمارة وبذلك تكونت عينة البحث من (105) طالباً يمثلون نسبة (80%) من اصل مجتمع البحث واستخدم الباحثان الوسائل الآتية :

الفصل التمهيدي

صمم الباحثان جدولاً يحتوي على اجزاء الجسم والاصابات الرياضية التي تتعرض لها هذه الاجزاء ، فضلاً عن ذلك قائمة بالاسباب المحتمل الاصابة من جرائها كذلك في أي درس عملي واي قسم من ذلك الدرس .

اضاف الباحثان مقدمة توضح للطالب كيفية الاجابة على هذه الاستمارة وتشمل الاستمارة كذلك على بيانات اولية كالعمر ونوع الرياضة الممارسة والعمر التدريبي .

وقام الباحثان بالمعالجات الاحصائية الآتية :

الوسط الحسابي ، الانحراف المعياري ، معامل الارتباط البسيط ، معامل الارتباط المتعدد ، معامل الانحدار المتعدد ، معامل التحديد ، ايجاد المعنوية الكلية للانحدار .

وتوصل الباحثان الى النتائج التالية :

ان تمزق الاربطة من اكثر الاصابات حدوثاً يليها تمزق العضلات ثم اصابات السحجات والالتهابات .

من اهم اسباب حدوث الاصابات الرياضية هو عدم الاحماء الجيد .

ان مفصل كاحل القدم من اكثر اجزاء الجسم تعرضاً للإصابة يليها مفصل الركبة ثم مفصل المرفق .

ان مادة كرة القدم هي من اكثر المواد التي تحدث خلالها الاصابات .

معظم الاصابات الرياضية تحدث في القسم الرئيسي من الدرس . (التكريتي والصفار ، 1998 ، 44)

و-5- دراسة هاشم احمد سلمان سند (1998) :

"الاصابات الرياضية عند لاعبي كرة السلة"

وهدفَت الدراسة الى التعرف على اكثر الاصابات الرياضية حدوثاً عند لاعبي كرة السلة .

استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقة المسح وتكونت عينة البحث من لاعبي محافظة نينوى والذين مثلوا فرق انديتها لمختلف المراحل وبلغ عددهم (36) لاعباً تراوحت أعمارهم ما بين (16-45) سنة . (16) منهم الذين تركوا اللعب وتراوحت أعمارهم ما بين (35-45) سنة ، اما باقي افراد العينة فقد

الفصل التمهيدي

تراوحت اعمار (14) منهم ما بين (20-34) سنة وستة منهم ما بين (16-19) سنة ، واستخدم الباحث النسبة كوسيلة للمعالجات الاحصائية . وتوصل الباحث الى الاستنتاجات الآتية :

ان اكثر المفاصل عرضة للاصابة عند لاعبي كرة السلة كان مفصل الكاحل بنسبة 36% يليه مفصل الركبة والذراع بنسبة 28% .

ان معظم الاصابات حدثت في المباريات وبنسبة 68% .

ان معظم المصابين قد شاركوا في المنافسات اثناء الاصابة . (سليمان ، 1998 ، 73)

و-6- دراسة سميرة خليل محمد (2002) :

"دراسة تحليلية للاصابات الرياضية عند طلبة كلية التربية الرياضية"

وهدفت الدراسة الى :

معرفة انواع واسباب ومواقع حدوث الاصابات .

وضع اسس وقائية يمكن ان نحقق بها المناهج الدراسية من خلال كشف نقاط الخلل من اجل تنفيذ المفردات المقررة دون اعاقه قدر الامكان .

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وتكونت عينة البحث من طلبة كلية التربية الرياضية (الجادية) المصابين وللمراحل الدراسية الاربعة حيث بلغ عددهم (204) مصاب من اصل (1845) طالب وهو العدد الكلي لطلبة الكلية ، أي ان نسبة المصابين شكلت (16.38%).

واستخدمت الباحثة الوسائل الآتية : استمارتان للاستبيان ، الأولى تخص معلومات عن الطلبة المصابين (انواع الاصابات ، اسبابها ، مواقعها في الجسم) . كذلك النشاطات التي حدثت فيها ، موزعة على المراحل الدراسية الاربعة .

وتتضمن الاستمارة الثانية أسئلة خاصة بالمدرسين الذين يشرفون على الدروس العملية في الكلية لاستطلاع آرائهم حول الاصابات ومن خلال خبراتهم التدريسية والعملية حيث تضمنت الاستمارة أربعة أسئلة وشملت (18) تدريسياً بواقع تدريسيين لكل نشاط حدثت فيه الاصابة. وقامت الباحثة

الفصل التمهيدي

بالمعالجات الاحصائية الآتية : (النسبة المئوية، الوسط الحسابي، الانحراف المعياري ، الاختبار التائي ، مربع كاي)

وتوصلت الباحثة الى الاستنتاجات الآتية :

هناك نسبة عالية من إصابات الالتواء في مختلف المفاصل وتليها الرضوض ثم التمزقات ثم الخلع وسجلت الكسور اقل نسبة وخاصة في المراحل المبكرة (المراحل الاولى والثانية).

ارتفاع نسبة اصابات الاطراف السفلى وخاصة مفصلي الركبة والكاحل ثم اصابات الظهر.

عدم كفاية (الاحماء بمفرديه والمفردات الخاصة لكل لعبة من الخواص التكتيكية والمهارية) كانت من ابرز اسباب الاصابات .

زيادة نسبة الاصابات في النشاطات متعددة التكنيك والمهارات التي تتطلب سرعة الاداء (ساحة وميدان ، جمناستك).

ظهور توافق بين ما توصلنا اليه من نتائج استبيانات الطلبة المصابين والاساتذة المشرفين على النشاطات وهذا يدل على خلل تنفيذ المفردات التنفيذية (محمد ، 2000 ، 92) .

و-7- دراسة وضاح غانم الصميدعي وآخران (2004) :

"العوامل المؤثرة على الاصابات الرياضية عند لاعبي الجمناستك"

هدفت الدراسة الى التعرف على :

اهم انواع الاصابات الرياضية الشائعة في لعبة الجمناستك .

اكثر الاصابات شيوعاً للاعبي الجمناستك .

اكثر اجزاء الجسم التي تتعرض للاصابة .

اهم الاسباب المؤدية لحدوث الاصابات الرياضية لدى لاعبي الجمناستك .

اكثر الاجهزة الجمناستيكية خطورة على اللاعب .

الفصل التمهيدي

واستخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقة المسح وذلك لملاءمته لطبيعة البحث ، وتكونت عينة البحث من (9) لاعبين بالطريقة العمدية من مجتمع البحث والبالغ عددهم (12) لاعباً فئة المتقدمين ، وبذلك بلغت النسبة المئوية 75% من المجموع الاصلي ، واستخدم الباحث من المقابلة الشخصية وسيلة لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالبحث .

وعولجت البيانات احصائياً باستخدام الوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المئوية:

واستنتج الباحثون ما يأتي :

ان اغلب الاصابات التي تحدث في لعبة الجمناستك هي اصابات المفاصل بشكل عام ومفاصل (الكتف ورسغ اليد والكاحل) بشكل خاص .

اكثر انواع الاصابات شيوعاً هي الالتواء والتشنج .

اغلب الاصابات حدثت في الحركات الارضية والمتوازي .

اهم الاسباب التي ادت الى حدوث الاصابة هي عدم الاحماء الكافي .

(الصميدعي ، وآخرون ، 2004 ، 163)

ز - الفرضيات :

ز - 1 الفرضية الاساسية :

نظرا لكثرة تعرض الرياضيين بالعاصمة الى انواع مختلفة من الاصابات الرياضية في مختلف اطراف الجسم وقد أثار ذلك الموضوع اهتمام الباحث في محاولة معرفة ماهي انواع تلك الاصابات واسبابها وشدتها ومناطق حدوثها ومدى تأثيرها في أداء الرياضيين في الالعاب المختلفة ونسبة وجودها في كل لعبة .

ز - 2 الفرضيات الفرعية :

ز - 2-1 الفرضية الأولى : اسهام السلوك الرياضي في تحمل الآلام

ز - 2-2 الفرضية الثانية : دراسة المحددات النفسية للسلوك نحو اعتماد تجربة الألم

الفصل التمهيدي

ز -2-3 الفرضية الثالثة : علاقة الشخصية بالمعرفة الإجتماعية لاعتماد السلوكيات الوقائية

ز -2-4 الفرضية الرابعة : العلاقة بين الشخصية والضعف المتصور

ز -2-5 الفرضية الخامسة : هناك علاقة المحددات النفسية والتأثر المتصور من الإصابة

ح - المنهجية المتبعة في البحث :

ح-1 المنهج الوصفي :

استخدمت المنهج الوصفي بأسلوب المسح والذي يتلاءم مع طبيعة البحث.

الاستبيان: هو استمارة يعدها الباحث لخدمة موضوع بحثه وتحتوي على أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة وأسئلة شبه مفتوحة.

ح-2 مجتمع البحث وعينته :

ح-2-1 مجتمع البحث :

تتكون مجتمع البحث من الرياضيين الذين يمارسون الألعاب الرياضية في أندية الجزائر العاصمة للمواسم الرياضي 2009/2012، راجعوا مركز الطب الرياضي من تاريخ 2009/06/10 ولغاية 2012/03/10 والتي تكون اكثر ايام المنافسات واللقاءات الرياضية خلال الموسم الرياضي (10) نوادي والبالغ عدد لاعبيهم (1010) .

ح-2-2 عينة البحث :

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من الرياضيين الذين تعرضوا الى اصابة مختلف الاطراف من مجتمع البحث البالغ عددهم (1010) لاعباً والذين راجعوا مركز الطب الرياضي لاجراء الفحوصات لهم ومعالجتهم وكان عدد افراد عينة البحث (1010) يمثلون نسبة 100% من اصل مجتمع البحث مصابين بمختلف الاطراف وتراوح اعمار عينة البحث بين (12-75) سنة

ح-3 وسائل جمع البيانات :

قاما الباحث بتصميم استمارة معلومات عن الاصابات الرياضية وتم من خلالها مقابلة اللاعبين المصابين وقاما الباحث بالاتصال بالمدرسين والهيئات الادارية في الاندية الرياضية وابلاغهم بضرورة مراجعة اللاعبين المصابين الى المؤسسة الاستشفائية المختصة الدويرة لاجراء الفحوصات الطبية عليهم ومعالجتهم كل على انفراد لملئ الاستمارة الخاصة بالمعلومات وتتضمن ثلاثة محاور .

المحور الاول : يتضمن معلومات شخصية عن المصاب ويحتوي على (8) فقرات

الفصل التمهيدي

المحور الثاني : يتضمن معلومات عن الاصابة ويحتوي على (5) فقرات

المحور الثالث : يتضمن معلومات عن فحص الاصابة ويحتوي (4) فقرات كما في الملحق (3).

وعلى ضوء هذه المقابلة يحال المصاب الى الطبيب المختص لفحصه سريرياً والتأكد من نوع الاصابة وموقعها لتشخيص النهائي من قبل الطبيب المختص (ملحق 4) في مركز الطب الرياضي (EHS).

وقد حصلت على نسبة اتفاق لآراء الخبراء (الملحق 5) قدرها 100% ، وهذا يعني ان الاستمارة صادقة ، إذ تم التحقق من صدق الاستمارة وصحة المعلومات التي يقدمها المصابون عن طريق الطبيب المختص الذي يحالون اليه والذي أكد صحة الاصابة ونوعها ، ان الاختبار الصادق هو الذي يقيس ما وضع لقياسه .

ح-4. التجارب الاستطلاعية :

تم بتاريخ 2009/06/10 اجراء تجربة استطلاعية لفريق العمل (ملحق 4) وذلك باطلاعهم على كيفية تسجيل المعلومات المطلوبة في استمارة التسجيل .

قاما الباحث باجراء تجربة استطلاعية على عشرة مصابين ، وعلى الاستمارة الخاصة بها ، واحالة من هو مصاب فعلاً الى الطبيب المختص لمعرفة مدى امكانية توفر كل المعلومات المطلوبة في الاستمارة ومطابقة المعلومات التي يدلي بها المصاب مع الفحص السريري من قبل الطبيب المختص .

ح-5. التطبيق النهائي للبحث :

تم تطبيق البحث في المدة من 2009/06/10 ولغاية 2012/03/10 وفق ما يأتي :

1. تم تصميم استمارة معلومات عن الإصابات الرياضية التي يتعرض إليها الرياضيون في مختلف الأطراف وذلك استناداً إلى آراء السادة الخبراء والمختصين من الأطباء في مجال الطب الرياضي (ملحق 5) .

الفصل التمهيدي

2. تم ابلاغ جميع المدربين والاداريين والعاملين في الأندية الرياضية بالجزائر العاصمة لمراجعة مركز الطب الرياضي (EHS) لغرض حصر وتشخيص حالات الإصابة التي يعاني منها لاعبيهم لأغراض البحث العلمي .

3. تم حصر حالات الإصابة في مختلف الاطراف لدى افراد عينة البحث وتشخيص هذه الاصابات سريريا من خلال الطبيب المختص ودونت المعلومات في الاستمارة المعدة لهذا الغرض .

4. بعد اجراء الكشف الطبي تم تفريغ البيانات ومعالجتها احصائيا على وفق الأسس العلمية اللازمة وذلك من خلال تصنيف حالات الإصابة وموقعها وشدتها ونوعها واسبابها .

5. من خلال النتائج الاحصائية التي حصل عليها الباحث في الاجراءات السابقة تم التحقق من اهداف البحث ومناقشة النتائج في ضوء ذلك .

ح-6. المعالجات الاحصائية :

تم استخدام النسبة المئوية كمعالجة احصائية للحصول على نتائج البحث

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times 100$$

كما تم كذلك استخدام قيمة مربع كاي (كا2) كمعالجة احصائية للحصول على نتائج البحث :

$$\text{كا}2 = \frac{\text{مج (المشاهدة - المتوقع)}^2}{\text{المتوقع}}$$

المباني الأول

الجانب النظري

الفصل الأول

الجانب التشريعي

الفصل الأول الجانب التشريحي

1 عظام الطرف العلوي :

يتألف الطرف العلوي من العظام الآتية :

1. حزام الكتف : وهو يتألف من عظم الترقوة من الأمام وعظم لوح الكتف من الخلف.
2. عظم العضد .
3. عظام الساعد (الكعبرة والزند).
4. عظام الرسغ : وهي ثمانية .
5. عظام اليد : وهي الأمشاط (خمسة) والسلاميات (سلاميتان للإبهام وثلاث لبقية الأصابع) .

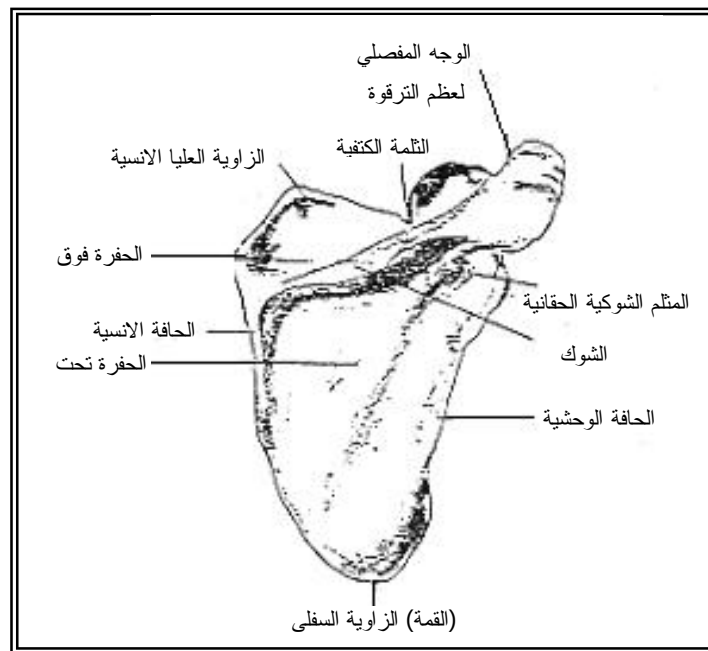
1-1. عظم لوح الكتف : (الشكل 1)

وهو عظم مسطح مثلث الشكل يقع على جدار القفص الصدري ما بين الضلع الثاني والسابع ويثبت بالعضلات . تكون قاعدة العظم الى الاعلى ورأسه الى الاسفل وللعظم ثلاث حواف وثلاث زوايا وسطحان .

الحافة الانسية وتكون موازية للعمود الفقري ، والحافة الوحشية تحوي في قسمها الاعلى التجويف الذي يرتبط به راس عظم العضد مكونة مفصل الكتف او المنكب . وبسبب ضحالة الحفرة الحقية وكبر راس عظم العضد فان هذا المفصل يتميز بحرية الحركة . ومن القسم العلوي للزاوية الوحشية ينشأ بروز يسمى النتوء الغرابي .

اما السطح الخلفي للعظم فيتميز بوجود عظم الشوك وهو عبارة عن بروز عظمي على شكل جسر مكوناً ما يشبه الرف ويقسم السطح الخلفي الى قسمين : الاعلى يسمى بالحفرة فوق الشوكية والاسفل بالحفرة تحت الشوكية . اما النتوء الآخر فينشأ من الشوك في نهايته .

الفصل الأول الجانِب التشرِيعي

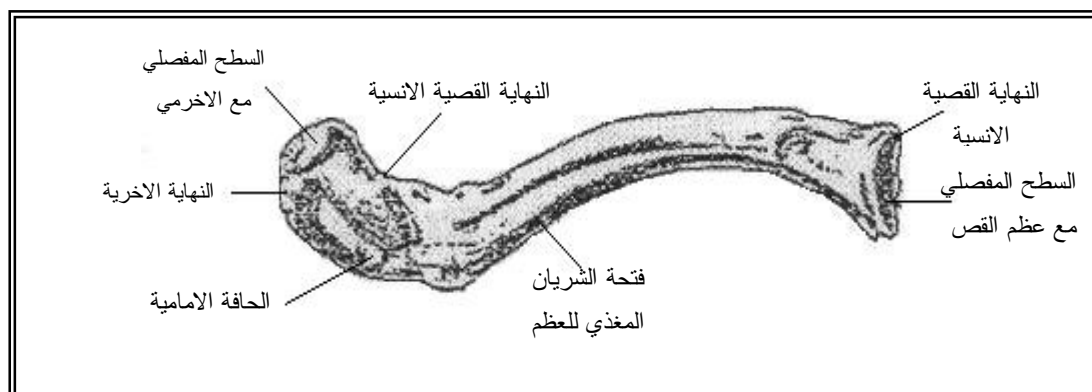


الشكل (1)

عظم لوح الكتف من الخلف

2-1- عظم الترقوة : (الشكل 2)

وهو عظم طويل ذو نهايتين يمتد بصورة أفقية في جذر الرقبة يتصل من الناحية الإنسية بعظم القص والنهاية الوحشية بالنتوء الأخرمي لعظم لوح الكتف ويسمى هذا الارتباط بحزام الكتف ويكون العظم على شكل حرف S حيث ان الثلثين الأنسيين المقعيرين الى الأمام والثلث الوحشي مقعر إلى الخلف.



الشكل (2)

عظم الترقوة

(الدوري ، 1980 ، 77)

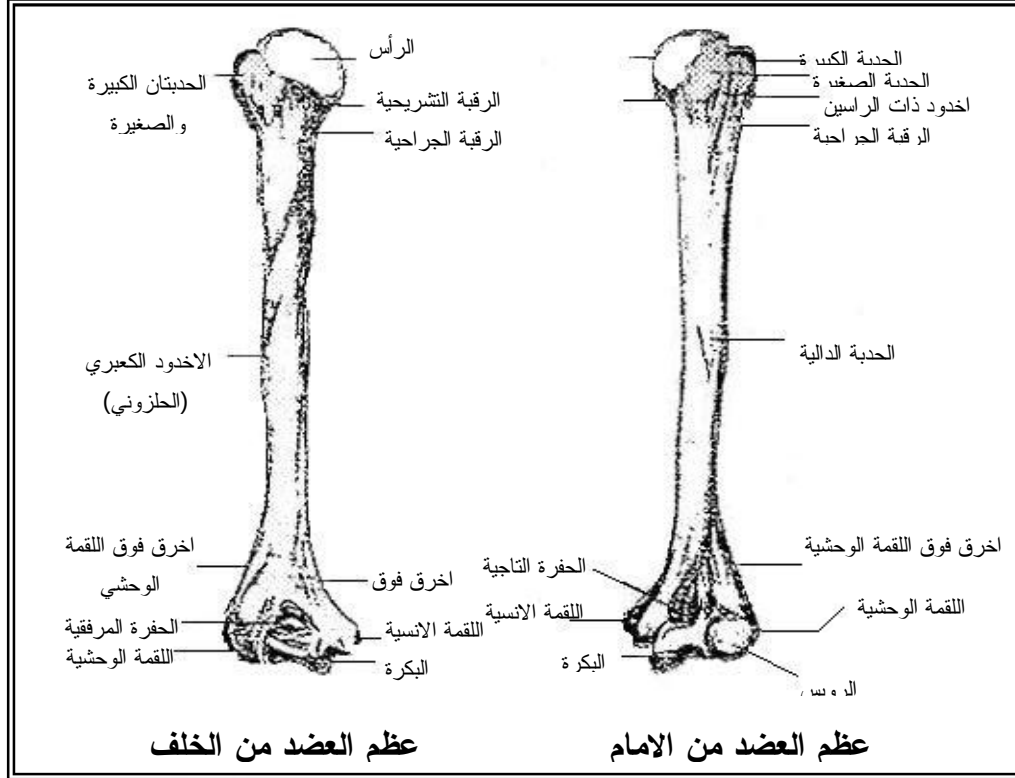
الفصل الأول الجانب التشريعي

الفصل الأول الجانب التشريحي

1-3- عظم العضد :

هو اطول عظام الطرف العلوي ويتألف من :

1. الرأس : وهو عبارة عن نصف كرة تقريباً .
2. الرقبة التشريحية .
3. الحديبتان الكبيرة والصغيرة تتصل بهما عضلات مهمة .
4. اخدود ذات الراسين ويقع بين الحديبتين .
5. الجسم وهو اسطواني في الشكل ينتهي باللقمة الانسية والوحشية . وفي السطح الخلفي يوجد اخدود ضحل يستقر فيه العصب الكعبري وفي منتصف العظم في جهته الوحشية يوجد الحدة الدالية .
6. النهاية السفلى : يحتوي على البكرة التي تتفصل مع عظم الزند والرويس الذي يتمفصل مع عظم الكعبرة . ويوجد فوق البكرة انخساف امامي يسمى بالحفرة التاجية وانخساف خلفي يسمى بالحفرة المرفقية .



الشكل (3)

الفصل الأول الجانب التشريحي

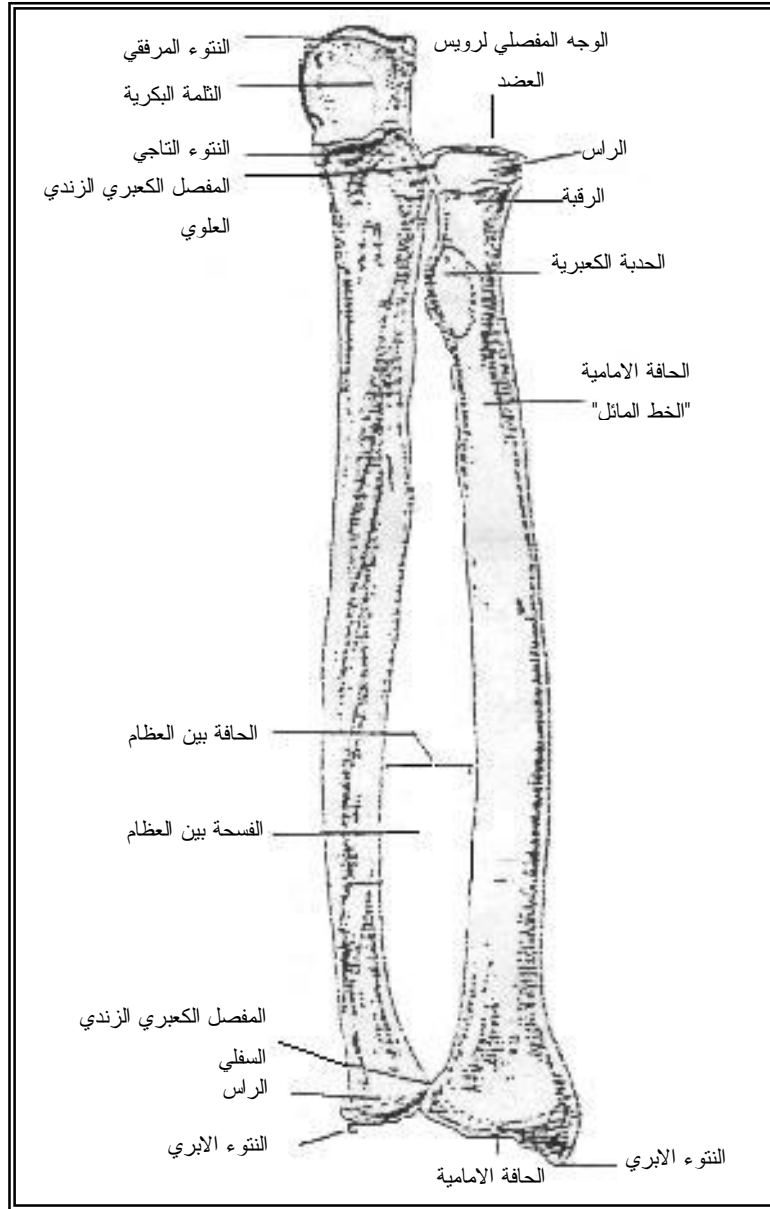
عظم العضد من الإمام والخلف

1-4- . عظم الكعبرة : (الشكل 4)

وهو العظم الوحشي من عظمي الساعد ويتكون من :

1. الرأس ويكون املساً ومدوراً وعلى شكل قرص يتمفصل مع رويس عظم العضد .
 2. الرقبة .
 3. الحذبة الكعبرية وهي مركز اتصال العضلة ذات الراسين العضدية .
 4. الجسم .
 5. النهاية السفلى وهي اكبر اجزاء العظم وتمتاز بوجود النتوء الابري . تتمفصل النهاية السفلى مع عظام رسخ اليد (Cunning , 1981,5-6) .
- جسم الكعبرة دقيق من الاعلى ويبدأ بالازدياد كلما اتجهنا للأسفل الى ان يصل حجمه الأسفل ضعف حجمه الأعلى (Cunning , 1981,6-7) .

الفصل الأول الجانب التشريحي



1-5- عظم الزند : (الشكل 4)

الشكل (4) عظام الساعد من الامام (الكعبرة والزند)

وهو العظم الانسي من عظام الساعد ويمتاز بوجود ثقب كبير في نهايته العليا يسمى بالتلمة البكرية ، وجزؤه العلوي يسمى بالنتوء المرفقي ، وجزؤها السفلي يسمى بالنتوء التاجي. يستقر النتوء المرفقي في الحفرة المرفقية والنتوء التاجي في الحفرة التاجية والثقب

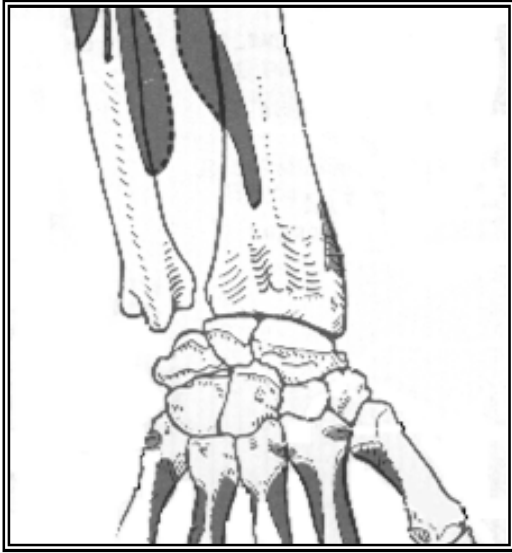
الفصل الأول الجانب التشريحي

يستقر فوق البكرة مكوناً مفصل المرفق . ويحتوي عظم الزند على جسم ونهاية سفلى تمتاز بوجود نتوء ابري صغير وتتمفصل ايضاً مع عظام رسغ اليد .

(Essential of Human Anatomy, 1999,35-36)

1-6- - عظام رسغ اليد : (الشكل 5)

وهي ثمانية عظام منتظمة في صفين ، اربعة عظام في الصف الخلفي للكعبرة واربعة عظام للصف الامامي المجاور لمشط اليد ، وكل عظم ينزلق على العظم المجاور ، ومرتبطة ببعضها البعض برابط ليفي، وكل صنف ينزلق على الآخر بشكل أسهل مما ينزلق عظام



الصف الواحد على بعضها البعض وقد سميت كل عظمة بأسم يناسب شكلها، وهكذا في الصف الخلفي (السطح القريب والعلوي) يتكون من :

1. العظم الزورقي .
2. العظم الحمصي .
3. العظم المثلي .
4. العظم الهلالي .

اما الصف الامامي (السطح البعيد والسفلي)

يتكون من :

1. العظم المربع المنحرف .
2. شبه منحرف .
3. الكبير .
4. الكلابي .

الشكل (5)

عظام رسغ اليد

(Thibodeau & Patton, 2000, p. 115)

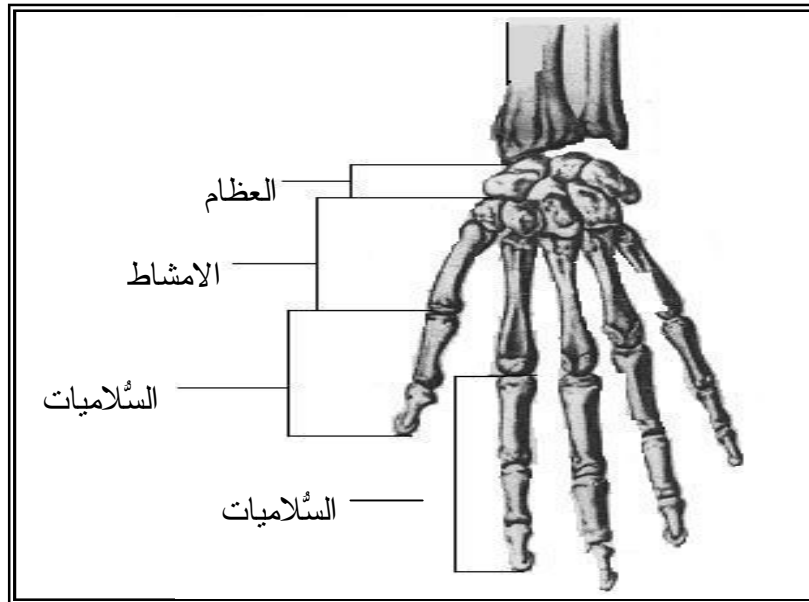
الفصل الأول الجانب التشريحي

7-1. عظام مشط اليد : (الشكل 5)

وهي خمسة عظام متطاولة ذات قاعدة مربعة الشكل ، ورأس متطاول ودائري ، وبينما تتصل القواعد بعضها ببعض فان الرؤوس غير متصلة مما بينها فيما يجعلها تسير باتجاه منفرد آخذة شكل المروحة ، ويلاحظ ان عظمة الإبهام أسهل حركة وأكثر من بقية عظام المشط وذلك بسبب سطحها المفصلي الذي يشبه السرج ، وتتصل رؤوسها بسلاميات الأصابع ، يتم فصل المشط الأول مع المربع المنحرف ، والثاني مع شبه المنحرف والثالث مع الكبير والرابع والخامس مع الكلابي (Cunningham, 1981,8) .

8. السلاميات :

جميع الاصابع باستثناء الإبهام لها ثلاث سلاميات . قاعدة السلاميات الجذعية مقعرة لتلائم رؤوس عظام المشط ، وفيما بين السلاميات سطوح لينة تسمح بالثني والمد ولكن لا تسمح بأية حركة أخرى . ونهاية السلاميات الطرفية منبسطة ومثلثة الشكل وهي حرة وتشكل قاعدة للاظافر (Cunningham,1981, 9) ، انظر الشكل (6) .



الشكل (6)

عظام مشط اليد

(اكاديميا ، 1998 ، 12)

الفصل الأول الجانب التشريعي

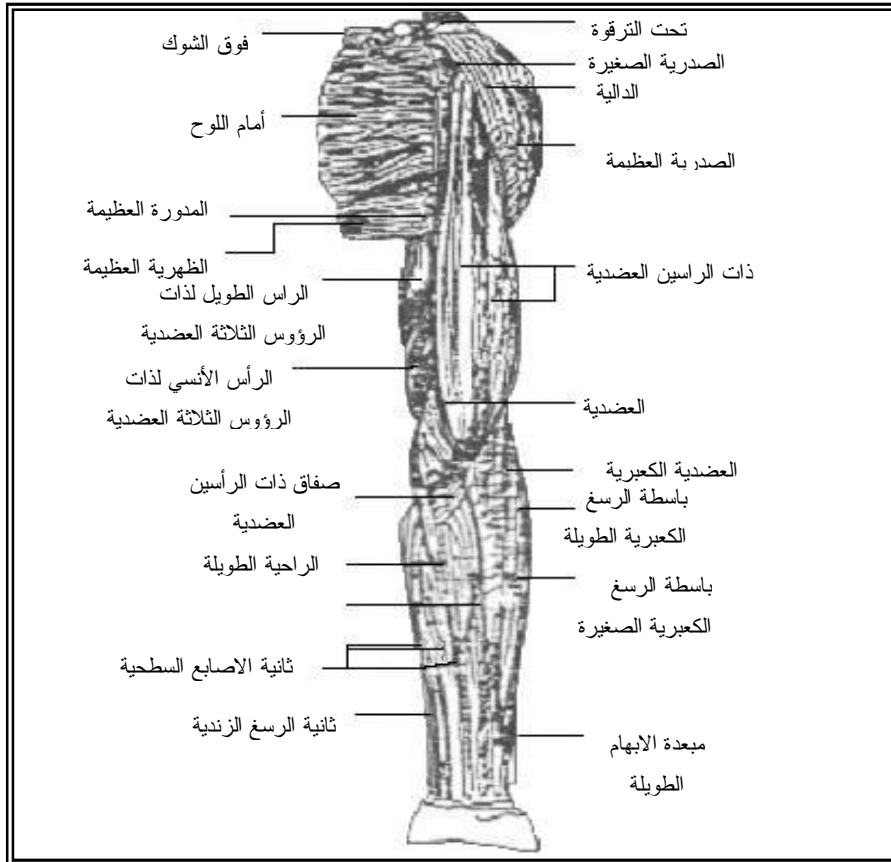
الفصل الأول الجانب التشريحي

2- عضلات الطرف العلوي :

وتشمل المجاميع الآتية :

1. العضلات التي تربط الطرف العلوي بالجذع (القسم الامامي والجانبى والخلفى للصدر) وهي عضلات حزام الكتف .
2. العضلات التي تربط حزام الطرف العلوي بالذراع والساعد .
3. العضلات التي تربط الذراع بالساعد .
4. العضلات الكابة والطارحة .
5. العضلات التي تحرك الرسغ والاصابع .

وفي هذا البحث تم أخذ إصابات العضلات حسب منطقة الإصابة مثلاً في الكتف او العضد او الساعد او اليد ولم يتم أخذ إصابات العضلات حسب العضلات المفردة وعلى هذا الأساس لم يتم شرح العضلات الموجودة في الطرف العلوي كل على حدة ، انظر الشكل (7).



الشكل (7)

عضلات الطرف العلوي

الفصل الأول الجانب التشريحي

1-2- مفاصل الطرف العلوي :

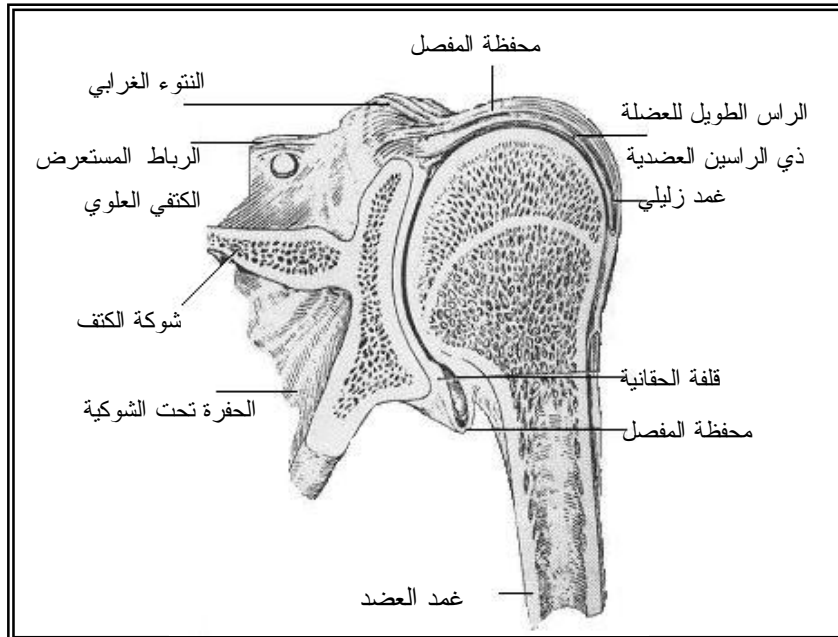
تعد مفاصل الطرف العلوي من المفاصل الزليلية ، ويكون الجزء الكبير من مفاصل الجسم خاصة الاطراف العليا والسفلى وهي اكثرها حركة ، ويتكون المفصل الزليلي النموذجي من الاجزاء الآتية :

1. السطح المفصلي للعظم ناعم وأملس ومغطى بغضروفه زجاجية .
2. يحاط المفصل بمحفظة من النسيج الليفي تتصل بالعظام المنفصلة على مسافة خارج السطوح المفصالية .
3. هناك اربطة تحيط بالمحفظة من الخارج لتقوية المفصل ولتساعد على ثباته واستقراره .
4. الغشاء الزليلي: وهو غني بالاووعية الدموية ويبطن المحفظة من الداخل وللنسيج الزليلي وظيفتان :

- أ. يجهز المفصل بالاووعية الدموية بواسطة الغشاء الزليلي .
- ب. يفرز السائل الزليلي من الغشاء الزليلي الذي يعمل على تزييت المفصل ومنع الاحتكاك. وتغذية النهايات العظروفية لعظام المفصل حيث تكون خالية من الاوعية الدموية.

2-2- مفصل الكتف : (الشكل 8)

وهو احد المفاصل الزليلية (من نوع الكرة والحق) يتكون من تمفصل الرأس الكبير لعظم العضد مع الحفرة الحقائية المسطحة والصغيرة نسبياً ويسمح هذا التكوين بحركة الذراع



ودورانه لجميع الجهات ، وان كبر رأس عظم العضد نسبة الى صغر وتسطح الحفرة الحقائية يزيد من مجال حركة المفصل وفي الوقت نفسه يقلل من متانته ويزيد من

الفصل الأول الجانب التشريحي

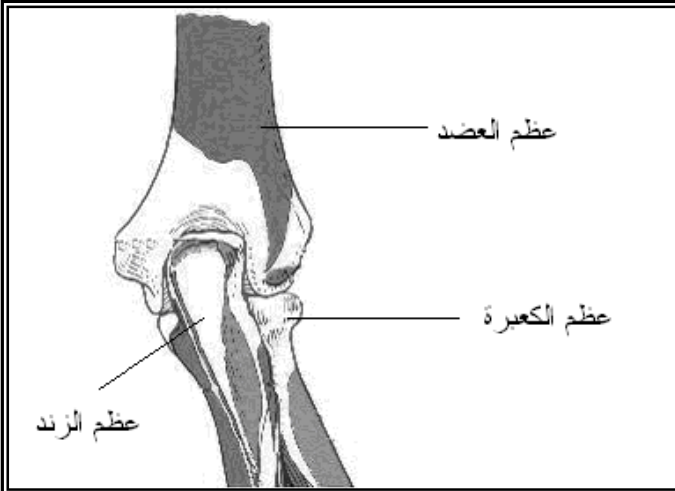
امكانية حدوث الخلع فيه (35-36 , last.1973)

تحيط بالمفصل من الخارج محفظة تتصل براس عظم العضد وبحافة الحفرة الحقائية اتصالاً رخواً وغير مشدود ويتدلى قسم من المحفظة اسفل المفصل .
كما يوجد رباطان رئيسان يقومان بمهمة ربط عظم اللوح مع عظم العضد وهناك رباط ثالث اعلى عظم اللوح وفوق المفصل مباشرة مما يعطيه تعزيزاً من الاعلى ، وتؤدي العضلات فضلاً عن الارتبطة دوراً مهماً في تقويته حيث توجد احدى عشرة عضلة تحيط به من جهاته المختلفة .

2-3- مفصل المرفق : (الشكل 9) :

وهو مفصل زليلي وحيد المحور يعمل بوساطة مجموعة من العضلات والاربطة المحيطة بها ان الحركات التي يقوم بها وهي الثني والمد والطرح للساعد ويمكن دوران عظم الكعبرة حول عظم الزند في حركتي الكب والمد والثني .
يتكون هذا المفصل من التقاء عظم العضد مع عظمتي الساعد (الكعبرة والزند) وبالتقاء هاتين العظمتين ، تتكون ثلاثة مفاصل هي:

1. المفصل بين عظم العضد وعظم الكعبرة حيث يتمفصل رويس عظم العضد مع راس عظم الكعبرة .
2. المفصل بين عظم العضد وعظم الزند حيث تتمفصل بكرة عظم العضد مع الثلمة البكرية لعظم الزند .
3. اما المفصل الثالث فيتكون من التقاء راس عظم الكعبرة مع الحفرة السينية الصغرى لعظم الزند .



4. تحيط بالمفصل محفظة ليفية تتقوى بالاربطة وهناك المحفظة الزليلية التي تبطن المحفظة الليفية ، وتوجد بين المحفظتين في الجزء العلوي من الحفرة المرفقية وسادة

الفصل الأول الجانب التشريحي

دهنية وكيس زليلي يفصل بين وتر العضلة العضدية ذات الرؤوس الثلاثة وبين المحفظة الليفية حيث تقلل من الصدمات التي تقع على المفصل من الخلف ، ويتعرض هذا المفصل الى الرضوض على النتوءات الحادة.

2-4- مفصل الرسغ : (الشكل 6)

هو التمثيل بين النهاية السفلى المتسعة لعظم الكعبرة والقرص المفصلي المثلث الشكل مع ثلاثة من عظام الصف العلوي لعظام الرسغ المكونة قوساً تحديه الى الاعلى ولا يشترك عظم الزند مباشرة في تكوين هذا المفصل لذا يسمى بالمفصل الكعبري الرسغي Radio-Carpal Joint.

وهذا المفصل هو من المفاصل الزليلية الاهليلجية ويتحرك كل انواع الحركات الرئيسية ما عدا الدوران حول محوره الطولي واكثر الحركات حدوثاً بدرجة كبيرة هي البسط في هذا المفصل بالنسبة للحركات الاخرى .

2-5- مفصل السلاميات :

وهي مفاصل زليلية تسمى بالمفاصل الرزية وتكون مثالية التركيب حيث تتألف من عظمين احدهما : ذو نهاية مقعرة ، والآخر ، ذو نهاية محدبة ويغلفان بمحفظة وغشاء زليلي وتكون حركة المفصل بمستوى واحد (ثني وبسط) Essential of human an (atomy,1999,28) .

2-6- إصابات الركبة

إن مفصل الركبة عادة ما يوصف بأنه المفصل الأكبر والأكثر تعقيداً في الجسم البشري وهو أيضاً واحد من أكثر المناطق الجسمية تعرضاً للإصابات خصوصاً في المجال الرياضي وهو بهذا يكون واحد من المراكز الصعبة التقييم والتشخيص للإصابات ومفصل الركبة بين أطول العظام ولهذا يكون معرضاً لقوى ضغطية كبيرة وحمل بدني شديد خلال الأداء الرياضي، وبهذا يحتل مكاناً بارزاً في حصول على الإصابات الشديدة أو البسيطة المتكررة.

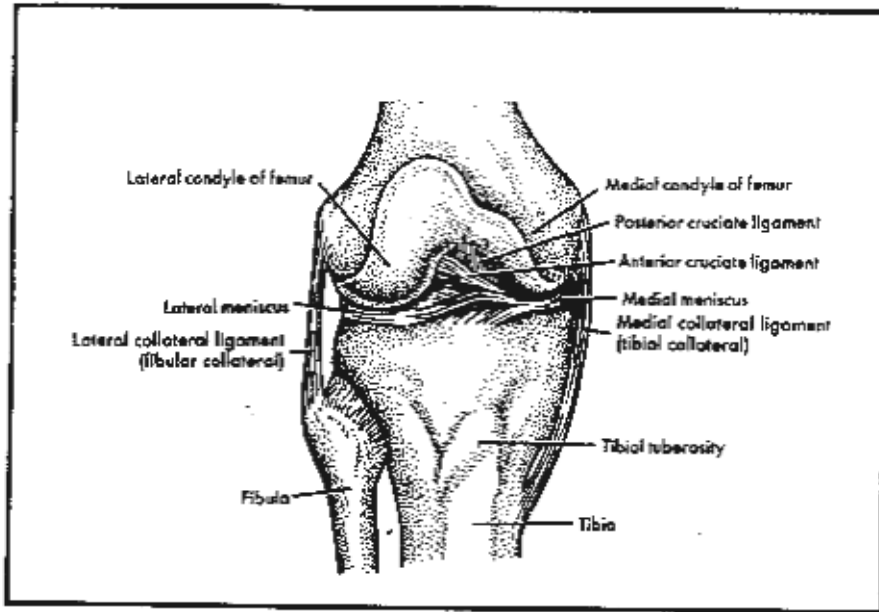
2-7- تشريح مفصل الركبة:

الفصل الأول الجانب التشريحي

مفصل الركبة هو من المفاصل اللقيمة تشترك ثلاث عظام في تكوينه وهي لقمتي عظم الفخذ ولقمتي عظم الظنوب القصبو والشظية، وبين سطوحهما المفصالية تقع الغضاريف الهلالية إثنان مع عظم الرضفة الذي يتمفصل مع السطح الأمامي للقمتي عظم الظنوب ليدور ويتزحلق عليها السطح السفلي للقمتي عظم الفخذ.

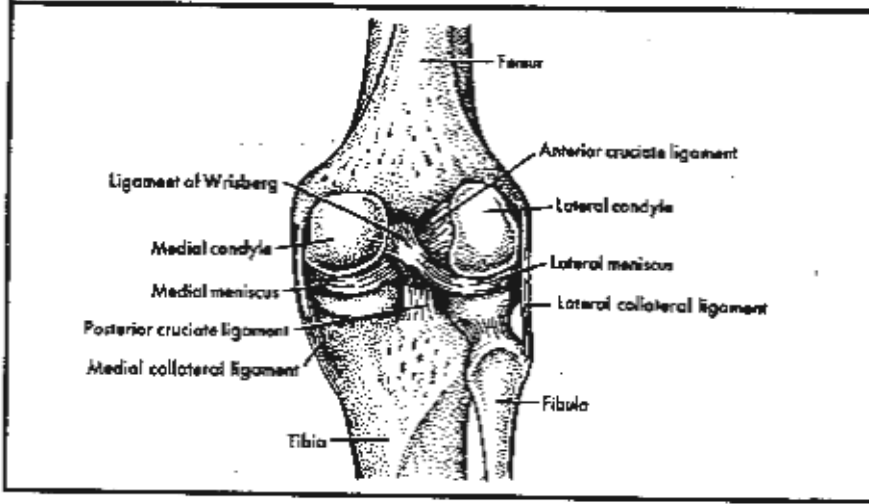
إن كل غضروف عبارة عن صفيحة منحنية على شكل هلال متحرك تقع على جوانب السطح المفصلي للقمتي عظم الظنوب لتزيد من تقعره وتكون سميكة في محيطها الخارجي أكثر من محيطها الداخلي في منتصفها.

تتكون هذه الغضاريف في معظمها على شكل اسفين سميك في حافته الخارجية ورقيق في حافته الداخلية. ولكون شكل الغضروفة هلالية لا تغطي كل السطح العلوي المفصلي للقمتي عظم الظنوب بل تستقر بحفرة مشابهة لشكلها تقريبا ويرتبط محيطها الخارجي بعظم الظنوب بل تستقر بحفرة مشابهة لشكلها تقريبا ويرتبط محيطها الخارجي بعظم الظنوب وبمحفظته المفصل شكل رقم 1-16 وشكل 2-16



شكل رقم (١٦ - ١)

الفصل الأول الجانب التشريحي



شكل رقم (١٦ - ٢) يوضح مفصل الركبة اليمنى من الخلف

وممكن لكل غضروفة نهايتين ليفيتين في التركيب تسمى بالقرن تفصل الغضروفة بواسطة هذين القرنين بالفسحة الأمامية والخلفية الموجودة بين السطحين المفصليين على السطح العلوي للقمتي عظم الظنوب.

ويكون السطح العلوي والسفلي لكل غضروفة أملس وناعم ومفصلي حيث يقع بين لقمتي عظم الفخذ وعظم الظنوب أن الغضروفة الوحشية كبيرة ودائرية الشكل لأن قرنيها يرتبطان متقاربين بالفسحة الأمامية والخلفية، أما الغضروفة الانسية فتكون أصغر وشكلها هلالى لأن قرنيها يرتبطان متباعدين بالفسحة الأمامية والخلفية للسطح العلوي للقمتي الظنوب.

وتتعرض هاتان الغضروفتان وخاصة الغضروفة الانسية منهما للتمزق أو الانفصال من عظم الظنوب في حالة الوقوف أي القدم على سطح الأرض فإن الحركة المفاجئة الدورانية قد تجعل لقمتي عظم الفخذ تستحق أو تلوى هذه الغضاريف وهذا التمزق أو الازاحة من موضعها يحدث غالبا عند لاعبي كرة القدم الشبان وعند حاملي الأثقال.

الفصل الأول الجانب التشريحي

يحاط المفصل بمحفظة غير كاملة لأقسامها الأمامي يحل محله وتر العضلة الفخذية ذات الرؤوس الأربعة الرصفة والرباط الرضفي ، أن قسما من الغشاء الزلالي الذي يبطن المحفظة يكون حواجز تفصل الأوتار والعضلات أو الأوتار على العظام. وبداخل المفصل يوجد رباطان متقاطعان يسميان الرباطين المتقاطعين أو المتصالبين وهي أربطة مدورة وقوية توجد بين لقمتي عظم الفخذ وتساعد في ربط عظم الفخذ بعظم الظنوب. وظيفتهما الرئيسية إعطاء الثبات للمفصل ومنع تزلزل العظمين أحدهما على الآخر للأمام وللخلف وتتقوى المحفظة من كل جهة برباط وهما في الجهة الوحشية الرباط الوحشي وهو رباط مدور قوي على شكل حبل ترتبط به من الأعلى للكمة الوحشية لعظم الفخذ ومن الأسفل يرتبط برأس عظم الشظية، ويقسم هذا الرباط وتر العضلة الفخذية ذات الرأسين إلى قسمين غير متساويين عن ارتكازهما كما يفصل عن المحفظة بقليل من الدهن الرباط الانسي. أما الرباط الانسي فهو أقوى وأوسع من الرباط الوحشي يرتبط من الأعلى بلكمة عظم الفخذ ومن الأسفل بلكمة عظم الظنوب ويرتبط أيضا بمحفظة المفصل ومن خلاله بالحافة الخارجية للغضروف الانسية الهلالية وتتقوى المحفظة من الخلف بامتدادات من أوتار بعض العضلات، لذا فإن مفصل الركبة من جهاته الأربعة وهذا ما يعطي الثبات للمفصل أثناء الحركة وتحمل وزن الجسم.

2-8- حركة مفصل الركبة:

في حركة الثني والمد في مفصل الركبة تدور وتترحلل لقمتي عظم الفخذ للأمام وللخلف على لقمتي عظم الظنوب وتساعد السطوح الملساء للغضروفين الهلاليين في هذا الترحل في القسم الأخير من حركة البسط و المد .

إن مجال الثني هو 40 درجة لأن الثني يتحدد بتماس عضلات حمأة الساق مع عضلات الفخذ الخلفية كما في حالة الجلوس على الركبتين المثبتتين أما مجال المد فهو 180 درجة حيث يكون الساق مع الفخذ خطأ مستقيما.

إن الثني لمجال حوالي 15 درجة تقريبا من وضع المد التام لمفصل الركبة مع بقاء الظنوب ثابتا ورسوخ القدم على الأرض تختفي فيها حركة تدوير لقمتي عظم الفخذ على لقمتي عظم الظنوب ويدور عظم الفخذ للجهة الانسية بتزحلل للكمة الانسية للخلف مع بقاء

الفصل الأول الجانب التشريحي

اللزمة الوحشية ثابتة وهذا الدوران القليل للجهة الانسية يسمح بالمد التام يكون لمفصل الركبة ويمنع الشد في الرباط الصليبي الأمامي والرباط المائل الخلفي ويكون المد أكثر في هذا المجال لأن الدوران لعظم الفخذ يقلل المفصل ولا يحدث هذا الدوران للجهة الأنسية إلا عندما يكون عظم الظنوب ثابتا مع رسوخ القدم بشدة على الأرض. أما عندما يكون القدم مرفوعا عن الأرض فإن عظم الظنوب يدور للجهة الوحشية وتترحل كل من لقمته والغضروفين على لقمته عظم الفخذ.

إن خط الجاذبية لحمل وزن الجسم يمر أمام المحور المستعرض لمفصل الركبة وهذا الخط يتغير موضعه باستمرار أثناء الحركة. ففي حالة الوقوف الساكن فإن ثقل الجذع يحاول أن يبسط المفصل (مدا) زائدا عن المجال الطبيعي.

أما في بداية الثني فهي حركة تفتح انقفال المفصل ويحدث عكس ما يحدث في أفعالها كما ذكرنا آنفا حيث يتم الدوران لعظم الفخذ للجهة الوحشية على عظم الظنوب وتقوم العضلة المأبضية بهذا العمل.

2-9- عظم الرضفة:

إن عظم الرضفة هو أكبر عظم سمسمي متولد في وتد العضلة الفخذية الرؤوس الأربعة وهو عظم فير مسطح ومثلث الشكل قاعدته للأعلى وقمته المدببة إلى الأسفل يقع أمام مفصل الركبة وله سطحان أمامي يتصف بتحدبه وعليه الشريان المغذي والسطح الآخر خلفي عليه وجه مفصلي ومقسوم بخط شاقولي إلى قسمين انسي ووحشي يكون القسم الوحشي أكبر وأعمق من القسم الانسي.

إن عظم الرضفة يشترك في تكوين مفصل الركبة بتمفصله مع القسم العلوي للسطح المفصلي للنهاية السفلى لعظم الفخذ. إن عظم الرضفة كما ذكرنا هو أكبر عظم سمسمي والتي تتكون بداخل أوتار العضلات بالقرب من المفاصل. وللظام السمسمائية وظائف عدة منها:

أنها تقوي الأوتار العضلية.

تساعد في توجيه الوتر عند مروره بالمنحيات.

الفصل الأول الجانب التشريعي

تمنع احتكاك الوتر بالعظام

كذلك يلعب عظم الرضفة دور الدرع العامي للسطح الأمامي للسطح الأمامي لمفصل الركبة، وبالنظر لتحرك هذا العظم فإنه نادرا ما يصاب بكسر على الرغم من أن مكانه عرضة للاصابة كما يمكن أن ينسلخ من الجسم دون أن يؤثر تأثيرا كبيرا على فعالية مفصل الركبة لذا فهو ذو أهمية قليلة في ثبات واستقرار مفصل الركبة.

هناك أيضا 13 كيس زلالي تعمل كوسادة حول مفصل الركبة، أربعة منها أمامية، أربعة جانبية، وخمسة أنسية، وهذه الوسائد عادة ما تصاب وتلتهب نتيجة الضربات المباشرة المفصل الركبة، أو الكسور التي تحصل بين تراكيب الركبة، ولكن هذه الوسائد لا تصاب دائما، ولكن الوسادة أو الكيس الزلالي الأكثر تعرضا للاصابة هو الكيس الرضفي والذي يقع بين الرضفة وجلد الركبة. وهذا يعتبر أكبر كيس يتعرض للاصابة بالضرب المباشر وهناك أحيانا تحدث حالة تورم المتكرر للكيس الرضفي بسبب تكرار السقوط على الركبة أو الاصابة المباشرة للرضفة، وهذه حالة إصابة سهلة التقييم بسبب كبر حجم السائل الذي يتجمع بين الجلد والرضفة.

وفي بعض الأحيان يحدث تورم لهذه الوسائد اللينة خصوصا في المنطقة الخلفية للركبة والتي عندما تحدث نشير إلى حصول إصابة في المنطقة وأعراضها التضخم، النعومة، انعدام الألم في كل المنطقة اللينة.

وهذه الوسائد ربما تتصل بالتجويف المفصلي، والورم يخنقي ويظهر. والسبب في تورم هذا المكان هو الاصابة المزمنة للركبة، النضج الداخلي، معاودة الانصباب المفصلي، أو ربما ورم اعتيادي خلف الركبة.

أما الاصابات التي تشمل الرضفة فهي كثيرة بعضها خلع الرضفة من مكانها بشكل كامل. أو الاصابة الأكثر شيوعا هي الخلع البسيط خلال الأداء الرياضي. إن الحركة تكون تقريبا كلها جانبية حينما تنزلق الرضفة على الجزء الجانبي والخلع الجزئي يصاحبه دوما ما يلي:

تشوه ولادي.

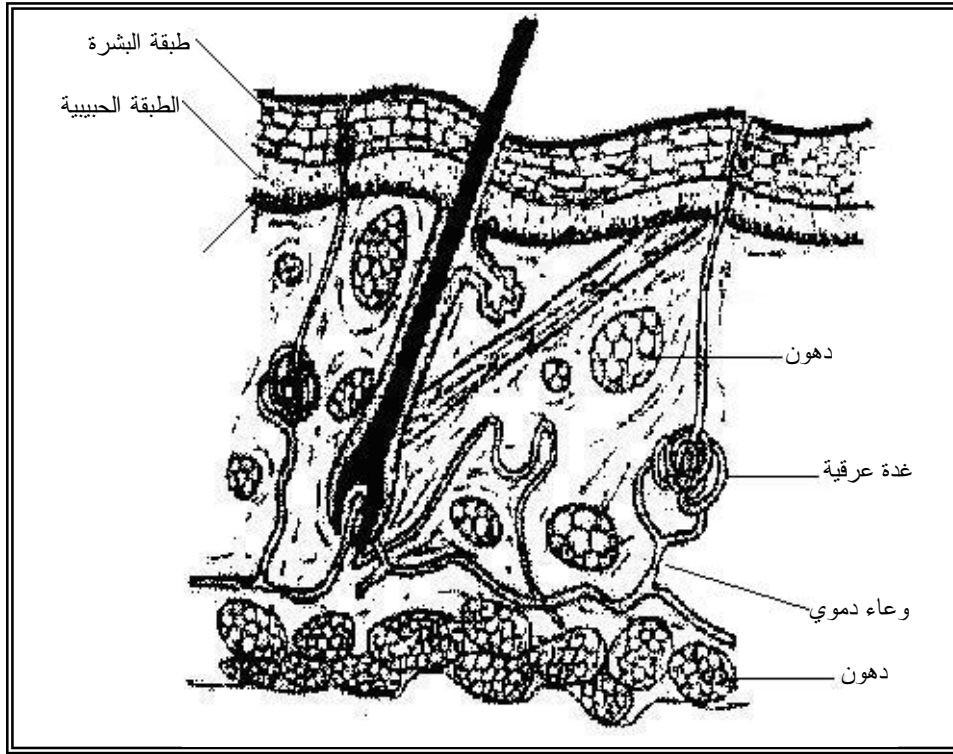
أو ضرر متراكم لميكانيكية عمل العضلة الرباعية الرؤوس الفخذية.

الفصل الأول الجانب التشريحي

والتشوه الولادي يشمل تجويف رضفي ضحل، رضة غير اعتيادية الشكل والتكوين، أو أن الرباط الرضفي متصل جانبيا وكذلك مطاطية الرضة، أو الركبة الساقطة والنساء تعاني كثيرا من هذه المواصفات وذلك بسبب سعة عظام الحوض لديهن. وكذلك اندفاع عظم الفخذ للداخل وفي كلا الجنسين فإن تحرك الرضة يحدث غالبا عندما تكون الركبة منتثية بين 20-45 درجة مئوية.

3- الجلد:

هو السطح الظاهري للجسم ويكسو العضلات وينقسم إلى طبقتين :
1. البشرة : وهي الطبقة الظاهرة تكون خالية من الأوعية الدموية والأعصاب وتكون دقيقة وتتركب من خلايا موضوعة فوق بعضها تسقط في بعض الاصابات على هيئة قشور. والبشرة شفافة لدرجة أن المادة الملونة الموجودة بجلد الانسان والتي تكسبه اللون الأبيض أو الأصفر أو الأسود أو الفحامي .



الشكل (10)

مقطع عرضي في الجلد

الفصل الأول الجانب التشريحي

3-1- الطبقة البطانية (الأدمة) : طبقة متصلة بالنسيج الخلوي تحت الجلد والتي تحتوي اعصاب وأوعية دموية عديدة ولها كثافة مختلفة لأجزاء الجسم فيختلف فيها سمك تلك الطبقات باختلاف وظيفة الجزء المستخدم وموقعه في الجسم ، أما الافرازات التي نشاهدها على سطح الجلد فهي صادرة من غدد التعرق والغدد الدهنية الموجودة في جميع اجزائه وتمنع انفصال الخلايا البشرة الجلدية

ويعمل الجلد على حماية الأجهزة الداخلية من الميكروبات والفايروسات الموجودة في البيئة المحيطة بالجسم البشري والتي تمنع فقدان السوائل ، ويعمل الجلد على تنظيم درجة حرارة الجسم (الشكل 10) .

4- الاصابات الرياضية :

4-1. تعريف الإصابة الرياضية:

هي تغيير تشريحي أو فسيولوجي يحدث في بعض أنسجة الجسم أو أعضائه (Litton 1979, 16) ، وتعرف كذلك بأنها : خلل يصيب عضواً أو أكثر من أعضاء جسد الرياضيين خلال التمرينات أو المباريات مما يؤدي إلى تعطيل هذا العضو بشكل مؤقت أو دائم عن القيام بالوظيفة الطبيعية له .

وكذلك هي تأثر نسيج أو مجموعة من الأنسجة بمؤثر خارجي أو داخلي أو ذاتي مما يؤدي الى تعطيل عمل او وظيفة ذلك النسيج .

- المؤثر الخارجي : مثل اصطدام اللاعب بزميله أو بالأرض أو بالأدوات .
- المؤثر الذاتي : هو إصابة اللاعب نفسه بنفسه نتيجة الأداء الخاطئ أو قلة الاحماء
- المؤثر الداخلي : مثل تراكم حامض اللبنيك في العضلات أو التعب الشديد والإجهاد وفقدان الماء والأملاح .

كما عرفت بانها : عبارة عن حادث مفاجئ موجه الى احد أجزاء الجسم مما ينتج عنه تغيير في صفاته التشريحية وخصائصه الوظيفية .

4-2. أسباب الإصابة الرياضية:

ان اصابات الرياضيين تختلف من حيث طريقة حدوث تلك الإصابة كما ان نوع الإصابة تختلف باختلاف نوع الرياضة فاصابات الالعاب الفردية تختلف عن اصابات الالعاب

الفصل الأول الجانب التشريعي

الجماعية وكذلك في الالعب ذات الاحتكاك المباشر عنها في الالعب التي ليس فيها مثل هذا الاحتكاك وهناك اسباب عديدة تؤدي الى اصابة اللاعبين منها :

4-2-1- سوء الاحماء الرياضي : تؤكد اغلب البحوث العلمية على ضرورة الاحماء الرياضي والذي يعد دخولاً الى قمة الاعداد الفسيولوجي للاعب ، في سبيل تقليل اصابات الملاعب وكذلك له دوره في اعداد الجهاز العصبي للأداء الرياضي التنافسي وزيادة ردة الفعل الانعكاسي العصبي وبالتالي سرعة انقباض العضلات وكذلك تحسين الدورة الدموية بزيادة ضخ القلب ، كما يزيد كفاءة العضلات لتصبح اكثر مرونة ومطاطية وتزيد من ليافتها البدنية .

4-2-2- سوء المستلزمات الرياضية :

- عدم ملائمة ارضية الملعب مثل وجود عوائق في الارض او عدم استوائها او وجود اجسام صلبة فيها او رشها بالمياه بطريقة خاطئة حيث يذكر ان ارضية الملعب تعد عاملاً من العوامل الرئيسة في حدوث الاصابة الرياضية فكلما كانت ارضية الملعب شديدة الصلابة ازدادت حالات الاصابة وان ارضية الملاعب المصنوعة من الخشب او ذوات الخواص المطاطية تكون من افضل الارضيات لبعض انواع الرياضيين (Andrea , 1984,5).

- سوء اختيار الحذاء المناسب حيث ان لكل فعالية رياضية نوعية خاصة تلائم ارضية الملعب التي تمارس عليها الفعالية بحيث يستطيع الرياضي التحرك بسهولة وتثبيت جيد .
- عدم الاستخدام الصحيح والمناسب للأدوات الرياضية وحسب نوع اللعبة فيجب ان يكون هناك تناسب بين عمر اللاعب والادوات المستخدمة في نشاطه الرياضي.

1. وتحدث الاصابات الرياضية نتيجة جهد عال على الجهاز الحركي ويتركز على الاطراف العليا والسفلى وحسب نوع اللعبة كما تم تحديد البرنامج التدريبي الشامل من حيث الراحة والنوم ونوع الغذاء المناسب والتأقلم الحراري وذلك من خلال تخطيط ايقاع أنشطة الجسم وفقاً في دورة الايقاع الحيوي اليومي للجسم ولعدم وصول اللاعب للارهاق ، ودراسة الدورات البيولوجية الفردية لمنع الاصابات الرياضية والوصول الى اعلى مستوى في الاداء .

الفصل الأول الجانب التشريعي

2. مخالفة القوانين الرياضية حيث ان الهدف من القانون الرياضي هو حماية اللاعب وتأمين سلامته ومخالفة هذه القوانين تؤدي الى حدوث إصابات كما ان مخالفة المواصفات الفنية والقانونية بملابس اللاعبين والادوات الرياضية تسبب اصابات اللاعبين.
3. هبوط في مستوى الاداء الممارس واطفاء في التكنيك قد يتسبب في حدوث تمزق العضلات ورضوض داخلية تؤدي الى اثاره الانسجة العضلية .
4. سوء تخطيط البرنامج التدريبي فمثلاً يجب ان تتناسب شدة وحجم الحمل تناسباً عكسياً والا تعرضت العضلة للتعب وزيادة فرصة التعرض للإصابة .
5. استخدام المنشطات يؤدي الى اجهاد وظيفي يعرض اللاعب لكثير من الاصابات حيث يبذل جهداً غير ملائم لمقدرته الفسلجية والجسمية .
6. الخشونة المتعمدة في اللعب .
7. كما ان عدم توفير الغذاء المناسب كماً ونوعاً وكذلك الماء والاملاح ومواعيد الغذاء يؤدي الى الاصابات الرياضية.
8. سوء الحالة النفسية للاعبين ، إذ يجب على اللاعب الالمام بمبادئ علم النفس في التدريب الرياضي ويعتبر في عصرنا الحديث من اهم العلوم الانسانية وقد تسبب اثاره اللاعب او خموله الى حدوث الاصابة .
9. عدم الاهتمام في اجراء الفحوصات الطبية والاختبارات الفسيولوجية للممارسين.
10. عدم توافق عمل المجموعات العضلية العاملة ، كتدريب مجموعات عضلية معينة واهمال تدريب مجموعات عضلية اخرى .
11. هناك اسباب تؤدي إلى الاستعداد للاصابة في المجال الرياضي مثل عدم ملائمة النشاط الجسمي لنوع النشاط الرياضي وعيوب خلقية في العضلات وفي العظام وكذلك عيوب خلقية في الاوتار والمفاصل (Booher and Gray, 1985, 472).
12. تأثير البيئة : لا يقتصر تأثير ارتفاع درجة الحرارة او زيادة البرودة او الرطوبة على طريقة اداء اللاعب فقط بل يتعدى تأثيرها الى احداث مجهود زائد يضاف الى المجهود العضلي الذي يقوم به اللاعب مما قد يتسبب في اجهاده المبكر وفق التوافق العضلي العصبي فيزيد ذلك من قابلية اصابة اللاعب .

الفصل الأول الجانب التشريعي

13. عدم استخدام ادوات الوقاية الكافية للعظام والعضلات والمفاصل حسب نوع النشاط الممارس اثناء ممارسة الانشطة الرياضية .

14. عامل التكرار ولمدة طويلة مع حدوث رد فعل تلامس جسم الرياضي مع الارض كل ذلك يؤدي الى اعباء على الجهاز العضلي والعظمي والمفصلي وكذلك على الاربطة المفصالية. وتزداد اصابات الرياضيين من خلال تكرار حركاتهم في الكعب والبطح وتؤدي الى التهاب في منطقة فوق اللقمة العضدية وهذا ما يحصل لدى لاعبي التنس والمبارزة كما يحدث التهاب في وتر الراس الطويل للعضلة ذات الراسين العضدية وغلافه بكثرة الاستخدام لمفصل الكتف وزيادة الاحتكاك للوتر صعوداً ونزولاً داخل الاخدود العضلي (Booher and Gray,1985,485-486) .

15. استمرار اللاعب الرياضي المصاب في ممارسة النشاط يعمل على مضاعفة الإصابة وبالتالي يمكن ان تأخذ شكلاً بنائياً جديداً مما يؤدي الى (حالة مزمنة) وهذا يتطلب علاجاً لوقت طويل مما يحرم اللاعب الممارسة الرياضية .

ومن هنا نلاحظ انه اذا كان المدرب على علم ودراية بالأسباب العامة للإصابات الرياضية التي اشرفنا إليها فان دوره في الحد والوقاية من الإصابات يكون ميسوراً لان معرفته سبب الإصابة تجعله يتخذ الاجراءات لمنع حدوثها .

4-2-3- اعراض وعلامات الإصابة الرياضية :

نحمل هنا الاعراض والعلامات التي تنتج من مختلف الاصابات الرياضية بعامة :

1. النزف الدموي وعادةً تظهر الاصابات التي يرافقها نزف اكبر مما هي عليه في الحقيقة حيث قد يكون النزف من جرح بسيط في الجلد ولكن في كل الأحوال يجب التأكد من منطقة النزف قبل رجوع اللاعب الى الملعب .
2. التورم الذي ينتج عادة من النزف الدموي .
3. التشوه ويمكن معرفته بموازنته بالجزء المناظر له في الجسم .
4. تلون الجلد ، احتقان الجلد ، التعرق الشديد.
5. وجود حركة غير طبيعية بالمفاصل .

الفصل الأول الجانب التشريحي

6. التغيرات العصبية غير الطبيعية مثل الخدر ، التئمل ، الوخزات ، الشعور بالضعف وشلل الحركة .

7. الألم بدون حركة الجزء المصاب أو اثناء المدى الطبيعي للحركة .

8. فقدان الحركة الطبيعية للجزء المصاب دون وجود الألم .

9. عدم ثبات المفصل بالرغم من عدم وجود الألم .

10. حدوث تيبس بالمفاصل المعرضة للإصابة أو القريبة من مكان الإصابة .

11. وجود ضعف أو ضمور بالعضلات .

12. عدم قدرة اللاعب على المشي أو الحركة بطريقة سوية.

13. سماع عدد من الاصوات اثناء الحركة ويمكن الاستفادة من اللاعب هنا لوصف ما يحدث بالضبط .

14. فقدان الوعي أي عدم القابلية للاستجابة للمؤثرات الحسية ولمدة ثواني فما فوق.

5- الفحص السريري للإصابات الرياضية :

5-1 تعريف الفحص السريري :

هو معاينة الإصابة مع ملاحظة الاعراض الظاهرة للاعب المصاب من قبل الطبيب

المعالج دون استخدام الاجهزة (Booher and Gray,1985,26) .

5-2 كيفية اجراء الفحص السريري :

تتضمن المبادئ الاساسية للفحص ما يأتي :

5-2-1- تاريخ الإصابة : وتشمل وقت، ومكان حدوث الإصابة ، وعدد مرات حدوثها سابقاً.

5-2-2- موقع الإصابة بالنظر : وهنا يجب نزع ملابس المصاب بصورة تضمن الرؤية

الجيدة للمنطقة مع مراعاة مقارنة الجزء المصاب بالجزء المناظر له بالجسم ومعاينة

الإصابة تكون كما يأتي :

- العظام : ملاحظة استقامة العظم ومكانه وعدم وجود قصر أو تشوه .
- الانسجة الرخوة تورم الجلد – تمزقه ، اختلاف اللون حيث ان اللون الازرق يعبر عن النزف تحت الجلد أو الاختناق ، واللون الاخضر عن قلة وصول الدم وانخفاض الضغط ، واللون الاحمر عن تمدد الاوعية الدموية كما في ارتفاع درجة حرارة المنطقة .

الفصل الأول الجانب التشريحي

5-3- لمس وتحريك الإصابة : حيث يمكن معرفة درجة حرارة الجلد ومقارنته بالمناطق الأخرى غير المصابة ، ومعرفة استمرارية العظم وشكله والاحساس بوجود اصوات عند الحركة والالام عند الضغط عليه أو تحريكه وكذلك المفاصل ومحدودية حركتها ، وإذا وجد أي تورم فيها أو الم عند تحريكها ، اما العضلات فيمكن معرفة درجة تقلصها وانبساطها أو عدم استمراريته والالام عند الضغط عليها وقوتها .

الفصل الأول الجانب التشريعي

4-5- فائدة سرعة اجراء الفحص السريري :

تكمن الفائدة في سرعة تشخيص الاصابات الرياضية لما في ذلك من اهمية قصوى في التخفيف من المضاعفات المحتملة الحدوث وبالتالي في سرعة شفاء اللاعب المصاب وعودته الى الملعب باسرع وقت ممكن ، وكذلك يمكن ملاحظة اللاعب المصاب اصابة بليغة واعطائه النصح بعدم اللعب خلال فترة زمنية يجب ألا يتجاوزها على الاطلاق .

5-6- الوسائل المساعدة في تشخيص الاصابات الرياضية :

5-6-1- الاشعة السينية : تستخدم الاشعة السينية عادة لتشخيص الكسور في الهيكل العظمي

حيث لا تستطيع هذه الاشعة اختراق العظم ولكن تستطيع اختراق جميع الانسجة الاخرى .

5-6-2- الاشعة الملونة : حيث تحقن المنطقة المصابة بسائل لا يستطيع الاشعة اختراقه

مما يعطي شكل الجزء ، كما في تصوير الحبل الشوكي والمفاصل والاعوية الدموية .

5-6-3- التخطيط الكهربائي للعضلة :

5-6-4- التخطيط العصب المغذي للعضلة : حيث يستخدم جهاز يعطي اشارة كهربائية من

بداية العصب وتتبع الاشارة الى نهايته لبيان مناطق القطع ان وجدت حتى يمكن معرفة

منطقة الاصابة (Davidou, 1991, 52).

5-6-5- فحوصات سوائل الجسم : مثل معدل ترسب الدم (ESR) والهيموكلوبين وعدد

كريات الدم الحمراء والبيضاء (NFS). وفحص الادرار وفحوصات اخرى خاصة .

6- انواع الاصابات :

6-1- انواع اصابات الجلد والانسجة الرخوة :

ان اصابات الجلد تختلف عن اية اصابة اخرى لاجزاء الجسم المختلفة لأن الجلد هو

احد الدعامات القوية في الجسم لمنع دخول البكتيريا وحدوث الالتهابات ، وعند تمزق الجلد

فانه يصبح في تماس مباشر مع المحيط الملوث ، ولهذا يجب اتباع الاسس الصحيحة في

علاج الاصابات الجلدية ، ويمكن تقسيم اصابات الجلد الى الانواع الآتية :

6-2- النفطات او الفقاعات:

وتنتج من احتكاك الجلد بقوة واستمرار بسطح خشن ولمدة قصيرة مما يؤدي الى

انفصال الطبقات العليا من الجلد عن الطبقات السفلى وظهور سائل بين هذه الطبقات يترشح

من الاوعية الدموية والاعوية اللمفاوية (Arnheim, 1989, 23-25) كما ان هناك القروح

التي قد يصاب الجلد بها نتيجة لتكرار الاحتكاك في نفس المنطقة .

الفصل الأول الجانب التشريعي

- علاج النفطات :

يجب المحافظة على هذه الانتفاخ الجلدي المائي كما هو انأمكن حيث نلاحظ بعد فترة قصيرة امتصاص السائل مرة أخرى ورجوع الجلد الى حالته الطبيعية اما اذا اراد اللاعب التخلص منه بسرعة فيجب تعقيم المنطقة بسائل معقم ومن ثمة فتح المنطقة بمشرط معقم مع وضع مادة حافظة فوق منطقة النفطة لمنع حدوث الالتهاب .

3-6- السحجات :

هناك اصابات عديدة قد تحدث للجلد ومنها السحجات وهي عبارة عن تمزق الطبقات العليا من الجلد فقط التي يتعرض لها اللاعب عند السقوط او الانزلاق على سطح خشن .

- علاج السحجات :

1. ازالة أي جسم غريب متعلق في المنطقة لمنع الالتهاب .

2. غسل المنطقة بالماء والصابون او بمعقم .

3. وضع قطعة من الشاش مع القليل من المضادات الحيوية

4-6- الجروح :

هو عبارة عن انفصال غير طبيعي في انسجة الجسم مع حدو قطع في الجلد ، هو فقدان استمرارية الجلد لتعرضه لشدة خارجية . وهناك عدة انواع من الجروح وهي:

• **الجرح القطعي :** ويحدث نتيجة التعرض لآلة حادة كالموس والسكين او قطع الزجاج ويتميز بكون حافتي الجرح منتظمين مع وجود نزف شديد في المنطقة لقطع عدد كبير من الاوعية الدموية .

• **الجرح النافذ :** ويحدث نتيجة اختراق الجلد بآلة حادة مدببة مثل الرمح وسلاح المبارزة أو أي جسم رفيع مدبب ، ويتميز بقلة الدم المصاحب للاصابة الا اذا اصاب عضواً داخلياً او اوعية دموية يتحول الى جرح خطير جداً قد يتسبب في وفاة المصاب ، خاصة اذا ثقب احد الاحشاء الهامة مثل القلب والكبد والطحال كما يساعد عمق الجرح على سهولة تلوثه بالميكروبات .

• **الجرح الرضي :** وينتج من ارتطام اللاعب بجسم غير حاد كالحجارة حيث يحدث تمزقاً في الأنسجة وتكون حوافي هذا الجرح غير منتظمة مع حدوث نزف اقل عادة في حالة الجرح القطعي.

الفصل الأول الجانب التشريعي

- علاج الجروح :

إذا كان الجرح صغيراً فلا يستدعي عرضه الى الطبيب ويمكن معالجته في مكان الإصابة . اما في حالة الجروح الكبيرة او النافذة فيجب استشارة الطبيب الاخصائي ، ومن اهم القواعد الاساسية للعلاج هي:

1. تعقيم مكان الإصابة بأحدى المطهرات المتوفرة مع عدم ازالة التجلد الدموي
2. العمل على ايقاف النزف اما بواسطة الضغط على مكان الإصابة بواسطة قطعة من الشاش او كيس من الثلج او رش كلور .

-7- اصابات العضلات :

في هذا البحث تم اخذ اصابات العضلات حسب منطقة الإصابة مثلاً في الكتف او العضد او الساعد او اليد او الركبة ولم يتم اخذ اصابات العضلات حسب العضلات المفردة وعلى هذا الاساس لم يتم شرح العضلات الموجودة في الطرف العلوي كل على حدة . وهي من الاصابات الواسعة الانتشار ويمكن تقسيمها كما يأتي :

1. كدمة العضلات .
2. تشنج العضلة .
3. اصابات السحب والتمزق العضلي .

-1-7- كدمة العضلات :

عبارة عن هرس وتمزق الأنسجة السطحية او العميقة تحت الجلد (بين الجلد والعظم) ومن أسبابه (صدمة خارجية او عنف خارجي كالأصطدام بجسم صلب او بجسم اللاعب) ، يعد كدم العضلات من اهم انواع الكدمات لكثرة انتشارها ويعرف الكدم بأنه هرس النسيج نتيجة لتعرضه لضغط شديد من شدة خارجية وهو من الاصابات المباشرة ، وقد تؤدي الى تمزق بعض الألياف العضلية .

وتتميز بالاعراض والعلامات الآتية :

- الم شديد في مكان الإصابة .
- يزداد الالم اذا حاول المصاب تحريك العضلة المصابة سواء بسحبها او لإنقباضها.
- حدوث ورم في مكان الإصابة يزداد طردياً مع شدتها نتيجة النزف الاوعية الدموية .

الفصل الأول الجانب التشريحي

- نلاحظ زيادة التورم تدريجياً أثناء الاربعة والعشرين ساعة الاولى من الاصابة مع ارتفاع درجة حرارة الجزء المصاب .
- يتغير لون الجلد من الازرق الى الاخضر ثم اللون الاصفر ويعود اللون الطبيعي عند الشفاء التام .

الفصل الأول الجانب التشريحي

2-7- التشنج العضلي:

هو رد فعل عصبي مفاجئ يحدث تقلصاً شديداً مؤلماً أكثر من شدة التقلص الاعتيادي، ويستمر الى ثوان او دقائق معدودة وذلك خلال او بعد احماء العضلة .

والتشنج العضلي تقلص قوي جداً واكبر من المعتاد نتيجة لرد فعل عصبي وقد يستمر ثواني الى دقائق معدودة خاصة بعد الاجهاد العضلي وهو مؤلم جداً , ويعد تشنج العضلات من الاصابات كثيرة الحدوث عند الرياضيين و احياناً يكون سببها مجهولاً ولكن من الممكن ان يكون ناتجاً عن الاسباب الآتية:

- تعب شديد ناتج عن تجمع المواد الحامضية في العضلة مثل حامض اللبنيك.
- عدم الإحماء الكافي .
- درجة الحرارة مثل البرد الشديد المفاجئ والحر الشديد.
- خلل موضعي في الدورة الدموية بسبب الضمادات او الالبسة الضيقة
- فقدان السوائل والاملاح من الجسم .
- قيام العضلة بمجهود مضاعف لفترات طويلة .
- تغذية غير متنوعة وغير كافية .
- اضطراب الحالة النفسية للاعب .
- فضلاً عن نقص بعض المواد بالدم خاصة مستوى الكالسيوم حيث توجد علاقة وثيقة بين هذه النسبة ونسبة حدوث التشنج.
- القيام بحركات قوية مفاجئة .

(Booher and Gray, 1985,)

- أعراض التشنج :

نستطيع ان نجمال اعراض التشنج العضلي في :

- الم حاد مكان الاصابة ، واي جهد زائد يؤدي الى تمزق العضلة .
- عادة يضع المصاب يده على مكان الالم مباشرة ، وليس على ما يجاورها.

الفصل الأول الجانب التشريحي

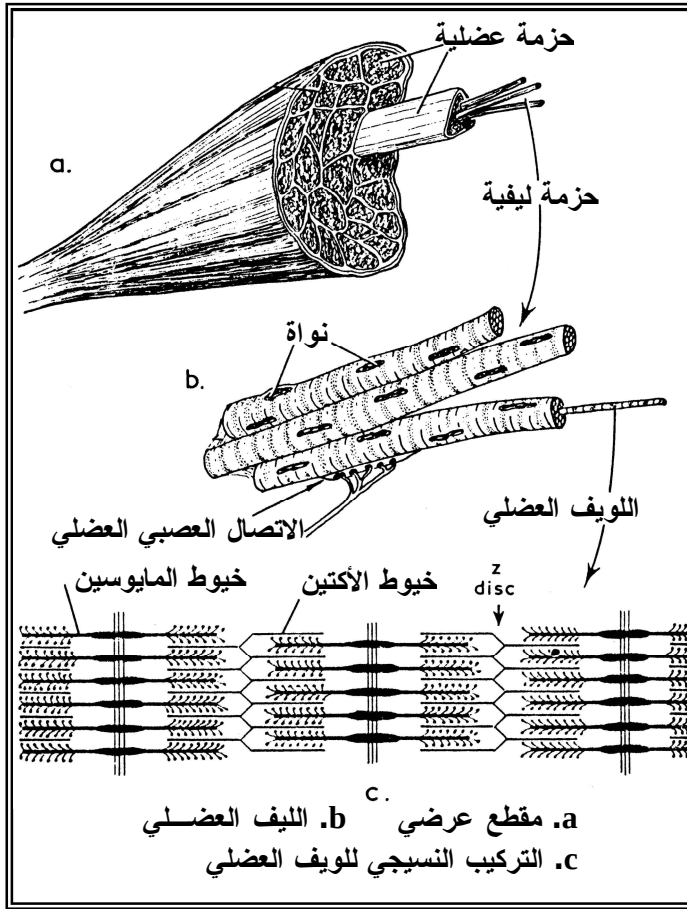
- علاج التشنج العضلي:

يتم العلاج بعد لف العضلة المتشنجة وعدم اجراء تدليك شديد لها ، لان ذلك من الممكن ان يؤدي الى قطع العضلة ، والعلاج هنا يتم عكس مختلف الاصابات الرياضية حيث نعمل اولاً على تدفئة العضلة المصابة ونعمل على سحب العضلة بقوة وببطئ ثم تثبت حتى لا يعود التشنج مرة اخرى (Arnheim, 1989, 70) .

3-7- التمزق العضلي : (شكل 11)

ان اصابة التمزق

العضلي عبارة عن شد او تمزق الالياف العضلية او الاوتار نتيجة جهد عضلي عنيف اكبر من تحمل العضلة ومن اسبابها التقلص العضلي غير الاعتيادي الذي ينشأ من عدة عوامل منها عدم تناسق الانقباض بين مجموعتين من العضلات تعاكس بعضها في العمل وكذلك تراكم النواتج الثانوية في العضلة والنتيجة عن التقلص العضلي ، وعدم الاحماء الكافي للمجاميع العضلية ، أو عودة اللاعب قبل تمام شفائه من شد او تمزق عضلي سابق او الانقطاع عن



a. مقطع عرضي c. b. الليف العضلي
c. التركيب النسيجي للليف العضلي

الشكل (11)

يوضح التركيب الدقيق للعضلة الهيكلية
(Reilly, 1981, 87)

التمرين لفترة طويلة ، الجهد العضلي الشديد بدرجة أكبر من قوة تحمل العضلة وكذلك قصر العضلات التشريحية وعدم مطاقتها بالدرجة التي تتطلبها طبيعة الحركات والمهارات التي يؤديها اللاعب والفقدان للماء والأملاح ، كما أن التمزق العضلي يكون كلياً أو جزئياً ويحدث

الفصل الأول الجانب التشريعي

من اي جزء في العضلة سواء في المنشأ أو العضلة نفسها أو في المدغم وقد يكون تمزقاً في الغلاف الخارجي للعضلة وهو ناتج عن عدم التكافؤ بين القوة والجهد الذي تتعرض له العضلة .

- درجات التمزق العضلي :

هناك ثلاث درجات من التمزق العضلي حسب شدتها :

1. الدرجة الاولى أو البسيطة وتشمل تمزق عدد قليل من الالياف العضلية.
2. الدرجة الثانية أو المتوسطة وتشمل تمزق عدد كبير من الالياف العضلات مع بقاء استمرارية العضلة .
3. الدرجة الثالثة أو الشديدة وتشمل تمزق العضلة بالكامل أو انقطاع وترها وينفصل احياناً جزء من العظم والذي ينفصل معه وتر العضلة.

- علامات وأعراض التمزق العضلي:

عند حدوث التمزق العضلي بدرجاته كافة من الممكن ظهور احدى أو جميع العلامات والأعراض التالية وحسب شدة التمزق:

1. الألم : وقد يحدث ألم مفاجئ عند حدوث الإصابة مباشرة ويتوقف على شدة الإصابة فقد تكون الإصابة خالية من الألم عند حدوثها وبالدرجات كافة ولكن في جميع الدرجات يظهر الألم بعد فترة قصيرة .
2. تورم مكان الإصابة نتيجة النزف الداخلي حيث يتغير لون المنطقة الى الاحمر والازرق والاصفر بعد مرور عدة ايام وقد لا يظهر أي تورم عندما تكون الإصابة بعيدة نسبياً عن منطقة الإصابة.
3. تشوه العضلة المصابة خاصة في الإصابات الشديدة وتجمع دموي في منطقة الإصابة .
4. ضعف مع تشنج العضلة.
5. عدم قدرة المصاب على تحمل الألم الشديد جراء لمس المنطقة أو الضغط على العضل المصاب (Arnheim, 1989, 60).

- علاج التمزق العضلي :

الفصل الأول الجانب التشريعي

ويكون العلاج في اليوم الاول باستخدام كمادات الثلج لمدة (20) دقيقة وكذلك في اليوم الثاني مع استخدام دوامات الماء لمدة (10) دقائق لحين اختفاء الالم مع رفع الجزء المصاب الى اعلى وربطه بلفاف ضاغط (باندج) لتقليل النزف الداخلي الناتج ومنع حصول تورم والتدليك فقط اعلى واسفل المنطقة المصابة لمدة (5) دقائق ثلاث مرات يومياً ثم نقوم بتأهيل اللاعب ببعض التمرينات لحين شفاؤه ، أما اذا كان التمزق شديداً فيجب اجراء عملية جراحية لخيطة العضلة الممزقة .

8- اصابات العظم (الكدم) :

8-1- كدم العظام :

من الممكن ان يصاب الجهاز العظمي بالكدم نتيجة لقوة الضربة العنيفة التي تؤدي الى نزيف دموي يحدث تحت السمحاق الخارجي للعظم تحت الجلد , وتعد المناطق المكشوفة وغير المغطاة بالعضلات من اكثر المناطق المعرضة للاصابة كما هو الحال في عظام الكتف والمرفق والكعب ، والركبة ، وعظام الوجه والرأس .

- اعراض كدم العظم :

1. ألم شديد مكان الاصابة وبخاصة عند الضغط عليها .
2. ورم مكان الاصابة نتيجة لتمزق جزء من السمحاق الخارجي وحدوث نزف دموي داخلي حيث ان هذا السمحاق غني بالاووعية الدموية والاعصاب .
3. تغير لون الجلد فوق مكان الاصابة وقد يحصل نيجة الشدة الخارجية .
4. اذا كان الكدم قريباً من مكان منطقة المفصل فيؤدي الى تحديد حركة العظم نتيجة الالم .
5. اعاقا اللاعب عن الاستمرار في استخدام العضو حسب نوعية وشدة الاصابة .

(Arnheim, 1989, 65)

- علاج الكدم :

لا يحتاج الكدم البسيط إلى أي علاج أما الكدم الشديد يجب التأكد اولا من عدم وجود كسر في العظم بأخذ صورة شعاعية للمنطقة المصابة ويوضع كيس من الثلج للتبريد لازالة التورم وتخفيف الألم . ويربط برباط ضاغط للحد من التورم ورفع الجزء المصاب فوق مستوى القلب واعطاء راحة تامة للمنطقة المصابة من (2-3) أيام وحسب شدة الكدم يعطى مسكنات للألام ثم نقوم بتأهيل اللاعب ببعض التمرينات لحين شفاؤه .

الفصل الأول الجانب التشريعي

(Jackson, 1978, p.117-16)

2-8- الكسور :

يعرف الكسر بأنه فقدان استمرارية العظم الطبيعية نتيجة لشدة خارجية كالضغط أو السحق أو السحب الشديد أو نتيجة المرض .

8-2-1 - اسباب حدوث الكسور:

1. إصابة مباشرة نتيجة ضربة قوية مباشرة تحدث في مكان الإصابة فقط .
2. إصابة غير مباشرة نتيجة السقوط من مكان مرتفع على القدمين الآليتين أدت إلى حدوث كسر عظام العنقية وقاع الجمجمة أو السقوط على الذراع وهي ممدودة تسبب كسر في عظم الترقوة .
3. نتيجة بذل مجهود زائد أدى إلى تقلص عضلي عنيف أقوى من قوة العظام أدى إلى أحداث شد وتر العضلة على نقطة الاندغام بالعظم فينفصل الوتر ومعه قطعة من العظام.
4. نتيجة إصابة الالتواء الشديد لأربطة المفاصل تؤدي إلى حدوث انفصال الرباط ومعه قطعة من عظام المفصل .
5. نتيجة إصابة العظام ببعض الأمراض (التهاب العظام ، لين العظام ، الكساح).

- أنواع الكسور :

تقسم الكسور عامة إلى نوعين أساسيين :

1. الكسور البسيطة: وهي كسر العظم بدون تعرضه للمحيط الخارجي وبقائه في مكانه (بدون بروزه خارج الجلد).
2. الكسور المضاعفة: وهي كسر العظم و بروزه خارج الجلد وفي هذه الحالة يصاحب الكسر تمزق الأنسجة المحيطة به من عضلات وأعصاب وجلد .

- أشكال الكسور :

1. الكسر المتفتت .
2. الكسر المنضغط .
3. كسر العود الأخضر .
4. الكسر المندغم .
5. الكسر الطولي .
6. الكسر المائل .
7. الكسر الحلزوني .
8. الكسر المنتشاري .

الفصل الأول الجانب التشريعي

9. الكسر المستعرض.

الفصل الأول الجانب التشريحي

8-2-2- علامات واعراض الكسور :

1. الشعور بالم شديد في مكان الاصابة تزداد حدة الالم عند تحريك الجزء المصاب .
2. ظهور انحراف عظمي ويمكن معرفته بالمقارنة بين العضو السليم والعضو المصاب.
3. وجود ورم في مكان الاصابة مع تغيير لون الجلد نظراً لتمزق الاوعية الدموية المحيطة.
4. وجود حركة غير اعتيادية في العضو المصاب واحياناً قد يبدو ان هناك مفصلاً آخرأ .
5. سماع طقطقة عند القيام بالفحص في مكان الاصابة ويفضل عدم تكرار سماعها .
6. حدوث ضعف عام مع عدم قدرة المصاب على الحركة وخاصة تحريك العضو المصاب.
7. حدوث صدمة نتيجة زيادة الالم والنزيف .
8. ألم شديد عند الضغط على منطقة الكسر .
9. ألم شديد في منطقة الكسر عند الضغط على العظم بعيداً عن منطقة الكسر .

8-2-3- علاج الكسور :

بعد تشخيص الكسر نهائياً ومعرفة منطقتيه بدقة ، يبدأ العلاج الذي يتكون من ثلاثة اجزاء رئيسية هي :

1. **رد الكسر :** لارجاعه الى وضعه الطبيعي وطوله واستقامته للتخلص من أي تشوه مستقبلاً ويتم رد الكسر بطريقتين هما :
 - أ. **الرد المغلق :** ويتم بوساطة اليدين وتحت التخدير الموضعي أو التام وأحياناً تحت جهاز الاشعة التلفزيوني لإرجاع العظم الى وضعه الطبيعي بوساطة السحب .
 - ب. **الرد المفتوح :** ويستعمل عند فشل الطريقة السابقة عند وجود قسم من الأنسجة المحشورة بين منطقة الكسر او في الكسور المضاعفة والكسور المتفتحة . ويتم هنا ارجاع العظم بوساطة العملية الجراحية تحت التخدير التام .
2. **التثبيت :** يكون في اغلب الاحوال باستعمال الجبس ولكن هناك اماكن وحالات كثيرة لا يستعمل فيها الجبس ويكون التثبيت بطرق اخرى سواء بالشد اذا كان الكسر بسيطاً وغير معقد ، أو باستعمال مسمار أو شرائح أو القضبان المصنوعة من المعدن التي لا تتفاعل مع انسجة الجسم مثل البلاستين أو سبائك الكروم أي بواسطة العملية الجراحية .

(Jackson , 1978,39)

الفصل الأول الجانب التشريحي

8-3- التاهيل والعلاج الطبيعي : حيث يجب التأكد من صحة الالتئام بعد فك الجبس او التثبيت الداخلي باخذ الصور الشعاعية وبعدها يتم العمل على تقوية المنطقة المصابة بوساطة الانقباضات العضلية الثابتة والمتحركة وتنشيط الدورة الدموية بالتدليك والماء الدافئ والتمرينات العلاجية المتدرجة حتى يعود الجزء المصاب الى حالته الطبيعية.

9- اصابات المفاصل والأربطة :

1. اللوي .

2. الخلع .

9-1- اللوي : (الشكل 12)

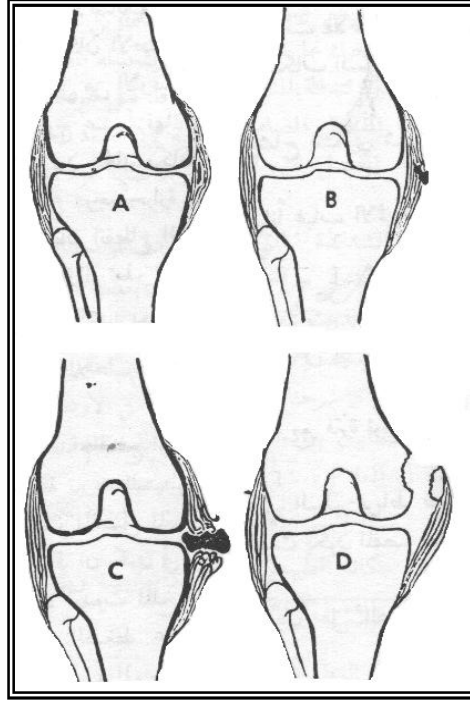
هو تمزق كلي او جزئي لرباط او اكثر من اربطة المفصل نتيجة زحزحة مؤقتة ويحدث في مفصل رسغ اليد ورسغ القدم ، وهو من اكثر الاصابات شيوعاً في الملاعب الرياضية ويحدث غالباً في الالعاب الفرقية ولكن يمكن حدوثه في أية لعبة اخرى .
واللوي او الملح هو عبارة عن تمزق جزئي او كلي لرباط او أكثر من أربطة المفصل نتيجة زحزحة مؤقتة ، أي ان العظام تعود الى وضعها الطبيعي تاركة الرباط متمزقاً وهو يحدث في احد المفاصل اثر سقوط على احد الاطراف او التعثر اثناء المشي او الجري او الانشاء المفاجئ ، وهو اكثر حدوثاً في مفصل رسغ اليد ومفصل القدم. حيث تخرج من مكانها الطبيعي بالمفصل ثم تعود مرة اخرى الى مكانها الطبيعي في الوقت نفسه ويمكن تصنيف اللوي الى ثلاث درجات وحسب شدته وكما يأتي :

1. **الدرجة الاولى :** وتشمل تمزق عدد قليل من الياف الرباط وبدون حدوث مضاعفات في حركة المفصل .

2. **الدرجة المتوسطة :** وتشمل تمزق الياف الاربطة بنسبة 5-95% ولكن بدون انقطاع الرباط وقد يؤثر على استقرارية المفصل . ففي اللوي المتوسط يحدث زيادة السائل الزلالي داخل المفصل والتهاب خفيف ونزيف دموي في الغشاء الزلالي وبين الانسجة المفصليّة وخصوصاً المنطقة التي تحيط بالرباط الموجودة بالجهة المصابة.

3. **الدرجة الثالثة :** (الشديدة) وتشمل تمزق الرباط او الاربطة بالكامل وقد يحدث خلع في المفصل او حتى في حالة عدم انقطاع الرباط وقد يحدث كسر في منطقة الرباط بالعظم .

الفصل الأول الجانب التشريحي



(a) الدرجة البسيطة (B) الدرجة المتوسطة (C) الدرجة الشديدة (انقطاع الرباط) (D) الدرجة الشديدة (كسر منطقة اتصال الرباط)

الشكل (12)

درجات اللوي

(Strauss, 1979, 193)

9-2- علامات واعراض اللوي :

1. ألم شديد في المنطقة يزداد في حالة الضغط عليها بالاصبع ، ويكون حدوث الألم فجأة لحظة حدوث الإصابة ، وعند فحص المصاب يزداد الألم في اتجاه الحركة التي سببت الإصابة ويقل اذا ماحدثت الحركة في اتجاه عكس الحركة التي سببت اللوي .
2. تغير لون الجلد مكان الإصابة اذا كان الارتشاح الدموي شديداً .
3. ارتفاع درجة حرارة المنطقة المصابة .
4. في حالة انقطاع الرباط بالكامل يحدث أحياناً غياب الألم عند حركة المفصل .
5. صعوبة او تعذر الحركة في المفصل .
6. تورم مكان الإصابة : ويحدث في الحال اذا كانت الإصابة نتيجة النزيف الحاصل من الاوعية الدموية الممزقة وكذلك انسكاب السائل الزلالي من المحفظة الى الخارج عند تمزقها. التهاب الغشاء الزلالي .

الفصل الأول الجانب التشريحي

7. نزيف دموي داخلي .

8. الم عند اداء الحركة تحدث شداً في الرباط.

9. تمزق الانسجة والاربطة

9-3- علاج اللوي :

يكون العلاج في اليوم الأول باستخدام كمادات الثلج لمدة (1-2 ساعة) مع فترة توقف 20 دقيقة لكل 20 دقيقة تبريد للسيطرة على النزف والتورم والألم بتثبيت المفصل في الوضع التشريحي السليم برباط ضاغط ويجب التأكد من عدم وجود كسر في المنطقة المصابة باخذ تصوير شعاعي للمنطقة وفي اليوم الثاني والثالث يتم تدليك المنطقة فوق وتحت مكان الاصابة لمدة دقائق مرتين يوميا وفي اليوم الرابع والخامس الاستمرار في تدليك المنطقة فوق وتحت مكان الاصابة وعمل حمام الماء الساخن للمساعدة على امتصاص التورم مع استمرار الضغط على المنطقة برباط ضاغط واجراء التمارين لباقي اجزاء الجسم لحين شفاؤه .

اما في الحالات الشديدة التي يحدث فيها انقطاع الرباط أو حدوث عدد من الكسور فيجب اجراء تداخل جراحي لربط الرباط المقطوع مع بعضه ، وبعد اجراء العملية يجب تثبيت المنطقة بواسطة الجبس ومن ثمة اجراء العلاج التأهيلي ببعض التمرينات لحين شفاؤه (Arnheim, 1989, 72)

10- الخلع :

وهو خروج العظم من مكانه الطبيعي (محفظة المفصل) نتيجة تاثير شدة على المفصل بشكل مباشر او غير مباشر , مما يحدث اراحة العظم عن مكانه الطبيعي في المفصل نتيجة لشدة خارجية ، ويؤدي عادة الى اصابة الاربطة المحيطة بالمفصل وهناك عدة انواع من الخلع:

1. الخلع الكامل : وهو خروج احد العظام المكونة للمفصل عن مكانها الطبيعي .
2. الخلع غير الكامل : وهو انتقال السطوح المفصالية عن بعضها نتيجة استطالة الياف اربطة المفصل اكثر من الحدود الطبيعية لها .
3. الخلع المرتد : وهو انتقال السطوح المفصالية عن بعضها نتيجة استطالة الياف اربطة المفصل اكثر من الحدود الطبيعية لها ، ثم ترتد الى مكانها الطبيعي دون أي تدخل .

الفصل الأول الجانب التشريحي

4. **الخلع المصحوب بكسر :** وهو من اصعب انواع الخلع حيث يحدث نتيجة اصابة مباشرة لعظام المفصل .

5. **الخلع المتكرر :** المقصود بالخلع المتكرر هو تكرار حدوثه اكثر من مرة في نفس المفصل ويحدث نتيجة عوامل تؤدي الى عدم ثبات المفصل.

10-1 - اسباب الخلع :

1. نتيجة شدة خارجية عنيفة مفاجئة مباشرة او غير مباشرة .

2. اداء المفصل حركة غير طبيعية في مدى واسع .

3. السقوط من اماكن مرتفعة .

10-2 - علامات واعراض الخلع :

1. فقدان الوظيفة الطبيعية للمفصل بعد شدة خارجية.

2. تشوه المفصل الناتج عن خروج العظم من محله الطبيعي واحياناً لا يكون هذا التشوه واضحاً خاصة عند وجود عضلات قوية وكبيرة حول المفصل ولهذا فمن الاهمية تحسس المفصل والتأكد من وجود العظام في محلها الطبيعي وموازنة الجزء المصاب بالمنطقة المقابلة له بالجسم .

3. ألم شديد عند تحريك الجزء المصاب نتيجة تمزق الاربطة والانسجة .

4. تورم المفصل مع ألم شديد عند الضغط عليه باليد والم عند حركته .

5. يجب اخذ صور شعاعية للمفصل والتأكد من عدم وجود مضاعفات تكسر نهايات العظام المتقابلة.

10-3 - علاج الخلع :

يجب اتباع المؤشرات الآتية في علاج الخلع :

1. تثبيت الطرف المصاب بوضع مريح لمنع أي تمزقات او مضاعفات لحين نقله الى الطبيب المختص .

2. إيقاف النزيف باستخدام كمادات الثلج .

3. يجب عدم تحريك العضو المصاب لحين التأكد من نوعية الإصابة .

4. يتم ارجاع المفصل الى وضعه الطبيعي تحت التخدير مثل الطبيب المختص .

الفصل الأول الجانب التشريعي

5. تثبيت المفصل المصاب في وضعه الطبيعي وحسب نوعية المفصل ولمدة اسبوعين الى ثلاثة اسابيع .

6. اجراء العلاج الطبيعي والتاهيل لاعطاء جلسات اشعة قصيرة وتدليك المنطقة المجاورة والقيام بتمارين متدرجة لتقوية اربطة المفصل والعضلات المحيطة.

4-10- الاسعاف الاولى للاصابات العضلية والمفصلية :

1-4-10- الاسعاف الاولى

يعرف الإسعاف الأولي بأنه العناية السريعة والمؤقتة التي تعطى للمصاب لحين وصوله الى الطبيب . ان الإصابات العضلية والمفصلية شائعة جداً ، ولهذا فان معرفة الإسعاف الأولي مهم جداً .

10-4-2- السيطرة على الاصابة ساعة حدوثها

وذلك بواسطة السيطرة على النزيف والالتهابات والتشنج والالم وبما يأتي:

1. **التبريد** :يستخدم جريش الثلج داخل كيس مطاطي او من القماش و تستخدم كمادات باردة او بعض المواد التي تتبخر بسرعة مثل الايثيل كلورايد . ويعمل التبريد على تقليل الالم والتشنج ويقلل من فعالية الانزيمات في المنطقة مما يقلل من تلف الانسجة . كما يعمل التبريد على زيادة لزوجة الدم وقلة ترشيحه من الاوعية الدموية مما يقلل من تورم المنطقة والاقبال من معدل التمثيل الاساسي وحاجة الانسجة الى الاوكسجين ولكن في الوقت نفسه يجب ان نتذكر ان التبريد الشديد والطويل الامد قد يؤدي الى تلف الانسجة وموتها ، وكقاعدة عامة يكون التبريد لمدة (20) دقيقة (2 دقيقة تبريد مع راحة دقيقة) كل (1-2) ساعة خلال النهار فقط ويعتمد على شدة الاصابة ومكانها ، وكمثال لذلك اذا اصيب اللاعب بشد عضلي فانه يحتاج الى (20) دقيقة تبريد لمرتين فقط ، اما اذا كانت الاصابة شديدة فان التبريد قد يستمر لمدة (3) أيام متتالية .

2. **الضغط واللف** : وهو من العوامل المهمة ، يستخدم حال وقوع الاصابة حيث يعمل على تقليل النزف وترشح السوائل من الاوعية الدموية وبالتالي تقليل النوم كما يعمل على الحد من حركة الجزء المصاب ، يجب ان يستمر الضغط طوال النهار ويمكن رفعه ليلاً .

الفصل الأول الجانب التشريعي

3. **الرفع :** يعمل على ارجاع الدم بفعل الجاذبية بسرعة مما يقلل من التورم والنزف ويستخدم ليلاً عند النوم .

4. **الراحة :** مهمة جداً لشفاء الاصابة وتوقف النزف.

5. **التجبير :** وهو مهم جداً في الاصابات الرياضية حيث ان أي اشتباه وجود كسر او خلع يجعلنا نستخدم الجبيرة والتي هي عبارة عن قطعة صلبة من المعدن او الخشب او البلاستيك ، يربط الجزء المصاب بها مع العلم بانه يجب شمول مفصلين احدهما فوق منطقة الاصابة والآخر أسفل منطقة الاصابة لضمان عدم حركة الجزء المصاب.

في الاطراف العليا فان اصابة مفصل الكتف تجعله يثبت مع الجذع ، وفي اصابات الذراع والرسغ فتكون الجبيرة في وضع بحيث يكون مفصل المرفق مثبتيًا بدرجة (90) وتثبت الاصابع مع بعضها البعض او بواسطة قطع خشبية صغيرة (Arnheim, 1989, 75) .

10-5- كيفية نقل المصاب:

في الحالات البسيطة التي يستطيع المصاب ان يقف على رجليه فيمكن اتكاؤه على شخصين لمساعدته في المشي ، وفي حالة عدم القدرة على المشي فيمكن حمل المصاب بواسطة شخصين وعلى الايدي المتشابكة .

اما اذا كانت الاصابة شديدة فنستخدم النقالة الطبية او اللوح الخشبي ويوضع المصاب بنفس وضعه عند الاصابة ، اما اذا كان المصاب فاقدًا للوعي او كانت الاصابة في العمود الفقري فيجب هنا نقل المصاب بواسطة خمسة أشخاص احدهم مسؤول عن حمل الراس والرقبة وثلاثة يحملون الجذع والقدمين والخامس يضع اللوح الخشبي او النقالة اسفل المصاب، واثناء ذلك يجب العمل على عدم تحريك العمود الفقري إطلاقاً.

11- طرق ربط وتثبيت الإصابات الرياضية :

هناك ثلاث أنواع من الأشرطة التي تستخدم في ربط وتثبيت الإصابات الرياضية

وهي :

الفصل الأول

الجانب التشريعي

1. الشريط اللاصق الذي يمتاز بالخفة والقوة في منع حركة الجزء المصاب بعد ان يلتصق به .
2. الشريط المطاطي : ويمتاز بسهولة الربط حيث يأخذ شكل الجزء المصاب تماماً بما فيه البروزات العظمية .
3. اللفافات الاعتيادية غير اللاصقة وغير المطاطية .

الفصل الثاني

الإصابة والسلوك

النفسي

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

1. المظاهر الإجهاد والإصابات الرياضية

وقد أظهرت العمل في علم النفس التجريبي أن المواجهة الفرد في المواقف العصبية هو المسؤول الأول عن عجز الإنتباه من الرؤية المحيطية والمركزية رؤية (Burssul, 1958)

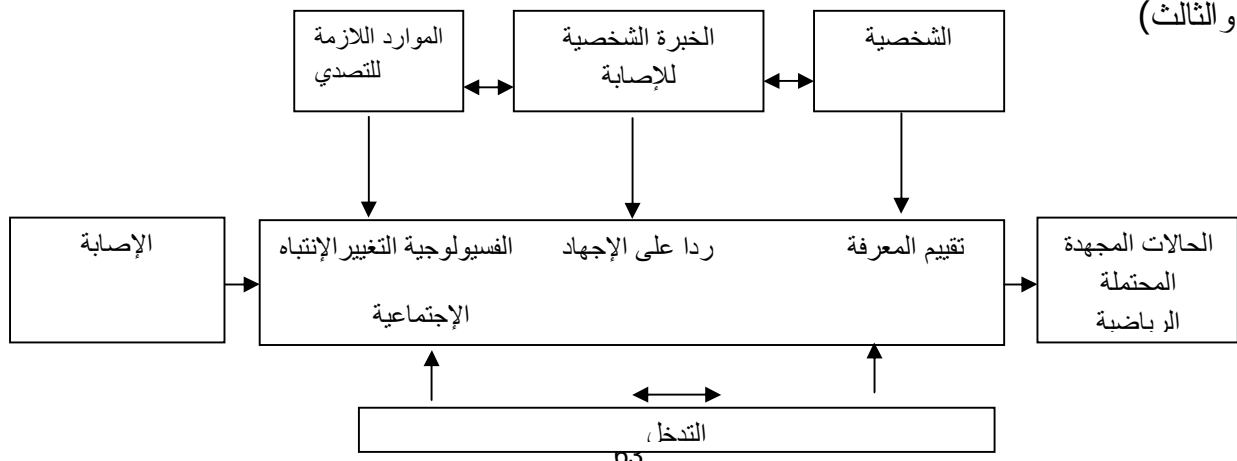
عضو مجلس محلي، (Kaniman. 1959) (Landers 1973، Wang، Courtet، 1985)؛
(Wanders، Rogers) (Weltma Egstrom 2003) (Williams، Tonymon، 1966) (Anderson، 1990).

بناء على هذه الدراسات، واقترح بعض الباحثين أن السلطة الرياضية هذه الاضطرابات اهتمام من شأنه أن يؤدي إلى الصعوبات في تحديد والاستجابة بسرعة لمنبهات البيئية تنبيههم من خطر على سلامتهم الجسدية (على سبيل المثال حركة لخصمك الذي يحاول معالجة في لعبة الركبي، مسار الكرة القيت من قبل زميله في كرة السلة). ومن شأن هذه الصعوبات المعرفية أثر إضعاف الجسد (1997 Williams et Andersson) (Williams et Andersson، 1998). على حد علمنا، أجريت دراستان للتحقق من هذا الاقتراح (Williams et Andersson 1999، 2005. Rogers، Wanders). كلا تثبت وجود علاقة كبيرة بين الرؤية المحيطية انخفاض في الوضع المجهد، ومظهر من قبل في أعقاب الإصابات الرياضية.

2. نموذج لربط التوتر مع وقوع إصابات: الإجهاد إصابة نموذج

نظرا للتأثير المحتمل للضغط على التسبب في هذه الرياضة، وقرر (Andersson Williams 1998) لإضفاء الطابع الرسمي على نموذج متعدد العوامل النظرية: الإجهاد والإصابات نموذج. هذا النموذج يشير إلى أن أحد الرياضيين وضعت في حالة توتر محتملة (على سبيل المثال الرياضية المنافسة، والتدريب المكثف) من المرجح أن يتصور أن هذه الحالة التي تهدد، وبالتالي يضر ق ط) لديه خبرة أحداث الحياة سابقا بأني كنت أرى الثاني غير المواتية) أنا هو سمة شخصية من التعرض للإجهاد،

والثالث)



الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

كان لديه القليل من الموارد الشخصية والاجتماعية للتعامل مع هذا الوضع المجهد. بصيغته المنقحة (Williams 1998)، وهذا النموذج يعتبر أيضا عرضة للمرض (Holmes, 1967) أو الإصابة بداهة (Holmes, 1970).

وقد تم تحديث العديد من الكتاب في وقت لاحق هذا البحث في مجال الرياضية من خلال تغيير SRRS إعادة التكيف الاجتماعي مقياس تصنيف لجعلها مناسبة لأحداث معينة أن الرياضيين يمكن أن يعيش في سياق ممارستها (مثلا تغيير من الوضع، والصراع مع مدرب). استخدام نطاقات جديدة، ولا سيما الاجتماعية "

وتقييم إعادة التكيف رياضية مقياس "(ACSES 1975، Bramwell، Holmes،)، في بروتوكولات البحث، أكدت أظهرت النتائج بواسطة (Holmes, 1970)، وذلك باستخدام SRRS، قبل بضع سنوات. لاختلاف النتائج تظهر أن وقوع أحداث كبرى خلال ممارسة الرياضة البدنية للمسؤولة جزئيا عن هشاشتها (Veach, Reed, & Griffey, 1985)، (Bramwell et ailes., 1975) (Schafer & McKenna, 1985). تظهر في البداية في سياق كرة القدم (Bramwell et al., 1975) (Troxel, 1980) ; Cryan & Ailes, 1983 ; Holmes, 1970)، والنشاط الذي منطوق داخلي يركز خصوصا حول الاتصال بين الأشخاص، وهذه العلاقة تم التحقق أيضا في ممارسة الرياضة المتنوعة مثل الجمباز (Kerr & Minden, 1988) والتزلج الألبى (May et al., 1985) أو تشغيل (Schafer & McKenna, 1985). ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن وقوع أحداث سلبية في حياة الرياضيين هي المسببة للأمراض.

لا يوضح ديناميات كأفراد إلى كل من هذه الأحداث. من خلال التركيز على البحوث أحداث الحياة أنفسهم على حساب نشاط الفرد التكيف مع التغييرات التي يخضع، هو وليس ذلك بكثير على الفرد الذي هو عرضة ويعتبر بيئته التي تكون المسببة للأمراض. حتمية جدا أحادي الاتجاه، كما SARRS SRRS تجاهل التمثيل كل رياضي هو انه يواجه أحداث الحياة (Falkstein, 1998)، حتى على الرغم من كل أثر خاص المعرفي والعاطفي لكل شخص. لدرجة أنه في الوضع المجهد، وتقييم ذاتي وهو مصنوع من الوضع هو أكثر أهمية من الحقائق نفسها (Lindsay Norman, 1980)، فمن المرجح أن هذه ليست فقط في عدد وشدة الأحداث التي يعيشها الرياضيين الذين يتحملون المسؤولية عن التسبب في إصابة ولكن تصورات وبالإضافة إلى ذلك من ضائقة أو، على العكس، وحسن بعد أن تكون هذه الأحداث، وهذا يعني، والتوتر. بعد عمل هذه المبادئ، والباحثين لذا أقترح موازين من أحداث الحياة من خلال هذا الموضوع الذي يقيم هذا الحدث كحدث طفيف أو كبير، ويعين التكافؤ،

الفصل الثاني

الإصابة والسلوك النفسي

إيجابية أو سلبية، كل على نطاق ونوع يكرت (e.g., Life Experiences Survey (LES), Sarason, Johnson), & Siegel, 1978) ; Athletic Life Experiences Survey (ALES), (Passer & Seese, 1983). بناء على هذه المقاييس، ويأمل الباحثون أن نفهم كيف دينامية الفردية التي تواجه الوضع المجهّد تؤثر على عملية المسببة للأمراض. وعموما، تؤكد الأبحاث أن يرتبط كل أحداث الحياة، إيجابية أو سلبية، مع وقوع إصابات (e.g. Blackwell & McCullagh, 1990 ; Gunnoe, Horodyski, Tennant, & Murphey, 2001 ; Hardy, Richman, & Rosenfeld, 1991) ; Hardy & Riehl, 1988 ; (Rogers & Landers, 2005). ومع ذلك، فإن الكتاب تختلف في تأثيرها عندما يتم تمييزها وفقا لالتكافؤ من أجل كل لعبة. بالنسبة للبعض، والأحداث السلبية من ذوي الخبرة فقط يؤهب للإصابة (e.g. Gunnoe et al., 2001) ; (Passer & Seese, 1983) ; (Patterson, Smith, Everett, 2001,) ; Pétrie, 1992 ; Pétrie, 1993) ; (Rogers & Landers 2005 ; Smith, Ptacek, & Smoll, 1992) ; (Smith, Smoll, & Ptacek, 1990). بالنسبة للآخرين، إذا كان تأثير هذه الأحداث تصور سلبي لا يمكن إنكاره، وخاصة على مدى خطورة الإصابة ((Hanson, McCullagh, & Tonymon, 1992)، وبعض الأحداث الإيجابية التي يعيشها الرياضيين على سبيل المثال تغيير كبير في مستوى المسؤولية

في فريق مسؤولة أيضا عن تكرار حدوث الإصابة (Hanson et al., 1992)، وحدة (Blackwell & McCullagh, 1990) أو الوقت الضائع في مجال التدريب بسبب الإصابة (Ford, Eklund, & Gordon, 2000 ; Pétrie, 1993). حول هذه النقطة الأخيرة، (Petri, 1993) تشير إلى أن هذه الأحداث الحياة، نظرت في البداية بأنها إيجابية، قد تصبح في نهاية المطاف إلى الأحداث السلبية المشاكل الحقيقية التي تشكلها على اللاعب. شرح جيد هذا التحول،

وفقا للمؤلف، مساهمتها في التسبب. هذا الاستدعاء ديناميكية ذاتية أن وراء إجراء تقييم أولي للوضع، هو تسلسل من شخص والبيئة العملية التي هي بارزة في التظاهرة، واستمرار أو اختفاء حلقة من التوتر (Lazarus & Folkman, 1984). قد يفسر هذه الصفقة افتراض أيضا لماذا التعرض المتكرر لشخص مع متاعب اليومية، والتي تتراكم الى حد الارهاق للغاية، لعب دورا رئيسيا في وقوع إصابات (Fawkner, McMurray, & Summers, 1999)

أخيرا، يمكن أن التجربة السابقة مع الإصابات الرياضية أيضا أن يكون حدث سلبي يؤدي إلى ظهور إصابات جديدة. وتظاهر نحو فعال العديد من البحوث الوبائية المحتملين وجود علاقة كبيرة بين وجود

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

الإصابات السابقة والمخاطر الحالية للإصابة (Kucera, Marshall, Kirkendall, Marchak, & Van Mechelen 1996); (Garrett, 2005) في نموذجهم، Williams (1998) Andersen تفترض أن هذه الإصابات يمكن أن تكون لها تداعيات الماضي نفسية هامة وتكون في الأصل من الإجهاد المرض. التجربة الفردية للإصابة التي ستكون مسؤولة عن ازدياد القلق والادراك السلبي على العودة إلى الرياضة ضعف من الناحية النفسية، فإن اللاعب يكون أكثر عرضة للإصابة.

ومع ذلك، إذا كان الارتباط بين وجود الإصابة السابقة ومخاطر جديدة.

قد يكون متورطاً تأسست إصابة، أي دراسة ركزت على عمليات الوساطة في هذه العلاقة.

1.2 التصرف الفردي للإجهاد و الإصابات الرياضية

بقدر ما تبدو مرتبطة الإجهاد في التسبب، قد تسبب التهيئة الفردية الإجهاد مباشرة الضعف البدني (Andersen & Williams, 1988): عدد وكثافة أحداث من الحياة أقل أهمية من العوامل من الحساسيات الفردية (Dantzer, 1989).

وقد دعمت العمل في علم النفس الصحة على وجه الخصوص فكرة أن العوامل الشخصية مثل العصبية، أو بشكل أكثر تحديداً، العداء، والاكتئاب أو القلق، هي سمة من الضعف الفردية للإجهاد والتنبؤ بذلك "الصحة البدنية للشخص (cf. Koleck, Bruchon-Schweitzer, & Bourgeois, 2003). وفقاً لهذه الدراسات، والدراسات التي أجريت في أحداث علم النفس الرياضي إظهار تأثير القلق تنافسية (Martens, 1977) في وقوع الإصابات الرياضية (Blackwell & sportives (Lavalley & Flint, 1994); (Kol t, Kirkby, 1994); (koll., 1992); (McCullagh, 1990) Pétie, 1993a); (1996). ومع ذلك، لم يرافق التقليدية التقييمات الذاتية للقلق (مثل القلق الرياضة سمة تنافسية (نوع من الموسيقي)، مارتينز، 1977) بقشور الدفاعي الحساسية (جداول تربط أو نفاق، وجداول الرغبة الاجتماعية)، أو عن طريق التدابير غير المباشرة (على سبيل المثال psychophysiological) تظهر اضطرابات عاطفية بموضوعية مواجهة الوضع المجهد، ومرتكب الجريمة عرضة للتحيز المنهجي في تقديم التقييمات يمكن أن تعتمد هذه الاحتياطات (Bruchon-schweitzer, 2002) ربما مزيد من المشاركة من القلق لشرح المرضية، في الوقت نفسه، لماذا لا تضع بعض البحوث

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

لا توثيق مساهماتها في وقوع إصابات (e.g. Kerr & Minden, 1988 ; Passer & Seese, 1983).

المكان من السيطرة الخارجية (Rotter, 1966, 1990) تتميز أيضا الضعف الفردية للإجهاد (Krause & Stryker, 1984) ، وبالتالي، فإن بعض الدراسات الضوء على مساهمة هذه العوامل في وقوع إصابات هذا التدبير له هو العام (Pargman & Lunt, 1989) أو محددة السياق الرياضية. (Dalhauser & Thomas, 1979) دراسات أخرى، ومع ذلك، فشل لإثبات تأثير هذا الحكم في الفرد المرضية ; Kerr & Minden, 1988 ; Hanson et al., 1992 (McLeod & Kirkby, 1995) وجدت دراسة واحدة حتى، على العكس، وهو موضع الداخلية للمراقبة قد تميز أيضا الإصابات الرياضية (Kolt & Kirkby, 1996) . أوجه القصور المنهجي للبحث، أي استخدام التدابير بأثر رجعي، وعدم وجود تدابير لغير المصابين الرياضيين (cf. Pétie & Falkstein, 1998, pour revue) ، مثل عدم مراعاة الأبعاد المتعددة لمفهوم المكان من السيطرة (Levenson, 1973, 1981)، يمكن أن تفسر هذه النتائج متناقضة.

إذا شخصية يمكن أن تكون سابقة مباشرة للإصابة، ومساهمتها يبدو أن لها علاقة أيضا إلى وجود في حالة مشغل الممرض (Bruchon-Schweitzer, 2002b). cf. في هذا المنظور، يمكن للتأثير على شخصية المرضية تعتمد على المواجهة الفعلية لتخصيص إلى الضغوطات، أي لحدث الحياة (Williams & Andersen, 1998)، والأحكام الفردية (على سبيل المثال الإحساس تسعى، واحترام الذات)، الذي مباشر تأثير على الآلية المرضية ليست واضحة، ويمكن بدلا من ذلك تساهم بصورة غير مباشرة . بل هو في الواقع الممكن، في إطار فرضية الاعتدال، وهذه الأحكام يمكن أن تفاقم من أثر واحد أو أكثر الأحداث المجهد على الصعوبات تعديل لهذه الرياضة، وبالتالي يؤدي إلى إصابة (مثل ماديسون

(Smith, 2005 ; Pétie, 1993a; Smith et al., 1992) وآخرون. درسوا بشكل خاص تأثير الإحساس تسعى في الوقت الضائع في مجال التدريب. بداهة، فإن هذا عامل شخصية تكون "salutogenic" بقدر أولئك الذين يسعون الأحاسيس هي أيضا تلك التي هي أكثر تسامحا من الولايات تفعيل عالية، الأمر الذي يجعل منها أقل عرضة لآثار الإجهاد (Johnson, Sarason, 1978; Siegel, 1979; Smith, Johnson, & Sarason, 1978) ، وبالتالي في الإصابات الرياضية. ومع ذلك، يمكن الإحساس تسعى وحده لا يميز إصابة الرياضيين الأصحاء. ومع ذلك، فإن تأثيره على المرضية يصبح كبيرا عندما تم القبض عليه، وليس بوصفه مؤشرا، ولكن كما

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

متغير الاعتدال في العلاقة بين التجربة من حدث المجهدة في الحياة والوقت الضائع في مجال التدريب. نظرا لسلبية حياة الحدث، والرياضيين تسعى الأحاسيس قليلة هي أكثر عرضة ماديا (Smith et al., 1992). وغيرها من المتغيرات مثل القلق (Pétie, 1993) التفاؤل ترتيبي، احترام الذات، والقدرة على التحمل النفسي (Ford et al., 2000) يسهم أيضا بشكل غير مباشر إلى المرضية. كل هذه النتائج تشير إلى أن عدم وجود علاقات مباشرة بين الميول الفردي وحدث الإصابات الرياضية لا تمنع من وجود علاقات غير المباشرة والمحتملة المتغيرات الاعتدال.

2-2- التعامل والإصابات الرياضية:

يتعرض الفرد للتوتر يعتمد على الجهود المبذولة من قبل الشخص قبل لمراقبة وتخفيف أو تحمل أثر هذا الحدث على رفاهية له (Lazarus & Folkman, 1984). موارد التكيف ضرورية للسماح للرياضيين للتعامل بفعالية مع الآثار الضارة للإجهاد على الصحة البدنية، وبالتالي تحتل دورا مركزيا في نموذج إصابة الإجهاد . (Williams, Andersen, 1998)

وذلك مرتبط بقوة تصور الدعم الاجتماعي للحفاظ على صحة جيدة عن طريق الحد من الضغوط النفسية (Sarason, Sarason, Potter, & Antoni, 1985). على وجه التحديد، والدعم الاجتماعي ينظر اثنين من آثار متناقضة حول المرضية غير من ناحية، فإن هذا البعد الاعتدال في العلاقة بين الحياة المجهدة و الحدث وقوع إصابات. ويون الدعم الاجتماعي منخفض جعل علاقة كبيرة بين الصورة السلبية أحداث الحياة السلبية

وقوع إصابات عند الدعم الاجتماعي عالية تعيق هذه العلاقة ; (Hardy et al., 1991 ; Patterson et al., 1998 ; Pétie, 1992, 1993b). من ناحية أخرى، يمكن أن الدعم الاجتماعي لها تأثير مباشر على الجرح، والضغط تجربة حياة الحدث (Hardy et al., 1991). ومع ذلك هذه التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، لا يتم التحقق دائما (Lavalley & Flint, 1996 ; Rider & Hicks, 1995 ; Rogers & Landers, 2005 ; Smith et al., 1990)

بعض المهارات النفسية تسمح أيضا التعامل مع الأحداث المجهدة {مهارات إدارة الإجهاد} وبالتالي تساعد على حماية أنفسهم من الإصابة المحتملة (Smith et al., 2005) ; (Rogers, 1990). وهي تشمل القدرة على التحكم في تفعيله، والتركيز على والبقاء واضح التعامل مع الإجهاد، ووضع أهداف محددة، والميل إلى المشاركة في حل المشاكل و الاستراتيجيات والميل إلى

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

الحصول على تغذية دعم لتصحيح. فإن هذه المهارات، ولكن، ليس لها تأثير مباشر على وقوع أو عدم وجود الإصابات الرياضية

ومع ذلك، بعض الموارد ذات الصلة لنمط الحياة (مثل النوم، وتستغرق وقتا لنفسك) ويبدو أن العوامل الوقائية ضد الإجهاد وبالتالي، تواجه خطر الاصابات الرياضية على الرغم من أن هذه النتائج لم تتكرر دائما (Lavallee & Flint, 1996 ; Pétrie, 1993a ; Rider & Hicks, 1995 ; Rogers & Landers, 2005 ; Smith et al., 1990)

نتائج الأدب وبالتالي تفتقر إلى التماسك. ويبدو أن هذه الموارد للتعامل مع التوتر لا يمكن أن تميز فقط من الضعف المادي للشخص وليس توضيح أحكامها الإصابة الجسدية والنفسية. ومع ذلك، اتخذت في الاعتبار تفاعلاتها وتأثيرها مجتمعة لتوصيف أكثر من الاتساق مع الناس الضعفاء بدنيا (2005)، (Prapavessis, 1990). في دراسة حديثة، (Prapavessis, 2005) تبين أن الدعم الاجتماعي المنخفض واستراتيجيات التعامل معها على أساس تجنب نوعان من العوامل تعمل معا لتضخيم تأثير الأحداث المجهدة في موضوع الصحة والرياضة (أي عدد الإصابات والوقت الضائع في التدريب). فقدت هذه النتائج تنفق مع ما ورد في دراسة أخرى تشير إلى أن الجمع بين هذين المتغيرين (الدعم الاجتماعي والتكيف) ويوضح الفرق أكثر من مرة في التدريب بسبب من أحداث الحياة السلبية في تحليل إسهامها بشكل منفصل (Smith; 1990) وآخرون ويمكن إدراج العوامل الإضافية (مثل القلق واضطراب تركيز ديل الماضي، يضر، ووضع لاعبين) في هذا النوع من التحليل تضخيم العلاقة بين الإجهاد والإصابة (2005 و Prapavessis، Petrie). وأظهرت من بين أمور أخرى، أن حالة لاعب (شاغل الوظيفة أو ما يقوم مقامه) تأثير كبير على العلاقة التي تربط الأحداث المجهدة في الحياة (توقع)، والدعم الاجتماعي ينظر إليها (منسق) وإصابة (معيار). إذا كانت هذه العلاقة ليست كبيرة لحاملي بدائل لاعبي كرة القدم، الذين تعرضوا للإصابة هم أيضا أولئك الذين يعيشون حياة أكثر الأحداث السلبية وتعود بالنفع على الأقل الدعم الاجتماعي. ومع ذلك، فإن مثل هذه المنهجية تتطلب اهتماما خاصا بشأن حجم كل المجموعات الفرعية، وانخفاض متناسب بواسطة تكاثر المتغيرات (أرنو عام 1982؛ بيتري، 1993)

2-3 - البرنامج للوقاية من الإجهاد والإصابات الرياضية

في حين أن الدراسات المستقبلية تؤكد على أهمية التصدي الموارد في تطوير الإصابات الرياضية (e.g. Smith et al., 1990)، وقد اقترح القليل من البحث في دور "salutogenic" التي يمكن أن تقوم به برامج منع لاقتناء هذه الموارد (Davis, 1991 ; Johnson, Ekengren, & Andersen, 2005 ; Kerr & Goss, 1996) ; (Perna, Antoni, Baum, Cordon,

الفصل الثاني

الإصابة والسلوك النفسي

(Schneiderman, 2003 & . في دراسته، يدل على أن تدريب الرياضيين في تقنيات الاسترخاء التدريجي جنبا إلى جنب مع تنمية القدرات العقلية التصوير يقلل على التوالي 52% و 33% من عدد الإصابات الجسدية في السباحة وكرة القدم . وفي الآونة الأخيرة، قد أظهرت أن برنامج التدخل (مثل الاسترخاء، وتحديد الأهداف، والثقة بالنفس) التي أجريت بين لاعبي كرة القدم تعتبر "في خطر" بسبب ملفه الشخصي النفسي (مثل القلق وضغوط الحياة، وانخفاض موارد التأقلم وكان "salutogenic" التعاقد مع هذه المجموعة من اللاعبين أقل إصابات من مجموعة المراقبة الذي لم يحصل على برنامج نفسك. وتتكرر هذه النتائج في دراسة أخرى (Prapavessi, 2005). أنها تعزز بالتالي الدور المحتمل لهذه البرامج في الوقاية من الإصابة من خلال مساعدة الرياضيين على حماية أنفسهم من الآثار الضارة للإجهاد الممرض. هذه البرامج تساهم ولا سيما في الحد من القلق (Johnson et al., 2005) (Maddison & Prapavessis, 2005) ;. على الرغم من أن الدراسات حتى الآن لم تستطع التوصل إلى نتيجة بشأن دور وساطة من هذا المتغير.

3. تأكيد نموذج للإجهاد إصابة مع وقوع الربط

(نموذج الإجهاد للإصابة)

إذا يبدو واضحا أن الناس المعرضين للضغوط الناجمة بسبب خبرتهم، شخصيتهم و / أو مواردها الذاتية، هي واهية بدنيا، وقد حاولت دراسات قليلة جدا حتى الآن للتحقق من إذا كان هؤلاء الناس هم أيضا منزوع وجه الوضع المجهد. ومن المفترض بعد هذه الاضطرابات أن يكونوا وسطاء في العلاقة بين الخصائص المميزة للضعف و الإجهاد والإصابات (Williams & Andersen, 1998). تماشيا مع الدراسات التي تبين أن التعرض لشخص لظروف ضاغطة في النتائج المختبرية في اضطراب الرؤية المحيطية (على سبيل المثال (e.g. Bursill, 1958) ، وقد أبرزت بعض البحوث أيضا تأثير معتدل من الخبرة مؤخرا حدث الحياة على عجز الانتباه أثناء الوضع المجهد التجريبية (Williams et al., 1997 ; Williams & Andersen , 1990) ; (Rogers , 2003) (Williams et al., 1991) ; 1990. وقد أظهرت إحدى الدراسات أيضا أن هذا التأثير هو في حد ذاته خاضعة للإشراف من خلال وجود موارد التأقلم. وهكذا، والرياضيين تلقي الدعم الاجتماعي المنخفض، بعد أن خاض تجربة أحداث الحياة السلبية، وأن ضيق الرؤية المحيطية هو الأكثر أهمية التي تواجه ظروف ضاغطة من أحد المختبرات، وأيضا أولئك الذين يحصلون على مزيد من الاصابات في سياق الرياضة (Andersen, 1990) Williams &) Andersen, 1990 وتؤكد هذه النتائج في

الفصل الثاني

الإصابة والسلوك النفسي

دراسة حديثة مقارنة رياضي لظروف ضاغطة في أي الحقيقية، والوضع في المنافسة (روجرز واندروز، 2005). أنها تسمح العثور على أثر وساطة من عجز الإنتباه في الوضع المجهد على العلاقة بين أحداث الحياة السلبية والمرضية، على الرغم من اضطرابات الانتباه الأخرى (على سبيل المثال، والتشتت) أو اضطرابات فسيولوجية معينة (أي زيادة التوتر العضلات) ومن المحتمل أيضا أن تشارك في هذه العلاقة.

4. القيود المفروضة على نموذج والمنظورات البحثية

وقوع (كثير) الأحداث المجهد في الحياة الرياضية لشخص أو اجتماعي يبني السياق الذي يمكن أن يستمر إما أن تزدهر، أو على العكس من أن تضعف بشكل دائم. هذه النتيجة يتوقف على تصرفات حالته النفسية والموارد لديها لمواجهة أكثر أو أقل فعالية لهذه الأحداث والضغط لذلك (Williams & Andersen, 1988), في اشارة الى وضع حد الإجهاد اصابة (Williams & Andersen, 1998), وهذه العوامل يمكن أن تحدد بالاشتراك الرياضيين الضعفاء جسديا. يجب أن مساهمة بعض المتغيرات (على سبيل المثال، موقع السيطرة، والتعامل موارد) قد يكون مع ذلك يخضع لمزيد من الدراسات في أن نتائج معينة أو أي مادة متناقضة أحيانا. ولذلك فمن الضروري مواصلة استكشاف، مستقبلا، وذلك باستخدام أدوات قياس محددة السياق الرياضة (Falkstein, 1998)، والظروف الشخصية والسياقية التي من خلالها تشارك في الواقع الضغط في وقوع من الجرح.

وركزت بشكل خاص على القليل من البحث في العلاقة بين الاستجابة للإجهاد والإصابات. وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات في هذا المجال لاختتام دور وساطة من المظاهر النفسية والجسدية في التسبب وتأثيرها مجتمعة.

أبعد من هذه الاعتبارات ومع ذلك والتأكيد على إصابة لديها نموذج القيد الرئيسي اعتبارا من لا تفكر في وقوع الإصابة التي من خلال تتويجا لسلسلة من مظاهر الإنتباه والجسدية التي يكون الشخص لديه أو مسؤولية، وتنفي سيطرة. حتمية جدا، وهذا النموذج استبعاد احتمال أن يرتبط أيضا عن إصابة لاختيار الأفراد، وخاصة مشاركتها متعمد في السلوكيات التي يمكن أن تقوض (Déroche, 2007). عن طريق تقييد التحليل على جزء فقط من الآثار الضارة للإجهاد، وهذا النموذج لا أخيرا

الاعتبار العوامل النفسية لهذه السلوكيات، في حين أن الصورة يمكن أن تكون عوامل عديدة من الضعف والحماية ضد خطر الإصابة.

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

هذا العمل الدكتوراه ولذلك يسعى إلى تحديد العوامل المسببة للأمراض الجديدة المحتملة. في المقطع التالي يناقش إمكانية تحديد، في سياق الممارسات البدنية والرياضية، والسلوكيات ذات الصلة وقوع إصابات. استنادا إلى دراسات في علم النفس الصحة، وتهدف أيضا إلى التمييز بين المحددات النفسية لهذه السلوكيات

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

5-المعتقدات السلوك المتصلة بحالات الإصابة

وينبغي التركيز على التوتر والعوامل المرتبطة به في دراسة المرضية لن تكون حصرية. لقد أظهرت دراسات قليلة في الواقع أن وقوع حوادث غالبا ما يعتمد على إعادة توظيف أي شخص في السلوكيات التي يمكن أن تزيد إما من خطر الإصابة أو للحيلولة دون وقوعها على خلاف ذلك على سبيل المثال (Mohtad، 1999، و Meeuwisse) علم من هذه السلوكيات

ويمكن التعرف على محدداتها النفسية تساعد على ذلك لإثراء فهم العمليات التي تقود الشخص إلى تضار. يقدم هذا الفصل استعراض الدراسات التي ربطت السلوكيات أن الشخص.

قد تعتمد في حين تشارك في أي نشاط بدني أو الرياضي وقوع اصابات. ويدفع أيضا اهتماما خاصا لدور الممرضة السلوك المحتمل للرياضيين، عند إحساسهم بألم. وعلاوة على ذلك، ما يفسر لماذا هذا الفصل النهج الاجتماعي المعرفي يمكن أن يوفر إطارا لتحليل المحددات النفسية لهذه السلوكيات، وكيف يمكن أن تستكمل هذه المناهج من قبل مساهمة العوامل الشخصية.

1. السلوكيات الصحية والإصابات

الآلية المرضية ويبدو أن ترتبط بشكل أساسي إلى التزام سلوك الشخص في بعض الوقايات الذكرية وقائية (مثل استخدام، وارتداء معدات)

الفصل 2. المعتقدات والسلوكيات حماية) أو السلوكيات المحفوفة بالمخاطر معينة (على سبيل المثال مع المخدرات، وممارسة الجنس غير الآمن، والنشاط البدني يحتمل أن تكون خطرة).

5-1-تعريف وتوصيف السلوكيات الصحية

مفهوم السلوك الصحي يشير إلى الإجراءات كافة على حد سواء طوعا أو التي تحافظ على تعزيز الحالة الصحية للشخص أن السلوك الذي يضعف حتى الضرر (Fickers, 1990) (1990 ؛ Wasylikiw)

وقد تم دراسة السلوكيات الصحية على نطاق واسع في سياقات مختلفة. وبالتالي، لقد لاحظت بعض الدراسات أن ممارسة النشاط البدني بانتظام وعقلاني مسبب (مثل الركض) أو اعتماد سمات سلوك غذائي متوازن لتعزيز الوقاية والصحة على سبيل المثال (Drinkwater 1995 ، ، Harter ،)؛ منظمة الصحة العالمية، (OMS 1998، 2003) (Heymsfield،)، جنبا إلى جنب مع تورط في فحص طبي منتظم (مثل تنظير القولون ، التصوير الشعاعي للثدي) لتحديد

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

الأمراض (مثل السرطان) في مرحلة غير متناظرة مثل الوكالة الوطنية لتقييم اعتماد الصحة الإلكترونية، (1998؛ Biancci Vanio). وأظهرت دراسات أخرى، على العكس، أن بعض العادات الصحية مثل انخفاض استهلاك الفواكه والخضار أو الشرب أو التدخين، وتفاقت خصائص السلوك المستقرة في خطر على سبيل المثال والقاعدة، عام (2002؛ Rmady، وErikssen، Sathetrland، (2001؛ Furu)، (1997؛ Leo)، (2001؛ McGinni S & Foege، 1993؛ Marcs)، وكذلك بعض خطوط عرضية مثل القيادة وهو في حالة سكر (1994؛ Holubowycz، Kloeden)، و(1994، 1995، 1995؛ Beirness).

وقد سعت بعض الدراسات أيضا إلى تحديد ما قد يكون في السلوكيات الصحية الرئيسية في سياق معين من النشاط البدني و / أو الرياضي. ما تبقى من هذا الفصل استعراضا للدراسات التي ترتبط السلوكيات لمنع حدوث أو وقوع إصابات. هذا جزء يخطط أيضا خط من الأبحاث لتحديد سلوك جديد X مسببات الأمراض في النشاط البدني و / أو الرياضي.

5-2- السلوكيات الصحية في النشاط البدني و / أو رياضي

إن أضرار أنشطة اجتماعية معينة، ولا سيما مياه الشرب والتدخين بشكل مفرط، يتم تأسيس، فمن الصعب الآن تحديد الأنشطة الرياضية التي تمثل خطرا حقيقيا على صحة الشخص. وقد أثبتت الدراسات لا لمعرفتنا في الواقع تصنيف علمي واضح والمرضية من الأنشطة البدنية، على الرغم من بعض (أي القفز بالمظلات، وتسلق الجبال، وقاعدة للقفز) هي "بشكل طبيعي" تعتبر الأنشطة خطر (Blenner 1993) (1991؛ I-Freixanet-) (1991؛ Jack) (1998؛ Murray) (2003؛ Zokrman)، - النظر أيضا أكثر ذات الصلة إلى وجود هذه الأنشطة في خطر مميت (أي القتل) عن وجود قسط كبير من المراضة. وبعبارة أخرى، أكدت الدراسة أن الناس لا يمارسون هذه الأنشطة هي أكثر عرضة للإصابة من الناس الذين يتورطون في الممارسات التقليدية (مثل كرة القدم، الجودو، التنس). على ما يبدو التي اعتمدت وقوع الحوادث والإصابات هو أكثر ذات الصلة لسلوك الشخص عندما ينخرط في الأنشطة البدنية و / أو يحتمل أن تكون الرياضة المسببة للأمراض.

الممارسة الفعلية (e.g. Benson et al., 1999) ; Spaite, Murphy, Criss, (Valenzuela, & Meislin, 1991) ; United States Consumer Product Safety (1994). Commission , وبالتالي، جرح اللاعبين الذين لا يرتدون أحذية مناسبة لهذا النشاط (الأحذية والجلود والمرابط) أكثر (McManu s et al., 2004). وبالمثل، فإن استخدام في لعبة الركبي أمر ضروري للحد من خطر الإصابة أو الوجه (Marshall et al., 2005). من

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

المتزلجين 8648 عن وقوع إصابات على الطرق في الولايات المتحدة بين آب 1992 ومايو 1994، وارتدى واحدة فقط من 44 المتزلجين حراس المعصم (الولايات المتحدة جنة سلامة المنتجات، 1994). تشير الدراسة إلى أن الدوارة، وارتداء واقية المعصمين والمرفقين أو الركبتين يقلل من عدد الإصابات بنسبة 87% عن المرفقين، والمعصمين إلى 82% و 32% للركبتين (Schieber et al., 1996). نشاط والتزلج، وركوب الدراجات هو نشاط شعبي ولكن الممرض جدا (الولايات المتحدة جنة سلامة المنتجات، 1994). إصابات في الرأس، مما تسبب الإعاقات الشديدة والوفاة، وتكثر خاصة منذ تمثل ما يقرب من ثلث مجموع الإصابات (Wood & Milne, 1988); (Cohen. 1986). الخوذة هي وسيلة فعالة لتفادي وقوع إصابات في رياضة الدراجات (Thompson, Rivara, & Thompson, 1989)، والحد من 45% إلى 63% من إصابات الرأس (McDermott, Lane, 1994). (Thoma s ., 1994) ; (Brazenor, & Debney, 1993). في خلاصة القول، ان ارتداء معدات الوقاية أمر بالغ الأهمية لذلك البقاء في صحة جيدة عندما يكون الشخص لديه للقيام بأنشطة من مسببات الأمراض مثل لعبة الركبي، التزلج، أو ركوب الدراجات. وعلاوة على ذلك، فقد أظهرت بعض الدراسات أن يرتدي معدات الوقاية يعكس اتجاهها أكثر شمولية لتجنب الانخراط في السلوكيات.

وقد وجدت الدراسات التي أجريت من معدات الوقاية في غيرها من الألعاب الرياضية، نتائج مماثلة. آخرونو (Benson, 1999) وجدت أن لاعبي الهوكي بما في ذلك ارتداء خوذة يحمي جزئيا فقط وجوه كانت 3، 2، 9-9 مرات أكثر عرضة للإصابة الرأس من تلك التي مع تغطيتها بالكامل (cf. (Fischer, & Larson. également Stuart, Smith, Malo-Ortiguera 2002) وقد أظهرت الكتاب الآخرين أيضا أن يرتدي خوذة أمر أساسي في الرغبة في تفادي وقوع إصابات الرأس إلى المتزلجين أو المتزلجين (Goulet, , 2000) (Ekeland & Rodven, 2000) (Macnab, Smith, Gagnon, & Macnab, 2002) (Robitaille, 2005) (2000)

يحتمل أن تكون الممرضة في النشاط البدني. على الرغم من أن يرتدي خوذة لا يحمي الجسم كله، (Spaite, 1991) وآخرون. لوحظ إلى انخفاض كبير في شدة وقوع إصابات بين راكبي الدراجات خوذات. من خلال عدم الأخذ في الاعتبار في إصابات الرأس الإحصائية يحلل وراكبي الدراجات الذين لا يرتدون خوذات وسبع مرات أكثر احتمالا للتعرضه لصدمة كبيرة من قبل الدراج خوذات. هذه النتائج تظهر بوضوح أن عدم استخدام خوذة يعكس اتجاه أوسع من أن يكون الدراج في السلوكيات الخطرة في نشاطها. ويبرز هذا الاتجاه في دراسة أخرى تبين أن راكبي الدراجات من دون خوذة يتعرض لها 6 مرات أكثر عرضة للقيادة وهو في حالة سكر.

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

ومرتين أقل عرضة للتوقف في وقف علامات، وسبع مرات أقل احتمالا لاستخدام إشارات اليد لإعلام مستخدمي الطريق الآخرين من نواياهم (1997، و Meislin). هذه النتائج تدعم الحاجة إلى النظر في تشكلات معينة من السلوكيات الصحية للتعرف على الناس من يتخذ من المخاطر وحماية أنفسهم عندما يمارسون نشاطهم البدني و / أو رياضتهم.

ويمكن أن تكون السلوكيات الصحية الأخرى آخر أسباب الحوادث عند ممارسة النشاط البدني أو الرياضة هي المسؤولية بشكل مباشر عن الطاقة الفائضة للتكيف للشخص. بعض السلوكيات تظهر، على سبيل المثال، مؤثرا في وقوع الحوادث البحرية في حين قرش البيوفيزيائية الغوص، الغوص إلى أعماق كبيرة وعدم احترام سلامة (مثلا: المستويات، والحد الأدنى من الوقت بين الغطس) يؤدي فعلا إلى إنشاء إزالة كافية من النيتروجين المتراكمة في أجزاء مختلفة من الجسم من الغطاس. هذه السلوكيات هما خصائص السلوك للخطر (2003 Bonnet ، Pedinieli ، Rouan). ولقد ثبت أيضا أن أخطاء من الرياضيين في برامجهم التدريبية .

كثافة من الدورات، مسافات، والتدفئة غير كافية تعطيل تكيف الجسم على الاجهاد (Hreljac, 2004)، ويمكن أن تفسر بالتالي وقوع اصابات خلال النشاط البدني،

(e.g. Vader, Minder, & Abelin, 1988 ; Messier & Pittala, 1988)

اعتماد بعض السلوكيات ويبدو أن يفسر لماذا يصاب الناس عندما يمارسون نشاطهم البدني و / أو رياضتهم. لتعزيز الكشف المبكر عن الضعفاء، يبدو من المهم أن تحدد، في هذا السياق المحدد، سلوكيات جديدة لمسببات الأمراض. معظم الدراسات التي تركز على السلوكيات الصحية الوقائية، وهذا يعني، والسلوكيات التي تحمي الفرد من مغبة المسببة للأمراض وقوع حادث (على سبيل المثال يرتدي خوذة). يبدو أن هناك حاجة لتسليط الضوء على وجود السلوكيات الصحية المحفوفة بالمخاطر، مسؤولية مسؤولية مباشرة عن اضطرابات التكيف والحوادث الناجمة عن ذلك. إلى حد أن الدراسات أثبتت تأثير مدمر من اضطرابات الانتباه (Andersen & Williams, 1999) تحديث السلوكيات أو منع هذه الاضطرابات ربما خلال الممارسة الفعلية تحديد وقوع اصابات. إلى حد ما، علاوة على ذلك، قد بنيت الباحثين والممارسين في كثير من الأحيان بروتوكولاتها على عدم مراعاة السلامة في ممارسة النشاط البدني (cf. Benson et al., 1999 ; Marshall et al., 2005)، وسيكون من المثير للاهتمام أن تولي اهتماما خاصا لاتخاذ المخاطر بقيمة اجتماعية. مع الإشارة إلى هذه الآلام، وجهات النظر والسلوك بما يتفق ويبدو أن وجود ذات الصلة من الدراسة.

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

فمن الممكن أن الرياضيين الذين يميلون إلى المحافظة على استثماراتهم عندما يشعرون الألم الجسدي، أو لتحمل التمارين مؤلمة، ويمكن أن تزيد من مخاطر الإصابات عن طريق تضخيم مطالب الانتباه المرتبطة المهمة الحالية من جهة، وشدة الألم من جهة أخرى. على الرغم من الاهتمام في الآونة الأخيرة ألم في سياق الرياضة توجد دراسات على حد علمنا لم تهتم حتى الآن في التعبير السلوكي من الألم من خلال النشاط البدني، وسعت لذلك للتأكد من أن ما المواقف حد ما عن الألم يمكن أن تمنع أو غير ذلك تسهيل ظهور إصابات

5-3- التغلب على الألم: 1 القيادة الرياضية بالمخاطر

دراسة سلوك هذا السياق دان الرياضية أهمية خاصة لما يمكن أن تتحول بعض الألعاب الرياضية في أماكن التحرش المعنوي مصدقة. قد يكون الخوف من الاحتقار والتهميش اثر اصابة أو موقفا من لاعبي الرياضات الأخرى الانخراط في آليات معينة من الحرمان من الألم (Flint, 1998). (Misner, 1992) يؤكد أن المدربين أو الزملاء يميلون إلى التقليل من الرياضيين الذين يرفضون هزيمة عندما يشعرون آلام. وعلى العكس، هو تضخيم في كثير من الأحيان تتجاوز أكثر من هذا الألم و ولذلك فمن المشتركة للرياضيين الذين يعانون من آلام حاد الاستمرار في ممارسة أعمالهم، لدرجة أن الألم يشكل في نهاية المطاف في المستوى المقبول. أكثر من في أي سياق آخر، يبدو من المهم التعرف على الآثار المسببة للأمراض من هذه السلوكيات، والنظر في العوامل الفردية.

5-4- المحددات النفسية من السلوكيات الصحية

ويجب أن يرتبط اعتماد سلوكيات معينة إلى حدوث عن وقوع اصابات خلال ممارسة النشاط البدني و / أو الرياضي(على سبيل المثال دعونا (المشير محمد، 2005). برامج الوقاية من الإصابات يكون ذلك لإقناع الناس لتبني السلوكيات الصحية أو خفض مشاركتها في السلوكيات الخطرة. التنقيب والإنتاج، وتصميم وفعالية هذه البرامج تحتاج إلى فهم مفصل للعوامل والعمليات التي تحدد هذه السلوكيات. وهذا الفهم يبدو هو أكثر ضرورة خصوصا أن هذه السلوكيات الصحية واضحة نادرا إلى الجهات المعنية. على سبيل المثال، يبدو واضحا أن هذه المعدات ميناء يوفر الحماية ضد مخاطر ممارسة الرياضة البدنية

التزلج وركوب الدراجات خصوصا، العديد من الدراسات تؤكد المفارقات أن بعض المتزلجين، أي (cf. Adams , Wyte , Paradise, & del Castillo , 1996) (al. ,) 7-1,4 (Williams-Aver y & MacKinnon , 1996) وبعض راكبي الدراجات، أي

الفصل الثاني

الإصابة والسلوك النفسي

14-39% (cf. Lajunen & Räsänen , 2001) تقرير تحمل معدات للوقاية من خطر الإصابة، أي خوذة، وحراس المعصم والكوع والركبة، في حين أن بعض في حيازة هذه الحماية (Schuster & Jacques, 1994) (Everett, Price, (Bergin , & Groves, 1996) (Israeli 1999) .

وقد أظهرت بعض الدراسات أن الذين عانوا من مشاكل الصحة يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود السلوكيات الصحية الوقائية (e.g. Rutter, Quine , & Albery , 1998). على سبيل المثال، السائقون الذين تعرضت لحادث في السنة هي أيضا أكثر تركيزا وأكثر من ذلك استخدام المعدات الواقية والملابس أي ضوء، مقارنة مع السنة السابقة. (Rutter et al. , 1998) وعلاوة على ذلك، والنساء اللاتي تعرضن للأعراض الصدر هم أكثر عرضة لإجراء اختبارات للكشف عن سرطان الثدي ممكن (cf. McCaul , Branstetter, Schroeder, & Glasgow , 1996,) ومع ذلك، والنماذج كثيرة، وخاصة الاجتماعية والمعرفية نماذج من الصحة، والتأكيد على أهمية العوامل النفسية في اعتماد سلوكيات صحية أو خطر.

5-5-مساهمة الاجتماعية المعرفية نهج الصحة

الاجتماعية والمعرفية نماذج من الصحة (e.g. Modèl e des Croyances sur la Santé , Health-Belief Mo del : Becker & Maiman . 1975 ; Rosenstock, 1990 ; Théori e de la Motivatio n à se Protéger , Protection Motivation Theory : Prentice-Dunn & Rogers, 1986 ; Théori e du Comportemen t Planifié , Theory of Planned Behaviour ; Ajzen , 1988, 1991, 1998) : نرى أن المعتقدات والتصورات المسبقة والتمثيلات لشخص لعب دورا في اعتماد سلوكيات

الصحة أو على العكس في إعادة الارتباط في السلوكيات التي تضعف (Bruchon-Schweitzer, 2002). وتستند هذه النماذج في الغالب على نظريات صنع القرار على سبيل المثال نظرية المنفعة المتوقعة موضوعية، ذاتية نظرية المنفعة المتوقعة (Edwards, 1954)، تحت أي شخص، قبل العمل، (أ) يحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة (ب) يحدد الآثار المترتبة على كل عمل؛ (ج) تقييم مدى جاذبية أو قيمة من كل ذلك؛ (د) وتقدر احتمال أن يترافق كل ذلك مع الإجراءات التي ينظر فيها، (هـ) وجميع بين مختلف هذه خطوات لاتخاذ قرار عقلائي. (Van der Pligt, 1996)

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

5-6-6- وتمثل أهمية المعرفة الاجتماعية نماذج من الصحة

5-6-1- النموذج الإيمان على الصحة

النموذج الأول بنيت بهدف شرح ما يشجع الشخص على التصرف في صحة الإيمان هو نموذج للصحة (MCS)، نموذج المعتقد الصحي (Becker, 1984) (Becker & Maiman, 1975)، (Rosenstock, 1974, 1990)؛ أسفل البريد على أساس أن الصحة هي قيمة هامة بالنسبة للشخص، وأن هذا القرار هو سلوك عقلائي، وهذا النموذج يركز على ستة عوامل تحديد احتمال وقوع * سلوك صحة (انظر الشكل 2)

- ضعف ينظر إلى مشاكل صحية (الحساسية في نظر الناس)، أي تقييم لاحتمال مواجهة هذه المشكلة
- وجدية (أو شدة) من ينظر إلى "مشكلة صحية {خطورة في نظر الناس)، أي تحسبا للعواقب الوخيمة لهذه المشكلة؛

• التصورات من الحواجز المدركة التي تحول دون اعتماد السلوك الصحي؛ هذا العمل الدكتوراه يركز فقط على النماذج المعرفة الاجتماعية للصحة التي تصنف على أنها المعرفة الاجتماعية نماذج ثابتة مقابل الديناميكية، على سبيل المثال النموذجي من التغيير، ونموذج Transtheoretical التغيير: Prochaska، DiClemente، (Norckos, 1992)، نموذج عملية اتخاذ الاحتياطات اللازمة، نموذج التحوط عملية التبني: (وينشتاين، 1988). وردت ولكن ديناميات هذه الصورة نموذج في مناقشة الدراسة (3) وعند الانتهاء من هذا العمل الدكتوراه

الفوائد المتصورة والمرتبطة اعتماد السلوك الصحي

تصور بعض القرائن التي تشارك الأفراد على العمل (وكان لمشاركة)، مثل أعراض أو معلومات مختلفة عن منع الحملة من وسائل الإعلام المختلفة والتي تواجه كل على حدة؛ والدوافع في الصحة (أسباب صحية)، أي ميل من شخص إلى أن تولي اهتماما لصحة (جيد) وسلامته.

خطورة ينظر الفوائد المرجوة من إجراءات وقائية لمسارات الحواجز للعمل

المتصورة ما ينظر الجاذبية

فوائد اتخاذ إجراءات وقائية:

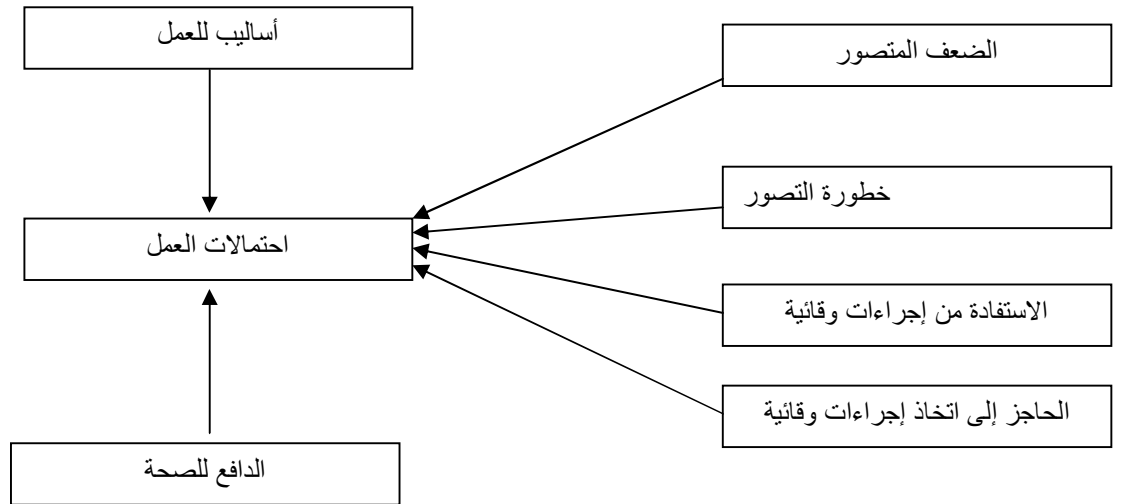
الحواجز التي تعترض العمل.

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

أساليب للعمل.

احتمال وقوع عمل.

الدافع للصحة.



الشكل 2. تأثيرات المعتقد الصحة نموذج من (becker, Janz ,1984)

2-6-5 - نظرية الدافع للحماية

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

وقد وضعت مع افتراض ان الخوف يدفع نظرية الدافع للحماية TMP , Protection Motivation (Rogers, 1983) ; (Rogers, 1975) , Prentice-Dunn & Motivation (Prentice-Dunn, 1997) الناس على تغيير السلوكيات (انظر الشكل 3). هذا استنتاج النتائج من اثنين من العمليات المعرفية التي تحدث عندما يكون الشخص يواجه تهديدا.

• تقييم التهديد أي تقدير لشخص ما من تعرضها لهذا التهديد وحدته في حالة رد فعل غير مناسب للسلوكية (أو في غياب ردود الفعل المناسبة)؛

• وبعد هذا التقييم الأولي، وتقييم الفرد لقدرته على التعامل مع هذا التهديد (تقييم التكيف)، أي تقدير لفعالية السلوك الموصى به (أو تكيف)، والقدرة على تطوير الشخصية هذا السلوك (النجاعة).

وعلاوة على ذلك، ويتأثر سلبا الدافع لأداء استجابة أوصت به لتكاليف (الاجتماعية والمادية أو المالية) من هذا الرد، والمنافع المحتملة من ردود أخرى، فهي ليست كافية

*العمليات المعرفية الوسطى

* استجابة الضعف الداخلية والخارجية المكافآت

*تقييم التهديد و الدافع هو الخوف

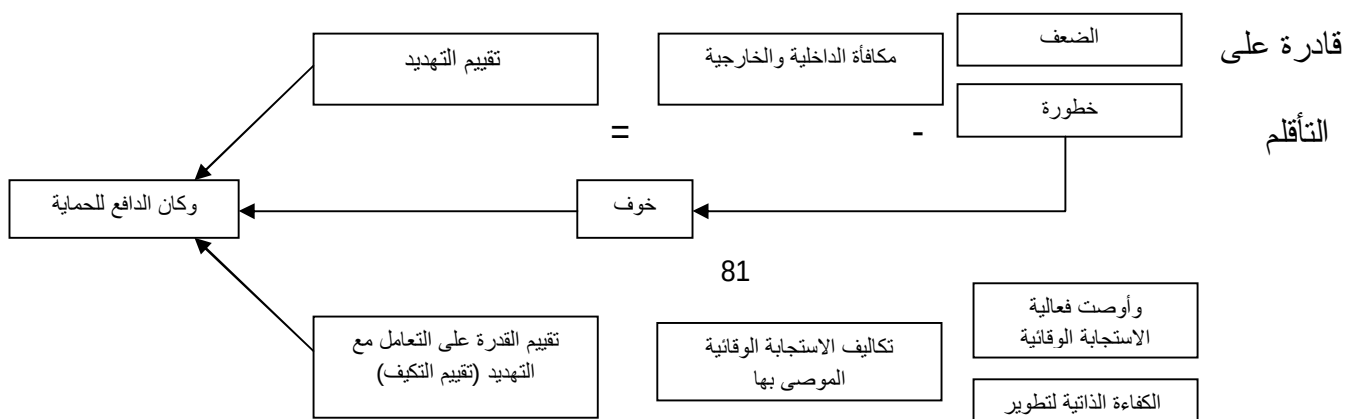
*حماية

*استجابة مناسبة

*استجابة الكفاءة ضياء وأوصت فعالية وقائية الذات المتصورة لتطوير استجابة تكاليف الاستجابة الوقائية الموصى بها

*ضياء تقييم القدرة على التعامل مع التهديد

استجابة غير



الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

استجابة

=

-

مناسبة

الشكل 3. نظرية الدوافع الحماية حسب (Rogers, Prentice - Dunn, 1997)

3-6-5 - نظرية السلوك المخطط

نظرية السلوك المخطط (TPB، نظرية السلوك المخطط، 1998، 1988، 1991، Ajzen)، والذي في نسخته الأولى التي تعرف بأنها نظرية عمل مسبب

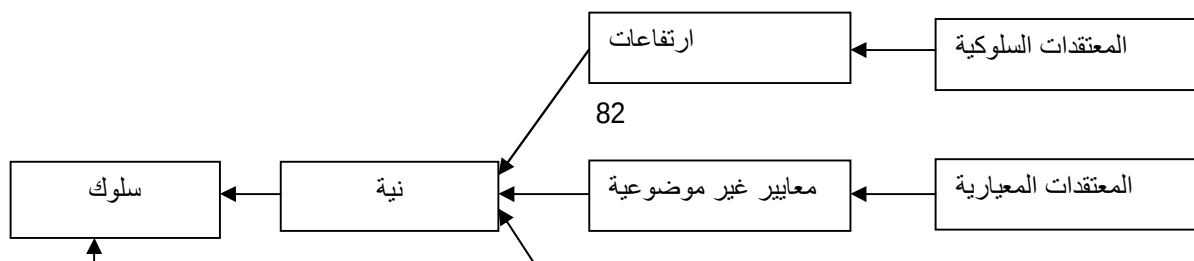
تطوع في السلوك الصحي يرتبط ارتباطا وثيقا في صياغة وجود نية (انظر الشكل 4). وهذا في حد ذاته تحديد نية من قبل:

- ومواقف موقف الفرد تجاه السلوك في مواجهة نحو السلوك، التي حددها معتقداتها بشأن أثر السلوك في مسألة وتقييم هذه النتائج السلوكية (المعتقدات)؛
- والمعايير الذاتية للشخص (المعايير الذاتية)، التي حددها معتقداتها حول آراء الناس مهم (الآباء والأمهات على سبيل المثال، والأقران) من هذا السلوك، وفائدته و / أو معتقداتها أهمية معياري؛
- النظرة إلى القدرة على السيطرة على اعتماد هذا السلوك

سيطرة السلوكية المحسوسة، التي تحددها معتقدات الشخص عن سهولة أو صعوبة تنفيذ السلوك يعتبر المعتقدات التحكم، في النموذج النهائي هذا الاعتقاد مشاركة يؤثر أيضا مباشرة على اعتماد هذا السلوك.

السلوكية المعتقدات

المعتقدات المعيارية للمعايير الشخصية للتحكم سلوك الإيمان المدركة



الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

الشكل 4. نظرية السلوك المخطط له من (Ajzen,1991)

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

4-6-5- تطبيقات النماذج المعرفية الاجتماعية

تقدم النماذج الثلاثة تلخيص جميع العوامل في اعتماد السلوك الصحي ش.ن. وقد تم دراسة مكوناتها مختلفة في سياقات مختلفة مثل:

• والسلوك الجنسي (e.g. Breakwell , Millward , & Fife-Schaw , 1994) (Kell y (Ethier , Kershaw , Niccolai , Lewis , & Ickovics , 2003) (Lollis , Antoni , Johnson, Chitwood , & Kalichman . 1998) (Terry , Griffin , 1995)(Parsons, Halkitis , Bimbi , & Borkowski , 2000) (Galligan , & Conway , 1993)

• الغذاء والتغذية (e.g. Baranowski , Cullen , Niklas , Thompson , & Baranowski , 2003)(Hanso n & Benedict, 2002)(Kim , Reicks , & Sjoberg, 2003) (Lautenschlager & Smith , 2007) (Lio u & Bauer, 2007)(Shephard, 1999)(Verbek e & Vackier , 2005)

• والامتثال لرعاية (e.g. Brownlee-Duffec k et al. , 1987)(Culver , Burke , Yasui , Durfy , & Press, 2001)(Fry & Prentice-Dunn , 2006)(Hounsa, Godin , Alihonou . Valois , & Girard , 1993)(Lipkus , Iden , Terrenoire , & Feaganes, 1999)(Schmiege et al. , 2007)(Sheeran & Orbell , 2000) ;

• استهلاك المواد ذات التأثير النفسي (e.g. Borland , Owen , Hill , & Schofield , 1991)(Christiansen, Roehling , Smith , & Goldman , 1989) (Giannetti , Reynolds , & Rihen , 1985) (Godin , Valois , Lepage, & Desharnais, 1992) (Goldberg , Halpern-Felsher, & Millstein , 2002) (Johnson & Fromme , 1986) (Kaufert . Rabkin , Syrotuik , Boyko , & Shane, 1994) (Norman , Conner, & Bell , 1999 ; Parsons, Siegel, & Cousins , 1997)

الفصل الثاني

الإصابة والسلوك النفسي

إن الكفاح ضد قلة النشاط البدني (e.g. Armitage , 2005 ; Conner & Abraham , 2001) (Chatzisarantis & Hagger, 2005, 2008) (Hausenblas et al. , 1997) (Johnston et al. , 2004) (Schmiede et al. , 2007)

• قيادة السيارات (e.g. Marcil , Bergeron , & Audet , 2001) (McKenna & Horswill , 2006) (Parker, Manstead , Stradling , Reason, & Baxter, 1992) (Simsekoglu & Lajunen , 2007) (Torbjorn & Iversen, 2004)

ويمكن أيضا أن تكون هذه النماذج إطارا ملائما تحليلية لشرح لماذا بعض الناس قد تجرح نفسها عندما ينخرطون في النشاط البدني أو الرياضي. ومع ذلك، فقد اعتبرت دراسات قليلة هذا الاحتمال (Kontos , 2004) (Lajunen & Rasänen , 2004) (Quine , Rutter, & Arnold , 1998) (Williams-Avery & MacKinnon , 1996)

العوامل الرئيسية من المشتركة بين النماذج المقدمة المعرفة الاجتماعية: أولا إدراك المخاطر، وتقييم الشخص الآخر من السلوك الصحي لاعتماد (أو المعتقدات السلوكية). ما تبقى من هذا الفصل يهدف إلى تقديم استعراض من الدراسات التي ربطت بين هذين العاملين والالتزام لشخص في السلوكيات الصحية من هذا الاستعراض، سيكون من الممكن تحديد مجالات جديدة للبحث لإثبات القدرة التفسيرية للاجتماعي المعرفي النهج

الصحة في سياق البدنية أو الرياضية.

2.1.2 تصور المخاطر والسلوكيات الصحية

2.1.2.1 الضعف المتصور لمشاكل صحية

معاهدة الفضاء الخارجي من النماذج المعرفة الاجتماعية من الصحة التأكيد على محورية مفهوم الشخص من ضعف بلده إلى التهديد الجسدي، أي سلوك خطير، وهذه حالة العدوى، مرض أو إصابة،

اعتماد سلوكيات وقائية (Conner & Norman , 2005 ; Weinstein , 2000)

وقد شهدت العديد من الدراسات في الواقع ملتزمة شخص يعتبرون أنفسهم قادرة عليه من الإصابة بسرطان إلى إجراءات طبية أكثر بسهولة مصممة للكشف عن ذلك . Katapodi, Lee , (Facione , & Dodd , 2004 ou McCaul et al., 1996 , pour revue) انظر

أيضا أنفسهم المرجح أن بفيروس نقص المناعة البشرية

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

ربط الجهود الرامية إلى الحد من حدوث الجنس بدون وقاية (Gerrard , Gibbons , Benthin , 1996) مع تشخيص الكلاميديا أو السيلان خلال حلقة ينظر إليها في البداية على أنها أقل عرضة للإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ثانية (Ethier et al. , 2003). وتشير دراسة حديثة أجريت مع السكان من المدمنين على المخدرات ويبين أيضا أن المخاطر المتوقعة للعدوى فيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد الوبائي المتعلقة استخدام مدمن المحاقن المستخدمة تلزم كل سهم إلى أقل محقنة (Bailey et al., 2007). في اتفاق مع مقترحات الاجتماعية والمعرفية نماذج من الصحة (MCS أي، TMP)، والضعف ينظر إلى الأحداث السلبية ويبدو أن أحد العوامل المحددة للسلوك الصالح للشرب الذي هو حماية صحته. من خلال استعراض 17 دراسة، هاريسون، مولين والأخضر (1992) الإبلاغ عن حجم تأثير كبير (0,10-0,20، $P < 0.01$) في العلاقة بين الضعف وينظر العديد من السلوكيات الصحية . فلويد، برنتيس دن وروجرز (2000) هي نفس الشيء في مراجعة أكثر حداثة (ص = 0,20، $P < 0.001$).

في سياق الرياضة، وخصوصا السياق المسببة للأمراض، واستكشفت دراسات قليلة جدا من تأثير ضعف ينظر إليها على اعتماد السلوكيات الصحية أو رأى هذا التصور على أنه تاريخ محتمل من الإصابات الرياضية. وليامز، وأفيري ماكينون (1996) تبين أن الرياضيين الذين يعتبرون أنفسهم عرضة للإصابة كما في أثناء ممارسة النشاط البدني وزيادة استخدام

أكثر كثيرا المعدات الواقية. (Kontos , 2004) يشير أيضا إلى أن: المراهقين الذين يرون خطرا يذكر من الحالات الفعلية في الألعاب الرياضية من شأنه أن يضر أكثر المسببة للأمراض مقارنة مع ادراك خطر أكثر المراهقين في هذه الحالات حتى هذه النتائج تشير الى ان مفهوم الضعف المادية لديه السلوكيات المحتملة التفسيرية التي يمكن أن تؤدي إلى

الإصابة، على الرغم من أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتأكيد مساهمتها.

5-6-5-خطورة تصور المشاكل الصحية

خطورة ينظر لها من مشكلة صحية أو التهديد الجسدي ويبدو أيضا أن باستمرار تنفيذ السلوك الصحي للشخص (انظر MCS). وقد أظهرت بعض الدراسات أن خطورة المتصورة للنوايا يحدد الشخص في التمتع بحياة جنسية ، بما في ذلك استخدام الواقي الذكري أو الامتناع عن ممارسة الجنس (e.g.

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

Iriyama, Nakahara, Jimba (1990,) (Wakai, 2007 ; Petosa & Jackson, 1991). هذا التصور يؤثر أيضا على إرادة شخص باستشارة الطبيب أو ممارسة ما لا يقل عن مرتين في الأسبوع (Abham, 2001). خطورة تصور وجود تهديد الجسدي هو أيضا عامل من المرجح أن يشجع أي شخص من أجل حماية أنفسهم، بينما تشارك في أي نشاط بدني و / أو الرياضي. و أنها تتعلق بشكل إيجابي في تواتر استخدام المعدات الواقية في الأسطوانة (Williams- (1996) Aver y & MacKinnon , وركوب الدراجات (2004) . Lajunen & Räsänen

2.1.3 المعتقدات والسلوكيات الصحية السلوكية

2.1.3.1 توقع النتائج المترتبة على اعتماد لديها المعرفة الإجتماعية بعض النماذج وخاصة (MCS و TCP) التأكيد على التأثير القوي لتصور مسبق لنتائج إيجابية.

5-7 . المعتقدات والسلوكيات

تبنى السلوك الصحي (أي الفوائد التي تعود على MCS، وهو موقف إيجابي وجها لوجه مع سلوك لبرنامج التعاون الفني)، أو معكوس احتمال عواقب سلبية بعد هذا السلوك أي الحواجز ينظر إلى MCS، وهو موقف سلبي وجها لوجه مع سلوك لبرنامج التعاون الفني.

الفوائد المتصورة و / أو سلوك إيجابي بالمقارنة السادس موقف حاسم وخاصة عندما يكون الشخص يقرر أن يشرب الكحول (Fromme et al., 1989); (e.g . Christianse n et al., 1997); (Fromme , Stroot , & Kaplan , 1993); (Goldber g et al., 2000) , Fromme , & D'Amico , 1994) , Johnson & Fromme , 2002) (أو التبغ (Pollay , 2000 ; Parson s et al., 1997) ، أو حيث تنوي تجاهل قوانين السير مثل السرعة حملة (McKenn a & Horswill , 2006). وفي الحالة الأخيرة، وقد تم كشف النقاب عن أن السائقين يميلون إلى دفع

ما وراء حدود السرعة لتوفير الوقت في عملهم اليومي، أو الوصول في الوقت المناسب للحصول على موعد. وقد وجدت الدراسات أخيرا التوازن بين المنافع المتصورة والعقبات في وجود أو عدم وجود السلوكيات الجنسية السليمة (Lolli s et al., 1998 : Kell y & Kalichman . 2000) (Parson s et al., 1995) وجدت أن أولئك الذين يرون في الجنس بدون وقاية يزيد من مشاعر السرور والإثارة في اتصال مع شريكه لا تميل إلى استخدام الواقي الذكري.

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

كما الممارسات جزء مادي، وليامز، وأفيري ماكينون (1996) تبين أن معظم الناس يعتقدون أن ارتداء معدات الوقاية في الأسطوانة يجعلها سخيفة أو التضحيات المالية الطلب، وأقل أنها تميل إلى أن تكون مجهزة . المتزلجين الذين يرون بدلا من معدات الحماية ككائنات فعال في الحد من خطورة إصابة في بكرة تميل لبسها. لاحظت دراسة حديثة نتائج مماثلة في رياضة الدراجات (Lajune n & Ràsanen , 2004) .

5-7-1- تصور للسيطرة السلوكية

لدرجة أنه من الممكن أن السلوكيات الوقائية ليست مباشرة تحت سيطرة الشخص، فإن نظرية السلوك المخطط (Ajzen, 1991) تقترح أن تؤخذ في الاعتبار للسيطرة السلوكية المحسوسة، وهو مفهوم قريب جدا من الشعور ، فعالية (Bandura, 1989). وبالتالي، أثناء ممارسة الجنس، والمزيد من يشعر الشخص قادرا على ممارسة السيطرة على هذا الوضع، وأكثر يبدو أنها قادرة على تبني سلوكيات وقائية، والواقعي الذكري على سبيل المثال استخدام (Breakwell , Fife-Schaw, & Clayden, 1991) ; (al., 1994) ; Hernande z & Diclemente, 1992) ; (Wulfert ; (Terry et al., 1993) ; (Rosenthal, Moore , & Flynn, 1991) ; (Wan, 1993) .) وقد لاحظت دراسات أخرى أيضا أن يكون الشخص لديه أعلى نية في الإقلاع عن التدخين عندما يستطيع ان يعتبر نفسه قادرة على السيطرة على التدخين

(e.g. Godin et al., 1992 ; Norma n et al., 1999)

في سياق الممارسات الفعلية، وجدت الدراسة أن معظم الناس يعتقدون أن يرتدي خوذة الدراجة يعتمد عليهم، بقدر ما تنوي تجهيزها (Quine et al., 1998). دراسة أخرى (Lajunen & Ràsânen, 2004) لم يؤكد هذه النتيجة، ومع ذلك، ويرجع ذلك أساسا أجريت لها في إطار المدرسة التي تكون الخوذة إلزامية. طبيعة تعديها ممارسة من دون خوذة قد يشجع في الواقع على بعض الطلاب لا يصلح في ذلك على الرغم من يعتبرون أنفسهم قادرين على السيطرة على هذه المشكلة، أي لتنفيذ بسهولة (Lajunen , Ràsânen, 2004). بغية التحقق من مساهمة هذا الاعتقاد في السلوكيات الصحية السلوكية، يبدو من الضروري لضمان الإرادة الحرة لكل مشارك.

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

5-7-2-الموضوعية المعايير للسلوك

ثم أنه من المرجح أن الفرد لا يشارك في كل وقت في السلوكيات الصحية في عقلانية واعية. قد تكون هذه السلوكيات تعتمد أيضا على التأثيرات الاجتماعية، وبخاصة على موافقة الآخرين على سلوك المعني. وفقا (زياني، 2002)، وبعض النماذج وخاصة (MCS) نظر الفرد ظلما كموضوع الذي يأخذ قراره وحده، "كما لو أطلق سراحه من علائقية له أو اجتماعية أو بدون ، تبعا لمنطق العقلانية الاقتصادية، التي تقوم أنا على الاستراتيجيات المعرفية لتعظيم الفوائد وتقليل التكاليف" (ص، 27). نماذج أخرى، وخاصة نظريات عمل مسبب والسلوك المخطط (Ajzen، 1998)، وبالتالي دمج البعد المعياري من خلال مراعاة معتقدات الفرد فيما يتعلق ما الآخرون (المرجع) فكر في هذا السلوك. ويمكن اعتماد فعالة من السلوك الصحي تكون مختلفة اعتمادا على ما إذا كان يعتبر السلوكية في مسألة معقدة اجتماعيا أو مقدم الطلب. فمن الشائع، على سبيل المثال اعتماد الاحتياطات أثناء ممارسة الجنس يتطلب مفاوضات مع شريكها، ودفع المفاوضات في بعض الأحيان واحد من اثنين الناس على الخروج من العادات والأعراف (مونثغومري وآخرون، 1989). وهذا يمكن أن النفوذ الاجتماعي يفسر لماذا دراسة واحدة تبين أن في نيوزيلندا، والأطفال هم أكثر من 80٪ من خوزة عند ركوب الدراجات (1999، و Graham)، أكثر من المراهقين أو البالغين (كاميرون، فولكان، فينش، ونيوسنيد، 1994)؛ Schuffha، Aikmen، و Filander Schelp، Svanstrom (1997، ..) Pove وآخرون، (1999؛ Schuffha & M (1997؛ Suchi) الآباء والأمهات، الذين استخدام الخوذات إلزامي، وتشكل على نحو فعال المرجع الرئيسي للأطفال (Lajune، 2004 و Räsänen). أكثر عموما، كل شخص، طفل

الكبار، ويبدو انها تميل أكثر عرضة لحمل خوزة إلى الباب في حال كان الشريك ان يحملها

أيضا (، 1996؛ Dannenber)، (، 1993؛ Evert) وآخرون، (، 1996؛ Jack).

2.1. المرافق العامة وأربعة نهج تكميلية لمعرفة الاجتماعية الصحية

وقد أكدت الأرقام من التلوي يحلل فائدة الاجتماعية المعرفة المنهجية

توقع اعتماد السلوكيات الصحية تفاوتت على سبيل المثال (، 2000؛ Floy)، (، 2000؛ Hagger)، (، 2002؛ Bidel)، تطبيق هذه النماذج، ومع ذلك، طرحت بعض الصعوبات.

وقد لاحظ بعض الدراسات عدم وجود علاقات هامة بين السلوكيات الصحية، وتعتبر واحدة أو أكثر

من مكونات برنامج التعاون الفني، أي المعايير الذاتية على سبيل المثال (، 1999؛ D

، Stroebe، Vroome، Sandfort، و Griensven Van) (، 2000؛ Jamner، Wolitski،

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

Korbi، و Fishbain،)، والمواقف (Siro، 2002، و Buunk)، وينظر إلى سيطرة السلوكية (مثل Flin 1997) وآخرون، (Lajunen و Rasanen، 1997)، (Saton؛ Msckfay، 2004)، ومع ذلك، Ajzen و Fischbain (2004) تشير إلى أن هذا الغياب لا يضر:

"لا يوجد شيء في نظرية تشير إلى أن موقف، معيار شخصي، المدركة عام سيطرة السلوكية لجعل. وسيكون لكل مساهمة كبيرة في التنبؤ نية لها أهمية اقاربهم من هذه الديون ثلاثة من المرجح أن تختلف من سنة إلى أخرى سلوك من السكان إلى آخر. هل يمكن العثور على بعض في مربع واحد، مسلمة أو آخر من العملة ثلاثة لديهم اي

كبير تأثير على نية. " (ص 432)

وقد وجدت دراسات أخرى أيضا أن الناس الذين يعتبرون أنفسهم عرضة لأمراض معينة (مثل فيروس نقص المناعة البشرية، والسرطان) لا تعني أكثر من الأحكام لمنع الناس من النظر في أنفسهم منخفضة المخاطر (على سبيل المثال مؤتمر شباب التبت، هادلي، و كروكيت، 2001؛ مؤتمر شباب التبت وآخرون، (Van der vildi، 2006، Pligt Van der، Hooykaas، 1994). وترتبط لكن هذه النتائج إلى المشاكل المنهجية وليس إلى التشكيك في النظرية المسلمات (بروير وآخرون، 2007). وينشتاين، 1993). هذا من شأنه أن الفرضية الأولى لقاء تحفيزي في الواقع الفرضية الثانية أن تصور الضعف هو انعكاس لتصور الفرد من الانخراط في السلوكيات الخطرة أو السلوكيات الواقية (فرضية الدقة): زيادة في أنبوب خطر الجنسي للمراهقين، وعلى سبيل المثال، يؤدي إلى زيادة في ضعفها ينظر إلى الآثار السلبية لهذه السلوكيات (انظر gerrard، 1996). ولذلك يمكن تحليل ذاكرة علائقية الدفاع عن افتراضين متناقضين (اينشتاين، 1993). فإن تحفيزية دعم وجود علاقة إيجابية بين الضعف المتصورة واعتماد سلوكيات وقائية، وعندما، على العكس، الفرضية القائلة بأن التعرض ينظر بعكس التزام للدفاع عن السلوكيات الصحية وجود علاقة عكسية بين هذين المتغيرين. ولذا فإن التأكيد على فرضية أن ترتبط موازين المحفزة المستخدمة لتقييم الضعف المتصورة (انظر بروير وآخرون، 2007). سيكون من الضروري بشكل خاص لتقييم هذا التصور من قبل تكييف

(1) في غياب السلوكيات الصحية التي نظر فيها.

(2) في اشارة الى خطر في حد ذاته وليس آخر.

(3) وضع خطر في وقت منظور.

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

4) تحديد أفضل تهديد فعلي (على سبيل المثال مع عدوى فيروس الانفلونزا بدلا من هذا المرض بشكل عام).

إذا كان كل نموذج ويبدو أخيرا أن يكون هناك إمكانية تفسيرية لاعتماد من قبل السلوكيات الصحية الفردية، كل لا، ومع ذلك، يلخص كل العوامل التي تدفع الشخص الى (تحديد) لحماية أنفسهم. MCS و TMP تجاهل الضغوط الاجتماعية التي تؤثر على الشخص عند تقييم الحاجة لحماية أنفسهم (Ziani, 2002)، في حين أن العديد من الدراسات أظهرت ليو رجحان على سبيل المثال (1999 Lajunen, Räsänen, Povey, 2004) وآخرون وعلى العكس، فإن برنامج التعاون الفني، والتي هي هذه التأثيرات الاجتماعية المركزية، لا يؤكد مساهمة تصورات المخاطر (أي. الضعف وشدة المتصور)، في حين أن الدراسات قد وجدت أنها تشكل خطوة أساسية 1 في اعتماد سلوكيات وقائية أو لتعزيز الصحة (Katapodi وآخرون، 2000 ، وليامز، وأفيري ماكينون، 1996). بعض الكتاب دعوة لذلك الباحثين لاستكشاف نماذج متكاملة من النظريات القائمة:

"لزيادة الإنتاجية في النماذج، ينبغي البحث في المستقبل

يجمع بين المتغيرات من عدة نظريات" (Barrani ;Kolin,1999)، ص 17، "هناك حاجة إلى مزيد من العمل على مستوى نظرية التكامل" (Barnno,2005)، ص 2 0. بارانو أيضا، أندرسون، وكارماك، (1998 Baranowsk) أنا وآخرون، (2003).

نظرية السلوك المخطط مفتوحة لإدراجها على وجه التحديد من عوامل إضافية، شريطة أن تكون قادرة على زيادة القدرة التفسيرية للنموذج الأصلي (Ajzen,1991). في هذا المنظور، فإن بعض الكتاب وشدد على الحاجة إلى إشراك تصور خطر . في اشارة الى هذا الاقتراح، وقد أظهرت دراسات التكامل بين الضعف المتصورة

تشكيل لنوايا بشأن الإقلاع عن التدخين (Norman وآخرون، 1999) أو أخذ دواء لمنع بعض الأمراض مثل الملاريا (Abraham وآخرون، 1999).

في سياق / والبدنية أو الرياضية، وبالمقارنة مع عدد قليل من الدراسات قوة تفسيرية من كل نموذج في تبني السلوكيات الصحية، وارتداء أي حماية الدراجة والعتاد. كواين وآخرون. (1998) قد أظهرت أن نظرية السلوك المخطط لها وأوضح 43% من التباين في

خوذ الدراجات في حين نموذج من المعتقدات الصحة في تفسير 18% فقط (انظر أيضا Lajunen و Räsänen, 2004). ومع ذلك، سعت الدراسة إلى التعرف لا على النحو الذي اقترحه Ajzen

الفصل الثاني

الإصابة والسلوك النفسي

1991))، إلى أي مدى إدراك المخاطر (المكون الرئيسي للمولودية و S TMP) ومكمل من الجوانب المختلفة لنظرية السلوك المخطط لها من أجل التنبؤ نوايا لحماية أنفسهم. هذا التكامل ولذا فإن الهدف من الدراسة في سياق معين من الممارسات الجسدية و / أو الرياضية.

2.2 تمديد النماذج المعرفية الاجتماعية: تأثير إضافية شخصية

ما وراء التكامل بين كل نموذج الاجتماعي المعرفي، قد تتميتها تعتمد على إدراج العوامل الأصلي (أي. Existan لا في أي نموذج)، وخاصة العوامل الشخصية (مثل (Koner Abrham,2000)). شهدت مشاركة أربعين عاما من ظهور مجموعة من المؤلفات يدل على وجود مساحات واسعة من السمات، قد تميز التكامل مستقرة وفردية لمجموعة من العواطف والسلوكيات والادراك. بعض هذه المناطق تبدو ذات أهمية خاصة لوصف الفروق الفردية في تبني السلوكيات الصحية (Jhonsson,2007).

في إشارة إلى نموذج العوامل الخمسة التي اقترحها كوستا و مكر (1992)، وقد أظهرت الأبحاث في الواقع أن نصف الصورة من الناس لديهم مستويات عالية من العصابية،(Bentler,1994)، هذا هو على استعداد لمواجهة المشاعر السلبية مثل الخوف، والحزن، والخل والغضب والشعور بالذنب والاشمئزاز، لاحتضان أفكار غير عقلانية، إلا من عواطفهم وتكون عرضة للإجهاد، وتميل أيضا أن يكون الشرب بينهم (2000، ؛ Chassin، 1994، و Carl)، أو التبغ القنوات، بالدي، و Dominiaue (1997، ؛ Schtain)، أو الدخول في مزيد من الممارسات الجنسية الخطرة (Costa، 2002). وتورط في هذه السلوك المتهور وتشمل وظيفة لتنظيم خصائص الحالة المزاجية السلبية من الأشخاص الذين لديهم درجة عالية من العصابية (كوبر، 2000). وقد لاحظت دراسات أخرى أيضا أن هم من المدمنين المنفتحون، وتتميز مؤانسة لهم، والثقة، وميلها إلى البحث عن الأحاسيس، إلى التدخين أكثر سهولة (أراي، هوسوكاوا، إيزومي، 1997)، (بريتشارد وكاي، 1993؛) (سيبر والخوف، 1990)، وتجاوزات الكحولية (كوك، والشباب، تايلور، وبيدفورد، 1990) (وهالفورسين، 1996؛) (وميلر 1997)، سيبر والخوف عام (1990)، وآخرون، والمخدرات (سيجوردسون وإعبر، 1996) أو غير آمنة الجنس آخرون (1999). وخلافا للشخص المنتهية ولايته، أصحاب الضمائر الحية ومدرّوس، لديه الإرادة والعزم و وبالتالي أن هؤلاء الناس الضميري يتجنب المخاطرة مثل التدخين أراي وآخرون، (Vollrat، 1997) وآخرون، (1999)، وشرب (Lucas، 2000) وآخرون، (1999)، أو ممارسة الجنس غير الآمن (Trost، 2000) وآخرون (2002) وافقوا، ولكن في طائفة واسعة من السلوكيات الصحية مثل ممارسة النشاط البدني.

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

نظام غذائي متوازن (انظر Roberts 2004) لاستعراض، وأكثر العناية بالوجه (Christine Smith 1995).

وعدد قليل من الدراسات قد نظرت في تكامل هذه العوامل الشخصية مع النظريات الاجتماعية المعرفية القائمة في التنبؤ اعتماد (أو تنوي اعتماد) السلوكيات الصحية. وقد أظهرت كونر وإبراهيم (2001) لكن هذا مع الأخذ في الاعتبار الطابع الضميري للشخص التنبؤ نواياه لمراقبة حالته الصحية في الأسبوعين المقبلين إلى زيادة كبيرة في نسبة التباين يفسر النهج الاجتماعي المعرفي فقط، أي ف TCP وخطر التصور، ($\Delta R^2 = 4\%$). هؤلاء المؤلفين أظهرت أيضا أن توسط في تأثير اجتهد من المواقف من شخص على السلوك الصحي التي تمت دراستها.

مساهمة ما قبل الأحكام الواردة في النماذج المعرفية الشخصية الاجتماعية ولذلك فإن وجهة نظر مثيرة للاهتمام لزيادة المعرفة من العوامل التي تشجع الشخص على ان يقرر لحماية نفسه أو على ان يتصرف بشكل خطير عندما ممارسة النشاط البدني و / أو الرياضي. احتمال أصبح ضروريا أكثر إذا دراسات عديدة للسعي للتعرف على تأثير العوامل الشخصية في اشتباك الشخص في الأنشطة الجسدية للخطر على سبيل المثال، (Casnay، 1999، و) (Scanff، 1990)، (2007؛ - -) Freixanet، (1991، Baritch، Kajtn)، (2004، Jack، Wornar)، (1998، Sanchez، Heyes)، ولكن قد أجريت دراسة على المعترف بها داخل هذه الممارسات الخطيرة، وهذه العوامل الشخصية (أي العصابية، الانبساط، الوعي) كانت مؤثرة في اعتماد سلوكيات صحية وقائية أو وعلى العكس من السلوك المتهور .

يبقى تحديد ما إذا كان شخصية يسهم بصورة مباشرة في اعتماد سلوكيات صحية أو إذا توصل نفوذها من قبل مختلف مكونات النماذج المعرفة الاجتماعية (أي. الإدراك للمخاطر أو المعتقدات السلوكية). الفصل التالي يبدو تماما السوابق النفسية الضعف المتصورة، وبين هذه السوابق، ومساهمة شخصي

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

خلاصة:

وقوع ضرر لا يبدو تعتمد اعتمادا كليا على التزام من شخص في نشاط خطر بموضوعية. السلوك المعتمدة في هذا النشاط هي أيضا مهمة في الآلية المرضية، وخاصة استخدام معدات الحماية (على سبيل المثال ، (Pinsson 1999, 2005 ، Marshal). مزيد من الدراسات يبدو ضروريا لإثراء المعرفة من السلوكيات ذات الصلة وقوع إصابات، وخاصة عندما يتم تقييم اجتماعيا هم. إلى حد أن الألم ويبدو أن من سمات اضطرابات التكيف (العضوية والانتباه)، قد المواقف من الألم لديها الإمكانيات التفسيرية في عملية المسببة للأمراض. لكن، على الرغم من الاهتمام في الآونة الأخيرة ألم في منتصف النشاط البدني والرياضة (على سبيل المثال Barthomilio وآخرون، 1999؛ Mayers وآخرون، 2001)، وسعت أي دراسة لإثبات تأثير تسببها هذه السلوكيات

وقوع الإصابات والوقاية من سلوكهم ويبدو أن يعتمد عندما يكون الشخص يتبنى تمرين عملي و / أو الرياضي ومع ذلك، والمعرفة من هذه السلوكيات الصحية لا تزال جزء من الغالبية العظمى من الدراسات التي تركز على ارتداء معدات الحماية (على سبيل المثال الخوذ، وحراس الفم). يمكن أن السلوكيات الصحية الأخرى، مما تسبب في اضطرابات التكيف الضارة، أيضا أن يكون له تفسير محتمل في التسبب.

وعلاوة على ذلك، في الرغبة لمنع الإصابة، يبدو من الضروري تحديد العوامل والعمليات التي تحكم تبني سلوك صحي مستدام.

المعرفة الاجتماعية نماذج من الصحة، وثقت بشكل كبير في منع حدوث الأمراض المختلفة، سرطان على سبيل المثال، وأمراض القلب والأوعية الدموية على سبيل المثال أيكن وآخرون، (1994؛ Krummel) و(همفريز، 1999)، يمكن أن توفر إطارا لتحليل نفسية محددات السلوكيات الصحية للفرد أن يعتمد في حين تشارك في أي نشاط بدني و / أو الرياضي. ومع ذلك فقد اعتبرت دراسات قليلة هذا الاحتمال. في اشارة الى اقتراحات من بعض الكتاب على سبيل المثال (Ajzen 1991، Barano)، (Kone, Abraham, 2005) وكان هذا العمل الدكتوراه يهدف أيضا في النظر في التكامل بين مختلف مكونات النماذج المعرفة الاجتماعية. وذلك بهدف استكشاف نموذج تكاملي وسياقاتها تشارك فيها جميع العوامل النفسية التي يمكن أن تشجع الشخص لحماية نفسه، وقال انه يدرس أيضا المساهمة المكملة للشخصية.

الفصل الثاني الإصابة والسلوك النفسي

الفصل الثالث

سوابق الضعف المتصور

الفصل الثالث

سوابق الضعف المتصور

1-السوابق من الضعف المتصورة

الضعف المتصورة هي عنصر أساسي من النماذج المعرفة الاجتماعية للصحة، على سبيل المثال نموذج الإيمان من الصحة، نظرية الحافز لحماية (Koner,2005). الذراع ويبدو أيضا أن تكون النماذج التكميلية التي لم يقرر في الأصل كأحد محددات السلوكيات الصحية، على سبيل المثال نظرية السلوك المخطط (Abraham 1999) وآخرون، (1999)،. تحديد السوابق النفسية للضعف ينظر لذا فمن الضروري لإثراء هذه النماذج، وتعميق معرفة العوامل والحد من قابلية تأثر الإلكتروني والحماية من خطر الإصابة.

1-1- تأثير التجارب السابقة في الضعف المتصورة

وقد اقترح العديد من النماذج أطر لفهم العمليات المختلفة التي تؤثر في ردود الفعل المعرفية والانفعالية والسلوكية رياضي في تجربة إصابة مثل عملية الضغط الأساسية نموذج، (فيسه وايس، 1987) . بعض الضوء أيضا على تأثير العوامل الشخصية مثل (العمر، والشخصية، والتسامح، ألم)، والظرفية مثل (مستوى المنافسة، ومركز رياضي، والدعم الاجتماعي) حول مستقبل التعافي البدني وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للشخص المصاب (على سبيل المثال نموذج متكامل للاستجابة النفسية الى اصابة رياضية وعملية إعادة التأهيل، (Bjornstal Smith; 1998، Morrey). ولكن ليس من المفيد جدا أن يتميز الرياضي الذي يتعافى جسديا، واجتماعيا (سبورتنغ) إعادة تأهيل.

لا يزال يعاني نفسيا من اصابة في الماضي الآن (Podlo, 2007).

وقد سعت بعض الدراسات ذلك لتحديد النتائج المترتبة على الإصابة في تمثيل ومعتقدات شخص عند عودته إلى تدريب على سبيل المثال ، (E & Jevne؛ 2006). من المقابلات السريرية، وروز (Jevne, 1993) عقد في فكرة وخصوصا أن تجربة اصابة للرياضيين يمكن أن يكون الدرس الذي قد يستغرق العمل في مسلمة التدريب واستأنفت مع وعي خاص لها (جديد) الضعف:

وقال "لقد وصلت الى ابقاء يعكس مرة أخرى على هذه العملية والحفاظ على أن نتذكر أن من واجبي أن أوجه الضعف والثاني يكون لها حدود" (جرانت، الترياتلون، نقلا عن روز (Jevne,1993)).

هذه المقابلات تؤكد اثر اصابة، نشعر بالقلق الرياضيين حول فكرة التي تواجه وضعاً مماثلاً لذلك الذي كان مصدر الإصابة بها (Taylor, 1997). وهذا يمكن أن القلق يبقى حاملاً لعدة أشهر (Ekland, 2006). دراسة كمية أظهرت أيضا أن يرتبط تجربة الإصابات الرياضية في الماضي لإدراك مزيد من الضعف (Williams, 1996)، وبالتالي استمرارا للعمل الذي أنشأ في قياس آخر، ومع ذلك، علما انه كان ضحية لتلك الأحداث المؤلمة (مثل سرطان والكوارث الطبيعية) ويرتبط

الفصل الثالث

سوابق الضعف المتصور

مباشرة مع المخاطر المتوقعة من استئناف الذين يعيشون هذه الأحداث تخضير، (Dollinger 1996)، و (Pitter، 1996؛ Shciberd Larse)، مؤتمر شباب التبت وآخرون، (2001).

ومع ذلك، هذه العلاقة بين خبرة من الإصابة وتصور الشخص من الضعف ليست دائما واضحة في الدراسات التي أجريت حتى الآن. وبالتالي، روز و (Jevne، 1993) التأكيد أيضا على وجود ردود

فرد متناقضة حول التنبؤ المخاطر المستقبلية التي تواجه خطر الهدف نفسه عامل أي تجربة من إصابة في الرياضة مسلمة في الماضي، يمكن لبعض الإصابات الرياضية في الماضي تجاهل الواقع المدروس من هذه التجربة والحفاظ عليها، على الرغم من الإصابة، شعور لا يقهر:

بعض الدراسات في علم النفس الصحة نلاحظ أيضا وجود تناقضات بين التجربة الأخيرة من مشكلة صحية والضعف في المستقبل المتصورة. وبالتالي، بعض النساء اللواتي يشعرون أحد أعراض في الصدر لا يتلقى قوة أكثر لعرضة لسرطان الثدي العقد (Katapodi 2005) وآخرون في حين أن آخرين، ومع ذلك، ضبط تصورهم بعد مثل هذه التجربة (Fenaughty، Aiken 1995؛ Facione، 2002؛ Lipkus، Strigo، Rimer).

التناقض في الردود الفردية إلى تجربة مشكلة صحية على سبيل المثال الإصابة يترك لذلك نفترض أن العوامل النفسية تلعب دورا أيضا في الحكم من قبل شخص من نقاط ضعفهم. هذه العوامل والعمليات النفسية تفسر رق شخص على حد سواء تبدأ بتقييم المخاطر

تتعلق التهديد المادية كما يمكن أن تكون على سبيل المثال إصابة، وبالتالي تحدد أيضا تحت أي ظروف هذا التقييم هو ممكن ومنصف / دقيقة. إذا وضعت دراسات تأثير للإصابة الماضي على المخاطر المتوقعة من إصابة في إعادة (Williams، Makinon، 1996)، وسعت لا شيء حتى الآن للتدليل على تأثير عوامل إضافية والعمليات النفسية في هذا التصور. وكانوا، مع ذلك، ليشرح لماذا بعض الرياضيين المصابين في الماضي لا يعتبرون أنفسهم عرضة للخطر في المستقبل.

1-2- عوامل نفسية وعمليات حاسما في التنبؤ بالمخاطر

كيف للناس تحديد ما إذا كانت معرضة ماديا أم لا؟ أدب وآخرون، (Aiken، Gerend، 1995؛ Erchull، 2004؛ DiLorenzo، Erbligh، Montogory)، وآخرون، (1999) يكشف عن وجود ما لا يقل عن أربعة أساليب مختلفة وقد تميز أيضا processu ق ق ق ممارسة النفسي يحدث في تسليم في التنبؤ خطر على المستقبل (أ) معرفة وفهم عوامل الخطر، وب) واستخدام الاستدلال (أساسا) المعرفي (ث) إدراك خصائص المخاطر (ج) وجود عوامل شخصية.

الفصل الثالث

سوابق الضعف المتصور

1-2-1- المعرفة من الأهداف عوامل الخطر

فمن المسلم به أن مجرد وجود عوامل موضوعية من خطر ينتج عادة في التنبؤ الضعف أكبر "على المشاكل الصحية المرتبطة بها. وهكذا، فإن اعتماد السلوكيات الخطرة مثل الكحول.

ويرافق الممارسات الجنسية غير المحمية من خلال تصور وجود احتمال كبير لمواجهة العواقب المسببة للأمراض من هذه السلوكيات (Eiser, 1988)، وآخرون، (Revenson 1990)، وReppucci، (Taylor، 1991) وآخرون، (Van der، 1992) وآخرون، (1994)، Vollrath وآخرون، (1999).. وبالمثل، فإن الطابع الوراثي للأمراض معينة (مثل السرطان وأمراض القلب، والسكري)، على سبيل المثال، بسبب التاريخ العائلي للخطر هدف عامل، وبالتالي مؤشرا كبيرا على تصورات التعرض لهذه الأمراض (على سبيل المثال و القاعدة)، (1995؛ Bovbjerg، Erbligh، Norman، Valdimarsdóttir، وMontogory)، ؛ مكجريجور وآخرون، (2004)، (2003، Montogry). قدمت النضال البحوث لإثبات باستمرار أن معرفة عوامل الخطر أهمية قصوى في تقييم التعرض للشخص. على الرغم من أن بعض الدراسات أظهرت أن المعلومات المقدمة من قبل العاملين الاجتماعيين تأثير كبير في النظرة إلى تسليم ذات الصلة من الضعف المادي من حوادث الطرق (Awadia 1999)، و (atn، 2006؛ Moshiro، Heuch، وKlepp، وKvale، 1990)، لا سيما وأنها تعتبر الصورة ذات مصداقية من قبل المشاركين، على دراسات سلع أخرى تجد المفارقة أن بعض برامج الوقاية أو التوقيف الصحي، ومصممة خصيصا لنقل وتقتصر معرفة عوامل الخطر على السكان المعينة، في قدرتها على تغيير المفاهيم من المخاطر الشخصية والسلوكيات يترتب على ذلك (البرام، 1980) (جيفري، 1990)، (نathan، 1986). تشير الدراسة إلى أن النساء بعد سن اليأس حتى لا يعتبرون أنفسهم عرضة لهشاشة العظام على الرغم من أنها توافق على أن سن اليأس هو المحدد الرئيسي لهذا المرض (بالارد، 2002). هذه النتائج تبين أن المعرفة فقط من له خطر تأثير محدود على التنبؤ من المخاطر المستقبلية.

العمليات النفسية الأخرى تكون أكثر ملاءمة لفهم لماذا وكيف يدرك الناس نقاط ضعفهم.

1-2-2- الاستدلال النفسي

ما وراء المعرفة من عوامل الخطر ذات الصلة التهديد الجسدي، والحكم من قبل الشعب من ضعفها في الخاصة يتطلب استخدام الاستدلال، حقيقي منطقي الاختصارات التي تساعد في الحد من العمليات المعقدة العقلية لجعل المهام البسيطة المعرفية (Kahneman، وFiske & Taylor، 1991) (Slovic، وTversky، 1982). هذه الاستدلال ذات الصلة ولا سيما عند دراسة كاملة وشاملة

الفصل الثالث

سوابق الضعف المتصور

من كل الاحتمالات للتنبؤ سيكون بطيئاً جداً أو غير فعالة (Gigerenzer & Todd , 1999)، الذي أنا هو الحال غالباً في كثير من الظروف ذات الصلة ليالي إلى حدوث المرض أو الإصابة.

من خلال هذه العملية، ويعتبر حدث معين وعلى الأرجح الشخص أنه من السهل أن يعطي التمثيل العقلي (Tversky & Kahneman , 1973). لذلك، والتجارب الشخصية و / أو غير المباشرة عن طريق صديق أو وسائل الإعلام إلى التهديد تلعب دوراً في هذه العملية منذ هذه التجارب تزيد من توافر العقلية من هذا التهديد، وبالتالي النفوذ، تصور احتمال وقوعه (Tyler , 1980). ديناميات المعرفي السائد عندما يكون الشخص يحاول التكهن ما إذا كان عرضة لأمراض معينة (e.g. Astrom et al., 2006 ; (Facione, 2002) ; (Montgomery et al., 2003) ; (Wardle , 2001) ; (Ty c et al., 2001) ; (Rees, Fry, & Cull , 2001) ; (Weinstein , 1995) وأوضحت لماذا طفل في مقتبل المراهقة والمراهقين الذين نجوا من السرطان (تجربة شخصية) يرون أنفسهم أكثر عرضة للمخاطر المادية المرتبطة باستهلاك التبغ، أي تطور السرطان (Ty c et al., 2001)

ويرتبط علم من صديق مريض بالانابه خبرة مع زيادة التعرض ينظر لهذا المرض (Katapod i et al., 2003) ; (Montgomery et al., 2005) . دراسات أخرى لديها فاي نالي إد أن الميل لشخص ينظرون إلى أنفسهم مماثلة كما لشخص عرضة للمرض عادة ارشادي التمثيلية، Kahnema (Tversky & n , 1973) وترافق أيضاً بزيادة أضعفهم ينظر (Gerend, Aiken , West, & Erchull , 2004) ; (Le k & Bishop , 1995) ; (McCo y et al., 1980) ; (Weinstein , 2001) ; (Rees et al., 1992) . يبدو أن الناس استخدام الاستدلال المعرفي عند محاولة للتنبؤ من خطر الإصابة بمرض. لا يزال من الضروري التحقق مما إذا كانت هذه العملية موجودة أيضاً عند محاولة للتنبؤ من خطر الإصابة.

1-2-3. التصورات الخصائص المخاطر

وثمة نهج يؤكد على تصور الشخصية من خصائص مخاطر العوامل المتعلقة بالضعف ينظر إليها (Vle k , 1981) ; (Slovic , 1987) ; (Baird , 1986) (e.g.) وهكذا، والأفراد النظر من تعرضهم للمخاطر أكثر من المرجح أن ينظر إليها باعتبارها تهديدا لا يمكن السيطرة عليها أو من الصعب منع (Slovic , 1987) ; (Brody , 1988) ; (Baird , 1986) (e.g.) (Vle k & Stallen, 1981) ; (Vaughan , 1993) ، جديدة أو غير مألوفة (Slovic , 1987) (e.g.) (Fischhoff, Lichtenstein , Read, 1978) ، وعواقب وخيمة آثار (على الصحة) هي على الفور بدلا من المؤجلة (e.g. Bjorkman , 1984).

الفصل الثالث

سوابق الضعف المتصور

عن طريق تحديد هذا النموذج على مجموعة متنوعة من المخاطر الصحية (أي تعاطي المخدرات، والنوبات القلبية، وحوادث السيارات والانتحار)، أظهرت لأول مرة وجود علاقة إيجابية بين المستوى المتوسط و تصورات التعرض لهذه المخاطر والإدراك من خصائصها.

وتثيرتها وشدتها، أو القدرة على الناس لمنع أو السيطرة عليها والنتائج المترتبة عليها (Lek & Bishop , 1995). وتأكد هذه النتائج مؤخرا في حدوث بعض الأمراض، أي مرض هشاشة العظام والنوبات القلبية، وسرطان الثدي (Gerend, Aiken, & West, 2004) ; (Aiken, West, & Erchull, 2004). ويعتبر مرض أكثر من شخص والمتكررة في عدد معين من السكان، وأكثر ويعتبر هذا الشخص من المحتمل أن ينكمش في المستقبل. وقد سعت الدراسة لكن لا لتحديد ما إذا كانت هذه العوامل يمكن تلوين الضعف الملحوظ للرياضي.

1-2-4. الشخصية:

يمكن أن المجالات الرئيسية للشخصية (Costa & McCrae , 1992) لها تأثير أخيرا لطبيعة التنبؤات الناس حول المخاطر الجسدية لحياتهم، وبالتالي تشكل تاريخا من الضعف النفسي ينظر إلى الفكرة من هذه العلاقة جذوره في العمل على العلاقة بين العوامل الشخصية، والعصبية، والشكاوى الجسدية (Costa & McCrae , 1980, 1985). العصابية في اتجاه معين يحدد من شخص ليشعر المشاعر غير السارة المرتبطة عاطفة سلبية، مثل الغضب والعداء، والقلق، والمزاج المكتئب (Adler & Matthe, 1994). الناس لديهم مستويات عالية من العصابية تميل لأعراض أكثر الطبية والشكاوى (Costa & McCrae , 1982) ; (Costa, Fleg, McCrae , & Lakatta, 1982) (Costa & McCrae, 1980). تفسيرها مبالغا فيه من الأحاسيس الجسدية التي تفسر هذا الاتجاه (Costa & McCrae, 1989). (Watson & Pennebaker, 1987 ; 1987). وقد أظهرت الأبحاث أن ذلك يترافق مع العصابية تصور أكبر من التعرض للمشاكل الصحية (Gerend, Darvill & Johnson, 1991; (Johnson, 2000) ; (Trobst et al., 2000) ; Vollrath Aiken,& West, 2004) ; et (all, 1999). وقد لاحظ أيضا أنها عالية القلق، والوجيه.

محدد العصابية (Costa & McCrae , 1992)، هو أيضا حاسمة في الناس عن تعرضهن للوقوع أحداث سلبية (Williams , 1987) , (Butler & Mathews , 1983) وعلى النقيض من القلق والعصابية، الانبساط أو هي العوامل الشخصية التي تربط مع عناصر ايجابية من الرفاه (McCrae & Costa ,1991). هذه الميول بالتالي فهي عرضة لارتكاب الشخص ينظرون إلى أنفسهم غير معرضة للخطر (Gerend , Aiken , & West , 2004) ; (Vollrath et al., 1999). وبالمثل، فإن اجتهد من شخص، بما في ذلك شهادة من أنه وأمره،

الفصل الثالث

سوابق الضعف المتصور

ويعكس رغبة الفرد في تجنب الانخراط في سلوك يمس صحة لها، مثل التدخين أو الشرب بشكل مفرط (; Friedmn et all, 1995) ; Booth-Kewle y & Vickers , 1994) (Lemos-Giralde z & Fidalgo-Aliste , 1997). وبالتالي فإن عامل شخصية تتعلق سلبا على الضعف المتصورة.

وإلى جانب هذه المجالات شخصية عظيمة (Cost a & McCrae , 1992) ، ويمكن أن الأحكام الفردية الأخرى تسهم في تشكيل وتلوين الضعف المتصورة. التفاؤل، على وجه الخصوص، يعتبر سمة شخصية أدت إلى انتشار توقعات لنتائج إيجابية في مسار حياته، بما في ذلك مواجهة الشدائد (Carve r & Scheier , 2002). التفاؤل بالتالي يحمي الفرد ضد الضائقة التي تواجهها مع الأحداث السلبية كما يمكن أن تكون الإصابات الرياضية. على سبيل المثال، تفاؤلا تشخيص سرطان الثدي يشعرون بقدر أقل من الشدة خلال السنة التي تلي التشخيص (Carve r et al., 1993). لذلك ويرافق هذا الحكم من قبل نزعة الفردية ينظرون إلى أنفسهم ليشعر قلق غير معرضة للخطر، وأقل ليكون أضعفت (McGrego r et al., 2004) (Gerend , Aiken , & West , 2004) (Wardle , 1995).

منظور مماثل، واحترام الذات يشرك الناس في التشوهات المعرفية التي تؤدي بهم إلى رفض المعلومات التي لا تتسجم مع تصوراتهم وآرائهم من أنفسهم (Knight , 1986). وبالتالي، بالمقارنة مع غيرها من النساء اللواتي احترمن الذات منخفضة، والنساء اللواتي احترمن الذات من المهم أن يدرك أقل من المحتمل أن يكون لها الحمل غير المرغوب فيه (Smith, Gerrard, & Gibbons, 1997) أو الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، على الرغم من مستوى مماثل من المخاطر (Gerrard, 1999) (Boney-McCoy , Gibbons, 2000) (. وتبين البحوث أن الناس يعتقدون أخيرا لديهم السيطرة على مصيرهم (أي موضع للمراقبة الداخلية) يعتبرون أنفسهم أقل عرضة لنتائج سلبية على الصحة مثل التعاقد أو يصبح يتعاطى الكحول (Hoorens & Buunk, 1993) شخصية لذا يبدو كعامل في مفهوم الضعف في الشخص. في بعض الحالات، والتي من خلالها وجود تهديد الجسدي قد تكون قليلة أو معدومة واضح، فمن الممكن أن هذه السمات الشخصية هي حاسمة جدا. يبقى أن تميز مساهمتها الفعلية في المخاطر المتصورة من الاصابة الرياضية.

2- والمحددات تكاملية وسياقاتها من الضعف المتصورة

ومن الآونة الأخيرة أن بعض الباحثين قد استكشفت العلاقات التي يمكن أن تحافظ على هذه المقاربة الثانية الاستدلال المعرفي، إدراك خصائص المخاطر، والشخصية في خطر التنبؤ (Gerend, Aiken, & West, 2004).

الفصل الثالث

سوابق الضعف المتصور

من خلال هذه الدراسة، والهدف من ذلك هو لتقييم إلى أي مدى يمكن للعوامل شخصية معينة لون تصورات الفرد من خصائص المخاطر

المرض أو يتسبب في استخدام الاستدلال المعرفي وبالتالي التأثير على حكم الفرد من المخاطر المستقبلية. باستخدام هذا النهج، فقد وجدت (Gerend , Aike , 2004) , أن النساء متفائلنا، انفتاحا على الخارج، واصفا نفسه من حيث الايجابية والنظر له سيطرة على مستقبل صحتهم شخصية،

يشعر تشبه إلى حد ما الناس عرضة للمرض ارشادي، وبالتالي، ترى نفسها أقل عرضة بدنيا. وعلى العكس، فإن النساء لديهم مستويات عالية من العصبية والقلق بشأن مستقبل صحتهم، ومعتبرا انه أصبح لا يعتمد عليها، وقال انهم شعروا أكثر مماثلة لنساء المعرضات للخطر بدنيا، وهو ما يزيد بدوره من الضعف المتصورة. هؤلاء الكتاب يدل أيضا على أن تعتبر المرأة مع المكان للمراقبة داخلية بشأن مستقبل صحتهم أكثر قدرة على منع حدوث المرض أو السيطرة على نتائجها. بدوره ورافقت هذه التصورات من قبل الاتجاهات لرؤية أنفسهم أقل عرضة لهذه الأمراض. على العكس من مكان خارجي من السيطرة تؤثر سلبا على القدرة على منع أو السيطرة على الأمراض، ويكون مسؤولا عن التوقعات لخطر الإصابة بها.

ما وراء النفوذ وساطة من الادراك فرد معين، وحقق بعض الكتاب (e.g . Smit h et al., 1997) أيضا تأثير معتدل (Baron & Kenny , 1986) من عوامل شخصية معينة في استخدام "المعلومات تهدف للمساعدة في توقع ضعفها الجسدي. وهكذا، احترام الذات هو ارتفاع أقل حساسية للحصول على معلومات واحترام منخفضة الذات. وعلى الرغم من هذه المعلومات، الأول الحفاظ على مفهوم انخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا ، ومع ذلك، ضبط تصوراتهم. على الجزء السفلي من تسليم يعمل لذلك فمن الممكن أن الناس مع مستويات عالية من احترام الذات تميل إلى استخدام عدد أقل من الإصابات في الماضي بوصفه معيارا لتقييم المخاطر في المستقبل. لا يزال لإثبات هذا الاحتمال.

الفصل الثالث

سوابق الضعف المتصور

3- الحد من الأعمال السابقة والتشكيك

بعد استعراض هذا الأدب، والإجهاذ، يمكن لم يعد يرتبط بها النظر في الخصائص النفسية فقط من خطر الإصابة. وقد حددت هذه الدراسات في الواقع على ضرورة التركيز على سلوك الصحية التي يتعين على الناس أن يشاركوا في الأنشطة الاجتماعية المختلفة و المادية، ومحددات هذه السلوكيات.

هذا البحث يدافع عن أطروحة أن النماذج المعرفة الاجتماعية للصحة، الذين يرغبون في المحددات النفسية من السلوكيات الصحية، والأطر التحليلية من عوامل الضعف والحماية ضد خطر الإصابة. الدفاع عن هذه الرسالة يعطي عنوان بعض القضايا العالقة في الأدب، والقضايا ونحن نكشف هذا.

1. ماهي السلوكيات المرتبطة مع وقوع إصابات أثناء ممارسة النشاط البدني أو الرياضي؟

اعتبرت غالبية كبيرة جدا من الأعمال الإلكترونية، وتأثير التوتر والعوامل المرتبطة به في وقوع إصابات (Williams , 1998 ; cf. Déroche et al., 2007). ربما هذه الحالة تعتمد حتى الآن على إعادة توظيف أي شخص في سلوك متعمد من المرجح أن يضعف. إذا تم التعرف على بعض السلوك الصحي، وتسهيل أي أو منع وقوع مشكلة الصحة، في الأنشطة الاجتماعية المختلفة مثل القيادة بعد شرب الكحول، ومع ذلك، وحددت دراسات قليلة السلوكيات في خطورة

الإصابات عندما يكون الشخص يشارك في النشاط البدني أو الرياضي. لديهم أيضا خفضت الى حد كبير هذه السلوكيات في منفذ واحد من المعدات الواقية، أي السلوكيات الصحية الوقائية (e.g. Spait et al., 1991) ; Benson et al. , 1999). تي انه أول دراسة من هذه الأطروحة يسعى إلى تحديد مسببات الأمراض الجديدة الرياضية السلوك، وتركز على السلوكيات الخطرة، وتحديدًا في اتجاه للرياضيين للحفاظ على كثافة الاستثمار الجسدية عند اتخاذ تجربة الألم أو تحمل مهمة مؤلمة.

2. ما هي العوامل التي تحدد تبني السلوكيات الصحية في النشاط البدني والرياضي؟

منذ ارتباط السلوكيات أن الشخص يعتمد في سياق البدني أو الرياضي إلى ضعفها، والوقاية من الإصابة يتطلب تحديد العوامل التي تحدد اعتماد هذه السلوكيات.

الفصل الثالث

سوابق الضعف المتصور

وقد أظهر العمل في علم النفس الصحة والمرافق العامة من النماذج المعرفة الاجتماعية لتحديد العوامل النفسية للسلوك وقائي أو تعزيز الصحة (e.g. Armitage , 2005) ; Lajunen & Räsänen (2004) ,). بقدر ما وضعت هذه النماذج لتعزيز المعلومات المقدمة للمستخدمين، وتحسين أثر حملات وقائية والامتثال للعلاج من المرضى (Pedinielli,1996)، واختبرت دراسات قليلة إمكاناتهم لتوضيح التزام من شخص في السلوكيات الخطرة (cf. McKenna & Horswill , 2006). وكانت الدراسة الثانية لعمل الدكتوراه ثم يتساءل: إلى أي مدى ضعف التدبير وحدة التصورة ، والمتغيرات المركزية للمعرفة الاجتماعية و نماذج من الصحة

اعتماد تحديد الشخص من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر خلال الأنشطة الرياضية.

واختبرت دراسات قليلة جدا أيضا كيف أن مختلف مكونات النماذج المعرفة الاجتماعية يمكن أن تكون مكملة لشرح ما يشجع على وجود شخص لحماية أنفسهم (e.g. Norman et al., 1999) ; (Abraham et al., 1999). أيا من هذه الدراسات المتعلقة بمنع الإصابة خلال النشاط البدني. في إشارة إلى اقتراحات من بعض الكتاب (Ajzen, 1991) ; (Conner & Abraham , 2001) ; (Baranowski, 2005) دراسة ثالثة تسعى للتحقق من صحة التكاملية المعرفة الاجتماعية نموذج، يحدد مدى ضعف حدة التصورة يمكن أن تكون عناصر متكاملة من مختلف نظرية السلوك المخطط (Ajzen, 1991)، من أجل التنبؤ نوايا المترجلين على ارتداء معدات الحماية أو الاستخدام الفعلي خلال التزلج والمشي. لدرجة أن عوامل شخصية معينة تبدو ذات صلة بالموضوع لوصف الفروق الفردية في تبني السلوكيات الصحية (e.g. Hagger- White, 2007) ; (Johnson 1998)، فإن هذه الدراسة تعتبر أيضا مساهمة هذه العوامل في النموذج الاجتماعي المعرفي التكميلي التي شملت الدراسة.

4. ما هي السوابق من المتصورة الضعف لدى إصابة؟

الدراسات الحديثة السوابق من الضعف ينظر إليها على أنها النماذج المعرفة الاجتماعية و متغير المركزي للصحة (Katapodi ; (Gerend, Aiken, West, & Erchull, 2004) ; (et al., 2005). لإكمال هذا النموذج الأصلي، واقترحوا اتباع نهج متكامل يأخذ في عين الاعتبار سياقاتها وما قبل بالاتصالات الشخصية أحكام العوامل السائدة الضعف المتصورة

الفصل الثالث

سوابق الضعف المتصور

السرطان وهشاشة العظام. أو النوبات القلبية. الدراسات الرابع والخامس المقدمة في هذه الأطروحة هي الأولى للنظر في تأثير الشخصية على قابلية ينظر إلى إصابة Stephan , Brewer (2007, L e Scanff, & .) والدراسة الرابعة يفحص مساهمة شخصية في تشكيل وتلوين من الضعف الواضح، بعد تجربة الإصابات الرياضية في الماضي. لديها تمييز من التي يجري تنفيذها في الشدائد الأمراض أي ممارسة لعبة الركبي تنافسية، والتي في الإصابة يمكن أن تصبح بسهولة معيارا مقبولا. لتسليط الضوء على تنوع محددات الضعف المتصورة، ودراسة 5 تعتبر أيضا مساهمة مباشرة من العوامل النفسية الأخرى، ولا سيما استخدام الاستدلال المعرفي ووجود تصورات المتعلقة بخصائص وقوع الضرر. و يسمح لاستكشاف نموذج تكاملي وسياقاتها (Gerend , Aiken , & West , 2004) يسلط الضوء على التكامل بين العوامل النفسية المشتركة عندما يكون الشخص يحكم ما اذا كان عرضة لخطر الإصابة. معا، هاتين الدراستين المعنية تمديد النماذج المعرفة الاجتماعية في الوقت الذي التعرف على مواطن الضعف الجديدة وحماية من خطر الإصابة.

الفصل الثالث

سوابق الضعف المتصور

خلاصة:

لا يمكن للتجربة من إصابة في الماضي في بعض الأحيان يكون كافيا لإدراك أن الشخص عرضة للإصابة آخر (Rose & Jevne, 1993). تشكيل وتكوين لضعف ينظر لشخص يعتمد أيضا على تصورات له من خصائص المخاطر من جهة، ويستخدم الاستدلال عند محاولة للتنبؤ هذا الخطر، من ناحية أخرى. على ما يبدو بعض الميول الشخصية هي أيضا تأثيرا في سلوك اثنين من العمليات النفسية المتصلة حكم من المخاطر، وعلى الرغم من أن الأبحاث الإلكترونية واحدة وقد تم التحقيق فيها وأكد هذا الاحتمال (West, 2004) (Gerend,1998). وينبغي النظر في مسألة العوامل النفسية التي ينطوي عليها المفهوم خطر مثل المسائل المتعلقة بالتكامل بين هذه العوامل موجودة، وبالتالي في سياق معين و البدنية الرياضية. تحديد السوابق من قابلية ينظر إلى إصابة مهمة لأنها تساهم في توسيعا لمعرفة الاجتماعية و نماذج من الصحة، وبالتالي لتحديد مواطن الضعف الجديدة وحماية ضد خطر الإصابة.

الباب الثاني

الجانب التطبيقي

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الدراسة الأولى:

دراسة مستقبلية واساهم المرضى لسلوك الرياضي في تحمل الآلام

1. الأهداف والفرضيات

إذا ثبت أن التجربة عن وقوع اصابات في الماضي هو واحد من أهم العوامل الحاسمة في خطر الإصابة في المستقبل (all., 1996) ; (e.g. Kucera et al., 2005)، فمن الممكن أن السلوكيات التي اعتمدها الناس عندما يمارسون نشاطهم البدني و / أو الألعاب الرياضية هي أيضا محددات في وقوع اصابات. (انظر الفصل 2، القسم 1.2). وقد أكدت العديد من الدراسات أن الرياضيين المصابين لم يكونوا يحملون في السابق معدات للحماية من الآثار المسببة للأمراض من 1 في حادث من المرجح أن تحدث أثناء الممارسة الجسدية ; (e.g. Benson et al., 1999) (Spaite et al., 1991) وقد سعى عدد قليل جدا من الدراسات ولكن لتحديد سلوك الرياضي التي يمكن أن تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذه الحوادث، ومنع أو تسهيل على العكس من التكيف الطاقة الفائضة للشخص.

أول دراسة من هذا العمل الدكتوراه يسعى إلى تحديد سلوك الرياضي الجديدة التي يمكن أن تمنع أو لبدء اضطرابات التكيف الضارة. وهي مهمة بصفة خاصة في السلوكيات الرياضيين عند تجربة الألم. الألم هو في الواقع هيئة التنبيه لتكون بداية لسلسلة من الإجراءات والسلوكيات التي تهدف إلى حماية ضد هذا التهديد الذي يمثل يمثل الألم

. على الرغم من الاهتمام في الآونة الأخيرة ألم في سياق الرياضة (Bartholome w et al., 2001) ; (Meyers et al., 1998)، لا توجد دراسات على حد علمنا لم تهتم حتى الآن في التعبير السلوكي من ألم في جزء من النشاط البدني، وسعت لذلك للتأكد من أن المواقف حد من الألم يمكن أن تمنع أو غير ذلك في تسهيل وقوع الضرر.

هذه الدراسة الأولى، على أساس تصميم المحتملين، لذا تهدف إلى دراسة تأثير اثنين من السلوكيات الرياضيين من المرجح أن تعتمد، عند إحساسهم بالألم الحفاظ على كثافة من استثماراتهم المادية ، وأنها لا تميل إلى تغيير مهمة مؤلمة، أي للحفاظ على الطبيعة من السنة المالية الحالية، من ناحية أخرى في وقت فقدت خلال التدريب أو المنافسة بسبب إصابة (الوقت المحتسب بدل الضائع الخسارة، iTL). ويبدو أن هذا كاف لتقييم وسطا بين رياضي يدرك أن توقف في بعض الأحيان حملتها لمنع الإصابة أو خطر كامن على المثابرة على المدى القصير قد تكون أكثر إتاحة على المدى المتوسط و الطويل. (ITL: INJURY TIME LOSS: وقت خسارة الإصابة)

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

في هذه الدراسة، ونحن جعل الفرضيات التالية:

الفرضية 1: سجل المعاملات الدولي يعتمد على ميل من الرياضيين للحفاظ على كثافة من استثماراتهم على الرغم من تجربة الألم الجسدي وليس لتغيير مهمة مؤلمة.

الفرضية 2: طالما أن تجربة آلام حادة قد تترجم أكثر في الاضطرابات البيولوجية وتقترن الاضطرابات الإنتباه من قبل أكبر، وهذه السلوكيات هما أكثر المتصلة تكنولوجيا المعلومات عند الرياضي وتشعر بألم شديد في مقارنة مع ألم أقل خبرة مكثفة

لكل من هذه الفرضيتين، سوف تسيطر على المساهمة المحتملة للإصابة زيادة في التسبب (انظر الشكل 5).



الشكل 5. المساهمة المرضية لسلوك في مواجهة الألم

2. أسلوب

2.1 المشاركون

وافق 167 من الرياضيين 121 رجال و 46 امرأة للمشاركة طوعا في هذه الدراسة، وهي تمارس على الأقل لفترة من النشاط الرياضي المنتظم (مثل الجودو والتايكواندو وكرة القدم)، على مستويات مختلفة من المنافسة (مقاطعة إلى وطني)، وفي مختلف المؤسسات الرياضية (جمعيات أو الجامعات). متوسط عمر عينة لدينا

20.61 سنة (ET = 5.27 و اعمار عينة البحث = 13-47 سنة).

2.2 تدابير

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

تقييم للإصابة (انظر الملحق 1). وينبغي أن الرياضيين الإبلاغ عن عدد الأيام اللازمة للممارسة (التدريب والمسابقات) أوجه القصور في غضون شهر بسبب إصابة في وقت خسارة الإصابة ، ITL. كثيرا ما يستخدم هذا المتغير لتقييم حدوث الإصابات الرياضية (cf. Pétri e & Falkstein, 1998). لدرجة أن المشاركين في هذه الدراسة لديها ترددات مختلفة من الناحية العملية، لقد تم تصحيح هذا السجل

وفقا لمؤشر مميز يعرض من فرصتهم في الحصول على إصابة (cf. Smith et al., 1990). تم احتساب هذا المؤشر من خلال طرح عدد من غياب التدريبات بسبب الإصابة (ب) وفشل هؤلاء لأي سبب آخر من الضرر (م) على عدد من التدريبات المبرمجة في غضون شهر واحد (ع). تم احتساب درجة من التوقف بعد الإصابات الرياضية أو أكثر على النحو التالي: $T = (ب / ع) - م$ - (ب)).

الإصابة السابقة (انظر الملحق 1). وطلب منه أن يوقع كل من الإصابات الرياضية أن الصورة ربما تكون قد تعاقبت في الاثني عشر شهرا الماضية. أن يقدم اصابات فقط تتطلب اغلاق محرك لديه على الأقل في اليوم أو اهتماما خاصا طبي.

شدة الألم (انظر الملحق 1). بعد الإبلاغ عن وجود أو لا الألم الجسدي خلال رياضتهم خلال الشهر الماضي، وكان كل رياضي أن يقدم تقريراً إلى درجة الألم انه من ذوي الخبرة في الإجابة على السؤال: "في المتوسط، وهذه وكان الألم الشديد؟". تمكن المشاركون من وضعه على نطاق والتماثلية البصرية (EVA) بواسطة خط واحد فقط (أي أرقام) على خط 100 ملم، الراسية من 0 (أي ألم) إلى 10 (أقصى ألم يمكن تصورها).

المواقف من الألم (انظر الملحق 2). هذه السلوكيات في هذه الدراسة تشير إلى اتجاه للرياضيين للحفاظ على كثافة من استثماراتهم في وجود الألم الجسدي وليس لتغيير مهمة مؤلمة. ويتم تقييمهم باستخدام بندين عكس لتجنب التحيز الرغبة. بعد الإبلاغ عن شدة الألم الذي تعانيه خلال ممارسته الفعلية، وكان كل مشارك يوجب على السؤال التالي: "في المتوسط من الألم وامتناع. هل جسديا؟". وقدمت ردودا على خدمات القيمة المضافة 100 ملم، الراسية من 0 (لا يزال 100%) إلى 10 (وقف لتدريب).

وقد سئل المشاركون أيضا إلى أي مدى هذه الآلام تسبب تغيرا في تدريبهم عن طريق الإجابة على السؤال التالي: "في المتوسط، هذه الآلام والتي تضطر الى تغيير هذه المناورات المقررة في التدريبات الخاصة بك؟". وقدمت ردودا على EV A 100 ملم، الراسية من 0 (لا تغيير) إلى 10 (وقف التدريب).

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

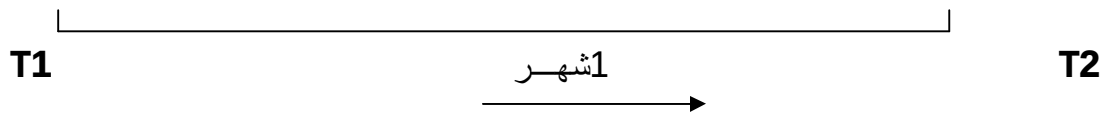
2- تحليل البيانات

تم تنفيذ سلسلة من تحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات لدينا. وتركزت جميع المتغيرات في هذه الدراسة من أجل تجنب المشاكل من القيم الخطية المتعددة. في كل تحليل، خسارة مرة خلال التدريب أو المنافسة بسبب الإصابة (ITL) هو المتغير التابع. لاختبار مساهمة المواقف من ألم في سجل المعاملات الدولية، ودرجة مع كل رياضي الذي حافظ على كثافة رأس المال المستثمر فيها والتي لا يطلب لتغيير مهمة مؤلمة، ودخلت في وقت واحد في المعادلة شعر الانحدار بعد ضبط المساهمة المحتملة لتجربة الإصابات الرياضية في الماضي، ونوع الجنس والعمر وشدة الألم. لاختبار الاحتمال الثاني أن العلاقة بين المواقف من الألم وتكنولوجيا المعلومات يعتمد على ما إذا الرياضيين يعانون من ألم شديد، أو منخفض، وكررنا هذا التحليل لمجموعات من المواضيع المنتمين و العلوي والسفلي الثالث للتوزيع

3- الإجراءات

وأجريت دراسة استطلاعية شهر واحد. تم الاتصال في البداية من خلال المدربين والرياضيين على علم الغرض من هذه الدراسة.

وكان في استقبال الاتفاق بعد اطلاعهم على سريتها. شرحنا من أجل تقديم هذا البحث، للرياضيين الذي نسعى لفهم لماذا بقيت في صحة جيدة عندما يقوم نشاطهم البدني. وقد بينا أيضا أن لديها لمساعدتنا، وملء سلسلة من الاستبيانات قبل تجريب، وبعد ذلك استبيان آخر بعد شهر من ذلك. واستخدمت المجموعة الأولى من الاستبيانات (T1) لتقييم عدد الإصابات التي لحقت في الاثني عشر شهرا الماضية، شدة الألم، وبما يتفق الرياضة السلوك. وقد تم جمع معلومات عن وقوع اصابات بعد شهر واحد اول سلسلة من القياسات (T2).



4- إصابة سابقة شدة الألم وسلوك في مواجهة الألم

الفصل التطبيقي

الدراسات الميدانية

و(1) معايير الاشتغال في عدم اصابة في بداية الدراسة؛ (2) وكانت تجربة من ألم في رياضته، (3) لاستكمال جميع الاستبيانات. وتم الاتصال من 286 رياضيا للمشاركة في هذه الدراسة ، سوى تسعة لم يشهد بأي ألم، و 110 لم تكتمل جميع الاستبيانات، بما في ذلك 108 الذين لم يشاركوا في المرحلة الثانية من الدراسة. وقد أدرجت أخيرا ما مجموعه 167 الرياضة في التحليل.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

5. النتائج

5-1- الإحصاء الوصفي

وسيلة، المتوسط (M) وتعرض الانحرافات المعيارية (ET) والارتباطات بين المتغيرات المختلفة في هذه الدراسة في الجدول رقم 1. وعموماً، 40,72% من العينة (ن = 68)

وقد تعاقدت واحد على الأقل من الإصابات خلال هذا الشهر. فقد بلغ متوسط عدد أيام بسبب الصورة أو إصابة 4.6 (ET= 7.00).

الجدول رقم 1. الوسائل، والانحرافات المعيارية ومصفوفة الارتباط بين المتغيرات في الدراسة 1 (ن = 167)

القيم	M	ET	1	2	3	4	5	6
1. الجنس	-	-	-	-	-	-	-	-
2. العمر	20.61	5.27	-20	-	-	-	-	-
3. الإصابة الماضية	1.24	1.34	-03	04	-	-	-	-
4. الشدة الألم	3.51	2.28	-1.2	14	18	-	-	-
5. الحفاظ على الكثافة	6.80	2.71	06	-12	-26	-50	-	-
الاستثمار المادي	6.92	2.91	08	-20	-25	-35	66	-
6. الحفاظ على	0.55	2.12	-11	00	22	11	01	-12
الممارسة المؤلمة								
7. الخسارة المرة								
بسبب الإصابة								

ملاحظة : كل الارتباطات | 1 8|. هامة $p > 0.05$.

5-2- التحليل من قبل الانحدار المتعدد

الفرضية 1: تحليل يكشف عن وجود علاقة إيجابية وهامة بين الدرجة الرياضيين للحفاظ على كثافة الاستثمار الخاصة بهم عند تجربة الألم الجسدي الرياضي وقت الذي فقد بسبب الإصابة ($\beta = p > 0.05$) ، والسيطرة على آثار الإصابة السابقة ($\beta = 0.22$, $p > 0.01$) ، والسن ($\beta = -0.05$ نانوثانية) والجنس ($\beta = -0.10$ نانوثانية) وشدة الألم من ذوي الخبرة ($\beta = -0.12$ ، نانوثانية). تحليل دان، يكون الاتجاه من الرياضات لا يغير المهمة ليست مؤلمة

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

ITL معنويا ($\beta = -0.20$ ، نانوثانية). وعموما، فإن معادلة الانحدار كان كبيرا، $F(6, 159) = 2.88$ ، $R^2 = 0.10$ ، $p > 0.05$ ، (انظر الجدول 2).

الجدول 2 : التنبؤ من السلوك وجه يرة ق الألم (ن = 167)

1 TL	مستقبل متغيرات المستقبل
β	
-0.05	السن
-10	الجنس
12	شدة الألم
**22	الإصابة القديمة
*25	الحفاظ على كثافة الاستثمار المادي
-20	الحفاظ على ممارسة مؤلمة
10	R^2
*2.88	F

ملاحظة : معاملات الانحدار موحدة. $p > 0.05$ ، $p > 0.01$ ، $p > 0.001$

الفرضية 2: وأجريت الانحدارات على حدة بالنسبة للرياضيين الذين تعرضوا لى الألم حاد في مقابل منخفضة (أنظر الجدول 3).

لمجموعة من الرياضيين الذين تعرضوا لألم شديد، أي ينتمون إلى الثلث الأخير من توزيع (ن = 49)، يبين التحليل فقط ايجابية وهامة للحفاظ على كثافة من استثماراتهم في المادية تكنولوجيا المعلومات L ($\beta = 0.46$ ، $p > 0.05$) ، عندما تأثير الإصابة السابقة ($\beta = 0.38$ ، $p > 0.05$)، السن ($\beta =$

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

- (5, 43) $p > 0.05$ ، ويتم التحكم في الجنس ($\beta = 10$ ، نانوثانية). كانت معادلة الانحدار الكبير، (5, 43) $R^2 = 0.05$ ، $F = 2.75$ ، $P > 0.05$ ، $R^2 = 0.24$

لمجموعة من الرياضيين الذين تعرضوا الى الألم أقل كثافة، والانتماء إلى أي الثلث الأول من توزيع (ن = 56) أو الحفاظ على كثافة من استثماراتهم المادية ($\beta = 13$ ، نانوثانية) أو أنها لا تميل إلى تغيير ممارسة مؤلمة ($p > 0.05$ ، نانوثانية) لا تؤثر على ITL، بدلا من ذلك عندما مساهمة الإصابة السابقة مهم ($\beta = 54$ ، $P > 0.05$) وبعد التحقق من جميع

السن ($\beta = 18$ ، نانوثانية)، والجنس ($\beta = 28$ ، $P > 0.001$ ، $R^2 = 0.33$). كانت معادلة الانحدار كبيرة.

الجدول 3. التنبؤ من السلوك في التعامل مع الألم للرياضيين الذين تعرضوا لآلام حاد في مقابل ضعف (ن = 167)

مستقبل متغيرات المستقبل	ألم معتدل	ألم شديد
	1TL	1TL
	β	β
العمر	18	-17
الجنس	28*	10
الإصابة القديمة	54***	38*
الحفاظ على كثافة الاستثمار المادي	13	46*
الحفاظ على ممارسة مؤلمة	-05	-27
R^2	33	24
F	4.91***	2.75*

ملاحظة: معاملات الانحدار موحدة. $p > 0.001$ ***، $p > 0.05$ *

حيث أن الدراسات قد ركزت في معظمها على مساهمة ميناء معدات الحماية إلى وقوع إصابات أثناء ممارسة النشاط البدني و / أو الألعاب الرياضية، أي سلوك الصحية الوقائية (e.g. Benso n et al., 1999)، وهذه هي أول دراسة للنظر في طبيعة المواقف المسببة للألم، أي أنبوب للخطر الرياضية.

4.1 الألم، والمواقف من الألم والمرضية

نتائج هذه الدراسة تؤكد جزئياً فرضيتنا. أنها تشير إلى أن أكثر رياضي يحافظ على كثافة من استثماراتها عند الألم الجسدي من ذوي الخبرة، والمزيد من أنه يفقد في المدى القصير (شهر) من أيام التدريب بسبب واحد أو أكثر وقوع اصابات. هذه العلاقة ليست واضحة بعد ضبط

مساهمة المسببة للأمراض من الاصابة السابقة (الفرضية 1). ومن المثير للاهتمام لا سيما أن هذا السلوك أمر بالغ الأهمية عندما كان اللاعب يعاني من ألم شديد، في حين لن تكون لي أي تأثير عندما يكون الآلام من كثافة منخفضة (الفرضية 2). لكن هذا الاتجاه من الرياضيين لا يتم أبدا تغيير مهمة مؤلمة تتعلق بشكل ملحوظ الرياضيين التوقف أعقاب وقوع إصابات واحد أو أكثر (الفرضيات 1 و 2).

كما تدل على وجود خلل بيولوجي أو هيئة قصور، والألم على ما يبدو اشارة الى ان الهيئة يجب أن تؤدي للرياضي لضبط سلوكه، وخصوصا لشدة استثماره المادي. الحفاظ على هذا الاستثمار المكثف يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية بما في ذلك الألم قد تكون عرضية، لتوليد العجز الكلي للرياضي في نشاطه الجسدي. بواسطة احتكار أيضا الموارد الإنتباه (e.g . Ecclesto n & Crombez , 1999)، فإنه من الممكن أيضا أن ألم يعطل التكيف للرياضي لطلبات الحصول على المهمة الحالية، وبالتالي يضعف. وقد أبرزت بعض الدراسات وخاصة تأثير اضطرابات الانتباه في وقوع الإصابات الرياضية (Roger s & Williams , 1999); (Anderse n & Landers , 2005). وهذه الاضطرابات الاهتمام يؤدي إلى صعوبات بالنسبة للرياضيين لتحديد والاستجابة بسرعة للمنبهات البيئية تنبيههم من خطر على سلامتهم الجسدية. وبالتالي، يمكن أن يصيب الرياضي بتطلع للحفاظ على استثماراته من الألم الجسدي الشديد حتى يشعر أكثر نظرا لافتقارها إلى القدرة على الاستجابة للمعلومات التي تهدد مختلف النابعة من بيئته.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

7- الثقافة الرياضية: الثقافة الأساسية لمسببات المرضية

هذه الدراسة هي واحدة من أولى لتصبح مهمة في تأثير السلوكيات المسببة للأمراض قيمتها في سياق الرياضة (Nixon , 1993) ; (Messner, 1992). بعض المنظمات الرياضية هي في الواقع أماكن الألم، وبعيدا عن الظهور بمظهر إشكالية، قد تكون علامة على القوة والاعتراف (Ewald & Nixon, 1992) ; (Hughe s & Coakley, 1991) ; (Jiobu, 1985). الخوف من الازدراء والتهميش الاجتماعي يترتب على الرياضيين الملتزمين إصابة ربما في آليات الحرمان من أعراض تعكس وجود هذه الإصابة. في هذه السياقات، قد يكون الوضع الطبيعي من الألم تسود في نهاية المطاف (Nixon , 1993) ; (Frey, 1991). وهذا قد يشمل الحياة الطبيعية في العلاقة بين (مدرب، رياضي)، ويمكن بالتالي أن ينظر إليه باعتباره أرضا خصبة لنشوء الإصابات الرياضية. من أجل منع الإصابة، يبدو من الضروري أن الوفد المرافق للرياضي للمساعد في فهم الألم كتحذير تدعي وجود تعديل سلوكها، بدلا من تشجيع، طوعا أو كرها، للحفاظ على استثماراتها على الرغم من وجود ألم.

7-1- حدود الدراسة والمنظورات البحثية:

هذا البحث يقدم عددا من القيود. أول هذه الدراسة يستخدم التقديرات بأثر رجعي لتقييم الألم والسلوكيات الناجمة عن ذلك. لكن الألم لا وجود له بدون قشرة الدماغ يستقبل المعلومات التي تنير على هذا النحو (Pen & Fisher, 1994). قد الرياضيين يكون قادرا على تذكر بعض الأحداث المؤلمة، ولكن دقة من شدة هذا الألم يمكن أن يكون صعبا (Meichenbaum , & Genest, 1987). ولذلك، من أجل تحديد تأثير العدوى من الألم ويترتب على ذلك السلوك، يجب أن منهجيات البحث الجديدة تجد

أن تحديد والإبلاغ عن شدة الألم أقرب إلى وقوعها. استخدام القياسات المتكررة، أي في كل ممارسة أو ممارسة كل ذلك، تلبية هذا المطلب في الوقت الذي من شأنه أن يضع المزيد من التركيز على العلاقة المتغيرة بين المواقف من الألم، وحدث الإصابات مع مرور الوقت.

وعلاوة على ذلك، إذا كان لنا أن نخلص إلى أن الحفاظ على كثافة الاستثمار المادي له يزيد من تكنولوجيا المعلومات لأن الألم هو الذي يسبب اضطرابات الانتباه، لا شيء يمكن في دراستنا لم تؤكد

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

المساهمة الفعلية لهذه الأحداث المرتبطة الإنتباه إلى ألم في وقوع إصابات. ومع ذلك، يمكن أن البروتوكولات التجريبية تحديد مسبق لمن هم أكثر عرضة من غيرهم للأعطال في وضع مؤلم الإنتباه، ونرى إلى أي مدى ويرافق هذه الحساسية من خلال ما يلي، على المدى القصير والمتوسط والطويل، شهدت أكبر وقوع إصابات خلال ممارسة النشاط البدني و / أو الرياضي، وشدة ألم يتم التحكم في مكان آخر.

أكثر عموماً، ودراسة عن إصابة لا يزال يشكل بعض الصعوبات المنهجية. استخدام تكنولوجيا المعلومات والمتغير التابع هو مشكوك فيه للغاية. المنهكة طبيعة إصابة يعتمد على خصوصية الفعلي للرياضة - رياضة مع كسر في الذراع يمكن أن تلعب كرة القدم وليس كرة اليد - والعوامل الفردية مثل التسامح الألم (Flint, 1998). وكشف في وضع معايير موثوقة وموضوعية على نحو أكثر دقة فهم من الإصابة وجود إصابات لا يزال يشكل تحدياً رئيسياً للتخلص إلى نتيجة حاسمة بشأن تأثير العوامل المسببة للأمراض في سياق لعبة رياضية. هذه الصعوبات والتحديات المنهجية لا تمنع من الحاجة إلى معرفة سلوك المسببة للأمراض المختلفة.

المعرفة هي في الواقع ضرورية للنظر في النهج السريري الذي سيكون الهدف هو منع وقوع الحوادث والإصابات في صفوف الرياضيين، والقضية الحقيقية

8- الصحة العامة.

باختصار، هذه هي أول دراسة للنظر في مساهمة السلوكيات المرضية تعتمد أن الرياضيين يتحملون الآلام. بالنظر إلى عواقب وخيمة للحفاظ على كثافة من استثماراتها على الرغم من تجربة الألم الجسدي، من الضروري لتحديد البحوث المستقبلية في العوامل المسؤولة عن مثل هذا السلوك. بينما حاسمة، لشدة الألم مسؤولة فقط عن 10 إلى 15٪ من الخلافات بين الأفراد (السكان صحي أو السريرية) سلوك في التعامل مع الألم (Labus, Keefe, & Jensen, 2003). النظريات الحالية تعترف بأن الآن، تدل على تأثير شدة الألم، والعوامل النفسية قد يعدل السلوك بما يتفق (cf. Turk, 2002, & Okifuji). ولذلك يبدو من الضروري تحديد الخصائص الفردية والاجتماعية التي تشجع الرياضيين على الحفاظ على كثافة الاستثمار الجسدية خلال الرياضة مؤلمة، وتصل إلى التعاقد مع واحدة أو أكثر وقوع إصابات. فإن هذه البحوث الإضافية على فهم أفضل لعوامل مسؤولة عن

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الإصابات والعمليات الأساسية. في الدراسة التالية من هذه الرسالة يثير مسألة محددات المواقف إلى ألم عند ممارسة النشاط البدني و / أو الرياضي.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الدراسة الثانية:

1- . الأهداف والفرضيات

الألم هو إشارة تحذير أن يتسبب في الجسم لتبدأ سلسلة من الإجراءات والسلوكيات بما في ذلك لحماية الجسم ضد التهديد أن هذا الألم الناتج. وقد أنشأت أول دراسة من هذه الأطروحة الى تسببها للرياضي عن طريق الحفاظ على كثافة الاستثمار البدني ما يتعرض له من آلام خلال ممارسته. من أجل تفادي وقوع إصابات يبدو من الضروري لفهم العوامل والعمليات التي تسهم في الالتزام من جانب الرياضيين في هذا السلوك المسببة للأمراض.

كما سلط الضوء في الجزء 2.2 من الفصل 2، المعرفة الاجتماعية و نماذج (e.g . Modèl e de s Croyance s su r la Santé, MCS , Becke 1998) ; (Théorie de la Motivatio n à se Protéger, TMP , Rogers , 1983) قد تشكل الأطر تحليل المحددات النفسية للسلوك وقائي أو تعزيز الصحة. على الرغم من أنها وضعت هذه النماذج لتعزيز المعلومات المقدمة للمستخدمين، وتحسين أثر حملات وقائية والامتثال للعلاج من المرضى (Pédinielli, 1996) ، وقد أثبتت الدراسات القليلة فائدتها في شرح التزام من شخص في التسليم خطر للسلوك، مثل ارتفاع استهلاك الكحول، على سبيل المثال e.g . Goldber g et al., (2002). لم يتم بعد الدراسات التي أجريت لتحديد المحتملة لهذه النماذج للتنبؤ السلوكيات الرياضية الخطرة. الدراسة الثانية الدكتوراه ويركز بالتالي على مساهمة من 2

العوامل النفسية المشتركة من قبل معظم النماذج المعرفة الاجتماعية لضعف الصحة، أي وحدة تصور (Conner & Norman , 2005 ; Weinstein, 2000). وهو يسعى إلى تحديد كيفية هذين العاملين بتفسير لماذا بعض الرياضيين يمكن الحفاظ على كثافة الاستثمار المادي عند العانة من آلام أثناء النشاط الرياضي .

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الدراسة هي الأولى لتحديد محددات المواقف إلى ألم عند ممارسة هذه الرياضة والنشاط البدني. دراسات قليلة حتى الآن مهتمة في الاستراتيجيات المعرفية المختلفة - وخاصة الميل إلى تهويل الألم أو تجاهله - للرياضيين عند نشر الصورة تعاني من ألم في أثناء عملهم (على سبيل المثال مايرز وآخرون (Paparizos , Tripp, 2001 Meyer s, 2001)

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

(Sullivan, & Rubenstein, 2005). واحد وجدت الدراسة أيضا تأثير هذه الاستراتيجيات، وتحديدًا في قالب درامي، تصور والتسامح من الرياضيين إلى الألم (Sullivan, Tripp, Rogers, Stanish, 2000) &. الدراسات السريرية من قبل السكان الآخرين، أي المريض مع التهاب المفاصل، من فيبروميالغيا أو التصلب المتعدد، أو من الأشخاص الأصحاء ولكن ليس الرياضة، وأظهرت أن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تحدد سلوكهم عند تجربة الألم الحاد أو المزمن (e.g. Osborne, Jensen, Ehde, Gheldof et al., 2006; Martin et al., 1996). وبالتالي، فإن الشخص الذي يكون قادرا على تجاهل مثل هذا الألم (Hanley, & Kraft, 2007). انه يميل إلى شعور معاق إلى حد ما ألم به (Cano, Mayo, & Ventimiglia, 2006) (Edwards, Moric, Husfeldt, Buvanendran, & Ivankovich, 2005), (Turner, Jensen, Warms, & Cardenas, 2002; Leisen, 1998). ومع ذلك، فإن ميل من شخص لتحويل ألم يشعر به يرتبط سلبا على مستوى النشاط في عام (Robinson et al., 2002; Sullivan et al., 1997). انها مباشرة المسؤولة عن مستشفى يبقى أكثر تكرارا وأطول.

(Phillips, & Williams, 1992) أو النفس المعاملة (Bédard, Reid, McGrath, & Chambers, 1997) وأخيرا، فإن شدة الألم أن الشخص قد يتعرض خلال نشاطها يحدد أكثر من 10 إلى 15٪ من التباين بين الأفراد في السلوك (Labus et al., 2003)

على الرغم من أن هناك دراسات تثبت تأثير هذه الاستراتيجيات على سلوك الرياضيين عند تجربة الألم، فمن المرجح أن تكون حاسمة في الحفاظ على الاستثمار في الرياضة البدنية. المساهمة المحتملة لهذه العوامل، أي من شدة الألم واستراتيجيات للتعامل مع هذه التجربة، وتسيطر عليه.

وباختصار، هذه الدراسة الثانية تهدف إلى التعرف على إمكانية تفسير الضعف المتصورة وحدة ينظر في اعتماد سلوك الرياضي من العوامل المسببة للأمراض الصحية، أي الحفاظ على كثافة من استثماراتهم على الرغم من تجربة الألم الجسدي (انظر الشكل 6).

في هذه الدراسة، ونحن جعل الفرضيات التالية:

الفصل التطبيقي

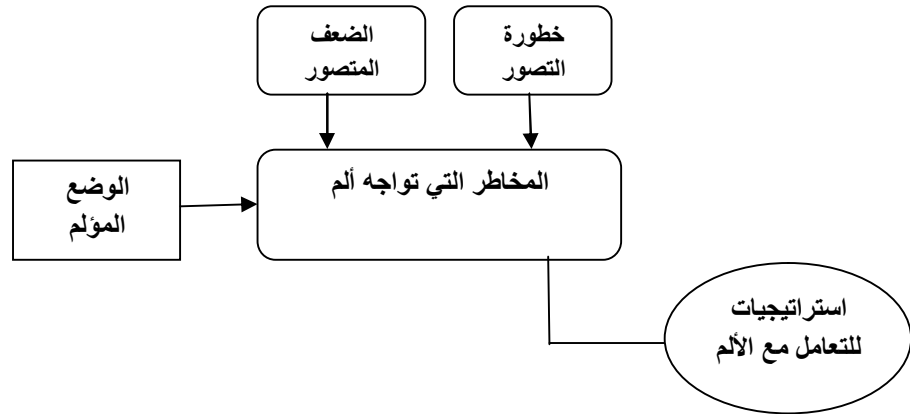
الدراسات الميدانية

الفرضية 1: الميل للرياضيين على الحفاظ على كثافة الاستثمار المادي يعتمد على إدراك نقاط ضعفهم للإصابة. إلا أنهم يرون أنفسهم أكثر عرضة للإصابة وانها تميل الى الحفاظ على الاستثمار المادي الشديد، على الرغم من تجربة الألم.

الفرضية 2: الميل للرياضيين للحفاظ على كثافة الاستثمار المادي يعتمد على تصورهم لخطورة الإصابة المحتملة. ما لم يحصلوا على إصابات أكثر خطورة مثل هذه ،سوف تميل للحفاظ على استثماراتهم المادية الشديدة، على الرغم من تجربة الألم.

الفرضية 3: الضعف وحدة المتصورة هي قوة مكملة للتنبؤ الصيانة شدة الرياضة البدنية من استثماراتهم.

لكل من هذه الافتراضات الثلاثة شعر المساهمة المحتملة من شدة الألم، مثل أن يتم التحكم في كل الاستراتيجيات الرياضي المنتشرة في التعامل مع هذا الألم.



الشكل 6. المحددات النفسية للسلوك الصحي في مواجهة الألم

2. أسلوب

2-1- المشاركون

205 رياضيًا (متوسط السن = 22.73، والانحراف المعياري = 6.45، العينة السن = 15-41 سنة)، و 47 نساء والرجال 158، ممارسة الرياضة القتالية (الجودو والمصارعة والكاراتيه والتايكوندو) وشارك طوعا في هذه الدراسة. في المتوسط، وهؤلاء الرياضيون ممارسة نشاطهم من 89,7 سنة (والانحراف المعياري = 5,92، مدى = 0-25 سنة)

2.2 تدابير

شدة الألم (انظر الملحق 1). بعد إشارة على وجود (أو لا) من الألم الجسدي في رياضتهم خلال الشهر الماضي، و كل رياضي أن يقدم شدة الألم كان قد شهد في الإجابة على السؤال: "في متوسط الاحيان هل كانت هذه الآلام شديدة؟". تمكن المشاركون من وضعه على نطاق والتماثلية البصرية (EVA) بواسطة خط واحد فقط (أي أرقام) على خط 100 ملم، الراسية من 0 (لا ألم) إلى 10 (أقصى ألم يمكن تصورها).

صحة صفقة سلوك مع الألم (انظر الملحق 2). بما يتفق مع نتائج دراستنا الأولى، ودراسة السلوك الصحي يشير إلى الحفاظ على كثافة من استثمارات في ظل وجود الألم الجسدي. ويتم تقييمها من خلال استخدام عنصر العكسي، من أجل تجنب التحيز الرغبة. بعد الإبلاغ عن شدة الألم الذي تعانيه أثناء الممارسة الجسدية، وكان كل مشارك الإجابة على السؤال التالي: "في المتوسط من الألم هل احساستم بنقص بدني ؟". وقدمت ردودا على خدمات القيمة المضافة 100 ملم، الراسية من 0 (لا يزال 100%) إلى 10 (وقف التدريب).

استراتيجيات للتعامل مع الألم (انظر الملحق 4). وجرى تقييم استراتيجيات محددة أن الرياضيين تبذل للتعامل مع الألم الذي يشعرون به أثناء ممارستها باستخدام الاستبيان استراتيجيات المواجهة ، CSQ (Rosenstiel & Keefe, 1983)، (Irachabal, Koleck , Rasclé, & Bruchon- Schweitzer , 2008). ويتضمن هذا الاستبيان 21 مقترحا لتقييم كيفية استخدام كل مادة خمس

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

استراتيجيات للتعامل مع الألم (. تسلية، الصلاة، إعادة تفسير أحاسيس الألم، تجاهل الألم ، تهويل الألم)، وذلك باستخدام تصنيف على مقياس من 1 (أبدا) إلى 4 (في كثير من الأحيان). لكل عامل، ألفا كرونباخ صحيحة (تسلية: $\alpha = 0.74$ ؛ الصلاة: $\alpha = 0.85$ ؛ إعادة تفسير

- 0.83، والجهل: $\alpha = 0.79$ ؛ المسرحة: $\alpha = 0.67$)، مما يعكس صحة داخلية جيدة من الاستبيان مع عينة الدراسة الشاملة.

إدراك المخاطر. ومعرفة تصور وجود خطر من خلال الإدراك للرياضي على حد سواء من تعرضها لاصابة في الإدراك من الشدة. تم تكييف المقاييس المستخدمة (انظر الملحق 3) من المقاييس الحالية (Weinstein , 2000) ; (Gerend, Aiken , West, & Erchull , 2004)، لمواصلة أهداف البحث لدينا.

وقد تم تقييم حساسية ينظر إلى إصابة في التسليم باستخدام الاقتراح التالي

"هل لديك خطر الإصابة هذا الموسم ممارسة الرياضة الخاصة بك؟". وطلب من المشاركين على مقياس من 0 (أي خطر) إلى 10 (بالتأكيد). يراها من شدة الإصابات الرياضية وقيمت أيضا باستخدام واحد الفنار م ش ن: "عموما، إصابة انها سوف يكون لها أثر سلبي على حياتك (الرياضية والاجتماعية والأسرية)؟". وطلب من المشاركين على مقياس من 0 (أي أثر) إلى 10 (خطر جدا).

2.3 تحليل البيانات

تم تنفيذ سلسلة من تحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات لدينا. وتركزت جميع المتغيرات لتجنب المشاكل من العلاقة الخطية المتداخلة. في كل تحليل، للدرجة ان الرياضي يحافظ على كثافة استثماراته في التجربة المادية للألم هو المتغير التابع. المساهمات المحتملة من العمر، من ذوي الخبرة بين الجنسين، والخبرة الرياضية، وشدة الألم ويتم التحكم في الاستراتيجيات الرياضيين ونشرت للتعامل مع هذا الألم. لاختبار يتم إدخالها لدينا ثلاث فرضيات، وشدة حساسية ينظر بشكل منفصل (الفرضية 1 و 2) في وقت واحد (الفرضية 3) في معادلة الانحدار

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

2-3- الإجراءات

تم الاتصال في البداية من خلال المدربين والرياضيين على علم الغرض من هذه الدراسة. وكان في استقبال اتفاقهما بعد اطلاعهم على سريتها. شرحنا من أجل تقديم هذا البحث، والتي نسعى لفهم لماذا بقيت في صحة جيدة عندما يمارس نشاطهم البدني. وقد بينا أيضا أن لديه ثانية، لمساعدتنا، وملء سلسلة من الاستبيانات قبل التمارين. و(1) معايير الاشتغال عدم الكشف عن إصابة في ذلك الوقت من هذه الدراسة، (2) أن يكون الألم من ذوي الخبرة في مجال الرياضة لها، (3) لاستكمال جميع الاستبيانات. وتم الاتصال مع اثنين من مئة وثلاثين ستة رياضيين للمشاركة في هذه الدراسة. من 236، قد شهدت 18 لا أشعر بأي ألم، و 13 لم تكمل جميع الاستبيانات. وقد أدرجت أخيرا ما مجموعه 205 رياضيا في التحليل.

3. النتائج:

3-1- الإحصاء الوصفي:

وسيلة، وتعرض الانحرافات المعيارية والارتباطات بين المتغيرات المختلفة في هذه الدراسة في الجدول رقم 04.

ويحلل علاقات هامة بين كشف شدة مواصلة الاستثمار على الرغم من تجربة الألم الجسدي وشدة الألم ($p < 0.05, r = -0.53$) والتجربة الرياضية ($p < 0.05, r = -0.18$). والضعف المتصورة ($r = -0.27$). ($p < 0.05$)، وشدة ينظر ($p < 0.05, r = -0.18$)، وقدرة الرياضيين على تجاهل الألم ($r = -0.18$). ($p < 0.05$)، والميل إلى تهويل، ($p < 0.05, r = -0.25$).

الجدول 4. متوسط والانحراف المعياري ومصفوفة الارتباط بين متغيرات

هامة.كل الارتباطات $|0.16| \leq$ هامة

الفرضية 1. وكشف التحليل وجود علاقة سلبية كبيرة بين الضعف وينظر إلى الدرجة الرياضيين الحفاظ على كثافة الاستثمار الخاصة بهم عند تجربة الألم الجسدي من الألعاب الرياضية ($\beta = 0.14$, $P > 0.05$)، والسيطرة بالنسبة للعمر ($\beta = 0.09$ نانوثانية) والجنس ($\beta = 0.04$ ، نانوثانية)، وتجربة الرياضة ($\beta = -0.13$, $P > 0.05$)، شهدت شدة الألم ($\beta = -0.47$, $P > 0.05$) واستراتيجيات للتعامل مع الألم ($\beta = 0.04$ نانوثانية)، للنطاق، من أجل إلهاء؛ ($\beta = 0.03$ نانوثانية، للنطاق، للصلاة؛ ($\beta = -0.07$ نانوثانية، للنطاق، ($\beta = 0.13$ ، نانوثانية) عن جهل؛ ($\beta = -0.15$, $P > 0.05$) وبالنسبة للدرامية).

الفرضية 2. ويكشف التحليل أيضا وجود علاقة سلبية كبيرة بين خطورة المتصورة والدرجة الرياضيين الحفاظ على كثافة الاستثمار الخاصة بهم عند تجربة الألم الجسدي من الألعاب الرياضية ($\beta = -0.14$, $P > 0.05$). في الآثار من العمر ($\beta = 0.09$ ، نانوثانية؟)، والجنس ($\beta = -$

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

0.00، نانوثانية)، وتجربة الرياضية ($\beta = -0.09$ ، نانوثانية)، و شدة الألم من ذوي الخبرة ($\beta = -0.51$ ، $P > 0.001$)، واستراتيجيات للتعامل مع الألم ($\beta = 0.05$)، للنطاق، لإلهاء، ($\beta = 0.01$ نث)، للنطاق، للصلاة و ($\beta = -0.08$)، للنطاق، لإعادة تفسير؛ ($\beta = 0.14$ ، $P > 0.05$)، عن جهل؛ ($\beta = -0.14$ ، $P > 0.05$) وبالنسبة للدرامية

. كانت معادلة الانحدار الكبير، $F(10, 194) = 10.98$ ($P > 0.001$) $R^2 = 0.36$. (انظر الجدول 5).

الفرضية 3. تم إجراء تحليل عن طريق إدخال الضعف المتصورة في وقت واحد وشدة ينظر في معادلة الانحدار. هذا التحليل يكشف عن مساهمة كبيرة في الضعف على حد سواء المتصورة ($\beta = -0.13$ ، $p > 0.05$)

ينظر بخطورة ($\beta = -0.13$ ، $p > 0.05$)، عندما الآثار من العمر ($\beta = 0.10$ ، نانوثانية؟)، والجنس ($\beta = 0.02$)، والخبرة الرياضية ($\beta = -0.09$ ، م)، لشدة الألم من ذوي الخبرة ($\beta = -0.48$ ، $P > 0.001$)، واستراتيجيات للتعامل مع الألم ($\beta = 0.05$)، لإلهاء؛ ($\beta = 0.03$) للصلاة، ($\beta = -0.08$)، للنطاق، لتفسير، ($\beta = 0.14$ ، $p > 0.05$)، عن جهل، ($\beta = -0.13$ نث، للنطاق، لمسرحة) يتم التحكم في معادلة الانحدار كان كبيرا، $F(11, 193) = 10.51$ ($P > 0.001$) $R^2 = 0.37$. (انظر الجدول 5).

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الجدول 5. تنبؤ الحفاظ على كثافة الاستثمار البدني من قبل الضعف المتصور و شدة المتصورة

الحفاظ على كثافة الاستثمار المادي			مستقبل متغيرات الدراسة
H3	H2	H1	
.10	.09	.09	العمر
.02	-.00	.04	الجنس
-.09	-.09	-.13*	الخبرة الرياضية
-.48***	-.51***	-.47***	شدة الألم
.05	.05	.04	إلهاء
.03	.01	.03	الصلاة
-.08	-.08	-.07	إعادة تفسير
.14*	.14*	.13	الجهل
-.13	-.14*	-.15*	رواية تصلح للتمثيل
-.13*		-.14*	الضعف المتصور
-.13*	-.14*		الخطورة المتصورة
.37	.36	.36	R ²
10.51***	10.98***	10.94***	F

***p > 0.05, *p > 0.001 ملاحظة . معاملات الانحدار موحدة.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

. مناقشة

هذه الدراسة تهدف الى تقييم مدى ضعف و / أو شدة المتصورة، واثنين من المتغيرات تشترك فيها معظم النماذج

وارتبطت، مع الحفاظ على رياضي من شدة استثماره عندما يشعر من الألم الجسدي، والصحية (Weinstein, 2000); (Conner & Norman, 2005).

1،4 الضعف المتصورة، وينظر إلى خطورة التصرفات الصحية

نتائج هذه الدراسة تدعم لدينا ثلاث فرضيات. انها تشير الى أن ينظر إليها أحد الرياضيين أقل عرضة للإصابة و / أو النظر في الإصابة كما حدث خطير، يكون أكثر عرضة للحفاظ على كثافة استثماراته على الرغم من تجربة الألم الجسدي. هذه العلاقة موجودة بعد ضبط شدة الألم الذي يعانيه، والمساهمة المحتملة التي استراتيجيات الرياضة المنتشرة في التعامل مع هذا الألم.

أول دراسة من هذا العمل يدل على أن له علاقة مباشرة في ميل للرياضي للحفاظ على كثافة من استثماراتها على الرغم من تجربة الألم الجسدي إلى وقوع إصابات. من خلال إظهار مساهمة الضعف المتصورة وخطورة واضحة في اعتماد مثل هذا السلوك، هي أول دراسة لمعرفة مدى ملائمة المعرفة الاجتماعية نهج لتحديد الرياضيين تبني السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كجزء من ممارساتهم. وقد لاحظ أن الغالبية العظمى من الدراسات في وقت سابق ان تصور ضعف وتحديد شدة اعتماد السلوكيات التي تهدف إلى حماية والحفاظ على صحة الشخص. ويرتبط في السلوك الجنسي، على سبيل المثال، كثيرا ما يتبين ينظرون إلى أنفسهم لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في الجهود الرامية إلى الحد من حدوث الجنس بدون وقاية (Gerrard , Gibbons , Benthin , et (1996) ; (Gerrard , Gibbons , & Bushman , 1996) .al., 1996). هذا الاتجاه أيضا إلى اعتبار يرتبط بشكل إيجابي الأمراض الجنسية الخطيرة لاستخدام الواقي الذكري أو الامتناع عن ممارسة الجنس (Petosa & Jackson , 1991); (Iriyam a et al., 2007) .(e.g . من ناحية أخرى جدا وقد نظرت بعض الدراسات إمكانية مساهمة هذه التصورات في التزام

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

في السلوكيات الخطرة. بعض الدراسات، على سبيل المثال، أثبتت أن استهلاك الكحول لدى المراهقين يعتمد على ميلها لعرض أنفسهم على أنهم غير معرضة للخطر للمخاطر المرتبطة بها (e.g. Goldber g et al., 2002). أيا من هذه الدراسات، ومع ذلك، فقد قلق من خطر الاصابات الرياضية.

3-3- محددات السلوك في مواجهة الألم

هذه الدراسة هو أيضا أول من التركيز على العوامل المحددة للسلوك الذي اعتمد من قبل الرياضيين للتعامل مع الألم. وتشير النتائج إلى أن الرياضيين الذين يعتبرون أنفسهم من المرجح أن يضر أو يصاب التي من شأنها أن يكون لها تأثير كبير على حياتهم الرياضية والاجتماعية أو العائلية، وأقل انتباها

على الأحاسيس الجسدية المختلفة مثل الألم، والتي كان ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار (Cioffi , 1991). وبالتالي هو الحفاظ على مزيد من الاستثمار المكثف البدني بالمقارنة مع الرياضيين الذين يعتبرون أنفسهم عرضة لخطر الإصابة والذين يميلون بالتالي إلى الالتفات إلى ألم و / أو النظر فيه باعتباره علامة على الضعف. على الرغم من أن الرياضيين

هذه العادة من الألم التي تعاني من (Sullivan et al., 2000) ; (Khan et al., 1995)، إلى الحد الذي جعله في المستوى المقبول في أنشطتها (Nixon , 1993)، نتائجا تظهر لذلك العمليات التي يقوم عليها سلوك الرياضيين التعامل مع الألم هي نفس السكان السريرية، أي مع أو ليس مختلف المشاكل و / أو الرياضية. على الرغم من أن الدراسات أظهرت أن هناك علاقة مباشرة لشدة الألم الذي تعانيه إلى القدرات البدنية للأشخاص الذين ينتمون إلى هذه المجموعات السكانية (e.g. Arnstein , Caudill ,1998) (Mandle , Norris , & Beasley , 1999) ; (Burton , Tillotson , Main , & Hollis , 1995) ; (Gatchel , Polatin , & Mayer , 1995) ; Levin . Lofland , Cassisi , Poreh , & Blonsky , 2002) (Sullivan et al., 1996)، وأنها رسلط الضوء أيضا على مساهمة إضافية العوامل

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

النفسية، وعلى وجه التحديد والاستراتيجيات المستخدمة لمواجهة الألم والمخاطر المتوقعة من مزيد من الإصابة / المرض / الألم (cf. Turk & Okifuji, 2002).

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

4.3 حدود الدراسة والمنظورات البحثية

هذا البحث يقدم عددا من القيود. أولا هذه الدراسة الثانية تستخدم الأولى، أقتبس مرة أخرى لتقييم الألم والسلوك والمجازفة وبالتالي انحياز كبير (انظر القسم 4.3 من الدراسة 1). وعلاوة على ذلك، لم تتم السيطرة على توقيت لتقييم المواقف من ألم في هذه الدراسة. لكن من المحتمل أن تجربة الألم ليس لديه ذاكرة المعنى، وبالتالي لا يولد سلوك نفسه، وقبل منافسة كبيرة أو مجرد هدنة قبل الرياضة (Flint, 1998).

أكثر عموما، يجب على الدراسات المستقبلية ان تحدد العوامل الفردية والاجتماعية التي يمكن أن يفسر لماذا يشارك الرياضي في السلوكيات الصحية. وتركز هذه الدراسة على وجه الخصوص أن جزء واحد فقط من النهج الاجتماعي المعرفي. إذا كان ينظر إلى الضعف وشدة هما المتغيرات المركزية في نماذج عدة المعرفة الاجتماعية (Conner & Norman, 2005 ; Weinstein, 2000)، قد تبني السلوكيات الصحية تعتمد أيضا على المعتقدات حول هذه السلوكيات. الناس على استعداد لتبني السلوكيات الصحية وخاصة إذا كانوا يعتقدون (1) أن هذا السلوك تعطي نتائج قيمة، (2) أن الناس وجهات النظر هي مهمة لهم يعتقدون أنهم يجب أن يتصرفوا بشكل جيد، (3) أن الإجراء المقترح يمكن السيطرة عليها (Conner & Norman, 2005). أخيرا، في محاولة لتحديد العوامل الفردية إضافة لضعف وشدة المتصور في اعتماد السلوكيات الصحية، وينبغي أن الدراسات المستقبلية تركز على المساهمة المحتملة للشخصية. وكانت هذه المساهمة في كثير من الأحيان

تظاهر العديد من السلوكيات الصحية (Loukas et al., 2004) (e.g. Bogg & Roberts, 2004) (2000) ولكن لم تكون دراستها في سياق البدني او الرياضي (Déroche et al., 2007).

الدراسة التالية من هذا العمل الدكتوراه تهدف إلى دراسة مدى تشكل عنصرا حاسما من هذه العوامل النفسية في اعتماد السلوكيات الصحية في النشاط البدني ولكن شعبية خاصة
المرضى: والتحول على الجليد.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الدراسة الثالثة.

دراسة النماذج التكميلية وحرية تقرير المعرفة الإجتماعية صاحب شخصية لتوقع اعتماد السلوكيات الوقائية

وقد تم في الترحلق على الأسطوانة (على الخط) ازدهارا منذ تأسيسها في عام 1980. جذابة على حد سواء لطابعها الترفيهية بواسطة إمكاناتها كحل للنشاط التشريد، وذلك على الرغم من ذلك الممرض كما يدل على ذلك زيادة في "قلق خاص" (الولايات المتحدة جنة سلامة المنتجات، 1994) وعدد من الإصابات المتعلقة بممارسة هذا النشاط، 37000 في عام 1993 إلى 83000 في عام 1994 في الولايات المتحدة. هذه الزيادة في عدد الإصابات خلال هذه الفترة أيضا ملحوظة في بلدان أخرى مثل كندا (Klassen 1995)، (Ellis, Kierulf, 1993)، والمملكة المتحدة (Heller, Routley, 1997)؛ (Routley, 1997)؛ (Chambers, 1996)، أستراليا (هيلر، Routley، والغرف، 1996؛ Routley، 60-75٪ من هذه الإصابات والجروح، والالتواء أو الكسور & Calle (McGrath & Beattie, 1996)؛ (Ellis et al., 1995)؛ (Eaton, 1993)، وقلق الجزء العلوي من الجسم، والتي تشمل الكتف والذراع والساعد والكوع والمعصم والأصابع (Ellis et al., 2002)؛ (Mulder & Hutten, 1993)؛ (Heller, 1995)؛ (cf. Wiese-Bjornstal et al., 1998)، وهذه الإصابات تسبب الإعاقات الشديدة، وحتى الموت (انظر الولايات المتحدة لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، 1994). الوقاية من إصابات في البكرة الترحلق من خلال التعرف على محدداتها وبالتالي قضية من قضايا الصحة العامة.

1. الأهداف والفرضيات

وأشار جزء 2.1 من الفصل 2 أن وقوع إصابات يعتمد على كيفية ممارسات معينة، دراسات على سلوك المرضية التزلج وحظ في الواقع لم يتضرر المشاركين معدات قبل للحماية ضد مخاطر محددة لممارستها (Ellis et al., 1993)؛ (Calle & Eaton, 1996)؛ (e.g. Adams et al., 1995)؛ (Heller, 1993)؛ (Product Safety Comm al., 1995). ومع ذلك العديد من الدراسات وجدت أن للمفارقة المتزلجين قليلة (1،4-7٪) تقرير تحمل معدات للوقاية من خطر الإصابة، أي

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

خوذة، وحراس المعصم والكوع ومنصات الركبة (e.g. Adam s et al., 1996) ; (Williams-Aver & MacKinnon , 1996) ; Schieber et al., 1996) ، على الرغم من أنها في حوزة. ولذلك فمن الضروري تحديد العوامل التي توظف هؤلاء الناس إلى ارتداء هذه المعدات الواقية عند ممارسة نشاطهم. إذا كانت بيانات وبائية تشير إلى تأثير العوامل الديموغرافية مثل العمر والجنس ومستوى الخبرة من الممارسين على استخدام منصات (e.g. Adam s et al., 1996) ; Williams-Aver y & MacKinnon , 1996 ; Youn g & Mark , 1995) وسعى عدد قليل من الدراسات لتحديد العوامل النفسية التي قد تؤثر أيضا على اعتماد هذه السلوكيات. تهدف هذه الدراسة لذلك لتقييم إلى أي مدى من النماذج والمعرفة الاجتماعية للصحة وشخصية يمكن أن تكون الأطر التحليلية التكميلية من المحددات النفسية للميناء من معدات الحماية في البكرة التزلج. وتركز هذه الدراسة على وجه الحصر لالمتزلجين الذين لديهم التزلج الممارسة ببكرة الترفيهية ، الممارسة الحرة على ارتداء مثل هذه المعدات هو الهدف الأسمى.

1.1 التكامل النماذج المعرفة الإجتماعية

مع إمكانية تصور المخاطر في تفسير اعتماد السلوكيات الصحية (انظر القسم 2.2.2، الفصل 2 للمراجعة)، وقد اعتبر بعض الكتاب بما في ذلك الإدراك من النماذج القائمة، وبين هذه النماذج، إلى نظرية السلوك المخطط Conner (1991) ; Ajzen, 1991 ; Abraham et al., 1999 ; e.g. Norman et al., 1999) ; (Norman et al., 1999) ; (Norman et al., 1999) ; (Norman et al., 1999) في سياق البدني أو الرياضي، وبالمقارنة مع عدد قليل من الدراسات إمكانات كل نموذج لشرح استخدام معدات الحماية بواسطة الدراجة (Quine et al., 1998) ; (Lajunen & Räsänen , 2004) . ومع ذلك، فقد تحقق أيا من هذه الدراسات إلى أي مدى شدة التأثير ينظر إليها وكانت مكملة لعنصر الصورة مختلفة من نظرية السلوك المخطط لها من أجل التنبؤية في اعتماد الفعال لهذا السلوك الصحي الوقائي، هذا التكامل ولذا فإن الهدف من الدراسة في سياق معين من الممارسات البدني / أو الرياضي.

1-2- المساهمة الشخصية لنماذج المعرفة الإجتماعية

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

وهو نهج يركز على المجالات الرئيسية للشخصية، أي العصابية، الانبساط، الضمير (Costa & McCrae , 1992) ومن المرجح أن يفسر لماذا الناس تبني سلوكيات وقائية أو السلوكيات المحفوفة بالمخاطر في سياقات اجتماعية مختلفة (راجع جزء 2.3، الفصل 2 للمراجعة). ومع ذلك، سعت أية دراسة لتحديد كيف يمكن لهذه المناطق من الشخصيات العزم على اعتماد السلوكيات الصحية الوقائية في ممارسة النشاط البدني و / أو الرياضي (انظر Castanier و Scanff و، في الصحافة ، للمراجعة). هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على مساهمة اجتهاد لشخص بقصد ارتداء معدات الوقاية والتزحلق على البكرة التزحلق في اعتماد فعال للسلوك الصحي.

وتعتبر هذه الدراسة أيضا على التكامل بين هذه العوامل مع النموذج الاجتماعي والمعرفي (e.g. Conner & Abraham , 2001) ; (Baranowski , 2005). طالما أن الضمير يعكس ميل الشخص ليكون مسؤولا، يمكن الاعتماد عليها، واتباع المعايير والقواعد أو الاتفاقيات (John & Srivastava, 1999)، فإن الناس اصحاب الضمير يكونون أكثر حساسية لمحيط خطابهم ، وخصوصا عندما يحاول الانخراط في السلوكيات الصحية (Tucker, Elliott, & Klein, 2006). ارتداء معدات الوقاية هو موضوع العديد من الحملات، التي أجريت في كثير من الأحيان من قبل مجموعات من المتزلجين أنفسهم. ولذا فمن الممكن أن المتزلجين هم أكثر وعيا تقبلا لهذه المعلومات / الخطاب من بيئتهم، والاستجابة مما أدى إلى مواقف أكثر إيجابية في مواجهة معدات وقائية، وزيادة الحساسية تجاه المعايير الاجتماعية فعالية هذه الحماية (قواعد موضوعية). في المقابل، فإن هذه المواقف ارتكاب لتشكيل نوايا بشأن ارتداء معدات الوقاية أو استخدامها بفعالية.

وخلاصة القول، واعتماد معدات وقائية في التزلج على الجليد ، أي خوذة، وحراس من المعصم والكوع ومنصات الركبة، يبدو ضروريا لمنع المخاطر المرتبطة ممارسة هذا التمرين. وتركز هذه الدراسة على ذلك السلوك المحددات النفسية والتكامل (راجع الشكل 7).

في هذه الدراسة، الجديد جعل الفرضيات التالية:

الفرضية 1. في اشارة الى السلوك المخطط، شخص مع معدات إيجابي تجاه في مواجهة موقف وقائي، الذين يعتقدون أن يعتبر استخدامها استخدام مهم بالاتصالات / ذات الصلة من أقاربه، وهذه هي سهلة التنفيذ، وأكثر

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

وتتوي ارتداء معدات الحماية (الفرضية 1)، والتزام أقوى في هذا السلوك الصحي (رطل فرضية).

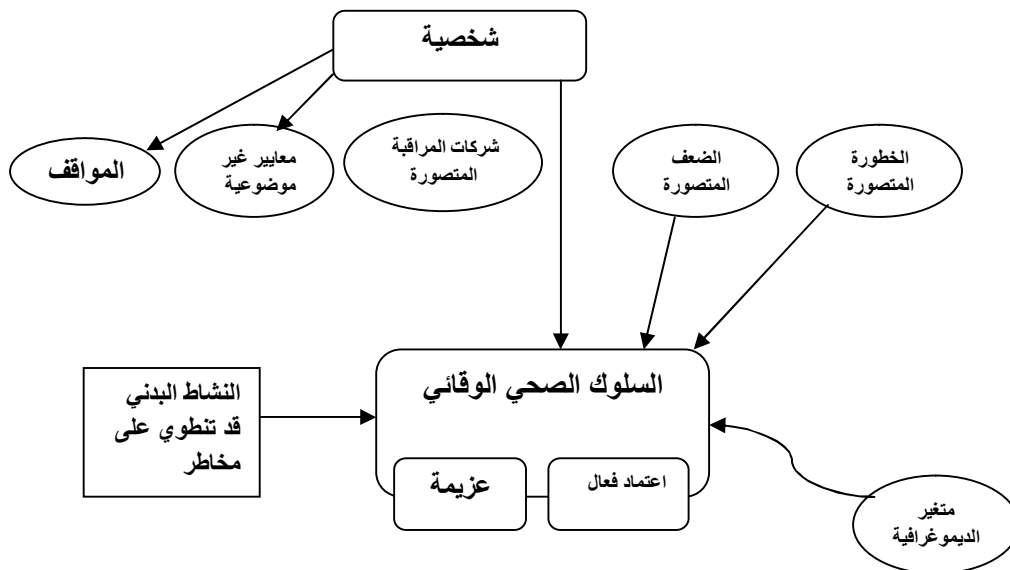
الفرضية 2. إدراك المخاطر، أي يرتبط بشكل إيجابي على الضعف المتصورة وشدة الإصابات التي لحقت نوايا (فرضية 2)، والاستخدام الفعال للمعدات الواقية (فرضية 2). كلما كان الشخص يعتقد انه من المرجح أن اصيب بجروح خلال هذا النشاط والنظر في هذه الاصابة خطيرة واحتمال، وأكثر وسوف تميل إلى حماية أنفسهم أو حمايتها. لدرجة أنه يمكن أن يكون نادرا في وقوع اصابات في البكرة التزحلق دون وقوع حادث قبل، أي سقوط أو اصطدام، سوف تسيطر على التصور من قبل كل متزلج من احتمال وقوع حادث في البكرة.

الفرضية 3. ويرتبط إيجابيا على اجتهاد من شخص لنوايا والاستخدام الفعلي المعدات الواقية في البكرة المتزحلق.

الفرضية 4. عناصر الضعف، وبرنامج التعاون الفني وشدة المتصورة، والضمير معا لتحديد نوايا واعتماد الفعلية والمعدات الواقية في البكرة المتزحلق.

الفرضية 5. المعايير والمواقف من شخص وسيطا في العلاقة بين الضمير والنوايا لتزويد الحماية واستخدامها الفعلي

لكل من هذه الفرضيات يمكن أن تسهم به العمر، ويتم التحكم بين الجنسين والخبرة



الشكل 7. النموذج تكاملي والسياقي لمحددات السلوكيات الصحية الوقائية

2. أسلوب

2-1- المشاركون

واتفقت 192 المتزلجين، و 124 من الرجال و 68 للنساء، للمشاركة في هذه الدراسة.

كل من شارك في التزلج والمشي في مدينة الجزائر. السن عينة المتوسط هو 30.04 عاما (ET=10.70، والعينة السن = 12-75 سنة).

2.2 تدابير

تتوي ارتداء معدات الحماية (انظر الملحق 3). وكان كل من أجل المتزلجين على ارتداء معدات الحماية، للإجابة على السؤال: "هل تتوي ارتداء المعدات الواقية خلال عملكم في المرة القادمة؟". أجاب المشاركون على نطاق

من 1 (لا على الإطلاق) إلى 7 (تماما). باستخدام عنصر واحد لتقييم هذه النوايا هو إجراء مشترك في مجال البحث في علم النفس والصحة (e.g Johnston et al., 2004).

استخدام معدات وقائية (انظر الملحق 2). وسئل لتوضيح متزلج ذلك أنا المعدات الواقية المستخدمة عند المشي لمسافات طويلة لعبت بين الأربعة التالية: الخوذة، ومنصات الكوع، حراس الرسغ ومنصات الركبة. لهذا، يجب أن تجيب على الأسئلة التالية: "هو اليوم واحد الخاص بك [خوذة ومساند الأذرع، حراس المعصم، ومنصات الركبة] للتحرك على ريش بكرة؟".

وقد أنشأت مجموع عدد المعدات الواقية المستخدمة عند المشي لمسافات طويلة (من معدات معدات 0-4).

إدراك المخاطر (انظر الملحق 3). ويعرف الإدراك المخاطر التي تصور كلا من الضعف المتزلجين إلى وقوع إصابات وتصورهم لخطورة هذه الإصابات المحتملة. تم صياغة العناصر من المقاييس الحالية (Weinstein, 2000) ، وأعقب على توصية من وآخرون ، وتحديدًا على الحاجة إلى حالة من الخطر من الصحة السلوكية. يعتبر التعرض للإصابة، وجرى تقييم باستخدام السؤال التالي: "كيف

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

المرجح هو أن تقوم خلال الخطوة التالية في إذا لم يكن لارتداء معدات الحماية؟". وطلب من المشاركين على مقياس من 1 (من المستبعد جدا) إلى 7 (من المرجح للغاية). تم تقييم أيضا تصور من قبل متزلج من شدة الإصابة باستخدام عنصر واحد: "كيف تكون خطورة الإصابة في مجال التزلج إذا لم يكن لارتداء معدات الحماية؟". وطلب من المشاركين على مقياس من 1 (ليس في كل الخطورة) إلى 7 (الخطورة جدا). أخيرا، منذ الإصابة المتزلجين عادة خلال اصطدام أو سقوط، كما تم تقييم مخاطر الحوادث. لهذا سئل المتزلجين للإجابة على السؤال.

"ما هو احتمال أن يكون لديك وقوع حادث (السقوط أو الاصطدام) خلال السفر في المرة القادمة؟". وطلب من المشاركين على مقياس من 1 (من المستبعد جدا) إلى 7 (من المرجح للغاية).

المواقف وجها لوجه المعدات الواقية (انظر الملحق 3). وتحدد المواقف الفردية وجها لوجه من قبل المعتقدات السلوكية حول عواقب السلوكية في سؤال والتقييم لتلك النتائج. وقد أكدت الدراسات على ضرورة التمييز بين المواقف العاطفية مفيدة (e.g. Lawton , Parker, Manstead , (1998) Stradling, 1997 ; Parker, Lajunen, & Stradling, 1997) وتكييف بنود جدول القائمة (e.g. Conner & Abraham , 2001) لتلبية الاحتياجات من دراستنا - تسليم سريع للصلاحيات من الاستبيانات الإلكترونية فقط قبل بدء الارتفاع. وطلب من المتزلجين الى مكان درجة من القبول على مقياس من 1 (لا أوافق بشدة) إلى 7 (أوافق بشدة)، استجابة لمقترحات: (1) "أجد أن أنا هو الحاجة إلى ارتداء معدات الحماية للالتفاف على شفرات بكرة" على تقييم المواقف مفيدة، (2) "أنا ذاهب الى شعور سخيف اذا كنت ارتداء معدات الحماية على السفر في المستقبل على التزلج على الجليد" لتقييم المواقف عاطفي.

معايير غير موضوعية (انظر الملحق 3). معايير موضوعية هي المعتقدات حول شخص ما كانوا يعتقدون أن الناس مهم (الآباء والأمهات على سبيل المثال، والأقران) من هذا السلوك، وفائدته و / أو أهميتها. لتقييم وطلب من هذه المعايير لتقييم المتزلجين مستواها توافق على مقياس (وليس في جميع توافق) إلى 7 (أوافق بشدة)، استجابة لمقترحات: (1) "ليالي هذا اعتقد ان المتزلجين المهم أن يرتدي المعدات الواقية عندما يسافر في التزلج على الجليد"، (2) بالقرب مني اعتقد انني لا يجب ان اتزلج دون معدات السلامة". وكشف التحليل المكون الرئيسي.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الإسقاط من هذين البندين على العامل نفسه، أي أن المعايير المتعلقة ارتداء معدات الوقاية في التزلج على الجليد الأسطوانة، ويفسر 71٪ من التباين مع القيمة الذاتية من 1.41. لذلك، حققت تدبيراً الشاملة من متوسطي درجات كل من البندين ($\alpha = 0.59$).

السلوكية سيطرة ينظر (انظر الملحق 3). لتقييم هذا التصور، سئل المتزلجين للتعبير عن مستوى الاتفاق على مقياس من 1 (لا أوافق بشدة) إلى 7 (أوافق بشدة)، رداً على الاقتراح التالي وإضافة "إذا أريد، فإنه من السهل بالنسبة لي أن وضعت معدات الحماية لممارسة الترحلق على الجليد."

الوعي (انظر الملحق 5)، وطلب من المشاركين إذا وافقوا مع 48 جمل قصيرة مما يعكس أحكامها (أي الكفاءة والنظام، والشعور بالواجب، وتحقيق السعي، والانضباط الذاتي المداولة)، على مقياس من 0 (لا أوافق بشدة) إلى 4 (أوافق بشدة). ألفا كرونباخ لهذا العامل هو الصحيح ($\alpha = 0.78$).

2-3- تحليل البيانات

تم تنفيذ سلسلة من الهرمية تحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات لدينا. وتركزت جميع المتغيرات لتجنب المشاكل من العلاقة الخطية المتداخلة.

تم إجراء تحليل مماثل لتحقيق كل المتغيرات المستقلة على حد سواء، أي نية لارتداء معدات الوقاية وعدد من الأجهزة التي المتزلجين المستخدمة فعلياً خلال الارتفاع. في كل تحليل، وتمت السيطرة على إمكانات تتأثر الجنس والعمر والخبرة في البكرة الترحلق في خطوة أولى.

في البداية، تم اختبار كل نموذج (تصور المخاطر، والسمات) على حدة في تحليلات منفصلة الثلاثة. ليحل كل هذه العوامل تم إدخالها من كل نموذج واحد في معادلات الانحدار.

في خطوة ثانية، تم إجراء تحليل شامل عن طريق إدخال جميع متغيرات الدراسة. في الخطوة الثالثة، أخيراً، تابعنا النهج الإحصائي الذي اقترحه بارون وكييني (1986) لاختبار كل وساطة: لتحديد M الوسيط (المواقف ومعايير غير موضوعية) من تأثير متغير A (الضمير) في آخر ب متغير (نوايا بشأن اعتماد معدات واقية واستخدامها على نحو فعال)، يجب أن تتحقق خمسة شروط: (1) ومتغير، ويجب أن تكون ذات صلة ب متغير بشكل كبير، (2) متغير، ويجب أن تكون ذات صلة M الوسيط بشكل كبير، (3) ب متغير و M الوسيط يجب أن تكون أيضاً ذات الصلة بشكل ملحوظ، (4) وينبغي

الفصل التطبيقي

الدراسات الميدانية

أن تأثير عمليات الاندماج على وسيط B متغير لا تختفي إذا كنا السيطرة إحصائياً تأثير متغير على B متغير، (5) تأثير متغير على B متغير يجب أن يختفي (وساطة كاملة) أو انخفاض كبير (وساطة جزئية) بعد ضبط تأثير إحصائياً M في الوسيط B متغير

2-4- الإجراءات

وتم الاتصال على المتزلجين فقط قبل بداية زيادة على علم الغرض من هذه الدراسة. وكان في استقبال اتفاقهما بعد اطلاعهم على سريتها. شرحنا من أجل تقديم هذا البحث، وأوضحنا الصورة لفهم أفضل لماذا بعض المتزلجين وضع معدات واقية عندما أخرى امتنعت عن التصويت، وقد بينا أيضاً أن لديها لمساعدتنا على تحقيق سلسلة استبيانات قبل. وكان المعيار لإدراجها في المشاركة في طلوع يوماً بعد يوم. مانتان

ووفقاً 39 متزلج على المشاركة في هذه الدراسة. من 239، 47 لم يكملوا جميع الاستبيانات. ما مجموعه 192 أدرج أخيراً إلى المتزلجين في التحليل.

3. النتائج

3.1 الإحصاء الوصفي

المتوسط، وتعرض الانحرافات المعيارية والارتباطات بين المتغيرات المختلفة في هذه الدراسة في الجدولين 6 و 7. ويحلل علاقات هامة بين كشف نية لارتداء معدات الحماية على المتزلجين بالبكرة، الجنس المتزحليين ($r = 0.26, p > 0.05$)، السن ($r = 0.30, p > 0.05$)، من ضعفها المتصور ($r = 0.37, p > 0.05$)، وشدة ينظر ($r = 0.29, p > 0.05$)، والمواقف مفيدة ($p > 0.05$). ($r = -0.36, p > 0.05$) والعاطفي ($r = -0.25, p > 0.05$)، معاييرها الذاتية ($r = 0.34, p > 0.05$). ($r = 0.28, p > 0.05$) والضمير ($r = 0.19, p > 0.05$). وبينت النتائج أيضاً وجود علاقة بين استخدام معدات وقائية للارتفاع، والجنس المتزلجين ($p > 0.05$). ($r = 0.20, p > 0.05$)، العمر ($r = 0.36, p > 0.05$) وشدة ينظر ($p > 0.05$). ($r = 0.32, p > 0.05$)، والمواقف الجوهرية ($r = 0.25, p > 0.05$)، والعاطفية ($r = 0.30, p > 0.05$).

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

($r =$ ، معاييرها الذاتية $r = 0.31$ ، $p > 0.05$) ، لسيطرتهم السلوكية المحسوسة $p > 0.05$ ، $r =$ والضمير $r = 0.18$ ، $p > 0.05$).

الجدول 6. المتوسطات والانحرافات المعيارية للمتغيرات الدراسة (ن=192)

ET	M	
10.73	30.04	1. السن
6.60	8.03	2. التجربة
1.73	2.88	3. خطر وقوع حوادث
1.90	3.36	4. الضعف المتصور
1.65	4.23	5. الخطورة المتصورة
1.85	2.55	6. دور المواقف الفعال
1.86	2.37	7. المواقف العاطفية
1.80	4.27	8. معايير غير الموضوعية
1.88	5.80	9. المراقبة السلوكية المتصورة
0.37	2.55	10. الوعي
2.54	3.90	11. النية ارتداء معدات الوقاية
1.56	1.88	12. استخدام المعدات الوقائية

الجدول 7. المصفوفة الارتباط بين المتغيرات الدراسة 3 (ن = 192)

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
												1. الجنس
										-	-03	2. السن
									-	14	-12	3. التجربة
								-	-18	06	06	4. الخطر من وقوع الحوادث
							-	63	-19	14	23	5. الضعف المتصور
						-	47	26	-08	-01	17	6. الخطورة المتصورة
					-	-15	-24	-06	09	-04	00	7. الدور المواقف الفعال
				-	20	04	-11	04	07	-26	-11	8. المواقف العاطفية
			-	-10	-20	27	34	13	-11	04	12	9. المعايير غير الموضوعية
		-	33	-24	-20	06	15	05	-07	23	02	10. المراقبة السلوكية المتصورة
	-	25	12	-17	-20	03	09	08	08	26	-11	11. الوعي
-	19	28	34	-25	-36	29	37	07	-13	30	26	12. النية ارتداء معدات الوقاية
77	18	28	31	-30	-30	25	32	06	-11	36	20	13. استخدام المعدات الوقائية

ملاحظة : كل الارتباطات $|0.14| \leq$ هامة $p > 0.05$

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

3-2- تحليل الانحدار المتعدد الهرمية

وتعرض نتائج التحليل في الجداول 8 و 9 و 10 و 11.

الفرضية 1أ. وكشف التحليل وجود علاقة كبيرة بين نية لارتداء معدات الوقاية ومواقف متزلج مفيدة الميناء وجها لوجه من معدات الحماية ($\beta = -0.27, p < .001$) والمعايير ذاتي ($\beta = .21, p < .001$) وبعد التدقيق في أول خطوة من آثار الجنس ($\beta = .26, p < .001$)، السن ($\beta = .33, p < .001$)، وخبرة في البكرة المتزحلقة ($\beta = -.14, p < .001$). وعلى النقيض من مساهمات المواقف العاطفية ($\beta = -.05, p < .001$)، وسيطرة السلوكية المحسوسة ($\beta = .08, p < .001$)، ليست كبيرة. عندما يتم إدخال جميع العوامل النفسية في معادلة الانحدار، ومساهمات من الجنس ($\beta = .23, p < .001$) والسن ($\beta = .27, p < .001$) لا تزال كبيرة. كانت معادلة الانحدار النهائي الكبير، $F(7, 184) = 14.40, p < .001$ ، $R^2 = .35$. (انظر الجدول 8).

الفرضية 1ب. التحليل يكشف أيضا وجود علاقة كبيرة بين استخدام معدات الوقاية ومواقف متزلج مفيدة الميناء وجها لوجه من معدات الحماية ($\beta = -.20, p < .001$)، ومعايير ذاتي ($\beta = .20, p < .001$) وبعد التدقيق في أول خطوة من آثار الجنس ($\beta = .19, p < .001$)، السن ($\beta = .39, p < .001$)، وخبرة تزلج ($\beta = -.14, p < .001$). وعلى النقيض من مساهمات المواقف العاطفية ($\beta = -.11, p < .001$)، وسيطرة السلوكية المحسوسة ($\beta = .07, p < .001$)، ليست كبيرة. هو عرض العوامل النفسية في معادلة الانحدار، ومساهمات من الجنس ($\beta = .16, p < .001$) والسن ($\beta = .32, p < .001$) لا تزال هامة، وكانت معادلة الانحدار النهائي الكبير، $F(7, 184) = 13.05, p < .001$ ، $R^2 = .34$. (انظر الجدول 8)

الفرضية 2. وكشف التحليل عن وجود علاقة كبيرة بين نية لارتداء معدات الحماية واحتمال ينظر إلى وقوع حادث، أي سقوط أو الاصطدام ($\beta = -.23, p < .01$)، والضعف ينظر إلى إصابة ($\beta = .34, p < .001$) والمتصورة شدة إصابة ($\beta = .16, p < .05$)، وبعد التدقيق في أول خطوة من آثار الجنس ($\beta = .26, p < .01$)، و السن ($\beta = .33, p < .001$) والخبرة في البكرة التزحلق ($\beta = .14, p < .05$). عندما يتم إدخال البريد العوامل النفسي في معادلة الانحدار، ومساهمات من الجنس ($\beta = .16, p < .05$) والسن ($\beta = .29, p < .001$) لا تزال هام. المعادلة النهائية من الانحدار هام، $F(6, 185) = 13.00, p < .001$ ، $R^2 = .30$ (انظر الجدول 9).

الفصل التطبيقي

الدراسات الميدانية

الفرضية 2ب. ويكشف التحليل أيضا وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام معدات الحماية واحتمال ينظر إلى وقوع حادث، أي سقوط أو الاصطدام ($\beta = -0.21, p > 0.01$)، و يعتبر التعرض للإصابة ($\beta = 0.29, p > 0.01$) وشدة المتصورة المسلمة الإصابة ($\beta = 0.14, p > 0.05$)، وبعد التدقيق في أول خطوة من آثار الجنس ($\beta = 0.19, p > 0.01$)، خبرة في ($\beta = 0.39, p > 0.001$) (الجنس) . ($\beta = -0.14, p > 0.05$). ظلت مساهمة من السن ($\beta = 0.36, p > 0.001$) هو عرض العوامل النفسية في معادلة الانحدار، كبيرة. المعادلة النهائية للانحدار كبير، $F(6,185) = 12.22, P > 0.001, R^2 = 0.28$ (انظر الجدول 9).

الفرضية 3. وكشف التحليل وجود علاقة كبيرة بين نية لارتداء معدات الوقاية واجتهاد من التسليم للتخصيص ($\beta = 0.16, p > 0.05$)، وبعد التدقيق في أول خطوة من آثار الجنس ($\beta = 0.26, p > 0.001$) . السن ($\beta = 0.33, p > 0.001$) والخبرة في البكرة التزلق ($\beta = -0.14, p > 0.05$). عندما يتم إدخال هذا العامل النفسي في معادلة الانحدار، ومساهمات من الجنس ($\beta = 0.27, p > 0.001$) والسن . ($\beta = 0.29, p > 0.001$) وتجربة في البكرة التزلق ($\beta = -0.15, p > 0.05$) لا تزال كبيرة. المباراة النهائية كبير، $F(4,187) = 12.11, P > 0.001, R^2 = 0.21$ (انظر الجدول 10).

الفرضية 3ب. تحليل يكشف عن عدم وجود علاقة كبيرة بين البيانات استخدام أي معدات واقية وإخلاص للشخص ($\beta = 0.12$ نانوثانية)، وبعد فحصها في الآثار من الجنس ($\beta = 0.19, p > 0.01$)، السن ($\beta = 0.39, p > 0.001$)، وتجربة التسليم ($\beta = -0.14, p > 0.05$). عندما يتم إدخال هذا العامل النفسي في معادلة الانحدار، ومساهمات من الجنس ($\beta = 0.21, p > 0.01$) ، السن ($\beta = 0.36, p > 0.001$)، وخبرة تزلج ($\beta = -0.14, p > 0.05$) لا تزال كبيرة. المعادلة النهائية، $F(4,187) = 12.31, P > 0.001, R^2 = 0.21$ (انظر الجدول 10).

الفرضية 4. سمح لنا لاختبار تحليل المساهمة المتغيرات النفسية على النية لارتداء ملابس واقية عند التزلج دخلوا في وقت واحد في معادلة الانحدار واحد. ويقدم التحليل الوارد في الجدول 11. ويكشف أن فقط في العلاقة بين بنية ارتداء معدات الوقاية والمواقف مفيدة ($\beta = -0.22, p > 0.001$)، والمعايير الذاتية ($\beta = 0.14, p > 0.05$)، احتمال وقوع حادث ينظر في الأسطوانة ($\beta = -0.16, p > 0.05$) .

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

والتعرض لينظر إلى إصابة ($\beta = 0.19, p > 0.05$.) كبير بعد التحكم في إيتاب آثار الجنس . ($\beta = 0.26, p > 0.001$),

، السن ($\beta = 0.33, p > 0.001$.) وخبرة في البكرة الترحلق ($\beta = -0.14, p > 0.05$.). عندما يتم إدخال جميع العوامل النفسية في معادلة الانحدار،

مساهمات من الجنس ($\beta = 0.19, p > 0.01$.) والسن ($\beta = 0.24, p > 0.001$.) لا تزال كبيرة. و لا الانحدار النهائي كان كبيراً، $F(11,180) = 10.80, p > 0.001, R^2 = 0.40$ (انظر الجدول 11).

الفرضية 4ب. سمح لنا لاختبار تحليل مساهمة المتغيرات النفسية على الاستخدام الفعلي للتزلج بكرة معدات الحماية عندما دخلوا في وقت واحد في ذاكرة ه الانحدار المعادلة. ويقدم أيضا هذا التحليل في (الجدول 11). ويكشف أن فقط في العلاقة بين استخدام المواقف معدات واقية ومفيدة ($\beta = -0.16, p > 0.05$.)

والمعايير الذاتية ($\beta = 0.14, p > 0.05$.) لا تزال كبيرة، وبعد التدقيق في أول خطوة من آثار الجنس . ($\beta = 0.19, p > 0.01$ ، السن ($\beta = 0.39, p > 0.001$.)، وخبرة في البكرة الترحلق . عندما ($\beta = -0.14, p > 0.05$.) تكون جميع العوامل النفسية، بقيت وإدخالها في معادلة الانحدار، و معامل السن ($\beta = 0.39, p > 0.001$.) و لا الانحدار النهائي كان كبيراً $F(11,180) = 9.46, p > 0.001, R^2 = 0.37$ (انظر الجدول 11).

الجدول 8. النية التنبؤ لحمل المعدات لاستخدامها من قبل نظرية السلوك المخطط (ن = 192)

المرحلة	النية ارتداء المعدات	استخدام المعدات الوقائية	
		مرحلة 1	مرحلة 2
		β	β
01	الجنس	26***	16**
	السن	33***	32***
	الخبرة	-14*	-08
02	دور المواقف الفعل	-27***	-20**
	المواقف العاطفية	-05	-11
	المعايير غير الموضوعية	21**	20**
	سيطرة السلوكية المتصورة	08	07
	R^2	18	34
	ΔR^2	17***	14***

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

13.05***	15.28***	14.40***	14.03***	F	
----------	----------	----------	----------	---	--

> 0.01 p * > 0.001 p ** > 0.05 p * : معاملات الانحدار موحد**

الجدول 9. النية التنبؤ لحمل المعدات لاستخدامها من قبل خطورة التصور (ن = 192)

المرحلة		النية ارتداء المعدات		استخدام المعدات الوقائية	
		مرحلة 1	مرحلة 2	مرحلة 1	مرحلة 2
المرحلة		β	β	β	β
01	الجنس	26***	16***	19**	21**
	السن	33***	29***	39***	36***
	الخبرة	-14*	-12	-14*	-12
02	التصور إلى احتمال وقوع حادث		-23***		-21**
	الضعف المتصور		34***		29**
	الخطورة المتصور		16*		14*
	R^2	18	30	20	34
	ΔR^2		12***		14***
	F	14.03***	13.00***	15.28***	12.22***

> 0.01 p * > 0.001 p ** > 0.05 p * : معاملات الانحدار موحد ملاحظة:**

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الجدول 10: النية التنبؤ لحمل المعدات لاستخدامها الحرف الضميرى (ن = 192)

النية ارتداء المعدات		استخدام المعدات الوقائية			
مرحلة 1	مرحلة 2	مرحلة 1	مرحلة 2		
β	β	β	β	المرحلة	مستقبل متغيرات الدراسة
26***	27***	19**	21**	01	الجنس
33***	29***	39***	36***		السن
-14*	-15*	-14*	-14*		الخبرة
16*			21	02	الوعي
18	21	20	21		R^2
	03*		01		ΔR^2
14.03***	12.11***	15.28***	12.31***		F

ملاحظة : معاملات الانحدار موحد * $p > 0.05$ ** $p > 0.01$ *** $p > 0.001$

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الجدول 11. النية التنبؤ لحمل المعدات لاستخدامها من قبل نظرية السلوك المخطط، التصور المخاطر الشخصية (ن = 192)

المرحلة	مستقبل متغيرات الدراسة	النية ارتداء المعدات		استخدام المعدات الوقائية	
		مرحلة 1	مرحلة 2	مرحلة 1	مرحلة 2
		β	β	β	β
01	الجنس	26***	24***	39**	30**
	السن	33***	29***	39***	36***
	الخبرة	-14*	-08	-14*	08
02	دور المواقف الفعال		-22***		-16*
	المواقف العاطفية		-05		-11
	المعايير غير الموضوعية		14*		14*
	السيطرة السلوكية المتصورة		08		07
	ينظر إلى احتمال وقوع حادث		-16*		-14
	الضعف المتصور		19*		16
	الخطورة المتصورة		13		12
	الوعي		06		03

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

37	20	40	18	R^2
17***		22***		ΔR^2
9.46***	15.28***	10.89***	14.03***	F

ملاحظة : معاملات الانحدار موحد $p > 0.05$ ** $p > 0.01$ *** $p > 0.001$

3,3 تحليل وساطات

الفرضية 5. نظرا افتراضاتنا من جهة، والخطوات المنهجية التي أدلى بها بارون وكني (1986) من ناحية أخرى، التحاليل المنفصلة أجريت لتحديد الآثار وساطة من المواقف العاطفية ومفيدة، والمعايير الذاتية و في العلاقة التي تربط المتزلجين الضمير بالنسبة لهم لارتداء معدات الوقاية في التزلج على الجليد البكرة. لكل من هذه التحليلات، والمساهمة المحتملة من السن، وتمت السيطرة بين الجنسين والخبرة في التزلج على الجليد.

الخطوة 1: متغير يحتوي على التنبؤ ب متغير كانت معادلة الانحدار النتائج تكشف عن وجود مساهمة كبيرة من الضمير على النية لارتداء معدات الحماية ($\beta = 0.16, p > 0.05$)، هام، $F(1, 187) = 12.11, p < 0.001, R^2 = 0.21$.

الخطوة 2: ترتبط بشكل كبير متغير يجب التنبؤ. الوسيط الوحيد مواقف مفيدة في الضمير) . $\beta = -0.20, p > 0.01$ ، مع معادلة الانحدار الكبير، $F(4, 187) = 2.46, p > 0.05, R^2 = 0.05$. المتزلجين لا توقع المواقف العاطفية ($\beta = -0.13$ نانوثانية) ولا ذاتي معيار ($\beta = 0.14$ نانوثانية). هؤلاء الآخرين ليست متغيرات وسطاء.

الخطوة 3: الوسيط يجب أن توقع المتغير. مواقف مفيدة تساهم بشكل كبير في نية من ارتداء معدات الوقاية ($\beta = -0.34, p > 0.001$)، معادلة الانحدار كان كبيرا، $F(4, 187) = 19.60, p < 0.001, R^2 = 0.30$.

الخطوة 4: تأثير عمليات الاندماج على وسيط B متغير لا ينبغي أن تختفي إذا كنا السيطرة إحصائيا تأثير متغير على المتغير B. وترتبط بشكل كبير مواقف مفيدة لنية لحمل المعدات

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

كانت معادلة الانحدار ($\beta = -0.32, p < 0.001$)، والسيطرة للتأثير من الضمير ($\beta = 0.09$ ، نث)، كبير، $F(5,186) = 16.16, p < 0.001, R^2 = 0.30$.

الخطوة 5: تأثير متغير على B متغير يجب أن يختفي وساطة كاملة أو تخفيضها بشكل ملحوظ وساطة جزئي بعد ضبط إحصائيا تأثير متغير وسيط في B. M إدراج المواقف أساسيا في معادلة الانحدار بشكل ملحوظ العلاقة بين الضمير المرصودة أعلاه، وتتوي ارتداء معدات الحماية الشخصية (ض = 2.38، $p > 0.05$). وبالتالي، يمكن أن تعتبر مفيدة المواقف وسطاء في العلاقة التي تربط بين اجتهد الشخص وتتوي ارتداء معدات الوقاية في التزلج على الجليد الأسطوانة.

الفرضية 5ب. بقدر ما الضمير لا تسهم بشكل مباشر في الاستخدام الفعال للمعدات واقية ($\beta = 0.12$ ، نث)، و في ضوء المتطلبات المنهجية التي وضعها البارون كين (1986) لاختبار وساطة الآثار لا يمكن لمعادلة أن تخضع للتحليل.

4. مناقشة

وقد أبرزت العمل في علم النفس الصحة تأثير نماذج التكامل والمعرفة الاجتماعية (e.g. Modèle des Croyances sur la Santé, Becker & Maiman, 1975; Théorie du Comportement Planifié, Ajzen, 1988, 1991, 1998). ومع ذلك، فقد درست دراسات قليلة جدا * إمكانات هذه النماذج لوصف العوامل النفسية التي تشجع على شخص

(تقرر) الانخراط في السلوكيات للوقاية من خطر الإصابة، بينما تشارك في أي نشاط بدني و / أو الرياضي (MacKinnon, 1996) (e.g. Lajunen & Räsänen, 2004). لم تقترح أي من هذه الدراسات أيضا التكامل بين هذه النماذج. وتهدف هذه الدراسة ولذلك لتحديد مدى المعرفة الاجتماعية لنماذج من الصحة وشخصيته في أطر تحليلية متكاملة من المحددات النفسية للمعدات الميناء

حماية الأسطوانة. ويتناول فقط أن المتزلجين الذين يمارسون الترحلق الترفيهية والاستجمام في الهواء الطلق في أي من ارتداء معدات الوقاية هي وفقا لتقدير كل طبيب.

4- مساهمة العوامل النفسية

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

4-1- نظرية السلوك المخطط والسلوكية الوقاية التزلج على البكرة

وأشارت إحدى الفرضيات، في إشارة إلى نظرية السلوك المخطط (Ajzen, 1988, 1991, 1998)، الموقف ايجابي من الشخص تجاه الموقف في مواجهة المعدات الوقائية، الذي يرى أن استعمالها تعتبر مهم / ذات الصلة من أقاربه، والتسليم هو سهولة التنفيذ، لديها على نية لارتداء معدات الوقاية وتشارك في هذا السلوك أكثر التزلج الصحي. وتؤكد النتائج جزئياً هذا البريد في نطاق المواقف المتزلجين دور فعال والقواعد وجها لوجه معدات الوقاية ترتبط نية للقيام من جهة، وعلى الاستخدام الفعال في حين أن المشي لمسافات طويلة، والبريد من ناحية. وهكذا، فإن أكثر ما أخذنا في الاعتبار أنه من غير الضروري ارتداء ملابس واقية للتحرك على التزلج على الجليد، معين انها تعترم ارتداء مثل هذه المعدات أو يستخدم في الواقع. وعلاوة على ذلك، اعتقد ان معظم الزملاء والأقارب متزلج النظر في مرافق الميناء

المهم التحرك في التزلج على الجليد، والأرجح أنها تنوي ارتداء أو استخدامها بفعالية.

وهذه النتائج متسقة مع دراسات مراقبة موقفا ايجابيا يحدد تبني السلوكيات الصحية الوقائية، على سبيل المثال، استخدام الواقي الذكري (cf. Albarracin et al., 2001)، أو ما يهمنا، ارتداء معدات الحماية (Lajunen & Räsänen, 2004). وعلاوة على ذلك، المساهمة الإيجابية للمعايير موضوعية عن نية لحمل المعدات أو الاستخدام الفعلي يشير إلى أن الفرد لا يشارك في كل وقت في السلوكيات الصحية حتى السلوك قد تعتمد أيضا أثر الاجتماعي، ولا سيما على موافقة الآخرين على سلوك في مسألة (Ziani, 2002). وهذه النتائج متسقة مع دراسات تظهر أن كل شخص، وطفل بالغ، يبدو أكثر ميلا إلى ارتداء خوذة دراجة إذا شريكهم أو أقرانهم هي أيضا (Coron et al., 1994) ; Jacques, 1994) ; Everett et al., 1996) ; (al., 1993) ; (1996). من المستغرب إلى حد ما، ومع ذلك، ينظر سلوكية تحكم بالاتصالات المواقف العاطفية وجها لوجه مع معدات لا يتوقع كثيرا من نية لارتداء التزلج على الجليد الأسطوانة أو وقائي لاستخدامها في الواقع عندما جاؤوا معا المواقف دور فعال

أو معايير موضوعية في التحليل. من خلال هذه النتيجة، يبدو أن استخدام المعدات الوقائية لديه الغرض الرئيسي والوقاية من الإصابة (المواقف مفيدة)، وبصرف النظر عن أي اعتبارات الجمالية التي قد

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

تعكس المواقف العاطفية ("انه أمر مثير للسخرية لارتداء الحماية ") أو الصعوبات التي قد تعترض على اعتماد هذا السلوك (ينظر السيطرة السلوكية).

وخلاصة القول، في حين ينظر إلى مراقبة السلوك والمواقف العاطفية للمعدات وجها لوجه المتزلجين وقائي لا ترتبط

تعتزم القيام أو إلى استخدامها الفعلي، وهذه النتائج تؤكد إمكانية التفسيرية لنظرية السلوك المخطط لها، وراء مساهمة العوامل الديموغرافية، أي الجنس والعمر ومستوى الخبرة (e.g. Adams et al., 1996) (Williams-Avery & MacKinnon , 1996) (; Young & Mark, 1995).

4-2- إدراك المخاطر والسلوكيات الوقائية في البكرة التزلج

يفترض وجود الفرضية الثانية في هذه الدراسة أن المخاطر المتوقعة من الإصابة في الأسطوانة، أي ضعف متصورة وشدة، ويرتبط أيضا إلى نوايا لاستخدام أو الاستخدام الفعلي للمعدات الوقائية. وتؤكد النتائج هذه الفرضية في أنه كلما كان الشخص يعتقد انها من المرجح أن اصيب بجروح خلال هذا النشاط والنظر في هذه إصابات خطيرة محتملة بالاتصالات الإلكترونية، والمزيد من انها سوف تميل إلى لحماية أنفسهم. هذه العلاقة ليست كبيرة عندما يتم التحكم في المخاطر المتوقعة وقوع حادث (والتي بدونها لا وجود إصابات أو عدد قليل من التزلج ممكن).

وهذه النتائج متسقة مع الدراسات التي أثبتت الضعف المتصور وذلك كخطوة أولى في تبني سلوك وقائي (Aiken, Gerend , & Jackson, 2001). وقد وجدت العديد من الدراسات أن يلتزم شخص معين الذي يمثل نفسه قادرة على الإصابة بسرطان أكثر سهولة في الإجراءات الطبية تهدف إلى الكشف عن ذلك (McCaul et al., 1996) (cf. Katapodi et al., 2000)). ويرتبط أيضا مشاهدة أنفسهم على أنهم قادرون بفيروس نقص المناعة البشرية في الجهود الرامية إلى الحد من حدوث الجنس بدون وقاية (Benthin, et al., 1996) ;

(Gerrard, Gibbons , & Bushman , 1996). في سياق رياضي، وقد أظهرت وليامس أفيري وماكينون (1996) أن الرياضيين الذين يعتبرون أنفسهم عرضة للإصابة كما في أثناء ممارسة النشاط البدني أكثر استخداما لمعدات الحماية

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

وهذا يمكن أن علاقة تفسر أيضا لماذا يصاب المراهقين الذين يرون خطرا يذكر في حالات الرياضة البدنية أكثر مسببات الأمراض بالمقارنة مع خطر إدراك أكثر المراهقين في هذه الحالات (Kontos , 2004) . وقد أظهرت بعض الدراسات أيضا أن ينظر إلى خطورة يحدد نوايا الشخص بخصوص حياته الجنسية، بما في ذلك استخدام الواقي الذكري أو الامتناع عن ممارسة الجنس (e.g. Iriyama , 1991) ; (Petosa & Jackson, 2007) . et al., 2007) . كما أن هذا التصور المرتبطة بشكل إيجابي في تواتر استخدام المعدات الواقية في الأسطوانة (Williams-Avery & MacKinnon , 1996) والدراجات (Lajunen & Râsanen, 2004)

هذه النتائج تؤكد إمكانية تفسيرية من تصورات المخاطر، وشدة المتصورة وأي الضعف، وراء مساهمة العوامل الديموغرافية، أي بين الجنسين، والعمر و * مستوى الخبرة . Adam s et al., 1996) ; (Williams-Avery & MacKinnon , 1996) ; (Young & Mark, 1995)

4-4- الشخصية والسلوكيات الوقائية في البكرة الترحلق

هناك أيضا فرضية ثالثة يركز على مساهمة شخصية في تشكيل نوايا بشأن ارتداء معدات الحماية أو الاستخدام الفعلي. وفي هذه الدراسة، يقترح اجتهاد من شخص ويرتبط بشكل إيجابي على نوايا لاستخدام والاستخدام الفعلي للمعدات الوقائية في الأسطوانة. يتم تأكيد هذه الفرضية جزئيا من خلال تحليل منذ اجتهاد من المتزلجين وتوقع إيجابي عزمها على استخدام في المستقبل معدات الحماية. وهذه النتائج متسقة مع فكرة أن أصحاب الضمائر الحية ومدرّس، مصممة جدا ومنضبطة وتنظيم (e.g. McCrae & John, 1992). أين المنخفضة الضميري أكثر استعدادا للانخراط في السلوكيات التي ترضي احتياجاتهم الفورية

بغض النظر عن العواقب على أنفسهم أو الآخرين (West, Elander, & French, 1993)، وأصحاب الضمائر الحية وتقبلا لسيطرة الاجتماعية من البيئة المحيطة بهم، وخصوصا عندما يتعلق الأمر الحفاظ على صحتهم واعتماد يتفق السلوكيات (Tucker et al., 2006). إلى حد أن ارتداء معدات الوقاية حملات عديدة، كثيرا ما تجرى من قبل مجموعات من المتزلجين أنفسهم المتزلجين الضميري، تقبلا خاصة لهذا الخطاب، لديها أعلى نية للامتثال. ومع ذلك، فمن

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

المستغرب أن هذا العامل لا يسهم في الشخصية، في هذه الدراسة، والاستخدام الفعال لهذه المعدات في اليوم من وراء ارتفاع مساهمة العوامل الديموغرافية، وخاصة العاملين في السن. هذه النتيجة، ولكن، أن نتذكر أن وراء كل نية، والذي هو حرف الضميري واحد من أنصار، وخارج العمل يتطلب تصور وجود بيئة داعمة ويتطلب بالتالي إلى رفع جميع الحواجز التي قد تعيق العمل. في هذا الصدد نقلت والمعتقدات في بيئة الشخص وتتعرض في مواقفهم وقواعد موضوعية بشأن السلوك الصحي في السؤال، قد يكون حاسما (انظر 1.2.4). وعلاوة على ذلك، في التركيز على أن مساهمة الضمير، فإن هذه الدراسة قد تحجب تأثير المناطق الأخرى المكمل للشخصية، خاصة العصبية والانبساط (Costa & McCrae, 1992). وقد أظهرت الدراسات في الواقع أن الجمع بين العصبية عالية، والانبساط، وهام على نحو أفضل في توقع اتجاه الشخص على شرب الكثير أن إدراج واحد من هذين العاملين (Kjcerheim et al., 1996)، وخصوصا عند عديمي الضمير (Vollrath & Torgersen, 2002). ويمكن وجود هذه الأنواع شرح بالتالي عدم وجود علاقة بين الضمير واستخدام معدات الوقاية.

4-5- التكامل بين العوامل النفسية

واختبرت دراسات قليلة للتاريخ وقوة تفسيرية من كل نموذج على حدة على ارتداء معدات الوقاية. كوين وآخرون. (1998) قد أظهرت أن نظرية السلوك المخطط لها وأوضح 43٪ من التباين في والخوذات في ركوب الدراجات، وعندما يكون نموذج الإيمان من الصحة يفسر 18٪ فقط (cf. (également Lajunen & Räsänen, 2004). في المقابل، سعى أيا من هذه الدراسات للتدليل على الطابع التكاملي للإدراك المخاطر (المكون الرئيسي للمولودية و S TMP) مع مختلف جوانب نظرية السلوكية المخططة، ثم ذاكرة أن هذا التكامل ومن المفترض (؛ (e.g. Ajzen, 1991) (Baranowski et al., 1999). وقد أدرجت في أي أيضا شخصية عامل موضحا نوايا أو استخدام المعدات الواقية. وكانت واحدة لفرضية التبرع تحقق التكامل بين العوامل النفسية اختبار للنتيجة نية لتزويد الحماية الأسطوانة الترحلق وفعاليه استخدام هذه المعدات. نتائج دراستنا تبين أن (1) مفيدة، والضعف في مستوى الصورة الذاتية والمدركة لتحديد نية لتزويد الحماية، (2) فقط مواقف مفيدة وقواعد موضوعية تساهم في الاستخدام الفعال هذه المعدات. من خلال إثبات وجود تكامل بين الضعف المتصورة ونظرية في السلوك من المخطط له، وهذه الدراسة تؤكد على نتائج دراسات أخرى في علم

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

النفس الطبى و غيرها من نوايا ذات الصلة، مثل نية التوقف عن التدخين (cf. Abraham et al., 1999 ; Norma n et al., 1999).

عدم وجود علاقة بين التعرض المتصورة والاستخدام الفعلي للمعدات وقائية، على الرغم من أنه يساهم في تكوين نوايا بشأن استخدام مثل هذه المعدات، هي أيضا نتيجة للاهتمام بوجه خاص. وهي تدل على اعتماد السلوكيات الصحية هي جزء

دينامية عملية. وتتطوي هذه العملية تمر عبر سلسلة من مراحل متميزة زمنيا ونوعيا. العوامل المؤثرة في الانتقال بين المراحل المختلفة لا تحدد بالضرورة الى مرحلة التنفيذ السلوك النهائي (Sandman & Weinstein , 1993). بعض الدراسات أظهرت أن ينظر إليها بما في ذلك التعرض أمر بالغ الأهمية خاصة لإنشاء دار لهذا التصور يبدو قليلا أو مؤثر عندما يتعلق الأمر الى هذا الشخص لتمرير هذا القانون، أي لتفعيل له مترمت (e.g. Weinstein , Sandman, & Roberts, 1991, 1990 وعلى سبيل المثال، نورمان وآخرون. وأظهرت (1999) أن الضعف ينظر يحدد نوايا الشخص على الإقلاع عن التدخين لكن لا تؤثر بصورة مباشرة على النهاية الفعلية على ما يبدو من خلال النتائج التي توصلنا أن هذا هو الحال أيضا عندما هو الحال بالنسبة لالمتزلجين على ارتداء معدات الوقاية أثناء المشي على. في الرغبة في بناء نموذج تكاملي وسياقاتها، وهي فرضية مشاركة من المفترض وجود وساطة الآثار المترتبة على المواقف والمعايير الذاتية وجهها لوجه المعدات الواقية في الأسطوانة في العلاقة التي تربط بين اجتهاد من المتزلجين على نية لتجهيز هذه الحماية أو إلى استخدامها الفعلي. ودراسة واحدة (Conner & Abraham , 2001) أثبتت بالفعل ارتباط قوي لمواقف أكثر إيجابية للسلوكيات الصحية وجهها لوجه، وممارسة على سبيل المثال، والتي بدورها تولد نوايا أكثر تميز لاعتماده. دراستنا تسلط الضوء أيضا وساطة من هذا القبيل. والضمير من المتزلجين فعلا مواقفهم فعال وجهها لوجه

المسمار معدات الوقاية والتزحلق على الجليد الأسطوانة، وبهذه الوسيلة، ويحدد عزمها على تقديم مثل هذه المعدات. هذه الدراسة تؤكد المساهمة المعرفة الاجتماعية نماذج في مجال الرعاية الصحية الشخصية لمنع خطر الإصابة عندما يمارس النشاط البدني يمكن أن تكون المسببة للأمراض. ولذلك يمكن النظر فيها، بناء على هذه النماذج، ونقاط ضعف جديدة والحماية ضد خطر الإصابة.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

4-6- حدود الدراسة وفاق البحثية

تقدم هذه الدراسة عددا من القيود. أولا، لا يمكن تقييم مستعرضة من المتغيرات لا تخلص إلى نتيجة حاسمة بشأن طبيعة التنبؤية لنماذج بشأن الاستخدام الفعلي للمعدات وقائية. ويمكن لتصميم المحتملين، بما في ذلك على قدر من العوامل النفسية ومقياسا للسلوك ثاليوم الصورة التي اعتمدت في T2، يكون أكثر عرضة للمساءلة عن سيطرتهم.

ثانيا، فإن هذه الدراسة تستخدم المواد البسيطة تقييم المعتقدات. على الرغم من أن هذه المنهجية أمرا شائعا بصورة متزايدة (Theobald, Kirsch, Passick, Holtsclaw, Donaghy, 1997) (Watkins, Daniels, Jack, Cummings, Dunham, Gardner, Dickinson, & van den Broek, 2001) (Pomeroy, Clark, & Philp, 2001) (Robins, Hendin, & Trzesniewski, 2001) (Nagy, 2002) (Pierce, 1998) (Wanous, Reichers, & Hudy, 1997) في دراسات في علم النفس، وكان يتطابق مع احتياجات هذه الدراسة على وجه التحديد الحاجة إلى موقع التسليم السريع ممارسة عمليات الشراء قبيل مغادرة من التزلج المشي لمسافات طويلة - كان من المثير للاهتمام أن ضرب العناصر في يد واحدة زيادة الخصائص السيكمترية من أدوات (Nunnally, 1978) و عن طريق التسليم من الاهتمام في نوعية المعدات الواقية. والواقع انه من الممكن مساهمة كل العامل النفسي يختلف تبعا لمعدات الحماية في الاعتبار وعلاوة على ذلك، وركزت هذه الدراسة الضمير فقط للتحقق من صحة الفرضية من مساهمة شخصية على نياتها الفعلية واعتماد السلوكيات الوقائية في الأسطوانة الترحلق . ولكن هناك دراسات واسعة النطاق مما يدل على العلاقة بين العوامل الشخصية الأخرى مثل العصابية أو الانبساط، واعتماد السلوك الصحي (Trobst et al., 1999) (Loukas, 1999) (Arai et al., 1997) (Vollrath et al., 1999) (al., 2002). ولذلك يبدو من الضروري النظر في البروتوكولات التي وسيتم تقييم كل هذه العوامل.

أخيرا، وهذا العمل يبدأ من دراسة ثلاثة نماذج من التكامل النفسي، أي نظرية السلوك المخطط، تصور المخاطر وشخصية، لتوقع تشكيل بنية الصورة والاستخدام الفعلي للمعدات واقية عندما ممارسة النشاط البدني. نظرا لأهمية ارتداء معدات الوقاية في الأسطوانة لمنع الآثار المسببة للأمراض وقوع حادث (United States, Ellis, 1995) (Adam s et al., 1996) (e.g.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

(1994, Consumer Product Safety Commission) هذه الدراسة تسهم في إثراء المعرفة من عوامل الحماية والتعرض لخطر الإصابة، وفهم العمليات الكامنة النفسية. لهذا الغرض، فإنه لا يزال لتحديد علاقات أخرى بين هذه المحددات المختلفة للصحة السلوك ثنائية (أي شخصية والمعرفة الاجتماعية). على الرغم من أن هذه الدراسة أظهرت نصف دور وساطة من المعتقدات السلوكية في العلاقة بين الشخصية وتتوي استخدام معدات الوقاية، فإنه لا يزال لدراسة العلاقات بين السمات والمكونات الأخرى من النماذج المعرفة الاجتماعية، ولا سيما من الضعف المتصور إليها على أنها خطوة أولى ضرورية في اعتماد صحة السلوك ثنائية . (Aiken et al., 2001)

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الدراسة الرابعة :

دراسة العلاقة بين الشخصية والضعف المتصور

1. الأهداف والفرضيات

ينظر الضعف هو متغير رئيسي في العديد من النماذج في علم النفس والصحة (Conner & Weinstein, 2000) (Norman , 2005). وقد أظهرت دراسة ثانية ان هذا العمل الدكتوراه التي ينظر إليها أحد الرياضيين أقل تعرضا لخطر الإصابة، وقال انه تم الانخراط في سلوك محفوف بالمخاطر خلال تجربة الألم. وأظهرت الدراسة الثالثة التي كان ينظر إليها الضعف المعتقدات السلوكية التكميلية أي المواقف والمعايير الموضوعية المتصلة بالسلوك في السؤال للتنبؤ نية لارتداء معدات الوقاية في التزلج على الجليد الأسطوانة. نظرا لأهمية قابلية ينظر في عملية الأمراض، مثيرا للتعرف على العوامل المحددة لهذا التصور. هذا المنظور هو أكثر من الضروري أن يكون التوضيح من العوامل والعمليات التي تنطوي في تشكيل وتلوين لضعف تصور أن يقترح تمديد المعرفة الاجتماعية لنماذج من الصحة، وزيادة، وبالتالي فإن فعالية البرامج الوقاية، والناس هدف أفضل على سبيل المثال الضعيفة، وتحسين نوعية رسائل الحملات الإعلامية (Gerend, Aiken, & West, 2004)

الدراسة الرابعة من هذا العمل الدكتوراه يهدف لدراسة قياس التجربة عن وقوع اصابات في الماضي، وشخصية ترتبط بلضعف المتصورة

كما جاء في الجزء 1 من الفصل 3، العديد من الدراسات أظهرت أن هناك علاقة مباشرة بعد الأحداث المؤلمة من ذوي الخبرة (الكوارث الطبيعية على سبيل المثال، سرطان) إلى المخاطر المتوقعة لهذه الأحداث ويعيش مرة أخرى (Helweg-Larsen & 1999) ; (Greening et al., 1996) ; (Ty c et al., 2001) ; (Shepperd, 2001) وقد لاحظ بعض الدراسات أيضا أن يجوز أن يرافق تجربة إصابة أثناء ممارسة النشاط البدني من قبل وجود وعي الشخص من ضعفها (Williams, -Avery & MacKinnon , 1996) ; (Podlog & Eklund, 2006) . ومع ذلك، فإن بعض الدراسات تشير أيضا إلى وجود تناقضات بين التجربة الأخيرة من مشكلة صحية (على سبيل المثال الإصابات)، والضعف في المستقبل ينظر إليه (e.g. Katapodi et al., 1993) ; (Rose & Jevne, 2005). التناقض في الردود الفردية بعد تجربة التهديد الفعلي نفسه

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

يؤحي بأن وراء هذه التجربة، والعوامل النفسية تلعب دوراً أيضاً في الحكم من قبل شخص من نقاط ضعفهم . (Weinstein, 1980, 1982, 1987) ; (e.g. Slovic, 1978)

كما سلط الضوء في الجزء 2.4 من الفصل 3، قد العوامل الشخصية تشكل تاريخاً من الضعف المتصورة. لا توجد دراسات، ومع ذلك، سعى إلى إثبات مساهمتها في السيطرة على الإصابات خبرة سابقة في الماضي. في هذه الدراسة، يقترح أن ينظر إليه هو لون قابلية للإصابة من قبل التصرف النفسية للشخص، ما وراء مساهمة الماضي يضر. في إشارة إلى العمل في علم النفس والصحة (انظر الجزء 4.2، الفصل (3 للمراجعة)، ومساهمة من العوامل الشخصية 2

وتجري دراسة في هذا البروتوكول: العصابية الأولى والثانية احترام الذات بشكل عام. إلى حد أن هذه العوامل تؤثر في شخصية 2 استخدام الناس للحصول على معلومات مفيدة في التنبؤ ضعفها المادي (Watson & Smith et al., 1997) ; (Costa & McCrae , 1987) ; (Pennebaker, 1989)، وتبحث هذه الدراسة

أيضاً كيف أن هذه العوامل معتدلة يمكن أن تسهم به في الإصابة السابقة إلى الضعف المتصورة.

هذه الدراسة في نهاية المطاف من التمييز تجري بين لاعبي الركبي. شديد العدوى، ويمكن تحقيق هذا النشاط المشاركين له للتغاضي عن إصابات، وأن تنظر فيها كمعيار مقبول (Flint , 1998). في المقابل، قد يكون لاعب الركبي نعتبر أن هذا ليس كثيراً على خبرة وقوع إصابات في الماضي الذي يجعلها عرضة لخطر المزيد من الإصابات وطبيعة نشاطها، الأمر الذي يضع قيوداً عديدة على الجسم. في حين أن دراسات يستخدمون خبراتهم الشخصية كمعيار لتقييم المخاطر التي تواجهها (مرة أخرى) لحدث , (Shepperd, 2001) فمن الممكن أن في هذا النشاط، هي الخصائص النفسية أكثر من الممارسين أن تجربتهم من الإصابة التي أنا هي الغالبة في تقييم التعرض للحضور.

وخلاصة القول، فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحديد تواريخ مختلفة من قابلية ينظر إلى إصابة الرياضة في النشاط الرياضي (لعبة الركبي) والتي من الإصابة قد تكون في المستوى المقبول. تبحث هذه الدراسة مساهمة الإصابة السابقة مقابل من (ما قبل) التصرفات النفسية في تشكيل الضعف المتصور (انظر الشكل 8).

الفصل التطبيقي

الدراسات الميدانية

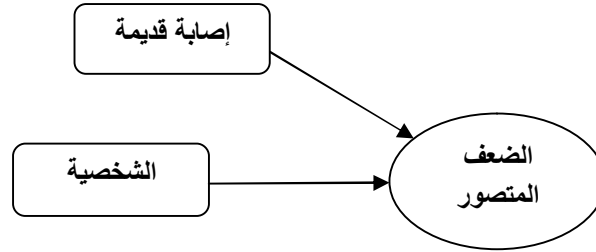
في هذه الدراسة، ونحن نجعل هذه الفرضيات التالية:

الفرضية 1. ويرتبط إيجابيا على تجربة عن وقوع إصابات في الماضي مع الضعف المتصورة.

الفرضية 2. مشاركة الشخصية في مجال التدريب والتلويين من الضعف الواضح، وراء المساهمة المحتملة للإصابات

الماضية. ويرتبط بشكل إيجابي العصائية مع قابلية المتصورة، على النقيض من احترام الذات العالمية ويرتبط سلبا مع هذا التصور.

الفرضية 3. الشخصية تعتدل العلاقة بين إصابات السابقة و الضعف المتصورة. كلما كان الشخص لديه درجة عالية من العصائية، واجهت المزيد من الإصابات في الماضي يحدد الضعف، ينظر إلى وقوع إصابات جديدة. وعلى العكس، كلما كان الشخص لديه تقديرات عالمية قوية في حد ذاته، إلا إذا كان الضرر تجربة الماضي يحدد الضعف المفترضة إلى وقوع إصابات جديدة.



الرقم 8. محددات التأثير المتصورة من قبل الاصابة

2. أسلوب

1.2 المشاركون

وتكونت عينة الدراسة من 235 من الرجال (متوسط السن = 23.06، الانحراف المعياري = 5.81، العينة السن = 14-42 عاما) ممارسة أندية الركبي على مستوى الدائرة الوطنية. وقالت الغالبية العظمى من هؤلاء اللاعبين واحد على الأقل في غضون اثني عشر إصابة

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

أشهر (75% من العينة)، بمتوسط قدره 1,83 إصابات (الانحراف المعياري = 1.74، و الموسعة = 8-0).

2.2 تدابير

الإصابة السابقة (انظر الملحق 1). وطلب منه أن يوقع على كل الإصابات لعبة الركبي تكون قد تعاقدت في الاثني عشر شهرا الماضية. كان عليهم أن يقدم إصابات فقط أن يطلب وفقا للقيادة ما لا يقل عن اهتمام يوم أو الطبية خاصة. التي يتم تقييمها أيضا درجة الحرارة منذ إصابة آخر باستخدام مقياس من ست نقاط (1 = أقل من شهر، ما بين 2 =

ثلاثة أشهر، 3 = ثلاثة إلى ستة أشهر، 4 = ستة أشهر إلى سنة واحدة، 5 = أكثر من سنة 6 = بدون جرح).

ينظر إلى الضعف (انظر الملحق 3). يعتبر التعرض المقررة باستخدام مقياس 4-البند، مقتبسة من المقاييس الحالية (Gerend, Aiken, West, & Erchull, 2004)، ثلاثة بنود لخطر الإصابة المطلقة، بندا للخطر المقارنة. وكانت البنود الثلاثة للخطر مطلق: "خطر التفكير يكون هذا الموسم من خلال ممارسة لعبة الركبي إصابة؟" هل يمكن أن يسبب لك الأذى، هذا الموسم في لعبة الركبي؟" من حيث النسبة المئوية، ما هي المخاطر التي هذا الموسم من خلال ممارسة لعبة الركبي؟". أجاب المشاركون على مقياس من 1 (أي خطر) إلى 5 (من المرجح جدا) للعنصر الأول، في الفترة من 1 (وليس على الإطلاق) إلى 5 (تماما) عن البند الثاني، من 1 (أقل من 10%) 5 (100%) بالنسبة للبند الثالث. وجرى تقييم المخاطر النسبية باستخدام عنصر واحد: "ما هي الخطر الذي هذا الموسم مقارنة مع لاعبي الركبي الأخرى التي بطولة؟" على مقياس من 1 (أقل بكثير من المحتمل) إلى 5 (أكثر ميلا).

وكشف تحليل المكونات الرئيسية التي من المتوقع أن أربعة بنود على العامل نفسه، أي ضعف المتصورة، وأوضح 64% من التباين مع القيمة الذاتية يساوي 2,57. ولذلك، تم إجراء قياس عالمي لقابلية ينظر باستخدام متوسط درجات لكل من البنود الأربعة ($\alpha = 0.81$).

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

العصابية (انظر الملحق 6). تم استخدام مقياس العصابية لتقرير تنفيذ البرامج الجديدة (Rollan d et al., 1998). وطلب من المشاركين اذا وافقوا مع 48 جمل قصيرة مما يعكس أحكامها (أي القلق والغضب - العداء، والاكتئاب، والخجل الاجتماعي، والاندفاع، والتعرض للإجهاد) على مقياس من 0 (لا أوافق بشدة) إلى 4 (أوافق بشدة). ألفا كرونباخ لهذه الدراسة هو جيد ($\alpha = 0.89$)

عالمي احترام الذات (انظر الملحق 7). تم استخدام مقياس من خمسة بنود من المخزون الذاتي البدنية (ISP, Ninot, Delignières, & Fortes, 2000)، للتكيف من الجرد احترام الذات (Coopersmith, 1984)، في هذه الدراسة. هل تبقى المواضيع طلب منهم تقدير أنفسهم على مقياس من 6 نقاط (1 = لا على الإطلاق إلى 6 = بشدة). معامل لاشاملة واحترام الذات في هذه العينة هي أقل من تلك التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة التحقق من صحة هذه الأداة (Ninot, 2000)، ولكن لا يزال مقبولا ($\alpha = 0.62$).

3.2 تحليل البيانات

تم تنفيذ سلسلة من تحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات لدينا. وتركزت جميع المتغيرات لتجنب المشاكل من العلاقة الخطية المتداخلة. في كل تحليل، وكان ينظر إلى قابلية المتغير التابع. لاختبار مساهمة التجربة عن وقوع اصابات السابقة على الضعف المتصورة، تم إدخال عدد من الإصابات السابقة كخطوة ثانية في معادلة الانحدار بعد ضبط تأثير محتمل من السن والوقت

إصابة آخر في خطوة أولى. لاختبار مساهمة العوامل النفسية في تصور العصابية، وقابلية والشاملة واحترام الذات

دخلت المرحلة النهائية، على حدة في وقت واحد، وبعد التحكم منذ وقت الإصابة الأخيرة في خطوة أولى، و الاصابات السابقة في خطوة ثانية. أخيرا، لاختبار تأثير التفاعل بين الإصابات السابقة والتصرفات النفسية، وتابعنا توصيات (Aiken et West, 1991) تركزت كل متغير بعد أن دخلت في المعادلة نفسها في الاصابات السابقة، و العصابية أو الذات الشاملة المقدرة، وشروط التفاعل، أي العصابية يضر في التحليل الأول لاصابة السابقة، يضر احترام الذات الشاملة في تحليل الثاني.

4.2 الإجراءات

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

تم الاتصال في البداية ثلاث مئة وسبعة وخمسون لاعبي الركبي من خلال المدربين وعلم الغرض من هذه الدراسة. وحصلت على موافقتهم بعد اطلاعهم على سريتها. شرحنا من أجل تقديم هذا البحث، وعلى اللاعبين أن نسعى إلى فهم أفضل لاعبي الركبي لماذا لا تزال سليمة عندما تمارس الرياضة. وقد بينا أيضا أن لديها لمساعدتنا على تحقيق مجموعة من الاستبيانات قبل التمارين. وكانت معايير الاشتغال (1) لا يمكن ان تصيب في ذلك الوقت من هذه الدراسة، (2) لجعل لعبة الركبي في الموسم الماضي. كل هذا لاعبين تستوفي معايير إدراجها. من بين 281، و 46 لم يكملوا جميع الاستبيانات واستبعدت من التحليل. وقد أدرجت أخيرا ما مجموعه 235 الرياضيين في التحليل.

3. النتائج

1.3 . الإحصاء الوصفي

تعرض، المتوسط، الانحرافات المعيارية والارتباطات بين المتغيرات المختلفة في هذه الدراسة في الجدول 12. يحلل علاقات هامة بين كشف الضعف المتصورة والاصابة السابقة ($p=0.20$, r). وعموما احترام الذات ($r = -0.15$ ، $p > 0.05$) والعصابية ($r = 0.25$ ، $p > 0.0001$).

الجدول 12. الوسائل، والانحرافات المعيارية ومصفوفة الارتباط بين متغيرات الدراسة (ن = 235)

القيم	M	SD	.1	.2	.3	.4	.5
1. الجنس	23.06	5.81	-				
2. الاصابة السابقة	1.83	1.74	.03	-			
3. وقت اخر اصابة	3.93	1.40	.04	-.55	-		
4. احترام الكلى لدات	4.19	0.71	.13	-.03	-.02	-	
5. العصابية	1.63	0.42	-.23	.14	-.11	-.50	-
6. الخطورة المتصورة	2.91	0.76	.03	.20	-.12	-.15	.25

ملاحظة : . كل ارتباط ≤ 0.13 | هامة $p > 0.05$

3-2 . تحليل الانحدار المتعدد الهرمية

الفرضية 1. ويكشف هذا التحليل عن مساهمة كبيرة من التجربة عن وقوع اصابات في الماضي على الضعف المتصور ($\beta = 0.18$ ، $p > 0.05$ ، $R^2 = 0.02$)، وبعد التدقيق في أول خطوة من آثار سن)

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

$\beta = 0.03$ ، نانوثانية)، ومرة منذ جرح آخر ($\beta = -0.12$ ، نانوثانية). كانت معادلة الانحدار الكبي F (227, 3) = 2.99 $P > 0.05$ $R^2 = 0.04$. (انظر الجدول 13)

الجدول 13. التنبؤ التأثير المتصور من الإصابات السابقة (ن = 235)

الضعف المتصور			
مرحلة 2	مرحلة 1		
β	β	مستقبل متغيرات الدراسة	المرحلة
.02	.03	الجنس	01
-.02	-.12	وقت من آخر إصابة	
-16*		الإصابة القديمة	02
.04	.02	R^2	
.02*		ΔR^2	
2.99*	1.75	F	

ملاحظة : موحدة معامل الانحدار. في $p^* > 0.05$

الفرضية 2. التحليل المنفصلين (انظر الجدولين 14 و 15) تكشف عن مساهمات كبيرة من العصابية ($\beta = .25, p > .001, \Delta R^2 = .05$). وعموما احترام الذات ($\beta = -.16, p > .05, \Delta R^2 = .02$) في التنبؤ الضعف المتصورة للإصابة، وبعد التدقيق في أول خطوة من آثار العمر والوقت منذ إصابة

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

آخر، ومساهمة من اصابة في الماضي في خطوة ثانية. وقدم تشيوان من العصابية في المعادلة، وأصبح إسهام إصابة الماضي 1 ضئيلة ($\beta = 15$ نث)، مع المعادلة النهائية كبيرة. في آخر التحليل $F(4,226) = 5.90, P > .001, R^2 = .09$ ، وعندما تم إدخال الاجمالى المقدرة بالتسليم احترام في المعادلة، ومساهمة من الاصابة السابقة β ($p = .17, .05 > p$)، مع المعادلة النهائية أيضا كبيرة $F(4,226) = 3.81, P > .001, R^2 = .06$.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الجدول 14. النية توقع التاثر المتصور من طرف الاصابات السابقة والعصبية (ن = 235)

الضعف المتصور				
مرحلة 1	مرحلة 2	مرحلة 1	مستقبل متغيرات الدراسة	المرحلة
β	β	β	السن	01
.08	.02	.03	الوقت من اخر اصابة	
-.01	-.02	-.12	إصابة قديمة	02
-.01	.18*		العصبية	03
.25***			R^2	
.09	.04	.02	ΔR^2	
.05***	.02*		F	
5.90***	2.99*	1.75		

ملاحظة : معاملات الانحدار موحدة. $0.001 > P^{*} \ 0.05 > p^*$**

الجدول 15. النية توقع التاثر المتصور من طرف الاصابات السابقة و إحترام الذات الكلى (ن = 235)

الضعف المتصور				
مرحلة 1	مرحلة 2	مرحلة 1	مستقبل متغيرات الدراسة	المرحلة
β	β	β	السن	01
.04	.02	.03	الوقت من اخر اصابة	
-.03	-.02	-.12	إصابة قديمة	02
.17	.18*		الكلى واحترام الذات	03
-.16*			R^2	
.06	.04	.02	ΔR^2	
.02*	.02*		F	
3.81***	2.99*	1.75		

ملاحظة : معاملات الانحدار موحدة. $0.001 > P^{*} \ 0.05 > p^*$**

تحليل سمح لنا أيضا لاختبار مدى مساهمة المتغيرات النفسية على الضعف المتصورة عندما دخلوا في وقت واحد في معادلة الانحدار واحدة (انظر الجدول 16). أنه يكشف الا ان العلاقة بين الضعف المتصورة والعصبية لا تزال كبيرة ($\beta = .22, p > .01$)، بعد ضبط آثار السن والوقت منذ آخر

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

إصابة في خطوة أولى، و الماضي مساهمة اصابة في الخطوة الثانية. المعادلة النهائية
كبيرة $F(5,225) = 4.82, P > .001, R^2 = .10$ ،

الجدول 16. النية توقع التاثر المتصور من طرف الاصابات السابقة،العصابية و إحترام الذات الكلى
(ن = 235)

		الضعف المتصور		
		مرحلة 1	مرحلة 2	مرحلة 2
المرحلة	مستقبل متغيرات الدراسة	β	β	β
01	السن	.03	.02	.08
	الوقت من اخر اصابة	-.12	-.02	-.02
02	إصابة قديمة		.18*	.15
03	العصابية			.22**
	الكلى واحترام الذات			-.05
	R^2	.02	.04	.10
	ΔR^2		.02*	.06***
	F	1.75	2.99*	4.82***

ملاحظة : معاملات الاتحاد موحدة. $0.05 > p^* 0.001 > P^{***}$

3.3 اختبار الإعتدال

الفرضية 3. وقد سمح لنا التحليل النهائي لاختبار ما إذا كانت العوامل النفسية يمكن أن تتفاعل مع
الاصابة السابقة في التنبؤ الضعف المتصورة. وقد تجلى أي تأثير معتدل. في أول تحليل، للتفاعل بين

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الإصابة السابقة والعصبية لم يكن كبيرا ($\beta = 0.01$ نث)، بعد ضبط آثار السن ($\beta = 0.08$ نث)، منذ ذلك الوقت

إصابة الأخير ($\beta = -0.01$ نانوثانية) الإصابة السابقة ($\beta = 0.14$ نانوثانية) و العصبية ($\beta = 0.25$ نانوثانية). ($0.01 > p$)

في التحليل الثاني، والتفاعل بين الإصابات السابقة والكلية احترام بالنفس ليست كبيرة ($\beta = 0.02$ نث)، بعد ضبط آثار العمر ($\beta = 0.04$ نث)، منذ ذلك الوقت إلى إصابة الأخير ($\beta = -0.03$ نث) الإصابات السابقة ($\beta = 0.17$ نانوثانية) وعموما احترام الذات ($\beta = -0.16$ نانوثانية). ($0.05 > p$)

وبالإضافة إلى ذلك، عينة الدراسة صغيرة جدا للنظر في طريقة أخرى (بارون و كيني، 1986) لاختبار تأثير محتمل الاعتدال بين المتغيرات، والتي ستكون على التمييز ضد مجموعات بناء على درجات عالية ومنخفضة (في أكثر أو ناقص واحد الانحراف المعياري) من المتغيرات الرئيسية للدراسة (أي إصابات السابقة وعوامل نفسية).

4. مناقشة

هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على العوامل التي تحدد ضعف ينظر إلى الإصابات الرياضية في لاعبي الركبي. أصبحت مهتمة في إمكانية التفسيرية للتجربة وقوع إصابات السابقة، والكلية واحترام الذات في تشكيل وتلوين الضعف المتصورة.

1.4 إصابات السابقة و التأثير المتوقع

يفترض أن الفرضية الأولى لمساهمة إصابات السابقة إلى الضعف المتصورة للعبة الركبي. وتؤكد النتائج هذه الفرضية بقدر ما يرتبط بشكل إيجابي على خبرة وقوع إصابات في الماضي إلى الضعف المتصورة عندما يتم التحكم في السن ومرة منذ إصابة آخر. هذه النتيجة تتفق مع الدراسات التي تبين أن ضحايا أحداث الحياة السلبية

(Weinstein , 1980) (؛ Greenin g et al. , 1996) (e.g.، وتحديد الإصابات (Williams - Aver y & MacKinnon , 1996)، ويعتبرون أنفسهم أكثر عرضة للعيش (مرة أخرى) هذه الأحداث. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الناس استخدام اختصارات المعرفي،

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

وتحديدا في الاستدلال المعرفي (Slovic , Fischhoff, & 1997) (Lichtenstein , 1980)، وعندما تسعى لتقييم خطر التعرض للمواجهة أمراض مثل سرطان الثدي أو التسليم , Katapod i et al. , 2004) ; (e.g. Gerend, Aiken , West, & , 2004) (2005 .) قد تكون هذه الاستدلال يفسر لماذا التجارب السابقة عن وقوع اصابات نتيجة في زيادة الضعف المتصورة. التعرض المباشر لأشخاص إلى نتائج الحدث مهددة في تمثيل أفضل للتسليم هذا التهديد، مما يسهل توفر لها المعرفية (توفر ارشادي) عندما تثار. في المقابل، فإن منشأة لتمثيل تهديد مساعدة تزيد من احتمال ينظر من هناك واجههم (مرة أخرى).

هذا من الممكن أيضا أن لدي الإصابات التي حدثت في الماضي أنفسهم مشابهة لتلك التي يحتمل أن يصيب (ارشادي)، والتي بدورها تزيد من ضعفها المتصورة. وعلاوة على ذلك، أظهرت دراسة حديثة أن نوعية بعد تجربة الإصابات الرياضية، ونشعر بالقلق الرياضيين حول فكرة أن تكون في حالة الإصابة (Podlog & Eklund , 2006). وهذا قد يكون نتيجة قلق لوجود ثغرة أمنية متصورة زيادة الإصابة منذ الدراسات أظهرت وجود علاقة بين هذين المتغيرين (e.g. Cameron & Diefenbach, 2001)

2.4 دور الشخصية

ثمة الفرضية ثانية المقترحة لاختبار مساهمة شخصية في تشكيل وتلوين من قابلية ينظر إلى إصابة الرياضية.

وأكد التحليل الأول الذي كان مرتبطا بشكل إيجابي بالعصابية إلى الضعف المتصورة، وراء مساهمة الإصابات السابقة . هذه النتيجة تتفق مع الأبحاث التي أظهرت أن العصابية يعتبر عاملا هاما من تصور الشخص من تعرضها لمشاكل صحية مختلفة) ; (Darvill & Johnson, 1991) (Gerend, Aiken , & West, 2004) ; (Johnson, 2000) ; Vollrath et al., 1999) (

هذا ومن المسلم به أن الناس لديهم مستويات عالية من العصابية تميل لأعراض أكثر الطبية والشكاوى (Costa & McCrae , 1980, 1985) ; (Costa et al., 1982) ردا على ذلك، لأنها قد تعتبر نفسها ممثلة للغاية من السكان المعرضين للخطر بشكل خاص. ان هذا المنطق يؤدي بالتالي إلى

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

زيادة قابليتها، وينظر (Gerend, Aiken, West, 1982) هذا التفسير مبالغ فيه من أعراضهم يؤدي أيضا إلى ميلها للقلق حول مخاوفهم، والصحة التي يمكن أن يخون العالية الضعف المتصورة (e.g. Cameron, 2001)

تحليل الثاني يظهر أيضا وجود علاقة سلبية بين الضعف المتصورة والكلّي احترام الذات. وهذه النتائج متسقة مع نتائج دراسات عن "مخاوف أخرى من الإصابة، مثل الأمراض المنقولة جنسيا أو الحمل غير المرغوب فيه (Smith et al., 1997) ; (Boney-McCoy et al., 1999). الرياضيين واللاعبين وخاصة لعبة الركبي، تعتبر في كثير من الأحيان إلى إصابة باعتباره علامة على الضعف البدني أو الفشل: ميلهم للعب العهد الاصابة الى بجد لقبول وتحمل هذه الحالة من شأن وهذا الوضع الخاص (Flint, 1998). بقدر الثقة بالنفس التي ارتكبت الناس في التشوهات المعرفية التي تؤدي بهم إلى رفض المعلومات التي لا تتسجم مع تصوراتهم ووجهات نظر أنفسهم (Knight & Nadel, 1986)، فمن الممكن أن لاعبي الركبي، بما في ذلك احترام الذات الكلّي مرتفعة

أن يقود إلى رفض احتمال أنها تؤدي نفسها في المستقبل. هذا من شأنه أن يؤدي إلى رفض التعرض أقل المتصورة.

ومع ذلك، فإن التحليل النهائي لا يبرهن على وجود أثر ملطف للشخصية في العلاقة ما بين الاصابات السابقة والضعف المتصورة (الفرضية 3). وشعور أقوى من الرياضة العالمية النفس أو العصائية المنخفض لا يؤدي في أقل استفادة من خبراتهم من إصاباتهم كمعيار لتقييم المخاطر في المستقبل. ويمكن تفسير هذه النتيجة بسبب عدم وجود علاقة بين الاصابات السابقة والضعف المتصورة عندما يتم إدخال جميع التصرفات النفسية في معادلة الانحدار. في بعض الحالات، والتي من خلالها وجود تهديد مادي يمكن أن يكون في المستوى المقبول (كما هو الحال في لعبة الركبي)، هذه الأحكام تبدو حاسمة النفسية. نموذج في النهاية، العصائية فقط يساهم بشكل كبير في تشكيل تصور الضعف للاصابة. متجذر في السوق المثير للاهتمام في منطقة الأساسية للشخصية، أي العصائية (Costa & McCrae, 1992) هذه العلاقة تبين بوضوح أن ينظر إلى قابلية الإصابة في لعبة الركبي في العوامل المستقرة للغاية، وليس عرضة للتغيير خلال الوقت، وحتى أثناء التجربة من الاصابة.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

3.4 حدود الدراسة وآفاق البحثية

وعموماً، فإن هذه الدراسة تساهم في أفضل المعرفة التي تحدد تشكيل والتكوين الضعف المتصورة. فمن أبرزها الأولى لاختبار وإظهار المساهمة الشخصية في الأحكام المتعلقة حدوث التهديد، من خلال التحكم في الآثار المحتملة لتجربة هذا التهديد في الماضي. وتشارك بالتالي في توسيع نطاق النماذج المعرفة الاجتماعية للصحة التي لم تحدد مصدر المساهمة. تقاس هذه النماذج

أطر تحليل محددات السلوك المتصلة وقوع إصابات، وهذا البحث يتيح لنا أن نتصور نقاط الضعف الجديدة والحماية ضد خطر الإصابة.

هذه الدراسة، ومع ذلك، هناك عدد من القيود. أولاً، لا يمكن للتقييم مقطعية لمتغيرات الدراسة لم تخلص إلى نتيجة حاسمة بشأن طبيعة التنبؤية لتصرفات الإصابات السابقة والنفسية على الضعف المتصورة. ويمكن لتصميم المحتملين، بما في ذلك تدابير عدة من الضعف ينظر على حد سواء قبل وبعد تجربة (جديدة) الإصابات، وتكون أكثر عرضة للمساءلة لتأثير دقيق من هذه الإصابات على إدراك المخاطر، لا سيما فيما يتعلق بالتغيير من الحدوث.

ثانياً، فإن هذه الدراسة تركز فقط على اثنين من التصرفات النفسية التي تعرض اللون المتصورة. على الرغم من أن هذين الحكمين زيادة التباين وأوضح أن هناك حاجة بحثية جديدة لزيادة المعرفة من العوامل النفسية التي ترتبط المخاطر المتوقعة من الإصابة. ولا سيما أنه قد تبين أنه التفاؤل هو سمة شخصية أدى إلى انتشار التوقعات من نتائج إيجابية في مسار ، بما في ذلك مواجهة الشدائد

حياته (Carver & Scheier, 2002). التفاؤل بالتالي يحمي الفرد ضد الضائقة التي تواجهها مع الأحداث السلبية كما يمكن أن تكون الإصابات الرياضية في يمكن أن يصاحب هذا الحكم من قبل نزعة الفردية لرؤية أنفسهم لا يشعرون بالضعف والقلق أقل مادياً لفكرة كونه أخيراً. أدب يكشف عن وجود ما لا يقل عن ثلاثة أساليب أخرى تميز مزيد من العمليات النفسية في ممارسة يحدث في التنبؤ خطر في المستقبل: أ) معرفة وفهم عوامل الخطر (Masatu ; e.g. Astrom et al., 1999) (2003، والثاني).. استخدام الاستدلال (أساساً) المعرفية ; 2002 , Facione (e.g. Tyc et al., 2003) ; (Rees et al., 2001) ; (Montgomery et al., 2003)

الفصل التطبيقي

الدراسات الميدانية

والثالث) تصور خصائص المخاطر (على سبيل المثال Gerend، أيكن، الغرب (Erchull، 2004). دراسة مساهمة هذه العمليات ويبدو أن الاساسية ليشرح لماذا يرتبط شخصية للتصورات من ضعفها. ونظرا للقيود التي نوقشت، والدراسة الأخيرة المقترح في هذه الورقة تهدف لذلك الطبيب (1) لتحديد العوامل الشخصية الأخرى المتعلقة الضعف المتصورة، (2) لدراسة النموذج الذي يجمع بين جميع العوامل الصعوبات النفسية التي قد تسهم معا في تشكيل وتلوين الضعف المتصورة للإصابة، والشخصية، أي تصور لخطر الإصابة خصائص واستخدام الاستدلال المعرفي.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الدراسة الخامسة.

دراسة النموذج المتعدد العوامل والمتكامل من المحددات النفسية و التاثر المتصور من الإصابة

1. الأهداف والفرضيات

إدراك نقاط ضعفهم ويبدو أن العامل النفسي في التسبب الاقل لانها تتعلق بإشراك شخص في السلوكيات الخطرة الرياضية (دراسة 2) أو في السلوكيات الصحية الوقائية أثناء النشاط البدني (دراسة 3). المحددات وتحديد الضعف ينظر لذلك من الضروري تحديد عوامل الضعف والحماية ضد خطر الإصابة.

(4) دراسة لهذا العمل الدكتوراه (Déroche et al., 2007) وأكد على مساهمة شخصية في تشكيل وتلويين لضعف المتصورة، إذا كانت هذه المساهمة لم يعد موضع شك (Gerend, Aiken, & West, 2004)، ومع ذلك يبدو من الضروري مواصلة دراسة ما هي العوامل الشخصية التي يمكن أن يتنبأ الضعف المتصورة. في هذا المعنى، فإن ميناء الدراسة اهتماما خاصا الأخير إلى المساهمة المحتملة اثنين من أبعاد جديدة، أي اجتهاد الفرد وتفاؤله (انظر الجزء 4.2، الفصل 3). وتوفر هذه الدراسة أيضا فرصة لتعميم النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة السابقة أنها تسعى للتحقق من تأثير العصبية والكلية في احترام الذات على الضعف الملحوظ في نشاط آخر لعبة الركبي، مع يسكنها خليط من الرجال والنساء ممارسة الجودو.

هذه الدراسة تهدف أيضا إلى التعرف على المحددات النفسية جديدة من المخاطر المتصورة للإصابة. كما لوحظ من قبل الأطراف

2.2 و 3.2 من الفصل 3، النهجين من المحتمل أن يفسر كيف يمكن للناس تحديد ما إذا كانت عرضة للمشاكل الصحية: أ) استخدام الاستدلال المعرفي الثاني) تصورات خصائص المخاطر. وقد أظهر كلا النهجين أهميتها المحتملة في مختلف مجالات الصحة (Gerend, Aiken, West, & Erchull, 2001) ; (Reeset al., 1992) ; (Lek & Bishop, 1995) ; (2004) ; Weinstein, 1980. وقد حاولت أية دراسة حتى الآن للتحقق من مدخلاتها على الضعف المتصور إلى وقوع إصابات.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

في النهاية، يكمن أن الشخصية، الاستدلال المعرفي والتصورات الخصائص مخاطر أن تكون مكملة لوصف العوامل التي تدخل في تشكيل وتلوين الضعف المتصورة. وأظهرت دراسة واحدة (Geren, Aiken, & West, 2004) أن بعض العوامل الشخصية قد لون تصورات لخصائص المخاطر الفردية من المرض أو تحديد كيفية استخدام الاستدلال المعرفي وتأثير ذلك على الفرد مستقبل المخاطر. هؤلاء وجد الباحثون ان النساء مثل التفاضل و الانفتاح على الخارج، واصفا نفسه من حيث الايجابية والنظر له سيطرة على مستقبل صحتهم (الشخصية)، تشبه إلى حد ما يشعر الناس عرضة للمرض (إرشادي) ولذلك، ترى نفسها أقل عرضة جسديا (انظر الجزء 3، الفصل 3). في اشارة الى هذه الدراسة، ونحن نسعى للتأكد من مدى من العوامل الشخصية (على سبيل المثال، العصابية، الضمير الحي والتفاؤل، أو الكلى في احترام الذات) يمكن تلوين تصورات الفرد من خطر الاصابة من الخصائص، أي تواترها وشدها، من التحكم والقدرة على منع أو تؤثر على استخدام ارشادي المعرفي، و، من قبل وسيط (Baron & Kenny, 1986)، وتكون ذات صلة المخاطر الفردية والمقبلة.

وباختصار، فإن هذه الدراسة تسعى إلى التعرف على السوابق النفسية للتصورات التعرض للإصابة. كما يبحث في العلاقات المختلفة بين هذه السوابق (انظر الشكل 9).

في هذه الدراسة، ونحن نجعل الفرضيات التالية:

الفرضية 1. وترتبط التصورات من الخصائص من خطر الإصابة (أي من التردد، وشدة، والتحكم والقدرة على منعها) إلى التاثر المتصورة للرياضيين.

الفرضية 2. استخدام الاستدلال المعرفي عند الرياضيين لتقييم مدى عرضتهم للإصابة.

الفرضية 3. الشخصية تشارك في تدريب و تلوين الضعف المتصور، العصابية يرتبط بشكل إيجابي لضعف المتصورة، والضمير مقلوب، من احترام الذات الكلى المقدرة والتفاؤل، والتي ترتبط سلبيا مع هذا التصور.

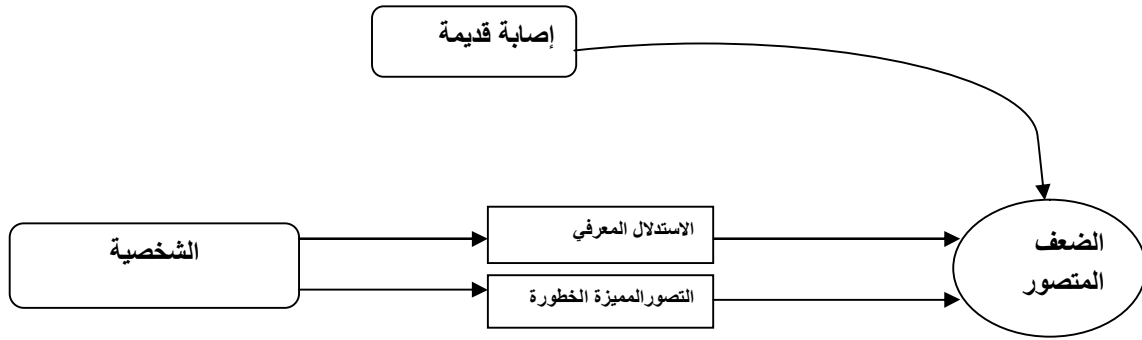
الفرضية 4. التصورات من الخصائص خطر الإصابة، واستخدام الاستدلال المعرفي وشخصية كل عامل يساهم بشكل مشترك لتشكيل وتلوين الضعف المتصورة.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الفرضية 5. الإستدلال أو التصورات المعرفية من خطر الإصابة والخصائص تكون لها دور في التوسط في العلاقة

الربط الضعف المتصورة والسمات.

لكل من هذه الفرضيات، ويتم التحكم في المساهمات المحتملة من السن، والجنس، والخبرة في الجودو، وقت الممارسة والإصابات السابقة



الشكل 9. النموذج المتكامل المتعدد العوامل والمحددات الضعف المتصور لدى الإصابة

2. أسلوب

1.2 المشاركون

وشارك 211 لاعب الجيدو ، 158 من الرجال و 53 من النساء (متوسط السن = 23.85، الانحراف المعياري = 11.15، عينة السن = 13-66 سنة)، على مستوى المؤسسة الاستشفائية المختصة بالدويرة، في هذه الدراسة. انها ممارسة الجودو في ساعات 4،8 متوسط في الأسبوع (الانحراف المعياري = 3.11، الموسعة = 1.5 إلى 20)، من 12.9 عاما (الانحراف المعياري = 8.55، الموسعة = 1-45 سنوات)، و 99 منهم (47٪ من عينة) عن إصابة واحدة على الأقل في الأشهر الاثني عشر الماضية (متوسط = 0.92، الانحراف المعياري = 1.13، الموسعة = 0-6).

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

2.2 التدابير

الإصابة السابقة (انظر الملحق 1). وطلب من لاعب الجيدو للإبلاغ عن كل الإصابات التي ربما تكون قد تعاقبت في الاثني عشر شهرا الماضية. كان عليهم أن يقدم إصابات الوحيد الذي يتطلب التوقف عن القيادة على الأقل يوم واحد أو عناية طبية خاصة. منذ وقت الإصابة الأخير

تم تقييم أيضا باستخدام مقياس من ست نقاط (1 = أقل من شهر، 2 = بين واحد وثلاثة أشهر، 3 = بين ثلاثة إلى ستة أشهر، 4 = بين ستة أشهر إلى سنة واحدة، 5 = أكثر من عام، 6 = لم يصب).

ينظر إلى الضعف (انظر الملحق 3). يعتبر التعرض للإصابة المقررة باستخدام مقياس 4-البند (Gerend, Aiken, West, Erchull, 2004); (Déroche et al., 2007)، ثلاثة بنود لخطر الإصابة المطلقة، بندا للمقارن للخطر. وكانت البنود الثلاثة للخطر مطلق: "خطر التفكير يكون من موسم هذه الإصابة عن طريق ممارسة رياضة الجودو؟" هل أنت من المحتمل أن يصب عليك هذا الموسم من خلال ممارسة رياضة الجودو؟" من حيث النسبة المئوية، ما هي المخاطر الإصابة هذا الموسم من خلال ممارسة رياضة الجودو؟". أجاب المشاركون على مقياس من 1 (أي خطر) إلى 5 (من المرجح جدا) للعنصر الأول، في الفترة من 1 (وليس على الإطلاق) إلى 5 (تماما) عن البند الثاني، من 1 (أقل من 10%) 5 (100%) بالنسبة للبند الثالث. وجرى تقييم المخاطر النسبية باستخدام بند واحد: "ما هي المخاطر الإصابة هذا الموسم بالمقارنة مع غيرها لاعب الجيدو من عمرك، والطبقة وزنك و مستواك ؟" على مقياس من 1 (أقل بكثير من المحتمل) إلى 5 (أكثر ميلا).

التحليل المكون الرئيسي تشير وتؤكد أن من المتوقع أن أربعة بنود على العامل نفسه، أي الضعف المتصورة، وأضح 66% من التباين مع القيمة الذاتية يساوي 2,66. ولذلك، تم إجراء متوسط القياس لقابلية ينظر من عشرات من كل واحد من البنود الأربعة ($\alpha = 0.83$).

و جرى تقييم تصورات خطر الإصابة الخصائص (انظر الملحق 3) تصورات باستخدام العناصر من المؤلفات العلمية (Gerend, Aiken, West, & Erchull, 2004): "ماذا يمكن للاعب الجيدو القيام به للحد من خطر تعرضهم للإصابة؟" (1 = هو / هيل لا يمكن أن تفعل شيئا للحد من المخاطر من أجل 5 = هو / هي يمكن أن تقضي تماما على المخاطر فيها)، وحول إمكانية منع ظهور

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الاصابة: "ماذا يمكنك السيطرة على (1) ويمكن لاعب الجيدو (أنت) لديها في وقوع ضرر؟" ($1 = لا$ تحكم على 5 = الكثير من السيطرة) على إمكانية التحكم من اصابة في الجودو، بشكل عام، بسبب اصابة انها سوف تعطل حياتك؟" ($1 = لا$ على الإطلاق إلى 5 = كثيرا) لخطورة الاصابة"، في رأيك، بشكل عام، ما هي نسبة احتمال ان لاعب الجيدو

يصاب خلال الموسم؟" ($1 = أقل من 10\%$ في 5 = 100%)، وطبيعة السائد من اصابة في الجودو.

الاستدلال المعرفي (انظر الملحق 3). كما تم تقييم استخدام الاستدلال المعرفي من المقاييس الحالية (Gerend, Aiken, West, & Erchull, 2004). لقياس مدى السهولة التي كل لاعب الجيدو لديها تمثيل للإصابة (توافر الاستدلال)، وكان الطلب للرد على الأسئلة التالية:

"هل تعرف شخصيا من ليالي لاعب الجيدو الذين يصابون من ممارسة الجودو في الآونة الأخيرة؟" ($1 = لا$ إلى 5 = كثيرا) بشأن بالانابه الخبرات المتعلقة في ممارسة الجودو في الآونة الأخيرة كان لديك الفرصة لرى او نسمع عن لاعب الجيدو إصابات في وسائل الإعلام؟" ($1 = أبدا$ إلى 5 = في كثير من الأحيان) بشأن بالانابه الخبرات المتعلقة في وسائل الإعلام وردت في الآونة الأخيرة لك معلومات عن الاصابات الرياضية من قبل الأطباء أو اشخاص في حياتك؟" ($1 = أبدا$ إلى 5 = في كثير من الأحيان)، بشأن بالانابه تجربة ذات الصلة بالبيئة لتقييم شامل اتجاه لاعب الجيدو لمعرفة ما انفسهم ثانية ممثل من اشخاص من المحتمل أن تضار في المستقبل (تشابه ارشادي)، طلبنا منهم للإجابة على السؤال: "تبدو وكأنها لك لاعب الجيدو والتي تميل إلى جرح أنفسهم من خلال ممارسة رياضة الجودو؟" ($1 = لا$ على الإطلاق إلى 5 = تماما).

الوعي (انظر الملحق 5). وقد استخدم التسليم على المستوى المحلي وعيه لتنفيذ البرامج الجديدة (Rolland et al., 1998). وطلب من المشاركين إذا كانوا

توافق مع 48 جمل قصيرة مما يعكس أحكامها (الكفاءة والنظام، والشعور بالواجب، وتحقيق السعي، الانضباط الذاتي، وتداول) على مقياس من 0 (لا أوافق بشدة) إلى 4 (أوافق بشدة). ألفا كرونباخ لهذه الدراسة هو جيد ($\alpha = 0.85$).

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

العصابية (انظر المرفق 6). تم استخدام مقياس العصابية (Rolland et al., 1998). وطلب من المشاركين إذا وافقوا مع 48 جمل قصيرة مما يعكس أحكامها (القلق والغضب العداء، والاكتئاب، والخجل الاجتماعي، والاندفاع، والتعرض للإجهاد) على نطاق من 0 (لا أوافق بشدة) إلى 4 (أوافق بشدة). ألفا كرونباخ لهذه الدراسة هو جيد ($\alpha = 0.83$).

الكلية احترام الذات (انظر الملحق 7). تم استخدام مقياس من خمسة بنود من المخزون الذاتي البدنية (Coopersmith, 1984), (ISP, Nino t et al., 2000)، للتكيف من الجرد احترام الذات في هذه الدراسة. سئل الموضوعات إلى معدل على مقياس من 6 نقاط (1 = لا على الإطلاق إلى 6 = بشدة). ألفا كرونباخ لهذه الدراسة هو الصحيح ($\alpha = 0.76$).

التفاؤل (انظر الملحق 8). تم تقييم التفاؤل الميول (Sultan & Bureau, 1999) اختبار التوجيه الحياة بصيغته المنقحة (LOT-R, Scheier, Carver, , 1999). فهم بهذا الحجم من ستة بنود تقييم التوقعات العامة وجهها لوجه مع نتيجة إيجابية أو أحداث سلبية. وكان على المواضيع التي تضع نفسها على كل بند على مقياس 4 نقاط وفقا لدرجة مع كل من (1 = لا أوافق بشدة على 4 = أوافق بشدة). ألفا كرونباخ لهذه الدراسة هو الصحيح ($\alpha = 0.74$).

3.2 التدابير

وقد تم جمع البيانات مع جمعيات لاعب الجيدو الرياضة في منطقة الجزائر العاصمة . و 437 لاعب الجيدو اتصلت في البداية للمشاركة في هذه الدراسة، وأبلغ من الهدف والإجراءات. تم التوصل إلى اتفاق على عدم الكشف عن هويته المضمون. شرحنا من أجل تقديم هذه الدراسة، واننا نريد لتحديد العوامل وتمكينهم من البقاء في صحة جيدة في حين يمارس رياضة الجودو. وقد بينا أيضا أن لديهم لإكمال سلسلة من الاستبيانات لمساعدتنا. وكانت معايير الاشتمال (1) عدم الكشف عن إصابة المؤمن من هذه الدراسة، (2) لجعل جماعة الدعوة في 12 شهرا. أراد 211 لاعب الجيدو ، والتي تلبي معايير لإدراج العاشر، واستكمال الاستبيانات.

4.2 تحليل البيانات

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

لاختبار الفرضيات لدينا، وأجريت انحدارات متعددة الهرمي. لكل تحليل، وكان ينظر إلى قابلية المتغير التابع، السن، الجنس، والخبرة الرياضية، وممارسة درجة الحرارة، وخبرة من الإصابات السابقة والوقت الذي يقضيه منذ الإصابة الأخيرة كانت يسيطر سابقا

في خطوة أولى.

لاختبار مساهمة تصورات خطر الإصابة على خصائص الضعف المتصورة (الفرضية 1)، وتصورات من وتيرتها وشدها، والتحكم في إمكانية منعهم يتم إدخالها في وقت واحد في معادلة الانحدار خطوة إلى المرحلة 2.

لاختبار مساهمة الاستدلال المعرفي على ضعف ينظر (الفرضية 2)، بالانابه خبرة من كل ضرر (توفر الاستدلال) وميل لاعب الجيدو لمعرفة مماثلة لأنفسهم لعبة الجودو

مثاله إصابة أي النواب الاستدلال يتم إدخالها في وقت واحد في خطوة ثانية في معادلة الانحدار.

لاختبار مساهمة سمات الشخصية على الضعف المتصورة (الفرضية 3)، ودخلت الثقة بالنفس الكلي والتفاؤل والعصابية والضمير تراجع المرحلة الثانية معادلات منفصلة بعد ذلك في واحد المعادلة.

لاختبار نموذج تكاملي وسياقاتها (الفرضية 4)، ويتم إدخال الاستدلال المعرفي والتصورات من خطر الإصابة من الخصائص في وقت واحد في خطوة ثانية، كل عامل شخصية على حدة في نفس الخطوة، ومراقبة المتغيرات في الأول من نوعه خطوة

أخيرا، لاختبار كل وساطة (الفرضية 5)، وتابعنا على النهج الإحصائي الذي اقترحه بارون وكيبي (1986): لتحديد M الوسيط (إدراك المخاطر من الخصائص إصابة، واستخدام الاستدلال المعرفي) تأثير متغير A (شخصية) في آخر ب متغير (قابلية المتصورة)، يجب أن تتحقق خمسة شروط: (1) وباء متغير والمتغير يجب أن تكون متصلة بشكل كبير، (2) ومتغير الوسيط و تكون متصلة بشكل كبير، (3) يجب أن يكون متغير وسيط M متصلة بشكل كبير، (4) وتأثير عمليات الاندماج على وسيط B متغير لا ينبغي أن يختفي إذا كان السيطرة إحصائية تأثير متغير على B متغير، (5) ويجب أن تأثير متغير على B متغير تختفي (وساطة الكل) أو انخفاض كبير (وساطة جزئي) بعد ضبط إحصائيا تأثير M الوسيط B متغير.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

3. النتائج

1.3 الإحصاء الوصفي

وسيلة، وتعرض الانحرافات المعيارية والارتباطات بين المتغيرات المختلفة في هذه الدراسة في الجدولين 17 و 18.

ويحلل علاقات هامة بين كشف الضعف المتصور إلى إصابة ووقت الجودو ($r = 0.21, p > 0.01$)، والخبرة عن وقوع إصابات السابقة ($r = 0.42, p > 0.001$)، والوقت منذ إصابة آخر ($r = -0.41, p > 0.001$)، وتصورات من شدة الإصابة ($r = 0.21, p > 0.01$)، وإمكانية منعها ($r = -0.17, p > 0.05$)، أو انتشارها ($r = 0.44, p > 0.001$)، وتجربة بالانابه من الإصابة، ($r = 0.34, p > 0.001$) لعبة الجودو ($r = 0.23, p > 0.001$)، مقابل نحو والميل ينظرون إلى أنفسهم مشابهة لعبة الجودو من المرجح أن يكون أصيب ($r = 0.49, p > 0.001$) والتفاؤل ($r = -0.15, p > 0.05$).

الجدول 17. متوسط والانحرافات المعيارية للمتغيرات الدراسة 5 (ن=211)

انحراف المعيارى	متوسط	القيم
11.15	23.85	1. السن
8.55	12.91	2. التجربة
3.11	4.80	3. وقت التطبيق
1.13	0.92	4. الإصابات السابقة
1.61	3.92	5. وقت السابق من اخر إصابة
1.06	3.40	6. الخطورة المتصورة
0.81	3.14	7. الوقاية المتصورة
0.97	2.93	8. التحكم المتصور
0.78	2.39	9. انتشار المعثر
1.17	3.02	10. تجربة بالانابه الجودو
0.90	1.61	11. تجربة بالانابه وسائل الاعلام
1.01	1.85	12. تجربة بالانابه البيئة
1.01	2.16	13. تشابه
0.93	4.27	14. واحترام الكلى للذات
0.57	2.80	15. التفاؤل
0.45	1.65	16. العصابية
0.44	2.46	17. الوعي
0.74	2.61	18. الضعف المتصور

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

--	--	--

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الجدول 18. مصفوفة

الارتباط بين متغيرات الدراسة 5 (ن=211)

القيم	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1. الجنس	-																	
2. السن	-11.	-																
3. التجربة	-13.	57.	-															
4. عدد مرات ممارسة	-16.	-20.	-03.	-														
5. إصابات السابقة	-08.	-19.	-02.	35.	-													
6. زمن منذ آخر الإصابة	-10.	15.	00.	-25.	-64.	-												
7. الخطورة المتصورة	-05.	15.	-09.	18.	09.	-05.	-											
8. الوقاية المتصورة	-11.	17.	-04.	-04.	-01.	-04.	12.	-										
9. التحكم المتصور	-09.	-02.	02.	06.	04.	-07.	15.	48.	-									
10. انتشار المعتبر	-07.	-31.	-08.	23.	26.	-26.	17.	-10.	10.	-								
11. تجربة بالاتجاه الجودو	-08.	-13.	00.	42.	33.	-24.	21.	16.	15.	36.	-							
12. وسائل الاعلام E V.	-15.	05.	23.	17.	04.	-09.	12.	04.	03.	20.	20.	-						
13. تجربة بالاتجاه البيئة	-10.	-02.	01.	24.	17.	-26.	15.	16.	10.	17.	29.	17.	-					
14. التشابه	-07.	-06.	-01.	11.	21.	-27.	13.	15.	00.	30.	27.	17.	17.	-				
15. واحترام الكلى للذات	-10.	09.	14.	10.	04.	-08.	11.	01.	03.	06.	17.	03.	-01.	-02.	-			
16. التفاؤل	-05.	17.	07.	03.	-06.	-04.	12.	11.	08.	-03.	03.	05.	-02.	01.	65.	-		
17. العصائية	-20.	-25.	-13.	-10.	08.	-03.	-04.	-05.	-03.	13.	-11.	-09.	-02.	-03.	-62.	-58.	-	
18. الوعي	-09.	37.	18.	07.	-05.	00.	22.	05.	05.	-14.	06.	06.	11.	-00.	34.	28.	-48.	-
19. الضعف المتصور	-09.	-12.	-04.	21.	42.	-41.	21.	-17.	-04.	44.	34.	14.	23.	49.	-11.	-16.	09.	-02.

ملاحظة : كل ارتباطات $|14| \leq$ هامة $p > 0.05$

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

3.2. تحليل الانحدار المتعدد الهرمية

الفرضية 1. حللت مساهمات كبيرة وكشف من تصورات من شدة الإصابة في الجودو ($\beta = 0.15, p >$ 0.05)، وانتشار ($\beta = 0.33, p > 0.05$) و انتقائها ($\beta = -0.16, p > 0.05$) في التنبؤ الضعف المتصورة، وبعد التدقيق في أول خطوة من آثار الجنس ($\beta = 0.06 -$ نانوثانية)، السن ($= 0.01$ ، نانوثانية)، وتجربة الرياضية ($\beta = 0.07 -$ نانوثانية) ، عدد مرات من ممارسة ($\beta = 0.08$ ، نانوثانية)، الإصابة السابقة ($\beta = 0.25, p > 0.01$)، وحدث منذ وقت آخر إصابة ($\beta = -0.22, p > 0.01$). عندما يتم إدخال التصورات من الخصائص من خطر الإصابة في معادلة الانحدار، التباين وأوضح زيادة كبيرة هـ 16% ($p > 0.001$). وكانت المعادلة النهائية كبيرة $F(10,199) = 12.14, P > 0.001$. $R^2 = 0.38$ ، (انظر الجدول 19).

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الجدول 19. التنبؤ الضعف وإدراك المخاطر من الخصائص إصابة (ن = 235)

الضعف المتصور			
مرحلة 2	مرحلة 1		
β	β	مستقبل متغيرات الدراسة	المرحلة
- .10	- .06	الجنس	01
.11	.01	السن	
- .11	- .07	الخبرة	
.02	.08	وقت التطبيق	
.21**	.25**	إصابات السابقة	
- .19*	- .22**	وقت مضى من آخر إصابة	
.15*		الخطورة المتصورة	02
- .16*		الوقاية المتصورة	
- .05		التحكم المتصور	
.33*		الانتشار المعتبر	
.38	.22	R^2	
- .16***		ΔR^2	
12.14***	9.62***	F	

ملاحظة : معاملات الانحدار موحدة. $0.001 > p^{*}$, $0.01 > p^{**}$, $0.05 > P^*$**

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الفرضية 2. يبين التحليل مساهمة كبيرة فقط لتشابه ($\beta = .36, p > .001$) في التنبؤ الضعف المتصورة ، وبعد التدقيق في أول خطوة من آثار الجنس ($\beta = -.06$ ، نث)، و السن ($\beta = .001$ ، نانوثانية)، وتجربة الرياضية ($\beta = -.07$ ، نانوثانية)، وقت الممارسة ($\beta = .08$)، وإصابة الماضي ($\beta = .25, p > .01$)، ومنذ زمن إصابة آخر ($\beta = -.22, p > .01$). زيادة التباين وأوضح عندما جميع الاستدلال المعرفي دخلت معادلة الانحدار، بشكل ملحوظ من 16%. ($p > .001$). وكانت المعادلة النهائية كبيرة ($F(10,119) = 12.29, P > .001, R^2 = .38$). (انظر الجدول 20)

الجدول 20. التنبؤ الضعف ينظر إليها من قبل الاستدلال المعرفي (ن = 211)

الضعف المتصور			
مرحلة 2	مرحلة 1		
β	β	مستقبل متغيرات الدراسة	المرحلة
-.04	-.06	الجنس	01
.01	.01	السن	
-.06	-.07	الخبرة	
.08	.01	وقت التطبيق	
.22**	.25**	الإصابات السابقة	
-.12	-.22**	وقت مضى من آخر إصابة	
.12		التجربة الغير المباشرة الجودو	02
.03		التجربة الغير المباشرة الاعلام	
.05		التجربة الغير المباشرة البيئة	
.36***		تشابه	
.38	.22	R^2	
-.16***		ΔR^2	
12.29***	9.62***	F	

ملاحظة : معاملات الانحدار موحدة. $0.001 > p^{}, 0.01 > P^*$**

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الفرضية 3. بعد التحقق في خطوة أولى لتحليل كل الآثار المترتبة على ممارسة الجنس ($\beta = -0.06$ نانوثانية)، السن ($\beta = 0.01$ نانوثانية)، وتجربة الرياضية ($\beta = -0.07$ ، نانوثانية)، وقت الممارسة ($\beta = 0.08$ نانوثانية)، الاصابات السابقة ($\beta = 0.25, p > 0.01$)، ومنذ وقت الإصابة الأخيرة ($\beta = -0.22, p > 0.01$)، وهو أول تحليل يبين مساهمة كبيرة من الثقة بالنفس الكلي (-0.15). $\beta = 0.05, p > 0.02, \Delta R^2 = 0.05$ في التنبؤ الضعف المتصورة. وكانت المعادلة النهائية كبيرة. والت (7,202) $F = 9.24, p > 0.001, R^2 = 0.24$. والتحليل الثاني يكشف عن مساهمة من التفاؤل ($\beta = 0.16, p > 0.05, \Delta R^2 = 0.03, p > 0.05$) في التنبؤ الضعف المتصورة. وكانت المعادلة النهائية كبيرة. في المقابل (7,202) $F = 9.44, p > 0.001, R^2 = 0.25$ ، بالتحليلين الاخيرين تبين أن لا العصابية ($\beta = 0.09$ ، نانوثانية)، ولا رياضي الضميري ($\beta = -0.02$ ، نانوثانية)، تساهم بشكل كبير في الضعف المتصورة (انظر الجدول 21).

أخيراً، عندما تم إدخال العوامل الشخصية في وقت واحد في معادلة الانحدار، لا تتوقع الضعف المتصورة ($\beta = -0.04$ ، نانوثانية)، للنطاق، العصابية، ($\beta = 0.03$ ، نانوثانية)، للنطاق، حرف الضميرى، ($\beta = -0.10$ ، نانوثانية)، لاحترام الذات الكلي، ($\beta = -0.12$ ، نانوثانية)، للنطاق، للتفاؤل).

الفرضية 4. اثنان ويحلل، واحدة لكل عامل تحليل شخصية، وقد اخترنا أيضا مساهمة جميع المتغيرات النفسية على الضعف المتصورة عندما دخلوا في وقت واحد في معادلة الانحدار واحد. ويحلل ويرد في الجدول 22.

وكشف التحليل الأولي علاقات هامة بين الضعف المتصورة والتصورات من شدة الإصابة في الجودو ($\beta = 0.13, p > 0.05$)، وانتشار ($\beta = 0.20, p > 0.001$)، وإمكانية منع ($\beta = -0.28, p > 0.001$) وتجربة غير المباشرة للجودو الأذى ($\beta = 0.15, p > 0.05$)، تشابه مع لاعب الجودو من المرجح أن يكون أصيب ($\beta = 0.33, p > 0.001$)، وعموما احترام الذات الكلي ($\beta = -0.18, p > 0.001$).

. وبعد فحصها في خطوة أولى آثار الجنس ($\beta = -0.06$ ، نانوثانية)، السن ($\beta = 0.01$ ، نانوثانية)، والخبرة الرياضية ($\beta = -0.07$ ، نانوثانية)، عدد مرات من ممارسة ($\beta = 0.08$ ، نانوثانية)، الاصابات

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

السابقة ($\beta = 0.25, p > 0.01$) منذ زمن آخر إصابة ($\beta = -0.22, p > 0.01$). زيادة التباين وأوضح عندما يتم إدخال هذه العوامل النفس في معادلة الانحدار، بشكل ملحوظ من 31٪ ($P > 0.001$). وكانت المعادلة النهائية كبيرة، $F(15,195) = 14.51, P > 0.001, R^2 = 0.53$.

وكشف التحليل الثاني علاقات هامة بين الضعف المتصورة والتصورات من شدة الإصابة في الجودو ($\beta = 0.13, p > 0.05$)، وانتشار ($\beta = 0.20, p > 0.001$)، من اتقائها ($\beta = -0.26, p > 0.001$)، والخبرات غير المباشرة من ليالي لاعب الجودو الأذى ($\beta = 0.12, p > 0.05$)، تشابه مع لاعب الجودو من المرجح أن يكون أصيب ($\beta = 0.34, p > 0.001$) والتفاؤل ($\beta = -0.16, p > 0.01$)، وبعد

يمكن التحكم في خطوة أولى من آثار الجنس ($\beta = -0.06$ ، نانوثانية)، السن ($\beta = 0.01$ ، نانوثانية)، وتجربة الرياضية ($\beta = -0.07$ ، نانوثانية)، والوقت ممارسة ($\beta = 0.08$ ، نانوثانية)، الإصابات السابقة ($\beta = 0.25, p > 0.01$)، ومنذ وقت الإصابة الأخيرة ($\beta = -0.22, p > 0.01$) عندما تكون هذه العوامل النفسية دخلت في معادلة الانحدار، الفرق

الجدول 21. التنبؤ الضعف ينظر إليها من قبل الشخصية (ن = 211)

الضعف المتصور						المرحلة
مرحلة 2	مرحلة 2	مرحلة 2	مرحلة 2	مرحلة 1	مستقبل متغيرات الدراسة	
β	β	β	β	β	الجنس	01
-0.07	-0.08	-0.07	-0.08	-0.06	السن	
0.02	0.03	0.04	0.02	0.01	الخبرة	
-0.07	-0.07	-0.07	-0.05	-0.07	وقت التطبيق	
0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	إصابات السابقة	
0.25**	0.24**	0.23**	0.25**	0.25**	وقت مضى من آخر إصابة	
0.22**	-0.22**	0.24**	-0.23**	-0.22**	واحترام الذات الكلى	02
			-0.15*		التفاؤل	
		-0.16*			العصابية	
	0.09				الوعي	
-0.02					R^2	
0.22	0.23	0.25	0.24	0.22	ΔR^2	
0.00	0.01	0.03*	0.02*		F	
8.22***	8.52***	9.44***	9.24***	9.62***		

ملاحظة : معاملات الانحدار موحدة. $0.001 > P^{***}$ $0.01 > p^{**}$, $0.05 > P^*$

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الفرضية 4. اثنان ويحلل، واحدة لكل عامل تحليل شخصية، وقد اختبرنا أيضا مساهمة جميع المتغيرات النفسية على الضعف المتصورة عندما دخلوا في وقت واحد في معادلة الانحدار واحد. ويحلل ويرد في الجدول 22.

وكشف التحليل الأولي علاقات هامة بين الضعف المتصورة والتصورات من شدة الإصابة في الجودو ($\beta = 0.13, p > 0.05$)، وانتشار ($\beta = 0.20, p > 0.001$)، وإمكانية منع ($\beta = -0.28, p > 0.001$). وتجربة غير المباشرة للجودو الأذى ($\beta = 0.15, p > 0.05$)، تشابه مع لاعب الجودو من المرجح أن يكون أصيب ($\beta = 0.33, p > 0.001$)، وعموما احترام الذات الكلي ($\beta = -0.18, p > 0.001$).

. وبعد فحصها في خطوة أولى آثار الجنس ($\beta = -0.06$ ، نانوثانية)، السن ($\beta = 0.01$ ، نانوثانية)، والخبرة الرياضية ($\beta = -0.07$ ، نث)، عدد مرات من ممارسة ($\beta = 0.08$ ، نانوثانية)، الإصابات السابقة ($\beta = 0.25, p > 0.01$) منذ زمن آخر إصابة ($\beta = -0.22, p > 0.01$). زيادة التباين وأوضح عندما يتم إدخال هذه العوامل النفس في معادلة الانحدار، بشكل ملحوظ من 31٪ ($P > 0.001$). وكانت المعادلة النهائية كبيرة، $F(15,195) = 14.51, P > 0.001, R^2 = 0.53$.

وكشف التحليل الثاني علاقات هامة بين الضعف المتصورة والتصورات من شدة الإصابة في الجودو ($\beta = 0.13, p > 0.05$)، وانتشار ($\beta = 0.20, p > 0.001$)، من اتقائها ($\beta = -0.26, p > 0.001$)، والخبرات غير المباشرة من ليالي لاعب الجودو الأذى ($\beta = 0.12, p > 0.05$)، تشابه مع لاعب الجودو من المرجح أن يكون أصيب ($\beta = 0.34, p > 0.001$) والتفاؤل ($\beta = -0.16, p > 0.01$)، وبعد

يمكن التحكم في خطوة أولى من آثار الجنس ($\beta = -0.06$ ، نانوثانية)، السن ($\beta = 0.01$ ، نانوثانية)، وتجربة الرياضية ($\beta = -0.07$ ، نانوثانية)، والوقت ممارسة ($\beta = 0.08$ ، نانوثانية)، الإصابات السابقة ($\beta = 0.25, p > 0.01$)، ومنذ وقت الإصابة الأخيرة ($\beta = -0.22, p > 0.01$) عندما تكون هذه العوامل النفسية دخلت في معادلة الانحدار، الفرق

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الجدول 22. التنبؤ الضعف التي يدركها إدراك المخاطر من الإصابة المميزة من الاستدلال

المعرفية والشخصية. (ن = 211)

		الضعف المتصور		
		مرحلة 1	مرحلة 2	مرحلة 2
المرحلة	مستقبل متغيرات الدراسة	β	β	β
01	الجنس	-.06	-.11*	-.09
	السن	.01	.12	.13
	الخبرة	-.07	-.07	-.10
	وقت التطبيق	.08	-.01	-.01
	الإصابات السابقة	.25**	.17*	.16*
	وقت مضى على آخر إصابة	-.22**	-.14*	-.14*
02	ينظر بخطورة		.13*	.13*
	منع المتصورة		-.28***	-.26***
	ينظر للتحكم		.01	.01
	يعتبر انتشار		.20***	.20**
	التجربة الغير المباشرة الجودو		.15*	.12*
	التجربة الغير المباشرة وسائل		-.02	-.01
	التجربة الغير المباشرة البيئة		.05	.05
	تشابه		.03***	.34***
	احترام الذات الكلى		-.18***	
	التفاوت			-.16**
	R ²	.22	.53	.52
	ΔR^2		.31***	.30**
	F	9.62***	14.51***	14.26***

ملاحظة : معاملات الاحدار موحدة. $0.001 > P^{*}$ $0.01 > p^{**}$, $0.05 > P^*$**

الفصل التطبيقي

الدراسات الميدانية

الفرضية 5. وهناك مجموعة من التحليلات النهائية التي تهدف لاختبار آثار وساطة من العمليات المعرفية في العلاقة بين الشخصية والضعف المتصورة (بارون وكيبي، 1986). في كل تحليل، الآثار المحتملة للسن، الجنس، كانت تسيطر خبرة في الجودو، وممارسة عدد مرات والإصابات السابقة.

الخطوة 1: متغير يجب أن تتنبأ بالمتغير من بين العوامل الشخصية التي تمت دراستها، إلا أن احترام الذات الكلي ($\beta = .15, p < .05, F(7,203) = 9.22, p < .001$) التفاؤل -. وتوقع (-.16. $\beta = .01, p < .05, F(7,203) = 9.44, p < .001$) الضعف المتصورة.

الخطوة 2: متغير يجب أن توقع وسيط م. لا توجد علاقة كبيرة تربط بين التفاؤل مع تصورات من شدة التسليم إصابة ($\beta = .09$ ، نانوثانية) ، في ($\beta = .01$ ، نانوثانية)، وإمكانية منع ($\beta = .07$ ، نانوثانية) للتحكم به ($\beta = .07$ ، نانوثانية) لا توجد علاقة تربط بين التفاؤل أيضا، واستخدام الاستدلال المعرفي ($\beta = .04$ ، نانوثانية ، لخبرة الغير المباشرة للجودو ، ، ($\beta = .02$ ، نانوثانية للنطاق، لخبرة الغير المباشرة سائل الإعلام ($\beta = -.06$ ، نانوثانية لخبرة الغير المباشرة المحيط، للنطاق، للتشابه. لا توجد علاقة كبيرة تربط أخيرا احترام الذات الكلي والتصورات من شدة إصابة ($\beta = -.00$ ، نانوثانية)، وانتشار ($\beta = .08$ ، نانوثانية)، وإمكانية منع ($\beta = .06$ ، نانوثانية) للتحكم به ($\beta = -.01$ ، نانوثانية) فقط في العلاقة بين احترام الذات الكلي ومعرفة من المصابين الخبرة الغير المباشرة هو ($\beta = .14, p < .05$) الاستدلال المعرفي ، مع F معادلة الانحدار الكبير $F(7,203) = 8.89, p < .001$.

الخطوة 3: الوسيط يجب أن يتوقع المتغير هو على علم إصابة الجودو يرتبط إلى حد كبير في الضعف المتصورة ($\beta = .22, p < .05$). كانت معادلة الانحدار الكبير، $F(7,203) = 10.18, p < .001$.

الخطوة 4: تأثير عمليات الاندماج على وسيط B متغير لا ينبغي أن تختفي إذا كنا السيطرة إحصائيا تأثير متغير على المتغير ب هو على علم الجدوكا إصابة لا تزال متعلقة إلى حد كبير في الضعف المتصورة ($\beta = .26, p < .01$) عندما يتم التحكم في تأثير عالمي واحترام الذات ($\beta = -.18, p < .01$). معادلة الانحدار

المهم، $F(8,202) = 10.36, p < .001$.

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

الخطوة 5: تأثير متغير على ب متغير يجب أن يختفي (وساطة كاملة) أو تخفيضها بشكل ملحوظ (وساطة جزئي) بعد ضبط إحصائيا

تأثير وسيط على ب المتغير انخفاض تأثير واحترام الذات الكلى على الضعف المتصورة لم يكن كبيرا ($\beta = 0.188, p > 0.05$). ويبرز ذلك أي أثر وساطة.

4. مناقشة

الدراسة الخامسة والأخيرة من هذه الرسالة التي تهدف للتأكد من مدى من الحكم "لعبة رياضية لأنها تواجه احتمال إصابة يمكن أن تعتمد على عوامل والعمليات النفسية. من النتائج التي لوحظت في دراسات من مخاطر الإصابة بالأمراض، وهشاشة العظام، أي نوبة قلبية، سرطان الثدي (e.g. Gerend, Aiken, West, & Erchull, 2004)، والدراسة الأخيرة ركزت على العوامل النفسية المحتملة والعمليات المعرفية،

أي تصور لخطر الإصابة خصائص واستخدام الاستدلال المعرفي في تشكيل وتلوين الضعف المتصورة. ونظرت اللجنة أيضا الدور الذي تلعبه الشخصية، التي تسعى لتأكيد مساهمة العصائية والعالمية النفس من جهة واستكشاف مساهمة التفاؤل واجتهاد من غيرها من الألعاب الرياضية جزء.

4-1- التصورات من خطر الإصابة من الخصائص والضعف

يفترض وجود الفرضية الأولى أن تصورات خطر الإصابة الخصائص (أي تردد، وشدة، التحكم والقدرة على منعها)، تشكل إطارا لتحليل المحددات النفسية للضعف المتصورة. ويرتبط بشكل إيجابي على نتائج تؤكد هذه الفرضية في أن ينظر إلى الضعف التصورات لشدة الإصابة ومدى انتشاره ويؤثر سلبا على اتجاه لاعب الجيدو لمعرفة ما انفسهم

قادرة على الحد من خطر الإصابة. أخذت معا، هذه العوامل إلى زيادة كبيرة في نسبة التباين وأوضح ($\Delta R^2 = 0.16, p > 0.001$). عندما مساهمات الاصابات السابقة يؤدي، ويتم التحكم في الوقت منذ آخر إصابة. هذه النتيجة تتفق مع الدراسات التي أجريت في سياقات أخرى ومخاطر صحية أخرى، مثل تعاطي المخدرات، والنوبات القلبية، وحوادث السيارات والانتحار (Gerend, Aiken ,

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

West, & Erchull , 2004) ;(Le k & Bishop , 1995) ;(Weinstein , 1980, 1982, 1987).

2.4 الاستدلال المعرفي والضعف المتصورة

في ظل الافتراض الثاني، طلبت هذه الدراسة إلى أي مدى استخدام لاعب الجيدو من الاستدلال المعرفي عندما يسعون إلى التنبؤ من خطر تعرضهم للإصابة. فقد بينت النتائج أن أكثر من لاعب الجيدو سوف تلقي مماثلة لتلك التي من المحتمل أن يكون أصيب (ارشادي تشابه)، ويرون أنفسهم أكثر عرضة للإصابة كما

في المستقبل. هذه النتيجة تتفق مع النتائج التي توصلت إليها الدراسات التي أظهرت غلبة هذا الكشف عن مجريات الأمور عند تقييم مخاطر تعرض الشخص لمرض Aiken , West, & Erchull , (Rees et al , 1992) ;(McCoy et al , 1995) ;(Le k & Bishop , 2004) ;(Weinstein , 1980) ;(al. , 2001).

ومع ذلك، فإن هذه الدراسة لا تكشف عن تأثير تجربة بالانابه من الإصابة على الرغم من هذه التجارب قد يسهل تمثيل إصابة وفي المقابل تزيد من ضعف المتصورة. وقد أظهرت الدراسات في الواقع أن يرافق عادة معرفة من صديق مريض بواسطة زيادة التعرض لهذا المرض (Katapod i et al. , 2003) ;(Montgomery et al. , 2005). ومع ذلك، فإن هذه الدراسات لا تستطيع السيطرة على المساهمة المحتملة من التجارب الشخصية من المشاكل الصحية (Déroche et al. , 2007). إذا كانت هناك اتصالات

في الواقع بين الضعف المتصورة وغير المباشرة عن وقوع إصابات التجربة (انظر ارتباط المصروفة)، ويبدو انهم لتكون أقل حساسا مما كان تجربة شخصية من الإصابات السابقة في تقييم المخاطر من قبل قابل للتعديل من إصابة في المستقبل.

3.4 الشخصية والضعف المتصورة:

وهناك مجموعة من الفرضيات تعطى الفرصة للتعرف على العوامل الشخصية المسؤولة عن تشكيل والتلوين الضعف المتصورة. نتائج تسليط الضوء على مساهمة سلبية من التفاوض والذاتي يقدر بالشامل

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

على تلوين الضعف المتصورة. هذه النتائج تدعم بالتالي فكرة أن الشخص الذي يميل إلى مضاعفة توقعات لنتائج إيجابية في مسار حياته (التفاؤل)، أو الانخراط في التشوهات المعرفية لرفض المعلومات التي لا تتسجم مع لها وينظر حتى (تقدير الذات)، وعموما أقل (al., 1999) (McGregor et al., 2004 ; Wardle,1995).

ومع ذلك، لدينا إبراز النتائج، والمدهش، أن أيا من العصابية ولا اجتهاد للفرد لها أهمية قصوى في تشكيل وتلوين من قابلية ينظر إلى الإصابة. وكانت دراسة سابقة في هذا العمل الدكتوراه، والتي أجريت مع عدد سكانها الركبي (rugby) كما هو موضح لكن ذلك كان مرتبطا العصابية إلى قابلية ينظر إلى إصابة (Déroche et al., 2007). هذا عدم وجود تناسق في نتائجنا تشير إلى أن طبيعة النشاط قد تؤثر على الطريقة التي ينظرون الممارسين من خطر تعرضهم للإصابة. في بعض الحالات، التي يمكن من خلالها وجود تهديد مادي يكون في المستوى المقبول (كما هو الحال في لعبة الركبي)، ينظر إلى قابلية الإصابة

يبدو أن تضرب بجذورها في العوامل مستقر جدا (الشخصية)، وغير رغبة في تتطور مع مرور الوقت، حتى عندما تكون تجربة الإصابة. في الرياضات الأخرى، مثل الجودو، و الإصابة واجهت المزيد من الاتفاقيات واللوائح. في هذه الأنشطة، قد ينظر إلى قابلية تعتمد أكثر على العوامل المرتبطة الحالات أو الظروف، وبين لهم خبرة الإصابة أو العمليات المعرفية مثل التصورات من خصائص خطر الإصابة.

4.4 النموذج التكاملي وخلفية متعددة العوامل من الضعف المتصور من إصابة؟

وكانت مجموعة من الفرضيات النهائي فرصة لاختبار مدى مساهمة في وقت واحد من كل هذه العوامل النفسية في الضعف المتصورة. في هذا المنظور، كان يفترض أن (1) مساهمة مباشرة من كل هذه العوامل النفسية، (2) في دور وساطة من الاستدلال المعرفي و تصورات من الخصائص من خطر الإصابة في العلاقة المتبادلة بين الشخصية الضعف المتصور إلى. نتائجنا تسليط الضوء على تنوع العوامل النفسية للضعف المتصورة. عندما يتم إدخال جميع العوامل النفسية في وقت واحد في معادلة الانحدار، وترتبط بشكل إيجابي الضعف المتصور إلى التصورات من شدة الإصابة ومدى انتشاره، واستخدام الاستدلال المعرفي. وعلاوة على ذلك، فإنه يؤثر سلبا على النظرة إلى إمكانية منع الإصابة

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

احترام الذات الكلى أو التفاؤل. وبالتالي، يمكن هذه النتائج يمكن ان تكون نموذجا سياقاتها ومتكاملة فيها تمثيل للخصائص من خطر الإصابة على يد الاستدلال المعرفي من ناحية أخرى، والشخصية، وأخيراً، فإن

واضاف "إذا ويعزى المسؤولية عن التنبؤ ليصب بأذى، وأنا هذا يفقد القتال" (المادة 29، تي التنظيمية الاتحاد الدولي للجودو والعشرون، 1994).

المسؤول العام لتشكيل وتلوين الضعف المتصورة عندما يتم التحكم مساهمة من تجربة الاصابات السابقة من المراقبة .

ومع ذلك، نتائجنا لا تظهر ظاهرة التفاعل بين كل هذه العوامل النفسية. مشيراً إلى دراسة حديثة (e.g. Gerend, Aiken, & West, 2004)، الجديدة توقعنا، لكن ذلك، على سبيل المثال، والرياضيين متفائل (الشخصية) يشعر تشبه إلى حد ما تلك التي من المحتمل أن عقد إصابة (ارشادي)، وبالتالي، ترى نفسها أقل عرضة بدنياً. ومع ذلك، فقد تم تسليط الضوء أي أثر وساطة من العمليات المعرفية في تحليلاتنا. العمليات الأخرى ويبدو أن المسؤولين عن مساهمة شخصية في تشكيل وتلوين الضعف المتصورة. ويمكن إيلاء اهتمام خاص في المستقبل لتأثير العوامل والعمليات النفسية، بما في ذلك احتمال تفسيرية وقد تجلى مؤخراً (e.g. Hanoach, 2002 ; Loewenstein , Weber, Hsee, & Welch, 2001).

5.4 حدود الدراسة والمنظورات البحثية

تقدم هذه الدراسة عددا من القيود التي ينبغي التذكير. أولاً، لا يمكن للتقييم مقطعية لمتغيرات الدراسة لم تخلص إلى نتيجة حاسمة بشأن طبيعة التنبؤية من العوامل النفسية في الضعف المتصورة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تقييم عوامل نفسية باستخدام عنصر واحد. هذه المنهجية هي شائعة في الدراسات التي سعت لتحديد حساسية سابقة (Gerend, , Erchull, 2004) ويتوافق مع الضرورات الزمنية المتصلة الضرب من المتغيرات التي شملتها الدراسة. ومع ذلك، يمكن استخدام عدة بنود زيادة الخصائص السيكمترية لهذه المقاييس

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

(Nunnally, 1978)، وبالتالي ضمان تحقيق المزيد من المساهمة بصورة نهائية من العوامل التي تحدد.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الدراسة تركز فقط على العوامل والعمليات المعرفية في العمل عندما يكون الشخص لتحقيق الحكم على احتمال التعرض للتصدى له بسبب الإصابة. ومع ذلك فقد أكد بعض الكتاب أن الناس غالبا ما تعتمد على مشاعرهم لتسهيل الحكم (Hanoch, 2002) ; (Loewenstein et al., 2001). في الآونة الأخيرة، واقترح الباحثون وجود الاستدلال العاطفي في أعمال الحكم (Slovic, Finucane , Peters, & MacGregor , 2002). وستكون هذه وخصوصا في العمل عندما يكون الشخص (أكثر أو أقل بقوة) المشاعر الايجابية أو في ذلك الوقت للحكم نفسه، والثاني) عندما تواجه خطر أو تمثل عقليا. هذه العملية العاطفية، ومع ذلك، قد تم استكشافه نادرا في علم النفس الصحة الفنزويلية ثم يبدو شخص مؤثر عندما يحاولون التنبؤ بمخاطر الإصابة بالمرض (Loewenstein et al , 2001). وينبغي أن الدراسات المستقبلية لذلك تتضمن بالضرورة هذه العوامل والعمليات الوجدانية وذلك بهدف تحديد مساهمة العوامل النفسية في تشكيل وتلوين الضعف المتصورة.

على الرغم من هذه القيود، فإن نتائج هذه الدراسة هي خطوة إلى الأمام في فهم العمليات التي تحكم تشكيل والتلوين الضعف المتصورة. هذا الفهم المهم بصفة خاصة أن يلاحظ دراسات وجود علاقة مباشرة بين الضعف المتصورة والسلوكيات و الحكمة من جهة (الدراسات 2 و 3 من هذا العمل الدكتوراه)، وقوع اصابات أخرى (Kontos , 2004). وستكون معرفة هذه العوامل النفسية

حتى تكون قادرة في النهاية إلى التمييز بين الرياضيين بداهة عرضة لأولئك الذين ما زالوا صحي. وهذا يمكن معرفة مسؤولة أيضا عن البناء

طرق جديدة للتدخل من شأنه أن يسعى إلى منع الإصابة. قد تتضمن برامج الوقاية من العمل على تمثيلات مختلفة من شخص عن خطر (الإصابة)، وشدة عواقبه، مدى انتشاره و إمكانية منع ذلك. ويمكن أن تساعد أيضا على شخص لمقارنة أنفسهم إلى الأشخاص المعرضين للخطر جوان تي في العتلات التي يمكن أن توفر الاستدلال النفسية (ممثلون عن مجريات الأمور). أنا ن قصير، ومنع /

الفصل التطبيقي الدراسات الميدانية

خطر السلوك والصورة أو تعزيز السلوك من الحماية ضد الإصابات من خلال معرفة أفضل، والأصل، والعوامل المسببة للأمراض والعمليات التي تحكم مظهرها.

الختام

خاتمة

ممارسة النشاط البدني و الرياضي هو الوقت المثالي للتعرف على العوامل المسؤولة عن صيانة أو، على العكس، في حالة صحية سيئة. على الرغم من أنه من المفيدة لمنع أمراض مثل السكري والسمنة وأمراض القلب والشرابين (Friedenreich & ; (e.g. Avenell et al., 2004) ; (McFall , 2005) ; (Shephard & Balady, 1999) ; (Orenstein, 2002) ، وممارسة النشاط البدني كل شخص تعرضوا لحوادث وآثارها الضارة. بحيث انه أدوات في خدمة تعزيز الصحة، وسعى هذا العمل الدكتوراه لتحديد العوامل والعمليات التي تحدد وقوع اصابات. وقد أظهرت بعض الدراسات أن هذه الحالة غالبا ما يعتمد على الالتزام المتعمد لشخص في السلوكيات التي يمكن أن تضعف أو، على العكس، وحماية (; (e.g. Benson et al., 1999) ; (Marshall et al., 2005). ويمكن المعرفة الاجتماعية نماذج من مصلحة "الصحة في محددات هذه السلوكيات تشكل الإطار الأصلي التحليلية والعوامل ذات الصلة من الضعف والحماية ضد الخطر الإصابة. قليلة هي الدراسات التي تعتبر هذا الاحتمال، ولكن (e.g Kontos 2004) (Râsânen, 2004) هذا العمل الدكتوراه يهدف الى اختبار صحة هذه النماذج وفقا لممارسات دان الجسدية و الرياضية، واثراها لها لتحديد العوامل المسببة للأمراض والعمليات الجديدة .

لقد تم بناء برنامج أبحاثا إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية هي: (1) ما هي السلوكيات المرتبطة بوقوع اصابات خلال ممارسة النشاط البدني أو الرياضي؟ (2) ما هي العوامل التي تحدد

اعتماد السلوكيات الصحية في النشاط البدني والرياضي؟ (3) ما هي السوابق من الضعف المتصور للإصابة؟ في إشارة إلى نتائج هذه الدراسات خلال هذا العمل الدكتوراه، ويمكن أن نقترح الاستنتاجات التالية.

ما السلوكيات مع وقوع اصابات خلال ممارسة النشاط البدني أو الرياضي؟

بما يتفق مع النماذج المعرفة الاجتماعية للصحة، فإن نتائج الدراسة تظهر لنا أن وقوع أول إصابة يعتمد على سلوك الإنسان عندما يتبنى تمرين بدني و / أو رياضي. وأكثر من اي رياضي يحافظ على استثماره المادي يواجه تجربة الألم، وأكثر فإنه يفقد في المدى القصير (شهر) من أيام التدريب بسبب واحد أو أكثر وقوع اصابات. هذا السلوك هو أكثر من الممرضة للرياضي وتشعر بألم شديد. معظم

العمل قد كشفت سابقا عن وجود السلوكيات ل ارتداء المعدات الواقية لتحمي الاشخاص من مغبة وقوع حادث اصابة ، أي السلوكيات الصحية الوقائية (Vickers et al., 1990). هذه أول دراسة تظهر أن بعض السلوكيات الدكتوراه ومن المحتمل أيضا أن تؤثر بشكل مباشر على مخاطر الحوادث والإصابات في رياضة. هذا العمل المهم خصوصا ان هناك أدب أن ترى العلاقة بين اعتماد طوعي للسلوك غير مقبول اجتماعيا وعواقبها على صحة الأفراد (على سبيل المثال، والقيادة من دون رخصة، والقيادة بسرعة والشرب والقيادة، لا تضع حزام الأمان)، عدد قليل من الدراسات تركز على الجانب الآخر لتحمل المخاطر مقبولة (Turner, McClure , 2004)، كما قد يكون الميل للرياضيين للحفاظ على استثماراتهم الرياضية

على الرغم من خبرة من ألم شديد في بعض الأحيان (Nixon, 1993). دراسة المواقف من ألم يتشكل في النهاية لتعدد وتكامل عملية الأمراض، والإجهاد، من جهة، والمشاركة في السلوكيات الصحية من جهة أخرى. صيانة متعمد من استثماراتها على الرغم من تجربة الألم الجسدي، يمكن أن يرتبط بشكل فعال إلى وقوع إصابات خلال اضطرابات الانتباه والألم الجسدي المسؤول (Eccleston & Crombez , 1999) . هذه الاضطرابات هي سمة من الآثار الضارة للإجهاد (Andersen & Landers , 2005) (Williams, 1999) ، وبالتالي فهي مركزية لنموذج الإجهاد الإصابة (Williams & Andersen , 1998). على الرغم من أن هذه أول دراسة لا يمكن تأكيد دور وساطة من اضطرابات الانتباه في العلاقة بين المواقف من الألم ووقوع إصابات، وأنه يساعد على النظر في الفرضيات جديدة للبحث، في حين أنه يفتح فرص جديدة للتدخلات التي تركز بشكل خاص على تثقيف الرياضيين حول مسببات الفعلية المرضية للألم، وإشارة إنذار حقيقي يطلب فيها تعديل السلوك الجسدي في تقدم.

ما هي العوامل التي تحدد اعتماد السلوك الصحي في النشاط البدني والرياضي؟

وفقا للمقترحات من النماذج المعرفة الاجتماعية من الصحة، ونتائج الدراسات 2 و 3 تبين أن التصورات والمعتقدات والتصورات المسبقة لتخصيص تحديد السلوكيات المرتبطة ووقوع اصابات.

تصورات التعرض لشخص ما الى مشكلة صحية (على سبيل المثال إصابة) وحدة من هذه المشكلة هي المكونات الأساسية في العديد من النماذج المعرفة الاجتماعية و الصحية، على سبيل المثال نموذج الإيمان من الصحة، من الحافز حماية (Weinstein, 2000); (Conner & Norman , 2005).

وقد سعى العديد من الدراسات لتحديد كيف يمكن لذلك الضعف وحدة التصور هي خطوة أولى في تبني سلوكيات سانت (Aiken et al., 2001). لاحظوا أن الشخص الذي يمثل كا عرضة للإصابة بسرطان أكثر سهولة لمشاركة في إجراءات الفحص الطبي (cf. Katapod i et al., 2004) (McCaul et al., 1996,) وجدت دراسة أخرى أن معظم المراهقين (أي 81.3%) مع تشخيص الكلاميديا أو السيلان خلال فترة سنة واحدة في البداية تصور نفسها على أنها ليس من المرجح أن تتكلمش الأمراض المنقولة جنسي (al. 2003) وقد أظهرت بعض الدراسات أيضا أن خطورة المتصور تحدد نوايا الشخص بخصوص حياته الجنسية، استخدام الواقي الذكري أو الامتناع عن ممارسة الجنس (Petosa & Jackson, 1991) (al., 2007) . في إشارة إلى نتائج هذه الدراسات والنماذج التي الدعم (MCS على سبيل المثال، TMP)، كنا نتوقع أن ينظر إلى الضعف وشدة المتصورة تشكل عنصرا حاسما في اعتماد السلوكيات الصحية في ممارسة النشاط البدني أو الرياضي. وأكدت نتائج الدراسات 2 و 3 دراسة هذا الاحتمال. الدراسة 2 تبين في الواقع أن ينظر إليها أحد الرياضيين أقل عرضة للإصابة و / أو الإصابة اعتبار ذلك الحدث خطير، والمزيد من أنه يميل إلى التصرف في هذه الرياضة الخطرة، أي للحفاظ على مبنائها البدني والاستثمار، وعلى الرغم من تجربة الألم. الدراسة 3 يدل على أن الضعف و الخطر المتصور يرتبط إلى قرار ارتداء معدات الحماية (أي خوذة، ومنصات الكوع، و اقى المعصم والركبة)، أو لاستخدامها الفعلي في الركوب.

إذا تصور خطر (على سبيل المثال، ينظر إلى شدة والضعف) كما يبدو شرطا أساسيا لإشراك شخص في سلوكيات الوقائية أو السلوك المتهور، فإنه ومع ذلك يلخص كل عناصر النماذج المعرفة الاجتماعية الصحية وفقا لهذه النماذج و السلوكيات.

تعتمد أيضا على المواقف تجاه السلوك في مواجهة الصحة المقترحة أو التأثيرات الاجتماعية التي يكون الشخص هو موضوع (Ziani, 2002). وقد حددت الدراسة 3 من هذا العمل الدكتوراه كيف النظرية السلوكية المخططة (TCP, Ajzen, 1991)، في هذه العوامل المركزية، كا النموذج

التنبؤي من سلوك يتعلق بوقوع إصابات . هذه الدراسة أثبتت أن ارتداء معدات الوقاية مثل (1) تدبيراً فعالاً للحيلولة دون وقوع إصابات في التزلج على الأسطوانة، (2) سلوك موصى بها من قبل حاشيته (الأسرة والأقران) ، لديها أعلى نية لتقديم مثل هذه المعدات أو يستخدم في الواقع. فهو يؤكد على نتائج دراسة (Lajunen & Rasanen, 2004) التي نفذت في تمرين آخر، أي سباق الدراجات، و آخر ممارسة وضع أكثر تقييداً، أي السياق المدرسي.

هذه الدراسة الثالثة هي في النهاية الأولى للتدليل على التكامل بين الضعف المتصورة ومكونات النظرية السلوك المخطط للتنبؤ نية لشخص من أجل حماية أنفسهم، بينما تشارك في أي نشاط بدني المسببة للأمراض يحتمل أن تكون (أي التزلج) . لم يتم تحديد هذا التكامل على اعتماد فعال من السلوكيات الصحية. 2 إذا أثبتت الدراسة وجود علاقة بين التعرض للمخاطر وجدية والتزام ينظر لهذه الرياضة في السلوك الخطر أو المواقف للرياضي أو معايير ذاتية له وجهاً لوجه مع سلوك وكانت السيطرة عليها. ويمكن لنتائج الدراسة (3) تنظر على أن العلاقة كبيرة بين شدة الأولي والضعف الواضح واستخدام المعدات الواقية في الأسطوانة يختفي عندما يتم إدخال هذه المعتقدات السلوكية في التحليل. وهذا يتفق مع مقترحات من بعض النماذج المعرفة الاجتماعية من الصحة درست قليلاً (نموذج Transtheoretical) من التغيير، 1983؛ لديه بورشسكا وآخرون، 1992؛ نهج عمل العملية على الصحة. ، عملية العمل الصحي النهج.

(Schwarzer, 1992) ونموذج عملية اتخاذ احتياطات، نموذج التحوط عملية التنبؤي: (Weinstein & Sandman, 1992) ; (Weinstein, 1988). وفقاً لهذه النماذج، واعتماد السلوك الصحي ينطوي على تمرير من خلال سلسلة من مراحل متميزة زمنياً ونوعياً. يتم التمييز بين الإدراك التي تشجع على الانتقال من مرحلة إلى أخرى وفقاً وبعبارة أخرى العوامل المؤثرة في الانتقال بين المراحل المختلفة لا تحدد بالضرورة إلى مرحلة التنفيذ النهائي السلوك (Sandman & Weinstein, 1993) . نتائج الدراسات 3 تشير إلى أن تصور المخاطر ليست سوى الخطوة الأولى في اعتماد السلوكيات الصحية، بقدر ما يحدد فقط من أجل المتزلجين على استخدام المعدات الواقية. المرحلة النهائية من تنفيذ السلوك، أي الاستخدام الفعلي لهذه المعدات، يعتمد بشكل حاسم على المعتقدات السلوكية، أي سلوك الأفراد ومعاييرها الذاتية. هذه النتيجة تؤكد أن التصميم النهائي من ليالي برنامج الوقاية يجب أن لا تعتمد فقط على معرفة عوامل الخطر وتقييم موضوعي يترتب على

ذلك من الضعف الخاصة بها إلى المشاكل الصحية المذكورة. لكثرة المعتقدات السلوكية في اعتماد سلوك صحي فعال يعكس الحاجة لتوعية الجميع على فعالية الاستجابات السلوكية تكييفها لتوليد مواقف إيجابية بشأن ما ورد أعلاه. إلى حد أن المعايير الذاتية هي أيضا حاسمة في تبني السلوك الصحي، يبدو من الضروري إشراك بيئة الشخص في مثل هذه البرامج.

في الرغبة في توضيح طبيعة النماذج التكاملية المعرفية الاجتماعية للصحة (Ajzen, 1991 ; Baranowski , 2005)، وبالتالي بتعدد أبعاد الضعف والحماية من خطر الإصابة، ويبدو أنه من المناسب أن تركز أخيرا ومكملات من المحددات شخصية ه بالاتصالات

السلوكيات الصحية التي اعتمدت خلال ممارسة النشاط البدني أو الرياضي. العديد من الدراسات قد سلطت الضوء على مساهمة من العوامل الشخصية في اعتماد سلوكيات صحية عديدة مثل الشرب أو التدخين بشكل مفرط، على ممارسة الجنس بدون وقاية (Louka s et Canals et al., 1997 ; al., 1999 ; Trobst et al., 2002 ; al., 2000). ومع ذلك، فقد دمج عدد قليل من الدراسات هذه العوامل إلى نماذج المعرفة الاجتماعية الأصلي لزيادة قدرتها التفسيرية (e.g. Conner & Abraham , 2001). واقترح أن أيا من هذه الدراسات التي تركز على السياق العملي للدراسة البدنية و / أو الرياضية، ولذلك، مسارات الطاقة 2 استكشاف العلاقات بين شخصية واعتماد أو التي تنوي اعتماد السلوكيات الصحية: (1) ومساهمة مباشرة من شخصية إلى المكونات بالإضافة إلى نموذج المعرفة الاجتماعية، (2)) ومساهمة غير مباشرة من خلال شخصية مكونات نموذج المعرفة الاجتماعية. هذه الدراسة أظهرت أن شخصية يحدد نية لاعتماد سلوك فقط من خلال المعتقدات السلوكية، أي أن المواقف من هذا الشخص. وتوضح هذه الدراسة أن العوامل الشخصية لذلك من المرجح أن تعزز المكونة للنموذج الاجتماعي والمعرفي الأصلي من المحددات البعيدة من سلوك الصحة.

وخلاصة القول، الدراسات 2 و 3 دراسة النماذج تؤكد إمكانية المعرفة الاجتماعية والتكامل بين مكوناتها، ومساهمة شخصية لشرح ما كان الشخص يمارس الرياضة في خطر السلوك (دراسة 2) أو تشجعها على (يقرر) تبني السلوكيات الصحية الوقائية في حين تشارك في أي نشاط بدني (دراسة 3). هذه الدراسات تنظر لذلك بديلا للنموذج الإجهاد الإصابة (Williams & Andersen, 1998) وذلك بهدف شرح لماذا قد يكون أصيب شخص في حين المشاركة في أي نشاط بدني أو رياضي

توصيات واقتراحات:

ما هي السوابق من الضعف المتصور لإصابة؟

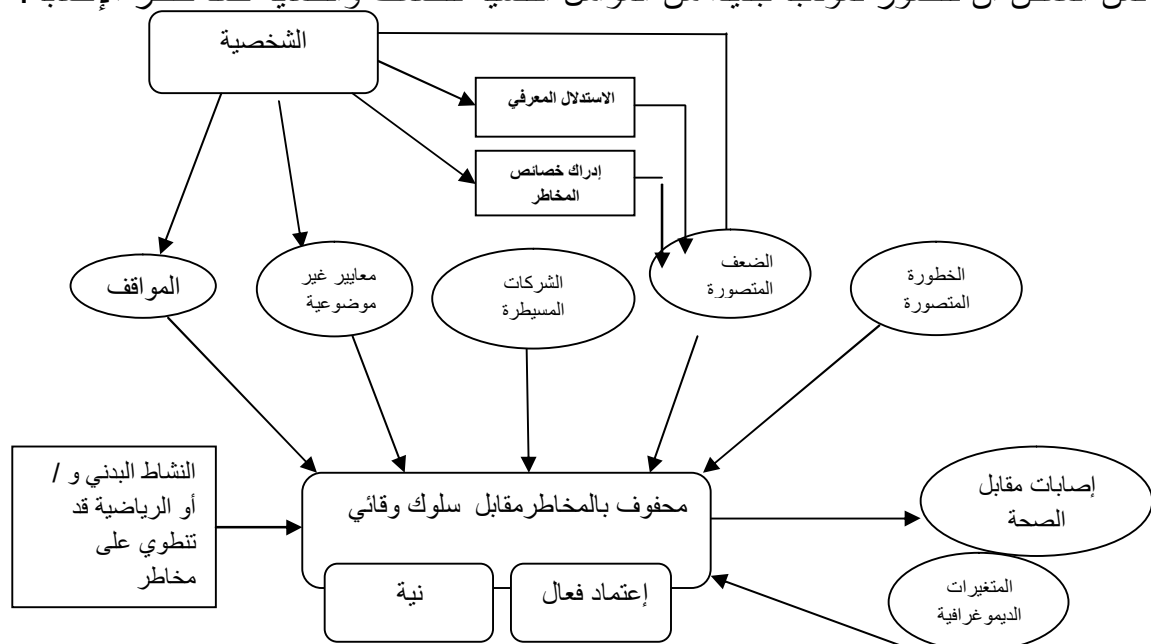
إلى حد أن ينظر إلى الضعف هو 1) عنصرا محوريا من النماذج المعرفة الاجتماعية للصحة، على سبيل المثال نموذج من الإيمان في نظرية الحافز الصحة، لحماية النماذج الإضافية التي لم تكن مقررًا في الأصل كأحد محددات السلوكيات الصحية، على سبيل المثال نظرية السلوك الاجتماعي . (Abraham et al., 1999) ، وتحديد تاريخ من الضعف النفسي يمكن أن ينظر إليها على حد سواء تعزيز هذه النماذج والسماح لتعميق معرفة نقاط الضعف والحماية ضد خطر الإصابة. ولذلك، فقد اقترحت الدراسات 4 و 5 لتحديد كيفية قياس شخصية يمكن أن يكون محتمل التفسيرية في التدريب والتلويح لضعف ينظر أبعد من مساهمة الخبرات الإصابة في الماضي. وقد أجريت هذه الدراسة 4 خصوصية يجري في الرياضة (مثل لعبة الركبي) يطلب فيها من الممارسين للتغاضي عن الإصابات وللنظر فيها باعتبارها المعيار المقبول ه (Flint, 1998). فقد بينت النتائج أن في مثل هذا السياق، فإن جذور الضعف الملحوظ في العوامل إصابة مستقرة جدا، أي العصابية (Costa & McCrae, 1992)، وقالت انها غير رغبة في تغيير مع مرور الوقت، حتى أثناء التجربة من الإصابة. للاهتمام بوجه خاص، العصابية يظهر في الزر كعامل وقائي بقدر ما هو حاسم للإنسان أن يتصور وجود خطر عندما ينخرط في حالات تهديد. ومع ذلك، منذ الأدب في كثير من الأحيان قد سلط الضوء على الصلة بين العصابية والسلوك الاجتماعي للخطر واستهلاك الكحول، على سبيل المثال (Loukas, 2000)، (al., 2000) وسيكون من المثير للاهتمام أن السؤال إلى أي مدى ويرافق هذا العامل الشخصية السلوكيات غير القادرة على التأقلم المفارقة للتعامل مع المخاطر المتوقعة بل هو أيضا من المستغرب أن نتائج الدراسة لم تظهر 5

وجود علاقة كبيرة بين العصابية والضعف المتصور للرياضيين ممارسة الجودو. هذا التناقض في النتائج تشير إلى أن طبيعة النشاط قد تؤثر على الطريقة الممارسين من خطر تعرضهم للإصابة. أنشطة ، والجودو، والتي يتم استبعادها من يهدد سلامة البناء البدني من الخصوم، قد ينظر إلى قابلية تعتمد أكثر على العوامل المرتبطة بالحالات أو الظروف، والمركز الأول في مجال البحث من تجربة الإصابات في الماضي.

في حين أن العديد من الدراسات وقد لاحظ أيضا أن تشكيل وتكوين الضعف المتصور يعتمد على عوامل والعمليات المعرفية، أي تصور خصائص المخاطر واستخدام ارشادي ثانية (Gerend, (Ree s et al., 2001) ; (Aiken, West, & Erchull, 200 4)، وتعتبر تكاملها واحدة مع العوامل الشخصية (Gerend, Aiken, & West, 2004). وأكدت الدراسة (5) من هذا العمل الدكتوراه وجود نموذج متكامل ومحددات سياقاتها الضعف المتصورة، وتقاس التصورات الخصائص من خطر الإصابة، والاستدلال المعرفي وشخصية تشارك تدريب وتكوين مفهوم الضعف عندما يتم التحكم مساهمة من تجربة الماضي من الإصابة. التأكيد على التعددية الضعف تاريخ المتصورة، فإن هذه الدراسة تلقي الضوء على نقاط الضعف متعددة الأبعاد والحماية ضد خطر الإصابة. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة لا تثبت دور وساطة لإدراك خصائص مخاطر الاستدلال المعرفي في العلاقة بين الشخصية والضعف المتصورة وهذه النتيجة تشير إلى أن هذه العلاقة قد تعتمد على غيرها من العوامل دراسة الصورة في قلب هذا العمل الدكتوراه، وبينهم العوامل العاطفية التي تنشأ مساهمة (e.g. Loewenstein et al., 2001)

ووضع نماذج جديدة من نقاط الضعف والحماية من خطر الإصابة؟

من النماذج المعرفة الاجتماعية من الصحة، وبالإشارة إلى نتائج الدراسات في هذا العمل الدكتوراه، فمن الممكن أن نتصور نموذجا جديدا من العوامل النفسية للضعف والحماية ضد خطر الإصابة.



الرقم 10. نموذج من عوامل الضعف والحماية ضد خطر الإصابة

في النموذج المقترح، وجود حالة خطر يحتمل أن يكون هو المحفز على الممرض. هذا لا يقتصر فقط على ممارسات التجنيد الطوعي في الرياضة البدنية و / أو خطرة بشكل موضوعي (مثل التسلق، والركبي، والأسطوانة). يبدو أن العودة إلى ممارسة تنافسية بسبب الإصابة هو أيضا عامل خطر كما ان ممارسة النشاط البدني المؤلم. في هذه الحالات و وقوع إصابات تعتمد على المشاركة المتعمد لشخص في السلوكيات الآمنة أو على العكس، في السلوكيات الخطرة (دراسة 1).

اعتماد و(أو تنوي اعتماد) تحدد السلوكيات الصحية الوقائية أو خطر من تأثير إضافية من العوامل النفسية: تصور الشخص من خطر الإصابة، أي ضعف وشدة من ينظر إليها يد واحدة (دراسة 2)، والمعتقدات المتصلة السلوكيات الصحية في الاعتبار، أي المواقف والمعايير الموضوعية، من ناحية أخرى (دراسة 3). شخصية أمر حاسم أيضا لأنه من شأنه أن يساعد على التأثير في كل من المواقف للشخص (دراسة 3)، وضعفها ينظر (الدراسات 4 و 5). وأخيرا، فإن النظرة إلى خطر الإصابة الخصائص واستخدام الاستدلال المعرفي وتحديد مواطن الضعف المتصورة بالتزامن مع هذه العوامل الشخصية (دراسة 5).

بنيت بطريقة استكشافية، وهذا النموذج يستحق دراسة استطلاعية والإحصائية المناسبة يحلل مثل تحليل المسار باستخدام هيكلية المعادلة.

القيود المفروضة على هذا العمل الدكتوراه والمنظورات البحثية كل هذا العمل الدكتوراه لديها عدد من القيود التي ينبغي التذكير أنا.

من ناحية المنهجية، وفعلنا الدراسة فقط المحتملين للدفاع عن أطروحة لدينا. ومع ذلك، هذه المنهجية يبدو أكثر ملاءمة لتسليط الضوء على مساهمة العوامل النفسية في تبني السلوكيات الصحية وحوادث إصابات. يمكن ان يستفيد منها خصوصا من منهجية التحقق من مدى العوامل

استخدام النفسية للتنبؤ القصير والطويل الأجل حماية المعدات. كان من الممكن أن يقدم تصميم المحتملين في الدراسة 4، بما في ذلك تدابير عدة من الضعف المتصور تدار على حد سواء قبل وبعد تجربة (جديد) الإصابات، وأكثر من حساب التأثير الدقيق لهذه الإصابات على التصور الخطر، والتغيرات وخاصة المرتبطة حدوثها.

هذا العمل الدكتوراه يقدم أيضا نقاط الضعف المنهجية فيما يتعلق بتقييم العوامل التي تمت دراستها، والإصابات الرياضية الأولى. عدد الألياف العضلية المصاب وربما كان المعيار الأكثر موثوقية للكشف عن وجود إصابات وتحقيقا لهذه الغاية، واستخدام استكشافية من الأجهزة الطبية (مثل التصوير بالرنين المغناطيسي)، ويبدو لظهور أكثر ملاءمة. ومع ذلك، كان القليل من البحث قادرا على استخدام هذه الأجهزة للتمييز بين الرياضيين المصابين والرياضيين بالصحة الجيدة ، وخصوصا بالنظر إلى الصعوبات المادية والمالية المتعلقة بالحصول على هذه المعلومات (Flint, 1998) ، فإننا نحذ استخدام معيار آخر، أي في الوقت الضائع في تدريب / المتنافسة بسبب الإصابة (ITL)، وانخفاض مستوى القائم على صدمة حقيقية من الأعراض، وهذا دير لعواقب الصدمات إذا وهي تساهم في استكمال التعريف الطبي للإصابات، تعريف التشريحية (بالنظر إلى الجسم والإصابة الشخصية) إلى تعريف أكثر وظيفية مرتبطة بقوة لمفهوم عدم اللياقة، وهذا يمكن أن يكون المعيار ولكن إشكالية لتقييم وقوع إصابات. طبيعة المنهكة من إصابة يعتمد على خصوصية الرياضة - رياضة مع كسر في الذراع يمكن أن تلعب كرة القدم وليس كرة اليد - والعوامل الفردية مثل التسامح الألم (1998 Suan,). ومن الشائع بالنسبة للرياضيين المصابين، بمعنى للمصطلح التشريحي ، الاستمرار في ممارسة نشاطهم البدني، وبالتالي فهي لا تعتبر في تحليلاتنا باصابة في المستقبل، يبدو من الضروري النظر في البروتوكولات .

سوف يكون هناك تعاون قوي بين الباحث والجهات الفاعلة الرياضية من جهة، والعاملين في مجال الصحة المسؤولة عن هذه الجهات الفاعلة الأخرى.

أخيرا، وغالبا ما تستخدم وحدات واحد لتقييم تصورات المشاركين. هذه المنهجية يبدو بوضوح أكثر ملائمة لتحقيق تسليم المكانية، مكان التدريب، ومضاعفة المتغيرات التي شملتها الدراسة. استخدام العناصر البسيطة هي أيضا شائعة بشكل متزايد (Pomero y et al., 2001) ; (Kirsch et al., 2001) (Watkin s et al., 2001) ; (al., 2001)، ودافعت عن (Gardner et al., 1998) (Wanous et al., 1997) ; (Robin s et al , 2001) ; (Nagy , 2002) ; في البحوث النفسية. ومع ذلك، يمكن استخدام عدة بنود لتقييم كل عامل في المستقبل ضمان النتائج التي حققناها من خلال زيادة الخصائص السيكمترية من كل مقياس (Nunnally, 1978).

على المستوى المعرفي من جهة أخرى، هذه الدرجة لا يهتم إلا في العمليات المعرفية والعوامل التي يمكن أن تكون حاسمة في عملية المسببة للأمراض. حتى الآن ثبت أن المخاطرة العمل كوسيلة من وسائل تنظيم عاطفي، بقدر ما أنهم متورطون في أعمال الصيانة، وبدء تعديل الاستجابات العاطفية، سواء كانت إيجابية أو سلبية. وقد وجدت بعض العوامل في الواقع وجود علاقة بين اعتماد سلوك غير حكيم ثانية، القمع العاطفي وتؤثر سلبيا (Trull & Sher, 1994). ويمكن في سياق الممارسة البدنية ، وقد تبين أن القفز يكون نشاط من المحتمل أن تؤثر على وضع مسافة السلبية المرتبطة رتبة ((Michel, Carton, & Jouvent, 1997)). وعلاوة على ذلك، ودراسة من قبل Bonne t et al. (2003) يدل على ان تتميز الغواصين الذين يشاركون في السلوكيات الخطرة (مثل الغوص إلى أعماق كبيرة، وليس احترام تخفيف الضغط) من قبل على مستوى من المشاعر السلبية أكثر حذرا من الغواصين.

يقتصر النماذج المقترحة في هذا العمل الدكتوراه لهذه العلاقة واحدة بين تجربة تأثير سلبي، تأثير إيجابي من البحوث واعتماد السلوكيات الصحية. العواطف هي أيضا من المحتمل أن يحدث عندما يكون الشخص يجري حاليا عملا من أعمال الحكم. في هذا العمل الدكتوراه، وأثبتنا أن الرياضيين يستخدمون الاستدلال المعرفي عندما محاولة لتقييم احتمالات انهم يواجهون في المستقبل بسبب الإصابة. وبالتالي، أكثر من لاعب الجيدو يعتبرون أنفسهم مشابهة لتلك التي من المحتمل أن تكون إصابة (ارشادي) بقدر ما يعتبرون أنفسهم / الضعفاء أنفسهم. ومع ذلك، هذه العملية المعرفية لا تلخص الاستدلال في العمل في التوقعات من المخاطر. مؤخرا، وقد أكد بعض الكتاب أن الأشخاص يعتمدون على عواطفهم لتسهيل الحكم (Loewenstein et al., 2002)؛ (Hanoch, 2002) (2001). ومساهمة من العواطف لتقييم المخاطر يؤدي بما في ذلك استخدام الوجدانية الاستدلال (Slovic et al., 2002). لا يزال التحقق من تورط من معالجة عاطفية في الحكم من قبل اي رياضي من الضعف نفسه، واستكشاف كيفية عمل هذه العملية يتفاعل مع التجربة عن وقوع اصابات في الماضي. بسبب (خطير) وتصاب اصابات

من ردود فعل عاطفية قوية (cf. Wies Bjornstalet al., 1998)، هو في الواقع المشروعة للتنشيك في تورط هذه الإصابات في الماضي شعر عاطفي في الفكر ويصاب.

يجب أن هذه الحدود لا ننسى أن هذا العمل الدكتوراه تعطي المبررات لإنهاء هيمنة نموذج الإجهاد الإصابة (Williams & Andersen , 1998) كإطار لتحليل نقاط الضعف والحماية ضد مخاطر وقوع اصابات. هذه نظرية المعرفة البديلة التي يروج المعرفي الاجتماعي النهج في النهاية يدافع عن فكرة أن الرعاية الصحية الشاملة "النتائج من العناية التي نتخذها من النفس والآخرين والقدرة على اتخاذ القرارات والسيطرة على ظروف معيشتهم (Charte d'Ottawa, 1986)

المراجع

قائمة المراجع :

قائمة المراجع باللغة العربية :

- 1- أحمد التكريتي : المعالجة الإحصائية ، بيت الحكمة ، 2004 بغداد.
- 2- خالد توفيق : أعراض اللوي ، دار الحكمة ، عمان 2000.
- 3- خالد قبة : طرق ربط وتنشيط الإصابات الأطراف العليا، دار الثقافة ، بغداد 2003.
- 4- خالد قبة : التأهيل والعلاج الحركي ، دار الثقافة ، بغداد 2005.
- 5- خالد قبة : علاج الخلع، دار الثقافة ، بغداد 1999.
- 6- حسين الثابت: الإصابات الرياضية ، الدار العلمية الدولية ، العراق 2000.
- 7- محمد سالم : الإسعاف الأولي ، دار العلم ، عمان 1987.
- 8- محمد يوسف : علامات وأعراض الكسور ، بيت الحكمة ، بغداد 1998.
- 9- عبد الحكيم البصري : كدم العظام ، دار المعرفة ، بغداد 1995.
- 10- سميرة خليل محمد : أصابات الرياضيين ووسائل العلاج والأهيل، جامعة بغداد كلية التربية الرياضية للبنات . بغداد 2008.
- 11- سميرة خليل محمد : التربية الصحية للرياضيين ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية للبنات ، بغداد 2004.
- 12- فريق كمونة: موسوعة ال'صابات الرياضية وكيفية التعامل معها، الدار العلمية الدولية عمان الأردن ، دار الثقافة 2002.

- Abraham, C , Clift, S., & Grabowski, P. (1999). Cognitive predictors of adherence to malaria prophylaxis regimens on return from a malarious région: a prospective study. *Social Science & Medicine*, 48, 1641-1654.
- Adams, S. L . , Wyte, C. D , Paradise, M . S., & del Castillo, J. (1996). A prospective study of in-line skating: Observational séries and survey of active in-line skaters - injuries, protective equipment, and training. *Académie Emergency Medicine*, 3, 304-311.
- Adler, N . , & Matthews, K. (1994). Health psychology: why do some people get sick and some stay well? *Annual Review of Psychology*, 45, 229-259.
- Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (1999). *Le dépistage du cancer du sein par mamographie dans la population générale. Etude d'évaluation technologique*. Paris: ANAES.
- Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (2002). *Le dépistage du cancer du sein par mamographie : évaluation de la méta-analyse de Gotzsche et Olsen. Etude d'évaluation technologique*. Paris: ANAES.
- Aiken, L. S., Fenaughty, A. M., West, S. G., Johnson, J. J., & Lockett, T. L. (1995). Perceived déterminants of risk for breast cancer and the relations among objective risk, perceived risk, and screening behavior over time. *Women's Health: Research on Gender, Behavior, and Policy*, 1, 27-50.
- Aiken, L. S., Gerend, M. A., & Jackson, K. A. (2001). Perceived risk and health protective behavior: Cancer screening and cancer prévention. In A. Baum, T. A. Revenson, & J. Singer (Eds.). *Handbook of health psychology* (pp. 727-746). New York: Erlbaum.
- Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). *Multiple Régression: Testing and Interpreting Interactions*. Newbury Park: Sage Publications.
- Aiken, L. S., West, S. G., Woodward, C. K., & Reno, R. R. (1994). Health beliefs and compliance with mammography-screening recommendations in asymptomatic women. *Health Psychology*, 13, 122-129.
- Ajzen, I . (1988). Attitudes, personality and behavior. Milton Keynes: Open University Press.
- Ajzen, I . (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Décision Processes*, 50, 179-211.
- Ajzen, I . (1998). Models of human social behavior and their application to health psychology'. *Psychology and Health*, 13, 735-739.
- Ajzen, I . , & Fishbein, M . (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

- Ajzen, L., & Fishbein, M. (2004). Questions Raised by a Reasoned Action Approach: Comment on Ogden (2003). *Health Psychology*, 23, 431-434.
- Albarracin, D., Johnson, B. T., Fishbein, M., & Muellerleile, P. A. (2001). Théories of Reasoned Action and Planned Behavior as Models of Condom Use: A Meta-Analysis. *Psychological Bulletin*, 127, 142-161.
- Anaut, M. (2003). *La résilience. Surmonter les traumatismes*. Paris: Nathan Université.
- Andersen, M. B., & Williams, J. M. (1988). A model of stress and athletic injury: Prédiction and prévention. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 10, 294-306.
- Andersen, M. B., & Williams, J. M. (1999). Athletic injury, psychosocial factors and perceptual changes during stress. *Journal of Sports Sciences*, 17, 735-741.
- Arai, Y., Hosokawa, T., Fukao, A., Izumi, Y., & Hisamichi, S. (1997). Smoking behaviour and personality: a population-based study in Japan. *Addiction*, 92, 1023-1034.
- Arendt, E., & Dick, R. (1995). Knee injury patterns among men and women in collegiate basketball and soccer. NCAA data and review of literature. *American Journal of Sports Medicine*, 23, 694-701
- Argas, W. S. (1985). Area review: Current trends in smoking control. *Armais of Behavioral Medicine*, 7, 25-44.
- Armitage, C. J. (2005). Can the theory of planned behaviour predict the maintenance of physical activity? *Health Psychology*, 24, 235-245.
- Armitage, C. J., & Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta-analytic review. *British Journal of Social Psychology*, 40, 471-499.
- Arnold, H. J. (1982). Moderator variables: A clarification of conceptual, analytic, and psychometric issues. *Organizational Behavior and Human Performance*, 29, 143-174.
- Arnstein, P., Caudill, M., Mandle, C. L., Norris, A., & Beasley, R. (1999). Self efficacy as a mediator of the relationship between pain intensity, disability and dépression in chronic pain patients. *Pain*, 80, 483-491.
- Astrom, A. N., Awadia, A. K., & Bjorvatn, K. (1999). Perceptions of susceptibility to oral health hazards: a study of women in different cultures. *Community dentistry and oral epidemiology*, 27, 268-274.
- Astrom, A. N., Moshiri, C., Hemed, Y., Heuch, I., & Kvale, G. (2006). Perceived susceptibility to and perceived causes of road traffic injuries in an urban and rural area of Tanzania. *Accident Analysis and Prevention*, 38, 54-62.
- Avenell, A., Brown, T. J., McGee, M. A., Campbell, M. K., Grant, A. M., Broom, J. et al. (2004). What interventions should we add to weight reducing diets in adults with

obesity? A systematic review of randomized controlled trials of adding drug therapy, exercise, behavioral therapy or combinations of these interventions. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 17, 293-316.

- Bahr, R., Kannus, P., & Van Mechelen, W. (2003). Epidemiology and prevention of sports injuries. In M. Kjoer, M. Krogsgaard, P. Magnusson, L. Engebretsen, H. Roos, T. Takala et al. (Eds.), *Textbook of sports medicine. Basic science and clinical aspects of sports injury and physical activity* (pp. 299-314). Oxford: Blackwell Science.
- Bahr, R., & Krosshaug, T. (2005). Understanding injury mechanisms : a key component of preventing injuries in sport. *British Journal of Sports Medicine*, 39, 324-329.
- Bailey, S. L., Ouellet, L. J., Mackesy-Amity, M. E., Golub, E. T., Hagan, H., Hudson, S. M . et al. (2007). Perceived risk, peer influences, and injection partner type predict receptive syringe sharing among young adult injection drug users in five U.S. cities. *Drug and Alcohol Dependence*, 91, S18-S29.
- Baird, B. N. R. (1986). Tolerance for environmental health risks: The influence of knowledge, benefits, voluntariness, and environmental attitudes. *Risk Analysis*, 6, 425-435.
- Ballard, K. (2002). Understanding risk: women's perceived risk of menopause-related disease and the value they place on preventive hormone replacement therapy. *Family Practice*, 19, 591-595.
- Ballard, P. (1996). Research brief: Athletic care and injury prevention services. Opinions of athletic directors. *National Association of Secondary School Principals Bulletin*, 80, 106-112.
- Bandura, A. (1989). Perceived self-efficacy in the exercise of control over AIDS infection. In V. M. May, G. W. Albee, & S. S. Schneider (Eds.), *Primary prevention of AIDS. Psychological Approaches* (pp. 128-141). Newbury Park: Sage.
- Baranowski, T. (2005). Integration of two models, or dominance of one? *Journal of Health Psychology*, 10, 19-21.
- Baranowski, T., Anderson, C., & Carmack, C. (1998). Mediating variable framework in physical activity research interventions: How are we doing? How might we do better? *American Journal of Preventive Medicine*, 15, 266-297.
- Baranowski, T., Cullen, K. W., & Baranowski, J. (1999). Psychosocial correlates of dietary intake: Advancing dietary intervention. *Annual Review of Nutrition*, 19, 17-40.
- Baranowski, T., Cullen, K. W., Niklas, T., Thompson, D., & Baranowski, J. (2003). Are current health behavior change models helpful in guiding prevention of weight gain efforts? *Obesity Research*. 11. 23S-43S.
- Baron, R. M . , & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategy, and Statistical

- Considérations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51, 1173-1182.
- Bartholomew, J. B., Brewer, B. W., Van Raalte, J. L., Linder, D. E., Cornélius, A. E., & Bart, S. M. (1998). A psychometric évaluation of the Sports Inventory for Pain. *The Sport Psychologist*, 12, 29-39.
- Becker, M. H., & Maiman, L. A. (1975). Sociobehavioral déterminants of compliance with health and médical care recommendations. *Médical Care*, 8, 10-24.
- Bédard, G. B., Reid, G. J., McGrath, P. J., & Chambers, C. T. (1997). Coping and selfmedication in a community sample of junior high school students. *Pain Research and Management*, 2, 151-156.
- Benson, B. W., Mohtad, N. G. H., Rose, M. S., & Meeuwisse, W. H. (1999). Head and neck injuries among ice hockey players wearing full face shields vs half face shields. *Journal of the American Médical Association*, 282, 2328-2332.
- Bjorkman, M. (1984). Decision-making, risk taking, and psychological time: Review of empirical findings and psychological theory. *Scandinavian Journal of Psychology*, 25, 31-49.
- Blackwell, B., & McCullagh, P. (1990). The relationship of athletic injury to life stress, compétitive anxiety and coping ressources. *Athletic Training*, 25, 23-27.
- Blenner, J. L. (1993). Visual evoked potential stimulus intensity modulation and sensation seeking in thrill seekers. *Personality and Individual Différences*, 14, 455-463.
- Bogg, T., & Roberts, B. W. (2004). Conscientiousness and health behaviors: a metaanalysis. *Psychological Bulletin*, 130, 887-919.
- Boney-McCoy, S., Gibbons, F. X., & Gerrard, M. (1999). Self-esteem, compensatory selfenhancement, and the considération of health risk. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 25, 954-965.
- Bonnet, A., Pédinielli, J. L., Romain, F., & Rouan, G. (2003). Bien-être subjectif et régulation émotionnelle dans les conduites à risque. Cas de la plongée sous-marine. *L'Encéphale*, 29, 488-497.
- Booth-Kewley, S., & Vickers, R. R. (1994). Associations between major domains of personality and health behavior. *Journal of Personality*, 62, 281-298.
- Borland, R., Owen, N., Hill, D., & Schofield, P. (1991). attempts and sustained cessation after the introduction of workplace smoking bans. *Health Psychology*, 10, 336-342.
- Bozionelos, G., & Bennett, P. (1999). The theory of planned behaviour as predictor of exercise. *Journal of Health Psychology*, 4, 517-529.
- Bramwell, S. T., Masuda, M., Wagner, N. N., & Holmes, T. H. (1975). Psychosocial

- factors in athletic injuries: Development and application of the Social and Athletic Readjustment Rating Scale (SARRS). *Journal of Human Stress*, 1, 6-20.
- Breakwell, G. M., Fife-Schaw, C., & Clayden, K. (1991). Risk-taking, control over partner choice and intended use of condoms by virgins. *Journal of community and applied social psychology*, 1, 173-187.
- Breakwell, G. M., Millward, L. J., & Fife-Schaw, C. (1994). Commitment to 'safer' sex as a predictor of condom use among 16-20 year-olds. *Journal of Applied Social Psychology*, 24, 189-217.
- Breivik, G. (1999). Personality, sensation seeking and risk taking among elite climbers and parachute jumpers. In G. Breivik (Ed.), *Personality, sensation seeking and arousal in high risk sports* (pp. 45-68). Oslo: Norwegian University of Sport and Physical Education.
- Brewer, N. T., Chapman, G. B., Gibbons, F. X., Gerrard, M., McCaul, K. D., & Weinstein, N. D. (2007). Meta-Analysis of the Relationship between Risk Perception and Health Behavior: The Example of Vaccination. *Health Psychology*, 26, 136-145.
- Brody, J. G. (1988). Responses to collective risk: Appraisal and coping among workers exposed to occupational health hazards. *American Journal of Community Psychology*, 16, 645-663.
- Brownlee-Duffeck, M., Peterson, L., Simonds, J. F., Goldstein, D., Kilo, C., & Hoette, S. (1987). The Role of Health Beliefs in the Regimen Adherence and Metabolic Control of Adolescents and Adults With Diabetes Mellitus. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 55, 139-144.
- Bruchon-Schweitzer, M. (2002a). *Psychologie de la santé. Modèles, concepts et méthodes*. Paris: Dunod.
- Bruchon-Schweitzer, M. (2002b). Un modèle intégratif en psychologie de la santé. In G. N. Fisher (Ed.), *Traité de psychologie de la santé* (pp. 47-71). Paris: Dunod.
- Brustad, R. J., Babkes, M. L., & Smith, A. L. (2001). Youth in sport: Psychological considerations. In R. N. Singer, H. A. Hausenblas, & C. M. Janelle (Eds.), *Handbook of Sport Psychology 2nd Edition* (pp. 604-635). New York: Wiley.
- Bursill, A. E. (1958). The restriction of peripheral vision during exposure to hot and humid conditions. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 10, 113-129.
- Burton, A. K., Tillotson, K. M., Main, C. J., & Hollis, S. (1995). Psychosocial predictors of outcome in acute and subchronic low back trouble. *Spine*, 20, 722-728.
- Butler, G., & Mathews, A. (1983). Cognitive processes in anxiety. *Advances in Behaviour Research and Therapy*, 5, 51-62.
- Butler, G., & Mathews, A. (1987). Anticipatory anxiety and risk perception. *Cognitive Therapy and Research*, 11, 551-565.

- Byers, T., Nestlé, M. , McTiernan, A., Doyle, C., Currie-Williams, A., Gansler, T. et al. (2002). American Cancer Society guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention: Reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical activity. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 52, 92-119.
- Calle, S., & Eaton, R. G. (1993). Wheels-in-line roller skating injuries. *Journal of Trauma, Injury, Infection and Critical Care*, 35, 946-951.
- Cameron, L. D., & Diefenbach, M. A. (2001). Responses to information about psychosocial consequences of genetic testing for breast cancer susceptibility: Influences of cancer worry and risk perceptions. *Journal of Health Psychology*, 6, 47-59.
- Cameron, M. H., Vulcan, A. P., Finch, C. F., & Newstead, S. V. (1994). Mandatory bicycle helmet use following a decade of helmet promotion in Victoria, Australia - an evaluation. *Accident Analysis and Prevention*, 26, 325-337.
- Canals, J., Baldé, J., & Domènech, E. (1997). Smoking and personality predictors in young Spanish people. *Personality and Individual Differences*, 23, 905-908.
- Cannon, W. B. (1932). *The wisdom of the body*. New York: W. W. Norton.
- Cano, A., Mayo, A., & Ventimiglia, M. (2006). Coping, Pain Severity, Interference, and Disability: The Potential Mediating and Moderating Roles of Race and Education. *The Journal of Pain*, 7, 459-468.
- Carver, C. S., Pozo, C., Harris, S. D., Noriega, V., Scheier, M. F., Robinson, D. S. et al. (1993). How Coping Mediates the Effect of Optimism on Distress: A Study of Women With Early Stage Breast Cancer. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65, 375-390.
- Carver, C. S., & Scheier, M. F. (2002). Optimism. In C. R. Snyder, & S. J. Lopez (Eds.), *Handbook of positive psychology* (pp. 231-243). New York: Oxford University Press.
- Castanier, C., & Le Scanff, C. (sous presse). Influence de la personnalité et des dispositions émotionnelles sur les conduites sportives à risques : Une revue de littérature. *Science et motricité*.
- Cazenave, N., Le Scanff, C., & Woodman, T. (2007). Psychological profiles and emotional regulation characteristics of women engaged in risk-taking sports. *Anxiety, Stress, and Coping*, 20, 421-435.
- Chatzisarantis, N. L. D., & Hagger, M. S. (2005). Effects of a brief intervention based on the theory of planned behavior on physical activity participation. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 4, 34-45.
- Chatzisarantis, N. L. D., & Hagger, M. S. (2008). Influences of personality traits and continuation intentions on physical activity participation within the theory of planned behaviour. *Psychology and Health*, 23, 347-367.

- Christensen, A. J., & Smith, T. W. (1995). Personality and patient adherence : Correlates of the five-factor model in renal dialysis. *Journal of Behavioral Medicine*, 18, 305-313.
- Christiansen, B., Roehling, P., Smith, G., & Goldman, M. (1989). Using alcohol expectancies to predict adolescent drinking behavior after one year. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 57, 93-99.
- Cioffi, D. (1991). Beyond attentional strategies: A cognitive-perceptual model of somatic interpretation. *Psychological Bulletin*, 109, 25-41.
- Coddington, R. D., & Troxel, J. R. (1980). The effect of emotional factors on football injury rates: A pilot study. *Journal of Human Stress*, 6, 3-5.
- Cohen, D. (1986). Bicycle accidents [éditorial]. *The Medical Journal of Australia*, 144, 114-115.
- Committee on Trauma Research (1985). *Injury in America: A continuing public health problem*. Washington: National Academy press.
- Conner, M., & Abraham, C. (2001). Conscientiousness and the Theory of Planned Behavior: Toward a more Complete Model of the Antécédents of Intentions and Behavior. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 27, 1547-1561.
- Conner, M., & Norman, P. (2005). *Predicting health behaviour: Research and practice with social cognition models*. Buckingham: Open University Press.
- Constans, J. I. (2001). Worry propensity and the perception of risk. *Behaviour Research and Therapy*, 39, 721-729.
- Cook, M., Young, A., Taylor, D., & Bedford, A. (1998). Personality correlates of alcohol consumption. *Personality and Individual Differences*, 24, 641-647.
- Cooper, M. L., Agocha, V. B., & Sheldon, M. S. (2000). A Motivational Perspective on Risky Behaviors: The Rôle of Personality and Affect Regulatory Processes. *Journal of Personality*, 68, 1059-1088.
- Coopersmith, S. (1984). *Manuel de l'inventaire d'estime de soi*. Paris: E.A.P.
- Coron, J., McLaughlin, G., & Dorman, S. M. (1996). Factors influencing use of bicycle helmets among undergraduate students. *Journal of American Collège Health*, 44, 294-297.
- Costa, P. T. Jr., Fleg, J. L., McCrae, R. R., & Lakatta, E. G. (1982). Neuroticism, coronary artery disease, and chest pain complaints: Cross-sectional and longitudinal studies.

- Expérimental Aging Research, 8, 37-44.
- Costa, P. T. Jr., & McCrae, R. R. (1980). Somatic complaints in males as a function of age and neuroticism: a longitudinal analysis. *Journal of Behavioral Medicine*, 3, 245-257.
- Costa, P. T. Jr., & McCrae, R. R. (1985). Hypochondriasis, neuroticism, and aging. When are somatic complaints unfounded? *American Psychologist*, 40, 19-28.
- Costa, P. T. Jr., & McCrae, R. R. (1987). Neuroticism, somatic complaints, and disease: Is the bark worse than the bite? *Journal of Personality*, 55, 299-316.
- Costa, P. T. Jr., & McCrae, R. R. (1992). Normal Personality Assessment in Clinical Practice: The NEO Personality Inventory. *Psychological Assessment*, 4, 5-13.
- Crombez, G., Eccleston, C., Baeyens, F., & Eelen, P. (1997). Habituation and the interference of pain with task performance. *Pain*, 70, 149-154.
- Cronin, C. (1991). Sensation seeking among mountain climbers. *Personality and Individual Differences*, 12, 653-654.
- Cryan, P. O., & Ailes, E. F. (1983). The relationship between stress and football injuries. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 23, 52-58.
- Culver, J., Burke, W., Yasui, Y., Durfy, S., & Press, N. (2001). Participation in Breast Cancer Genetic Counseling: The Influence of Educational Level, Ethnic Background, and Risk Perception. *Journal of Genetic Counseling*, 10, 215-231.
- Dalhauser, M., & Thomas, M. B. (1979). Visual disembedding and locus of control as variables associated with high school football injuries. *Perceptual and Motor Skills*, 49, 254.
- Dannenberg, A. L., Coté, T. R., Kresnow, M. J., Sacks, J. J., Lipsitz, C. M., & Schmidt, E. R. (1993). Bicycle helmet use by adults: the impact of companionship. *Public Health Reports*, 108, 212-217.
- Dantzer, R. (1989). *L'illusion psychosomatique*. Paris: Odile Jacob.
- Darvill, T. J., & Johnson, R. C. (1991). Optimism and perceived control of life events as related to personality. *Personality and Individual Differences*, 12, 951-954.
- Davis, J. O. (1991). Sport injuries and stress management: An opportunity for research. *The Sport Psychologist*, 5, 175-182.
- Day, G. (1951). Psychosomatic approach to pulmonary tuberculosis. *Lancet*, 1, 1025-1028.
- De Wit, J. B. F., Stroebe, W., De Vroome, E. M. M., Sandfort, T. G. M., & Van Griensven, G. J. P. (2000). Understanding AIDS preventive behaviour with casual and primary partners in homosexual men: The theory of planned behaviour and the information-motivation-behavioural-skills model. *Psychology and Health*, 15, 325-340.

- Demissie, K., Mills, O. F., & Rhoads, C. G. (1998). Empirical comparison of the results of randomized controlled trials and case control studies in evaluating the effectiveness of screening mammography. *Journal of Clinical Epidemiology*, 51, 81-91.
- Déroche, T., Stephan, Y., Brewer, B. W., & Le Scanff, C. (2007). Predictors of perceived susceptibility to sport-related injury. *Personality and Individual Differences*, 43, 2218-2228.
- Déroche, T., Stephan, Y., Lecocq, G., & Le Scanff, C. (2007). Les déterminants psychologiques de la blessure physique du sportif: une revue de littérature. *Psychologie Française*, 52, 389-402.
- Doll, R., Peto, R., Wheatley, K., Gray, R., & Sutherland, I. (1994). Mortality in relation to smoking: 40 years' observations on male British doctors. *British Medical Journal*, 309, 901-911.
- Drinkwater, B. L., Grimston, S. K., Raab-Cullen, D. M., & Snow-Harter, C. M. (1995). American College of Sport Medicine position stands on osteoporosis and exercise. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 27, i-vii.
- Easterbrook, J. A. (1959). The effect of emotion on cue utilization and the organization of behaviour. *Psychological Review*, 66, 183-201.
- Eccleston, C. (1994). Chronic pain and attention: a cognitive approach. *British Journal of Clinical Psychology*, 33, 535-547.
- Eccleston, C., & Crombez, G. (1999). Pain demands attention: A cognitive-affective model of the interruptive function of pain. *Psychological Bulletin*, 125, 356-366.
- Edwards, R. R., Moric, M., Husfeldt, B., Buvanendran, A., & Ivankovich, O. (2005).
- Ethnic similarities and differences in the chronic pain experience. A comparison of African American, Hispanic, and White patients. *Pain Medicine*, 6, 88-98.
- Edwards, W. (1954). The theory of decision making. *Psychological Bulletin*, 51, 380-417.
- Eibner, F., Barth, J., & Bengel, J. (2006). Predicting perceived vulnerability for breast cancer among women with an average breast cancer risk. *British Journal of Health Psychology*, 11, 607-621.

- Eiser, J. R., & Gentle, P. (1988). Health behavior as goal-directed action. *Journal of Behavioral Medicine*, 11, 523-535.
- Ekeland, A., & Rodven, A. (2000). Injuries in alpine skiing, telemarking, and snowboarding. In R. J. Johnson, P. Zucco, & J. E. Shealy (Eds.), *Skiing Trauma and Safety: Thirteenth Volume* (pp. 87-94). West Conshohocken: American Society for Testing and Materials.
- Ekman, R., Schelp, L., Welander, G., & Svanström, L. (1997). Can a combination of local, regional and national information substantially increase bicycle-helmet wearing and reduce injuries? Experience from Sweden. *Accident Analysis and Prevention*, 29, 321-328.
- Ellis, J. A., Kierulf, J. C., & Klassen, T. P. (1995). Injuries associated with in-line skating from the Canadian hospitals injury reporting and prevention program database. *Canadian Journal of Public Health*, 86, 133-136.
- Erblich, J., Bovbjerg, D. H., Norman, C., Valdimarsdottir, H. B., & Montgomery, G. H. (2000). It won't happen to me: Lower perception of heart disease risk among women with family histories of breast cancer. *Preventive Medicine*, 31, 714-721.
- Erikssen, G. (2001). Physical fitness and changes in mortality: The survival of the fittest. *Sports Medicine*, 31, 571-576.
- Ethier, K. A., Kershaw, T., Niccolai, L., Lewis, J. B., & Ickovics, J. R. (2003). Adolescent Women underestimate their susceptibility to sexually transmitted infections. *Sexually Transmitted Infections*, 79, 408-411.
- Everett, S. A., Price, J. H., Bergin, D. A., & Groves, B. W. (1996). Personal goals as motivators: Predicting bicycle helmet use in university students. *Journal of Safety Research*, 27, 43-53.
- Ewald, K., & Jiobu, R. M. (1985). Explaining positive deviance: Becker's model and the case of runners and bodybuilders. *Sociology of Sport Journal*, 2, 144-156.
- Facione, N. C. (2002). Perceived risk of breast cancer: Influence of heuristic thinking. *Cancer Practice*, 10, 256-262.
- Farris, C., Spaite, D. W., Criss, E. A., Valenzuela, T. D., & Meislin, H. W. (1997). Observational Evaluation of Compliance With Traffic Regulations Among

- Helmeted and Nonhelmeted Bicyclists. *Annals of Emergency Medicine*, 29, 625-628.
- Fawkner, H. J., McMurray, N. E., & Summers, J. J. (1999). Athletic injury and minor life events: a prospective study. *Journal Science Medicine sport*, 2, 117-124.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Reading: Addison-Wesley
- Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (1991). *Social cognition*, New York: McGraw Hill.
- Flint, F. (1998). sport psychology and sports medicine in Research: The dilemmas. *Journal of Applied Sport Psychology*, 10, 83-102.
- Floyd, D. L., Prentice-Dunn, S., & Rogers, R. W. (2000). A meta-analysis of research on protection motivation theory. *Journal of Applied Social Psychology*, 30, 407-429.
- Flynn, B. S., Dana, G. S., Goldstein, A. O., Bauman, K. E., Cohen, J. E., Gottlieb, N. H. et al. (1997). State legislators' intentions to vote and subsequent votes on tobacco control legislation. *Health Psychology*, 16, 401-404.
- Fontaine, K. R. (1994). Personality correlates of sexual risk-taking among men. *Personality and Individual Differences*, 17, 693-694.
- Ford, I. W., Eklund, R. C., & Gordon, S. (2000). An examination of psychosocial variables moderating the relationship between life stress and injury time-loss among athletes of a high standard. *Journal of Sports Sciences*, 18, 301-312.
- Frey, J. H. (1991). Social risk and the meaning of sports. *Sociology of Sport Journal*, 8, 136-145.
- Friedenreich, C., & Orenstein, M. (2002). Physical activity and cancer prevention: Etiologic evidence and biological mechanisms. *Journal of Nutrition*, 132, 3456S-2464S.
- Friedman, H. S., Tucker, J. S., Schwartz, J. E., Martin, L. R., Tomlinson-Keasey, C., Wingard, D. L. et al. (1995). Childhood conscientiousness and longevity: Health behaviors and cause of death. *Journal of Personality and Social Psychology*, 68, 696-703.
- Fromme, K., Katz, E., & Rivet, K. (1997). Outcome expectancies and risk-taking behavior. *Cognitive Therapy and Research*, 21, 441-442.

- Fromme, K., Stroot, E., & Kaplan, D. (1993). Comprehensive effects of alcohol: Development and psychometric assessment of a new expectancy questionnaire. *Psychological Assessment*, 5, 19-26.
- Fry, R. B., & Prentice-Dunn, S. (2006). Effects of a psychosocial intervention on breast self-examination attitudes and behaviors. *Health Education Research*, 21, 287-295.
- Furu, K., Straume, B., & Thelle, D. S. (1997). Legal drug use in general population: association with gender, morbidity, health care utilization, and lifestyle characteristics. *Journal of Clinical Epidemiology*, 50, 341-349.
- Gardner, D. G., Cummings, L. L., Dunham, R. B., & Pierce, J. L. (1998). Single-item versus multiple-item measurement scales: An empirical comparison. *Educational and Psychological Measurement*, 58, 898-915.
- Gatchel, R. J., Polatin, P. B., & Mayer, T. G. (1995). The dominant role of psychosocial risk factors in the development of chronic low back pain disability. *Spine*, 20, 2702-2709.
- Gerend, M. A., Aiken, L. S., & West, S. G. (2004). Personality factors in older women's perceived susceptibility to disease of aging. *Journal of Personality*, 72, 243-270.
- Gerend, M. A., Aiken, L. S., West, S. G., & Erchull, M. J. (2004). Beyond medical risk: Investigating the psychological factors underlying women's perceptions of susceptibility to breast cancer, heart disease, and osteoporosis. *Health Psychology*, 23, 247-258.
- Gerrard, M., Gibbons, F. X., Benthin, A. C., & Hessling, R. M. (1996). A longitudinal study of the reciprocal nature of risk behaviors and cognitions in adolescents. What you do shapes what you think and vice versa. *Health Psychology*, 15, 344-354.
- Gerrard, M., Gibbons, F. X., & Bushman, B. J. (1996). Relation between perceived vulnerability to HIV and precautionary sexual behavior. *Psychological Bulletin*, 119, 390-409.
- Gheldof, E. L. M., Vinck, J., Van den Bussche, E., Vlaeyen, J. W. S., Hidding, A., & Crombez, G. (2006). Pain and pain-related fear are associated with functional and social disability in an occupational setting: Evidence of mediation by pain-related fear. *European Journal of Pain*, 10, 513-525.

Giannetti, V. J., Reynolds, J., & Rihnen, T. (1985). Factors which differentiate smokers from ex-smokers among cardiovascular patients: A discriminant analysis. *Social Science and Medicine*, 20, 245.

Gigerenzer, G., & Todd, M. P. (1999). Simple heuristics that makes US smart. New York: Oxford University Press.

Gil, K. M., Abrams, M. R., Phillips, G., & Williams, D. A. (1992). Sick leave cell disease pain

2. Predicting health care use and activity level at 9-month follow-up. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 60, 267-273.

Godin, G., Valois, P., Lepage, L., & Desharnais, R. (1992). Predictors of smoking behavior: An application of Ajzen's theory of planned behavior. *British Journal of Addiction*, 87, 1335-1343.

Goldberg, J. H., Halpern-Felsher, B. L., & Millstein, S. G. (2002). Beyond invulnerability: the importance of benefits in adolescents' decision to drink alcohol. *Health Psychology*, 21, 477-484.

Gomà-i-freixanet, M. (1991). Personality profile of subject engaged in high physical risk sports. *Personality and Individual Differences*, 12, 1087-1093.

Gore, S., Farrell, F., & Gordon, J. (2001). Sports involvement as protection against depressed mood. *Journal of Research on Adolescence*, 11, 119-130.

Greening, L., Dollinger, S. J., & Pitz, G. (1996). Adolescents' perceived risk and personal experience with natural disasters: An evaluation of cognitive heuristics. *Acta Psychologica*, 91, 27-38.

Gunnoe, A. J., Horodyski, M., Tennant, L. K., & Murphey, M. (2001). The effect of life events on incidence of injury in high school football players. *Journal of Athletic Training*, 36, 150-155.

Hagel, B., Pless, I. B., Goulet, C., Platt, R., & Robitaille, Y. (2005). The effect of helmet use on injury severity and crash circumstances in skiers and snowboarders. *Accident Analysis and Prevention*, 37, 103-108

Hagger, M. S., Chatzisarantis, N. L. D., & Biddle, S. J. H. (2002). A meta-analytic review of the theories of reasoned action and planned behavior in physical activity: An examination of predictive validity and the contribution of additional variables. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 24, 3-32.

Hagger-Johnson, G. E., & Whiteman, M. C. (2007). Conscientiousness facets and health behaviors: A latent variable modeling approach. *Personality and Individual Differences*, 43, 1235-1245.

Hanoch, Y. (2002). The effects of emotions on bounded rationality: a comment on

- Kaufman . Journal of Economic Behaviour and Organization, 49, 131-135.
- Hanson, J. A. , & Benedict , J. A . (2002) . Use o f the Healt h Belie f Mode l t o Examin e Olde r Adults ' Food-Handlin g Behaviors . Journal of Nutrition Education and Behavior, 34, S25-S30.
- Hanson, S. J., McCullagh , P., & Tonymon , P. (1992) . The relationship o f personality charactristics, lif e stress, and copin g ressources to athletic injury . Journal of Sport and Exercise Psychology, 14, 262-272.
- Hardy , C. J., Richman , J. M. , & Rosenfeld, L . B . (1991) . Th e rôl e o f social support i n the lif e stress/ injur y relationship. The Sport Psychologist, 5, 128-139.
- Hardy , C. J., & Riehl , M . A . (1988) . A n examinatio n o f the lif e stress-injury relationship among noncontact sport participants. Behavioral Medicine, 14, 113-118.
- Harrison , J. A. , Mullen , P. D. , & Green, L . W . (1992) . A meta-analysis o f studies o f the health belie f mode l wit h adults. Health Education Research, 7, 107-116.
- Hassmén , P., Koivula , N. , & Uutela, A . (2000) . Physical Exercise and Psychologica l Well - Being : A Populatio n Study i n Finland . Préventive Medicine, 30, 11-25.
- Hausenblas, H . A. , Carron , A . V. , & Mack , D . E. (1997) . Applicatio n o f the théorie s o f reasoned action and planned behavior to exercise behavior: A meta-analysis. Journal of Sport and Exercice Psychology, 19, 36-51 .
- Heller, D . (1993) . Rollerbladin g injuries. Hazard, 15, 11-13.
- Heller, D. , Routley, V. , & Chambers, S. (1996). Rollerblading injuries in young people. Journal of Paediatrics and ChildHealth, 32, 35-38.
- Helweg-Larsen, M. , & Shepperd, J. A . (2001). Do moderators o f the optimistic bias affect Personal or target risk estimâtes? A review o f the literature. Personality and Social Psychology Review, 5, 74-95.
- Hernandez, J. T., & Diclemente, R. J. (1992). Self-control and ego identity development as predictors o f unprotected sex in late adolescent maies. Journal of Adolescence, 15, 437-447.
- Hinkle, L . E., & Wolff, H . G. (1958). Ecologie investigations o f the relationship between illness life expériences and the social environment. Annals of International Medicine, 49, 1373-1388.

Holmes, T. H. (1970). Psychological screening in football injuries: Paper presented at a workshop (pp. 211-214). Sponsored by Sub-committee on Athletic Injuries, Committee on the Skeletal System, Division of Medical Sciences, National Research Council, Feb. 1969. Washington, DC: National Academy of Sciences.

Holmes, T. H., & Rahe, R. H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. *Journal of Psychosomatic Research*, 11, 213-218.

Holubowycz, O. T., Kloeden, C. N., & McLean, A. J. (1994). Age, sex, and blood alcohol concentration of killed and injured drivers, riders, and passengers. *Accident Analysis and Prevention*, 26, 483-492.

Hoorens, V., & Buunk, B. P. (1993). Social comparison of health risks: Locus of control, the person-positivity bias, and unrealistic optimism. *Journal of Applied Social Psychology*, 23, 291-302.

Hounsa, A. M., Godin, G., Alihonou, E., Valois, P., & Girard, J. (1993). An application of Ajzen's theory of planned behaviour to predict mothers' intention to use oral rehydration therapy in a rural area of Bénin. *Social Science and Medicine*, 37, 253-261.

Hoyle, R. H., Feifar, M. C., & Miller, J. D. (2000). Personality and Sexual Risk Taking: A Quantitative Review. *Journal of Personality*, 68, 1203-1231.

Hreljac, A. (2004). Impact and overuse injuries in runners. *Medicine and Science in Sport and Exercise*, 36, 845-849.

Hughes, R. H., & Coakley, J. (1991). Positive deviance among athletes: The implications of overconformity to the sport ethic. *Sociology of Sport Journal*, 8, 307-325.

Humphries, D., & Krummel, D. A. (1999). Perceived susceptibility to cardiovascular disease and dietary intake in women. *American Journal of Health Behavior*, 23, 250-260.

Institut National de Santé et Recherches Médicales (2008). *Activité physique. Contextes et effets sur la santé*. Paris: Lavoisier Editions.

International Association for the Study of Pain (1979). Pain terms: A list with definitions and notes on usage. *Pain*, 6, 249.

Irachabal, S., Koleček, M., Rascle, N., & Bruchon-Schweitzer, M. (2008). Stratégies de coping des patients douloureux : adaptation française du coping strategies questionnaire (CSQ-F). *L'Encéphale*, 34, 47-53.

Iriyama, S., Nakahara, S., Jimba, M., Ichikawa, M., & Wakai, S. (2007). AIDS health beliefs and intention for sexual abstinence among male adolescent students in

- Kathmandu, Népal: A test of perceived severity and susceptibility. *Public Health*, 121, 64-72.
- Jack, S. J., & Ronan, K. R. (1998). Sensation seeking among high-and low-risk sports participants. *Personality and Individual Differences*, 25, 1063-1083.
- Jacobs, S. J., & Berson, B. L. (1986). Injuries to runners: a study of entrants to a 10,000 meter race. *American Journal of Sports Medicine*, 14, 151-155.
- Jacques, L. B. (1994). Rates of bicycle helmet use in an affluent Michigan County. *Public Health Reports*, 109, 296-301.
- James, S. L., Bates, B. T., & Osternig, L. R. (1978). Injury to runners. *American Journal of Sports Medicine*, 6, 40-50.
- Jamner, M. S., Wolitski, R. J., Corby, N. H., & Fishbein, M. (1998). Using the theory of planned behaviour to predict intention to use condoms among female sex workers. *Psychology and Health*, 13, 187-205.
- Janssen, S. A. (2002). Negative affect and sensitization to pain. *Scandinavian Journal of Psychology*, 43, 131-137.
- Janz, N. K., & Becker, M. H. (1984). The Health Belief Model: A decade later. *Health Education Quarterly*, 11, 1-47.
- Jeffrey, R. W. (1990). Risk behaviors and health: Contrasting individual and population perspectives. *American Psychologist*, 44, 1194-1202.
- John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin, & O. P. John (Eds.), *Handbook of personality: Theory and research* (pp. 102-138). New York: Guilford.
- Johnson, C., & Fromme, K. (1994). An experimental test of affect, subjective craving, and alcohol outcome expectancies as motivators of young adult drinking. *Addictive Behaviors*, 19, 631-641.
- Johnson, J. H., Sarason, I. G., & Siegel, J. M. (1979). Arousal seeking as a moderator of life stress. *Perceptual and Motor Skills*, 49, 665-666.
- Johnson, M. O. (2000). Personality correlates of HIV vaccine trial participation. *Personality and Individual Differences*, 29, 459-467.

Johnson, U. , Ekengren, J., & Andersen, M. B. (2005). Injury Prévention in Sweden: Helping Soccer Players at Risk. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 27, 32-38.

Johnston, D. W., Johnston, M. , Pollard, B., Kinmonth, A. , & Mant, D. (2004). Motivation Is Not Enough: Prédiction of Risk Behavior Following Diagnoses of Coronary Heart Disease From the Theory of Planned Behavior. *Health Psychology*, 23, 533-538.

Johnston, L. H. , & Carroll, D. (2000). The psychological impact of injury: Effects of prior sport and exercise involvement. *British Journal of Sports Medicine*, 34, 436-439.

Jordan, M. S., Lumley, M. A., & Leisen, J. C. C. (1998). The relationships of cognitive coping and pain control beliefs to pain and adjustment among African-American and Caucasian women with rheumatoid arthritis. *Arthritis Care and Research*, 11, 80-88.

Kahneman, D. (1973). *Attention and Effort*. Englewood-Cliffs: Prentice-Hall.

Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (1982). *Judgment under uncertainty: heuristics and biases*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1973). On the psychology of prédiction. *Psychological Review*, 80, 237-251.

Kajtna, T., Tusak, M. , Baric, R., & Burnik, S. (2004). Personality in high-risk sports athletes. *Kinesiology*, 36, 24-34.

Katapodi, M. C , Facione. N. C , Humphreys, J. C , & Dodd, M. J. (2005). Perceived breast cancer risk: heuristic reasoning and search for a dominance structure. *Social Science and Medicine*, 60, 421-432.

Katapodi, M. C , Lee, K. A., Facione, N. C , & Dodd, M. J. (2004). Predictors of perceived breast cancer risk and the relation between perceived risk and breast cancer screening: A meta-analytic review. *Preventive Medicine*, 38, 388-402.

Katz, E., Fromme, K., & D'Amico, E. (2000). Effects of outcome expectancies and personality on young adults' illicit drug use, heavy drinking, and risky sexual behavior. *Cognitive Therapy and Research*, 24, 1-22.

Kaufert, J. M. , Rabkin, S. W., Syrotuik, J., Boyko, E., & Shane, F. (1986). Health beliefs as predictors of success of alternate modalities of smoking cessation: Results of a controlled trial. *Journal of Behavioral Medicine*, 9, 475-489.

Kelly, J. A., & Kalichman, S. C. (1998). Reinforcement Value of Unsafe Sex as a Predictor of Condom Use and Continued HIV/AIDS Risk Behavior Among Gay and Bisexual Men. *Health Psychology*, 17, 328-335.

- Kerr, G., & Goss, J. (1996). The effect of a stress management program on injuries and stress levels. *Journal of Applied Sport Psychology*, 8, 109-117.
- Kerr, G., & Minden, H. (1988). Psychological factors related to the occurrence of athletic injuries. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 10, 167-173.
- Khan, K., Brown, J., Way, S., Vass, N., Crichton, K., Alexander, R. et al. (1995). Overuse injuries in classical ballet. *Sports Medicine*, 19, 341-357.
- Kim, K., Reicks, M., & Sjöberg, S. (2003). Applying the Theory of Planned Behavior to Predict Dairy Product Consumption by Older Adults. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 35, 294-301.
- Kirsch, K. L., Passick, S., Holtsclaw, E., Donaghy, K., & Theobald, D. (2001). Get tired for no reason: A single item screening for cancer-related fatigue. *Journal of Pain and Symptom Management*, 22, 931-937.
- Kjarsheim, K., Mykletun, R., & Halvorsen, T. (1996). Sélection into the restaurant business based on personality characteristics and the risk of heavy drinking. *Personality and Individual Differences*, 21, 625-629.
- Knight, P. A., & Nadel, J. (1986). Humility revisited: Self-esteem, information search, and policy consistency. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 38, 196-206.
- Koleck, M., Bruchon-Schweitzer, M., & Bourgeois, M. L. (2003). Stress et coping: un modèle intégratif en psychologie de la santé. *Annales Médico Psychologiques*, 161, 809-815.
- Kolt, G. S., & Kirkby, R. J. (1994). Injury, anxiety, and mood in competitive gymnasts. *Perceptual and Motor Skills*, 78, 955-962.
- Kolt, G. S., & Kirkby, R. J. (1996). Injury in Australian female competitive gymnasts: A psychological perspective. *Australian Physiotherapy*, 42, 121-126.
- Kontos, A. P. (2004). Perceived risk, risk taking, estimation of ability and injury among adolescent sport participants. *Journal of Pediatric Psychology*, 29, 447-455.
- Krause, N., & Stryker, S. (1984). Stress and well being: the buffering rôle of locus of control beliefs. *Social Science and Medicine*, 18, 790.
- Kucera, K., Marshall, S. W., Kirkendall, D. T., Marchak, P. M., & Garrett, W. E. (2005). Injury history as a risk factor for incident injury in youth soccer. *British Journal of Sports Medicine*, 39, 462-466.

Labus, J. S., Keefe, F. J., & Jensen, M. P. (2003). Self-reports of pain intensity and direct observations of pain behavior: When are they correlated? *Pain*, 102, 109-124.

Lajunen, T., & Rasänen, M. (2001). Why teenagers owning a bicycle helmet do not use their helmets. *Journal of Safety Research*, 32, 323-332.

Lajunen, L., & Rasänen, M. (2004). Can social psychological models be used to promote bicycle helmet use among teenagers? A comparison of the Health Belief Model, Theory of Planned Behavior and the Locus of Control. *Journal of Safety Research*, 35, 115-123.

Landers, D. M., Wang, M. Q., & Courtet, P. (1985). Peripheral narrowing among experienced and inexperienced rifle shooters under low- and high-stress conditions. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 56, 122-130.

Lautenschlager, L., & Smith, C. (2007). Understanding gardening and dietary habits among youth garden program participants using the Theory of Planned Behavior. *Appetite*, 49, 122-130.

Lavallee, L., & Flint, F. (1996). The relationship of stress, competitive anxiety, mood state, and social support to athletic injury. *Journal of Athletic Training*, 31, 296-299.

Lawton, R., Parker, D., Manstead, A. S. R., & Stradling, S. G. (1997). The rôle of affect in predicting social behaviors: The case of road traffic violations. *Journal of Applied Social Psychology*, 27, 1258-1276.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer.

Leddy, M. H., Lambert, M. J., & Ogles, B. M. (1994). Psychological consequences of athletic injury among high level competition. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 65,

Lee, C. (1989). Perceptions of immunity to disease in adult smokers. *Journal of Behavioral Medicine*, 12, 267-277.

Lek, Y. Y., & Bishop, G. D. (1995). Perceived vulnerability to illness threats: The rôle of disease type, risk factor perception and attributions. *Psychology and Health*, 10, 205-217.

Lemos-Giraldez, S., & Fidalgo-Aliste, A. M. (1997). Personality dispositions and health-related habits and attitudes: A cross-sectional study. *European Journal of Personality*, 11, 197-209.

Levenson, H. (1973). Multidimensional Locus of Control in Psychiatric Patients. *Journal of*

Consulting and Clinical Psychology, 41, 397-404.

Levenson, H. (1981). Differentiating among Internality, Powerful Others and Chance. In H. M. Lefcourt (Ed.), Research with the Locus of Control Construct, vol. 1: Assessment Methods (pp. 15-63). New York: Academic Press.

Levin, J. B., Lofland, K. R., Cassisi, J. E., Poreh, A. M., & Blonsky, E. R. (1996). The relationship between self efficacy and disability in chronic low back pain patients. International Journal of Rehabilitation and Health, 2, 19-28.

Lindsay, P. H., & Norman, D. A. (1980). Traitement de l'information et comportement humain. Une introduction à la psychologie. Montréal: Études Vivantes.

Liou, D., & Bauer, K. D. (2007). Perceptions of Psychosocial and Environmental Influences on Obesity Prevention in Chinese Americans. Journal of the American Dietetic Association, 107, A103.

Lipkus, I. M., Halabi, S., Strigo, T. S., & Rimer, B. K. (2000). The impact of abnormal mammograms on psychosocial outcomes and subsequent screening. Psycho-Oncology, 9, 402-410.

Lipkus, I. M., Iden, D., Terrenoire, J., & Feaganes, J. R. (1999). Relationships among Breast Cancer Concern, Risk Perceptions, and Interest in Genetic Testing for Breast Cancer Susceptibility among African-American Women with and without a Family

History of Breast Cancer. Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, 8, 533-539.

Liu, S., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Rexrode, K. M., Hu, F. B., & Rimm, E. B. (2001). Whole grain consumption and ischemic stroke. ACOG Clinical Review, 6, 10.

Loewenstein, G. F., Weber, E. U., Hsee, C. K., & Welch, N. (2001). Risk as feelings. Psychological Bulletin, 127, 267-286.

Lollis, C. M., Antoni, M. H., Johnson, E. H., Chitwood, D. D., & Griffin, D. K. (1995).

Does the health belief model predict risk sexual practices in injection drug users?

Clinical Psychology and Psychotherapy, 2, 227-233.

Loukas, A., Krull, J. L., Chassin, L., & Carie, A. C. (2000). The relation of personality to alcohol abuse/dependence in a high-risk sample. Journal of Personality, 68, 1153-1175.

- Macchi, R., & Crossman, J. (1996). After the fall: reflections of injured classical ballet dancers. *Journal of Sport Behavior*, 19, 221-234.
- MacLeod, A. K., Williams, J. M. G., & Berekian, D. A. (1991). Worry is reasonable: The rôle of explanations in pessimism about future personal events. *Journal of Abnormal Psychology*, 100, 478-486.
- Macnab, A. J., Smith, T., Gagnon, F. A., & Macnab, M. (2002). Effect of helmet wear on the incidence of head/ face and cervical spine injuries in young skiers and snowboarders. *Injury Prévention*, 8, 324-327.
- Maddison, R., & Prapavessis, H. (2005). A psychological approach of the prediction and prevention of athletic injury. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 27, 289 - 310.
- Marcil, I., Bergeron, J., & Audet, T. (2001). Motivational factors underlying the intention to drink and drive in young male drivers. *Journal of Safety Research*, 32, 363-376.
- Marshall, S. W., Loomis, D. P., Waller, A. E., Chalmers, D. J., Bird, Y. N., Quarrie, K. L. et al. (2005). Evaluation of protective equipment for prevention of injuries in rugby union. *International Journal of Epidemiology*, 34, 113-118.
- Martens, R. (1977). Sport competition anxiety test. Champaign: Human Kin Publishers.
- Marti, B., Vader, J. P., Minder, C. E., & Abelin, T. (1988). On the epidemiology of running injuries: the 1984 Bern Grand-Prix study. *American Journal of Sports Medicine*, 16, 285-293.
- Martin, E. D., & Sher, K. J. (1994). Family history of alcoholism, alcohol use disorders, and the five-factor model of personality. *Journal of Studies on Alcohol*, 55, 81-90.
- Martin, M. Y., Bradley, L. A., Alexander, R. W., Alarcon, G. S., Triana-Alexander, M., Aaron, L. A. et al. (1996). Coping strategies predict disability in patients with primary fibromyalgia. *Pain*, 68, 45-53.
- Martinsen, E. W., & Stephens, T. (1994). Exercise and mental health in clinical and free-living populations. In R. K. Dishman (Ed.), *Advances in exercise adherence* (52-72). Champaign: Human Kinetics.
- Martsh, C. T., & Miller, W. R. (1997). Extraversion predicts heavy drinking in college students. *Personality and Individual Differences*, 23, 153-155.
- Masatu, M. C., Kvale, G., & Klepp, K. L. (2003). Frequency and perceived credibility of reported sources of reproductive health information among

primary school adolescents in Arusha, Tanzania. *Scandinavian Journal of Public Health*, 31, 216-223.

May, J. R., Veatch, F. L., Reed, M. W., & Griffey, M. S. (1985). A psychological study of health, injury and performance in athletes on the U.S. Alpine ski team. *Physician and Sportsmedicine*, 13, 111-115.

Mayhew, D. R., Brown, S. W., & Simpson, H. M. (1995). Alcohol Use among Drivers and Pedestrians Fatally Injured in Motor Vehicle Accidents: Canada 1993. Ottawa: Traffic Injury Research Foundation.

Mayhew, D. R., Donelson, A. C., Beirness, D. J., & Simpson, H. M. (1986). Youth, alcohol and relative risk of crash involvement. *Accident Analysis and Prevention*, 18, 273-287.

McCaul, K. D., Branstetter, A. D., Schroeder, D. M., & Glasgow, R. E. (1996). What Is the Relationship Between Breast Cancer Risk and Mammography Screening? A Meta-Analytic Review. *Health Psychology*, 15, 423-429.

McCown, W. (1991). Contributions of the EPN paradigm to HIV prevention: a preliminary study. *Personality and Individual Differences*, 12, 1301-1303.

McCoy, S. B., Gibbons, F. X., Reis, T. J., Gerrard, M., Luus, C. A. E., & von Wald Sufka, A. (1992). Perceptions of smoking risk as a function of smoking status. *Journal of Behavioral Medicine*, 15, 469-488.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. Jr. (1991). Adding Liebe und Arbeit: The full five-factor model and well-being. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 17, 227-232.

McCrae, R. R., & John, O. (1992). An introduction to the five-factor model and its applications. *Journal of Personality*, 60, 214.

McDermott, F. T., Lane, J. C., Brazenor, G. A., & Debney, E. A. (1993). The effectiveness of bicyclist helmets: a study of 1710 casualties. *Journal of Trauma, Injury, Infection and Critical Care*, 34, 834-845.

McGinnis, J. M., & Foege, W. (1993). Actual causes of death in the United States. *The Journal of the American Medical Association*, 270, 2207-2212.

McGrath, D., & Beattie, T. F. (1996). Rollerblading in children: the Edinburgh experience. *Journal of Accidents and Emergency Medicine*, 13, 354-355.

- McGregor, B. A., Bowen, D. J., Ankerst, D. P., Andersen, M. R., Yasui, Y., & McTiernan, A. (2004). Optimism, perceived risk of breast cancer, and cancer worry among a community-based sample of women. *Health Psychology*, 23, 339-344.
- McKenna, F. P., & Horswill, M. S. (2006). Risk Taking From the Participantes Perspective: The Case of Driving and Accident Risk. *Health Psychology*, 25, 163-170.
- McLeod, S., & Kirkby, R. J. (1995). Locus of control as a predictor of injury in elite basketball players. *Sports Medicine, Training, and Rehabilitation*, 6, 201-206.
- McManus, A., Stevenson, M., Finch, C. F., Elliot, B., Hamer, P., Lower, A. et al. (2004). Incidence and risk factors for injury in non-elite Australian Football. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 7, 384-391.
- Messier, S. P., & Pittala, K. A. (1988). Etiologic factors associated with selected running injuries. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 20, 501-505.
- Messner, M. A. (1992). *Power at play: Sports and the problem of masculinity*. Boston: Beacon Press.
- Meyers, M. C., Bourgeois, A. E., & LeUnes, A. (2001). Pain coping response of collegiate athletes involved in high contact, high injury-potential sport. *International Journal of Sport Psychology*, 32, 29-42.
- Michel, G., Carton, S., & Jouvent, R. (1997). Recherche de sensations et anhédonie dans les conduites de prise de risque. Etude d'une population de sauteurs à l'élastique (benji). *L'Encéphale*, 23, 403-411.
- Mokdad, A. H., Marks, J. S., Stroup, D. F., & Gerberding, J. L. (2004). Actual causes of death in the United States. *Journal of the American Medical Association*, 291, 1238-1245.
- Montgomery, G. H., Erblich, J., DiLorenzo, T., & Bovbjerg, D. H. (2003). Family and friends with disease: Their impact on perceived risk. *Preventive Medicine*, 37, 242-249.
- Montgomery, S. B., Joseph, J. G., Becker, M. H., Ostrow, D. G., Kessler, R. C., & Kirscht, J. P. (1989). The Health Belief Model in understanding compliance with preventive recommendations for AIDS: how useful? *AIDS Education and Prevention*, 1, 303-323.

- Mulder, S., & Hutten, A. (2002). Injuries associated with inline skating in the European région. *Accident Analysis and Prévention*, 34, 65-70.
- Murray, D. M. (2003). *Living On The Edge : Sensation Seeking And Extrême Sports Participation*. Lamson Library Kinesiology Publications online [On-line].
- Nagy, M. S. (2002). Using a single-item approach to measure facet job satisfaction. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 4, 361-375.
- Nathan, P. E. (1986). Outcomes of treatment for alcoholism: Current data. *Annals of Behavioral Medicine*, 8, 40-46.
- Nemeth, R. L., von Baeyer, C. L., & Rocha, E. M. (2005). Young gymnasts' understanding of sport-related pain: A contribution to injury prévention. *Child: Care, Health and Development*, 31, 615-625.
- Ninot, G., Delignières, D., & Fortes, M. (2000). L'évaluation de l'estime de soi dans le domaine corporel. *STAPS*, 53, 35-48.
- Nixon, H. L. (1992). A social network analysis of influences on athletes to play with pain and injuries. *Journal of Sport and Social Issues*, 16, 127-135.
- Nixon, H. L. (1993). Accepting the risks of pain and injury in sport: Mediated cultural influences on playing hurt. *Sociology of Sport Journal*, 10, 183-196.
- Norman, P., Conner, M., & Bell, R. (1999). The theory of planned behavior and smoking cessation. *Health Psychology*, 18, 89-94.
- Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric theory*. New York: McGraw-Hill.
- Oliver, R. L., & Berger, P. K. (1979). A path analysis of preventive health care decision models. *Journal of Consumer Research*, 6, 113-122.
- Osborne, T. L., Jensen, M. P., Ehde, D. M., Hanley, M. A., & Kraft, G. (2007). Psychosocial factors associated with pain intensity, pain-related interference, and psychological functioning in persons with multiple sclerosis and pain. *Pain*, 127, 52-62.
- Otten, W., & Van der Pligt, J. (1992). Risk and behavior: The mediating rôle of risk appraisal. *Acta Psychologica*, 80, 325-346.

Paparizos, A. L., Tripp, D. A., Sullivan, M. J. L., & Rubenstein, M. (2005). Catastrophizing and Pain Perception in Recreational Ballet Dancers. *Journal of Sport Behaviour*, 28, 35-50.

Pargman, D., & Lunt, S. D. (1989). The relationship of self-concept and locus of control to the severity of injury in freshman collegiate football players. *Sport Medicine, Training and Rehabilitation*, 1, 201-208.

Parker, D., Lajunen, T., & Stradling, S. G. (1998). Attitudinal predictors of interpersonally aggressive violations on the road. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 1, 11-24.

Parker, D., Manstead, A. S. R., Stradling, S. G., Reason, J. T., & Baxter, J. S. (1992). Intention to Commit Driving Violations: An Application of the Theory of Planned Behavior. *Journal of Applied Psychology*, 77, 94-101.

Parsons, J., Halkitis, P. N., Bimbi, D., & Borkowski, T. (2000). Perceptions of the benefits and costs associated with condom use and unprotected sex among late adolescent college students. *Journal of Adolescence*, 23, 377-391.

Parsons, J., Siegel, A., & Cousins, J. (1997). Late adolescent risk-taking: Effects of perceived benefits and perceived risks on behavioral intentions and behavioral change. *Journal of Adolescence*, 20, 381-392.

Passer, M. W., & Seese, M. D. (1983). Life stress and athletic injury: Examination of positive versus negative events and three moderator variables. *Journal of Human Stress*, 9, 11-16.

Patterson, E. L., Smith, R. E., Everett, J. J., & Ptacek, J. T. (1998). Psychosocial factors as predictors of ballet injuries: Interactive effects of life stress and social support. *Journal of Sport Behavior*, 21, 101-112.

Pédinielli, J. L. (1996). Les théories étiologiques des maladies. *Psychologie Française*, 41, 137-145.

Pen, L. J., & Fisher, C. A. (1994). Athletes and pain tolerance. *Sports Medicine*, 18, 319-329.

Perna, F. M., Antoni, M. H., Baum, A., Cordon, P., & Schneiderman, N. (2003). Cognitive behavioral stress management effects on injury and illness among competitive athletes: A randomized clinical trial. *Annals of Behavioral Medicine*, 25, 66-73.

Petosa, R., & Jackson, K. (1991). Using the Health Belief Model to predict safer sex intentions among adolescents. *Health Education Quarterly*, 18, 463-476.

Pétrie, T. A . (1992). Psychosocial antécédents of athletic injury: the effect of life stress and social support on female collegiate gymnasts. *Behavioral Medicine*, 18, 127-138.

Pétrie, T. A . (1993a). Coping skills, competitive trait anxiety, and playing status: Moderating effects of the life stress-injury relationship. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 15, 261-274.

Pétrie, T. A . (1993b). The moderating effect of social support and playing status on the life stress injury relationship. *Journal of Applied Sport Psychology*, 5, 1-16.

Pétrie, T. A . , & Falkstein, D. L . (1998). Methodological, measurement, and statistical issues in research on sport injury prédiction. *Journal of Applied Sport Psychology*, 10, 26-45.

Podlog, L. , & Eklund, R. C. (2006). A longitudinal investigation of competitive athlètes' return to sport following serious injury. *Journal of Applied Sport Psychology*, 18, 44-68.

Podlog, L. , & Eklund, R. C. (2007). The psychosocial aspects of a return to sport following serious injury: A review of the literature from self-determination perspective. *Psychology of Sport and Exercise*, 8, 535-566.

Pollay, R. (2000). Targeting youth and concerned smokers: Evidence from Canadian tobacco industry documents. *Tobacco Control*, 9, 136-147.

Pomeroy, 1. M. , Clark, C. R., & Philp, I. (2001). The effectiveness of very short scales for dépression screening in elderly médical patients. *International Journal of Géiatrie Psychiatry*, 16, 321-326.

Povey, L. J., Frith, W. J., & Graham, P. G. (1999). Cycle helmet effectiveness in New Zealand. *Accident Analysis and Prévention*, 31, 763-770.

Prentice-Dunn, S., & Rogers, R. W. (1986). Protection motivation theory and préventive health: Beyond the health belief model. *Health Education Research*, 1, 153-161.

Pritchard, W. S., & Kay, D. L. C. (1993). Personality and smokin g motivation of U.S. smokers as measured by the State-Trait Personality Inventory, the Eysenc k personality questionnaire, and Spielberger's smokin g motivation Questionnaire. *Personality and Individual Différences*, 14, 629-637 .

Prochaska, J. O., & DiClemente , C. C. (1983). Stages and processes of self-change in smoking : Toward an integrative model of change . *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51, 390-395 .

- Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change: Applications to addictive behaviors. *American Psychologist*, 47, 1102-1114.
- Quackenbush, N., & Crossman, J. (1994). Injured athletes: a study of emotional responses. *Journal of Sport Behavior*, 17, 178-187.
- Quine, L., Rutter, D. R., & Arnold, L. (1998). Predicting and understanding safety helmet use among schoolboy cyclists: A comparison of the theory of planned behaviour and the health belief model. *Psychology and Health*, 13, 251-269.
- Quinn, A. M., & Fallon, B. J. (1999). The changes in psychological characteristics and reactions of elite athletes from injury onset to full recovery. *Journal of Applied Sport Psychology*, 11, 210-229.
- Rees, G., Fry, A., & Cull, A. (2001). A family history of breast cancer: Women's experiences from a theoretical perspective. *Social Science and Medicine*, 52, 1433-1440.
- Reppucci, J. D., Revenson, T. A., Aber, M., & Reppucci, N. D. (1991). Unrealistic optimism among adolescent smokers and nonsmokers. *Journal of Primary Prevention*, 11, 227-236.
- Rider, S. P., & Hicks, R. A. (1995). Stress, coping, and injuries in male and female high school basketball players. *Perception Motor Skills*, 81, 499-503.
- Robins, R. W., Hendin, H. M., & Trzesniewski, K. H. (2001). Measuring global self-esteem: Construct validation of a single-item measure and the Rosenberg Self-Esteem Scale. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 27, 151-161.
- Robinson, M. E., Riley, J. E., Myers, C. D., Sadler, I. J., Kvaal, S. A., Geisser, M. E. et al. (1997). Coping Strategies Questionnaire: A large sample item level factor analysis. *The Clinical Journal of Pain*, 13, 74-81.
- Rogers, R. W. (1975). A protection motivation theory of fear appeals and attitude change. *Journal of Psychology*, 91, 93-114.
- Rogers, R. W. (1983). Cognitive and physiological processes in fear-based attitude change: A revised theory of protection motivation. In J. Cacioppo, & R. Petty (Eds.), *Social psychophysiology: A sourcebook* (pp. 153-176). New York: Guilford.
- Rogers, R. W., & Prentice-Dunn, S. (1997). Protection motivation theory. In D. Gochman (Ed.), *Handbook of health behavior research: Vol. 1. Determinants of health behavior: Personal and social* (pp. 113-132). New York: Plenum.

Rogers, T. J., Alderman, B. L., & Landers, D. M. (2003). Effects of life-event stress and hardiness on peripheral vision in a real-life stress situation. *Behavioral Medicine*, 29, 21-26.

Rogers, T. J., & Landers, D. M. (2005). Mediating effects of peripheral vision in the life event stress/ athletic injury relationship. *Journal of Exercise and Sport Psychology*, 27, 271-288.

Rolland, J. P., Parker, W. D., & Stumpf, H. A. (1998). Psychometric examination of the French translation of the NEO PI-R and NEO-FFI. *Journal of Personality Assessment*, 71, 269-271.

Rose, J., & Jevne, R. F. J. (1993). Psychosocial processes associated with athletic injuries. *The Sport Psychologist*, 7, 309-328.

Rosenstiel, A. K., & Keefe, F. J. (1983). The use of coping strategies in chronic low back pain patients: Relationship to patient characteristics and current adjustment. *Pain*, 17, 33-44.

Rosenstock, I. M. (1974). The Health Belief Model and Preventive Health Behavior.

Health Education Monographs, 2, 354-368.

Rosenstock, I. M. (1990). Explaining health behavior through expectancies. In K. Glanz, F.

M. Lewis, & B. K. Rimer (Eds.), *Health behavior and health education* (pp. MO• IS?). San Francisco: Jossey-Bass.

Rosenthal, D., Moore, S., & Flynn, I. (1991). Adolescent self-efficacy, self-esteem and sexual risk-taking. *Journal of community and applied socialpsychology*, 1, 77-88.

Rotter, J. B. (1966). Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of

Reinforcement. *Psychological monographs*, 50, 1-28.

Rotter, J. B. (1990). Internal Versus External Locus of Control of Reinforcement.

American Psychologist, 45, 489-493.

Routley, V. (1997). Rollerblading injury to older children (10-14 years) - An update.

Hazard, 31, 12.

Rutter, D. R., Quine, L., & Albery, I. P. (1998). Perceptions of risk in motorcyclists: Unrealistic optimism, relative realism and predictions of behaviour. British Journal of Psychology, 89, 681-696.

Sanchez, X., & Heyes, A. V. (2005). Personality and sensation-seeking profiles in high-risk sports: A study of climbers and parachutist. Journal of Sports Sciences, 23, 164-165.

Sandman, P. M., & Weinstein, N. D. (1993). Predictors of home radon testing and implications for testing promotion programs. Health Education Quarterly, 20, 471-487.

Sarason, I. G., Johnson, J. H., & Siegel, J. M. (1978). Assessing the impact of life changes: Development of the Life Experiences Survey. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 932-946.

Sarason, I. G., Sarason, B. R., Potter, E. H., & Antoni, M. H. (1985). Life events, social support, and illness. Psychosomatic Medicine, 47, 156-163.

Schafer, W. E., & McKenna, J. F. (1985). Life changes, stress, injury and illness in adult runners. Stress Medicine, 1, 237-244.

Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): a reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063-1078.

Schieber, R. A., Branche-Dorsey, C. M., Ryan, G. W., Rutherford, G. W., Stevens, J. A., & O'Neil, J. (1996). Risk Factors for Injuries from in-Line Skating and the Effectiveness of Safety Gear. New England Journal of Medicine, 335, 1630-1635.

- Schmiede, S. J., Aiken, L. S., Sander, J. L., & Gerend, M. A. (2007). Osteoporosis Prevention Among Young Women: Psychosocial Models of Calcium Consumption and Weight-Bearing Exercise. *Health Psychology*, 26, 577-587.
- Schuffham, P., & Langley, J. D. (1997). Trends in cycle injury in New Zealand under voluntary helmet use. *Accident Analysis and Prevention*, 29, 1-9.
- Schuster, M., & Israeli, A. (1999). Survey of injuries and protective gear worn by in-line skaters in public parks. *American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation*, 78, 7-10.
- Schwarzer, R. (1992). Self-efficacy in the adoption and maintenance of health behaviors: Theoretical approaches and a new model. In R. Schwarzer (Ed.), *Self-efficacy: Thought control of action* (pp. 217-243). London: Hemisphere.
- Selye, H. (1976). *The stress of life*. New York: McGraw-Hill.
- Sheeran, P., & Orbell, S. (2000). Using Implementation Intentions to Increase Attendance for Cervical Cancer Screening. *Health Psychology*, 19, 283-289.
- Shepherd, R. J. (1999). Social determinants of food choice. *Proceedings of the Nutrition Society*, 58, 807-812.
- Shepherd, R. J., & Balady, G. J. (1999). Exercise as cardiovascular therapy. *Circulation*, 99, 963-972.
- Sieber, M. F., & Angst, J. (1990). Alcohol, tobacco and cannabis: 12-year longitudinal associations with antecedent social context and personality. *Drug and Alcohol Dependence*, 25, 281-292.
- Sigurdsson, J. F., & Gudjonsson, G. H. (1996). Psychological characteristics of juvenile alcohol and drug users. *Journal of Adolescence*, 19, 121-126.
- Simsekoglu, O., & Lajunen, T. (2007). Why Turks do not use seat belts? An interview study. *Accident Analysis and Prevention*, 40, 470-478.
- Sissons Joshi, M., Beckett, K., & Macfarlane, A. (1994). Cycle helmet wearing in teenagers - do health beliefs influence behaviour? *Archives of Disease in Childhood*, 71, 536-539.
- Slovic, P. (1978). The psychology of protective behavior. *Journal of Safety Research*, 10,

58-68.

Slovic, P. (1987). Perception of risk. *Science*, 236, 280-285.

Slovic, P., Finucane, M., Peters, E., & MacGregor, D. G. (2002). The affect heuristic. In T.

Gilovich, D., Griffin, & D. Kahneman (Eds.), *Heuristics and biases* (pp. 397-410). New York: Cambridge University Press.

Slovic, P., Fischhoff, B., & Lichtenstein, S. (1980). Facts and fears: Understanding perceived risk. In R. C. Schwing, & W. A. Albers (Eds.), *Societal risk assessment: How safe is safe enough?* (pp. 181-214). New York: Plenum.

Slovic, P., Fischhoff, B., Lichtenstein, S., Read, S., & Combs, B. (1978). Safe is safe enough? A psychometric study of attitudes towards technological risks and benefits. *Policy Sciences*, 9, 127-152.

Smith, A. M., Stuart, M. J., Wiese-Bjornstal, D. M., Milliner, E. K., & OTallon, W. J. (1993). Competitive athletes: Pre and post injury mood state and self-esteem. *Mayo Clinic Proceedings*, 68, 939-947.

Smith, D. W., & McFall, S. L. (2005). The relationship of diet and exercise for weight control and the quality of life gap associated with diabetes. *Journal of Psychosomatic Research*, 59, 385-392.

Smith, G. E., Gerrard, M., & Gibbons, F. X. (1997). Self-Esteem and the Relation Between Risk Behavior and Perceptions of Vulnerability to Unplanned Pregnancy in College Women. *Health Psychology*, 16, 137-146.

Smith, R. E., Johnson, J. H., & Sarason, I. G. (1978). Life change, the sensation seeking motive, and psychological distress. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 46, 348-349.

Smith, R. E., Ptacek, J. T., & Smoll, F. L. (1992). Sensation seeking, stress, and adolescent injuries: A test of stress-buffering, risk-taking, and coping skills hypotheses. *Journal of Personality and Social Psychology*, 62, 1016-1024.

Smith, R. E., Smoll, F. L., & Ptacek, J. F. (1990). Conjunctive moderator variables in vulnerability and resiliency research: Life stress, social support and coping skills, and adolescent sport injuries. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58, 360-369.

Spaite, D. W., Criss, E. A., Weist, D. J., Valenzuela, F. D., Judkins, D., & Meislin, H. W. (1995). A prospective investigation of the impact of alcohol consumption on helmet use, injury severity, medical resource utilization, and health care costs

in Bicycle-Related Trauma. *Journal of Trauma, Injury, Infection and Critical Care*, 38, 287-290.

Spaite, D. W., Murphy, M., Criss, E. A., Valenzuela, F. D., & Meislin, H. W. (1991). A prospective analysis of injury severity among helmeted and non-helmeted bicyclists involved in collisions with motor vehicles. *Journal of Trauma, Injury, Infection and Critical Care*, 31, 1510-1516.

Starkey, C. (1999). *Therapeutic Modalities*. Philadelphia: Davis, F.A.

Stein, J. A., Newcomb, M. D., & Bentler, P. M. (1994). Psychosocial correlates and predictors of AIDS risk behaviors, abortion, and drug use among a community sample of young adult women. *Health Psychology*, 13, 308-318.

Stuart, M. J., Smith, A. M., Malo-Ortiguera, S. A., Fischer, F. L., & Larson, D. R. (2002).

A comparison of facial protection and the incidence of head, neck, and facial

injuries in junior A hockey players: a function of individual playing time. *American Journal of Sports Medicine*, 30, 39-44.

Sullivan, M. J. L., Rodgers, W. M., Wilson, P. M., Bell, G. J., Murray, T. C., & Fraser, S.

N. (2002). An experimental investigation of the relation between catastrophizing and activity intolerance. *Pain*, 100, 47-53.

Sullivan, M. J. L., Tripp, D. A., Rogers, W., & Stanish, W. (2000). Catastrophizing and pain perception in sports participants. *Journal of Applied Sport Psychology*, 12, 151-167.

Sultan, S., & Bureau, B. (1999). Quel optimisme en psychologie de la santé? *Revue*

Européenne de Psychologie Appliquée, 49, 43-50.

Sumilo, D., & Stewart-Brown, S. (2006). The causes and consequences of injury in students at UK Institutes of Higher Education. *Public Health*, 120, 125-131.

Sutton, S., McVey, D., & Glanz, A. (1999). A comparative test of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior in the prediction of condom use intentions in a national sample of English young people. *Health Psychology*, 18, 72-81.

Taylor, J., & Taylor, S. (1997). *Psychological approaches to sports injury rehabilitation*.

Gaithersburg: Aspen.

Taylor, S. E., Kemeny, M. E., Aspinwall, L. G., Schneider, S. G., Rodriguez, R., & Herbert, M. (1992). Optimism, Coping, Psychological Distress, and High-Risk Sexual Behavior Among Men at Risk for Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). *Journal of Personality and Social Psychology*, 63, 460-473.

Terry, D. J., Galligan, R. F., & Conway, V. J. (1993). The prediction of safe sex behaviour: The rôle of intentions, attitudes, norms and control beliefs. *Psychology and Health*, 8, 355-368.

Thomas, S., Acton, C., Nixon, J., Battistutta, D., Pitt, W. R., & Clark, R. (1994). Effectiveness of bicycle helmets in preventing head injury in children: case-control study. *British Medical Journal*, 308, 173-176.

Thompson, R. S., Rivara, F. P., & Thompson, D. C. (1989). A case-controlled study of the effectiveness of bicycle safety helmets. *New England Journal of Medicine*, 321, 1194-1196.

Torbjorn, R., & Iversen, H. (2004). Risk perception and driving behaviour among adolescents in two Norwegian counties before and after a traffic safety campaign. *Safety Science*, 42, 1-21.

Tracey, J. (2003). The Emotional Response to the Injury and Rehabilitation Process. *Journal of Applied Sport Psychology*, 15, 279-293.

Tripp, D. A., Stanish, W. D., Coady, C., & Reardon, G. (2004). The subjective pain experience of athletes following anterior cruciate ligament surgery. *Psychology of Sport and Exercise*, 5, 339-354.

Trobst, K. K., Herbst, J. H., Masters, H. L., & Costa, P. T. Jr. (2002). Personality Pathways to Unsafe Sex: Personality, Condom Use, and HIV Risk Behaviors. *Journal of Research in Personality*, 36, 117-133.

Trobst, K. K., Wiggins, J. S., Costa, P. T. Jr., Herbst, J. H., McCrae, R. R., & Masters, H. L. (2000). Personality psychology and problem behaviors: HIV risk and the Five-Factor model. *Journal of Personality*, 68, 1233-1252.

Trull, T. J., & Sher, K. J. (1994). Relationship between the five-factor model of personality and Axis I disorders in a nonclinical sample. *Journal of Abnormal Psychology*, 103, 350-360.

- Tucker, J. S., Elliott, M. N., & Klein, D. J. (2006). Social Control of Health Behavior: Associations With Conscientiousness and Neuroticism. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 32, 1143-1152.
- Turk, D. C., Meichenbaum, D., & Genest, M. (1987). *Pain and behavioral medicine*. New York: Guilford Press.
- Turk, D. C., & Okifuji, A. (2002). Psychological factors in chronic pain: Evolution and révolution. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 70, 678-690.
- Turner, C., McClure, R., & Pirozzo, S. (2004). Injury and risk-taking behavior - a systematic review. *Accident Analysis and Prévention*, 36, 93-101.
- Turner, J. A., Jensen, M. P., Warm's, C. A., & Cardenas, D. D. (2002). Catastrophizing is associated with pain intensity, psychological distress, and pain-related disability among individuals with chronic pain after spinal cord injury. *Pain*, 98, 127-134.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. *Cognitive Psychology*, 5, 207-232.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185, 1124-1131.
- Tyc, V. L., Hadley, W., & Crockett, G. (2001). Predictors of Intentions to Use Tobacco Among Adolescent Survivors of Cancer. *Journal of Pédiatrie Psychology*, 26, 1121.
- Tyc, V. L., Lensing, S., Rai, S. N., Klosky, J. L., Stewart, D. B., & Gattuso, J. (2006). Predicting perceived vulnerability to tobacco-related health risks and future intentions to use tobacco among pédiatrie cancer survivors. *Patient Education and Counseling*, 62, 198-204.
- Tyler, T. R. (1980). Impact of directly and indirectly experienced events: The origin of crime-related judgments and behaviors. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39, 13-28.
- Udry, E., Gould, D., Bridges, D., & Tuffey, S. (1997). People helping people? Examining the social ties of athlètes coping with burnout and injury stress. *Journal of Sport and Exercice Psychology*, 19, 368-395.
- United States Consumer Product Safety Commission (1994). *In-Line Skating Report*. Bethesda: U S Consumer Product Safety Commission.

Van der Pligt, J. (1996). Risk perception and self-protective behaviour. *European Psychologist*, 1, 34-43.

Van der Velde, F. W., Van der Pligt, J., & Hooykaas, C. (1994). Perceiving AIDS-related risk: Accuracy as a function of differences in actual risk. *Health Psychology*, 13, 25-33.

Van Mechelen, W. (1997). Sport injury surveillance Systems. "One size fits ail"? *Sports Medicine*, 24, 164-168.

Van Mechelen, W., Twisk, J., Molendijk, A., Blom, B., Snel, J., & Kemper, H. C. G. (1996). Subject-related risk factors for sports injuries: a 1-yr prospective study in young adults. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 28, 1171-1179.

Vancleef, L. M. G., & Peters, M. L. (2006). The Interruptive Effect of Pain on Attention. *The Journal of Pain*, 7, 21-22.

Vanio, H., & Bianchini, F. (2002). Breast cancer screening. IARC handbooks of cancer prevention. Lyon: IARC Press.

Vaughan, E. (1993). Chronic Exposure to an Environmental Hazard: Risk Perceptions and Self-Protective Behavior. *Health Psychology*, 12, 74-85.

Verbeke, W., & Vackier, L. (2005). Individual determinants of fish consumption: application of the theory of planned behaviour. *Appetite*, 44, 67-82.

Vickers, R. R., Conway, T. L., & Hervig, L. K. (1990). Demonstration of replicable dimensions of health behaviors. *Preventive Medicine*, 19, 377-401.

Vlek, C. S., & Stallen, P. (1981). Judging risks and benefits in the small and in the large. *Organizational Behavior and Human Performances*, 28, 235-271.

Vollrath, M., Knoch, D., & Cassano, L. (1999). Personality, risky health behaviour, and perceived susceptibility to health risks. *European Journal of Personality*, 13, 39-50.

Vollrath, M., & Torgersen, S. (2002). Who takes health risks? A probe into eight personality types. *Personality and Individual Differences*, 32, 1185-1198.

Wanous, J. P., Reichers, A. E., & Hudy, M. J. (1997). Overall job satisfaction: How good are single-item measures? *Journal of Applied Psychology*, 82, 247-252.

- Wardle, J. (1995). Women at risk of ovarian cancer. *Journal of the National Cancer Institute Monographs*, 17, 81-85.
- Wasyliw, L., & Fekken, G. C. (1999). The Dimensionality of Health Behaviors. *Journal of Social Behavior and Personality*, 14, 585-596.
- Watkins, C., Daniels, L., Jack, C., Dickinson, H., & van den Broek, M. (2001). Accuracy of a single question in screening for depression in a cohort of patients after stroke: Comparative study. *British Medical Journal*, 323, 1159.
- Watson, D., & Pennebaker, J. W. (1989). Health complaints, stress, and disease: Exploring the central rôle of negative affectivity. *Psychological Review*, 96, 234-254.
- Weinstein, N. D. (1980). Unrealistic optimism about future life events. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39, 806-820.
- Weinstein, N. D. (1982). Unrealistic optimism about susceptibility to health problems. *Journal of Behavioral Medicine*, 5, 441-460.
- Weinstein, N. D. (1987). Unrealistic optimism about susceptibility to health problems: Conclusions from a community-wide sample. *Journal of Behavioral Medicine*, 10, 481-500.
- Weinstein, N. D. (1988). The precaution adoption process. *Health Psychology*, 7, 355-386.
- Weinstein, N. D. (1993). Testing four competing theories of health-protective behavior. *Health Psychology*, 12, 324-333.
- Weinstein, N. D. (2000). Perceived Probability, Perceived severity, and Health-Protective Behavior. *Health Psychology*, 19, 65-74.
- Weinstein, N. D., & Sandman, P. M. (1992). A model of the precaution adoption process: Evidence from home radon testing. *Health Psychology*, 11, 170-180.
- Weinstein, N. D., Sandman, P. M., & Roberts, N. E. (1990). Determinants of self-protective behavior: Home radon testing. *Journal of Applied Social Psychology*, 20, 783-801.

Weinstein, N. D., Sandman, P. M., & Roberts, N. E. (1991). Perceived susceptibility and self-protective behavior: A field experiment to encourage home radon testing. *Health Psychology*, 10, 25-33.

Welkenhuysen, M., Evers-Kiebooms, G., Decruyenaere, M., & van den Berghe, H. (1996).

Unrealistic optimism and genetic risk. *Psychology and Health*, 11, 479-492.

Weltman, G., & Egstrom, G. (1966). Perceptual narrowing in novice divers. *Human Factors*, 8, 499-506.

West, R. J., Elander, J., & French, D. (1993). Mild social deviance, Type-A behaviour pattern and decision-making style as predictors of self-reported driving style and traffic accident risk. *British Journal of Psychology*, 84, 207-219.

Wiese, D. M., & Weiss, M. (1987). Psychological rehabilitation and physical injury: Implications for the sportsmedicine team. *The Sport Psychologist*, 1, 318-330.

Wiese-Bjornstal, D. M., Smith, A. M., Shaffer, S. M., & Morrey, M. A. (1998). An integrated model of response to sport injury: Psychological and sociological dynamics. *Journal of Applied Sport Psychology*, 10, 46-69.

Williams, J. M., & Andersen, M. B. (1997). Psychosocial influences on central and peripheral vision and reaction time during demanding tasks. *Behavioral Medicine*, 22, 160-167.

Williams, J. M., & Andersen, M. B. (1998). Psychosocial antécédents of sport injury: Review and critique of the stress and injury model. *Journal of Applied Sport Psychology*, 10, 5-25.

Williams, J. M., Tonymon, P., & Andersen, M. B. (1990). Effects of life-event stress on anxiety and peripheral narrowing. *Behavioral Medicine*, 16, 174-181.

Williams, J. M., Tonymon, P., & Andersen, M. B. (1991). The effects of stressors and coping resources on anxiety and peripheral narrowing. *Journal of Applied Sport Psychology*, 3, 126-141.

Williams-Avery, R. M., & MacKinnon, D. P. (1996). Injuries and use of protective equipment among college in-line skaters. *Accident Analysis and Prévention*, 28, 779-784.

Wood, T., & Milne, P. (1988). Head injuries to pedal cyclists and the promotion of helmet use in Victoria, Australia. *Accident Analysis and Prévention*, 20, 177-185.

World Health Organisation (1998). Obesity: Preventing and managing the global épidémie. Geneva: WHO .

World Health Organisation (2003). Diet, nutrition and the prévention of chronic diseases: Report of a WHO study group. Geneva: WHO .

Wulfert , E. , & Wan , C. K. (1993). Condom Use: A Self-Efficacy Model . Health Psychology, 12, 346-353.

Young , C. C , & Mark , D. H. (1995). In-line skating: An observational study of protective equipment used by skaters. Archives of Family Medicine, 4, 19-23.

Yzer , M. C , Siero, F. W. , & Buunk , B. P. (2001). Bringing up condom use and using condoms with new sexual partners: Intentional or habituai? Psychology and Health, 16, 409-421 .

Zhu , S., St-Onge, M. P., Heshka, S., & Heymsfield , S. B. (2004). Lifestyle Behaviors Associated With Lower Risk of Having the Metabolic Syndrome . Metabolism, 53, 1503-1511 .

Ziani , B. (2002). Théories et modèles en psychologie de la santé . In G. N. Fischer (Ed.) , Traité de psychologie de la santé (pp. 21-46) . Paris: Dunod .

Zuckerman , M. (1983). Sensation seeking and sports. Personality and Individual Differences, 4, 285-292 .

الملاحق

الملحق 1

أدوات لتقييم الطبية الحيوية

نود أن جمع المعلومات عن حالتك المادية. قراءة كل سؤال. لكل سؤال، وتقديم إجابة واحدة. في محاولة للرد على جميع الأسئلة كما قدر ممكن من الدقة.

إصابة ماضية

على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، وكيف في كثير من الأحيان هل يضر (توقف التدريب) ممارسة [رياضة]؟

على الأقل 1 ش 1ش-3 ش 3ش-6 ش 6ش-عام 1+عام لا يصاب

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

قد انقضت منذ كم من الوقت إصابتك الأخيرة؟

خسر مرة بسبب الإصابة (إصابة في خسارة الوقت)

خلال الشهر الماضي

كم مرة هل يضر بالممارسة [الرياضة]؟

كم عدد حملة (ق) قد فاتك بسبب هذه الإصابات؟

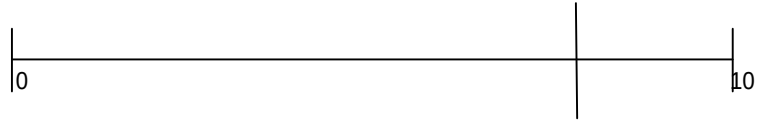
كم عدد حملة (ق) قد فاتك لأسباب أخرى من الإصابات الرياضية (المرض، وأسباب شخصية، الخ.)؟

كم كان (كانت) حملة (ق) المقدمة؟

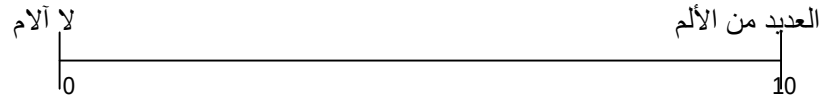
خصائص ألم

نود أن جمع المعلومات عن حالتك المادية خلال الشهر الماضي.

للإجابة على الأسئلة التي تحتاج لوضع نفسك عن طريق وضع سطر واحد فقط (أي الأرقام) في سلسلة متصلة بين 0 و 10 درجة مما يدل على وحدتها التي تنتمي إليها أو لا على سؤال أو بيان، كما في بعد المثال:



هذا الشهر، وممارسة [رياضة]، هل شعرت احد أو أكثر من الألم الجسدي؟



في المتوسط، وكانت هذه الآلام هم شديد؟

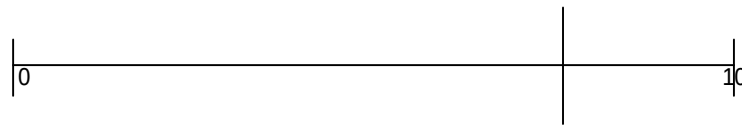


الملحق 2

مقاييس لتقييم السلوكيات الصحية

لمواقف من الألم

نود أن جمع المعلومات عن حالتك المادية خلال الشهر الماضي. للإجابة على الأسئلة التي تحتاج لوضع نفسك عن طريق وضع سطر واحد فقط (أي الأرقام) في سلسلة متصلة بين 0 و 10 درجة مما يدل على وحدتها التي تنتمي إليها أو لا على سؤال أو بيان، كما في بعد المثال:



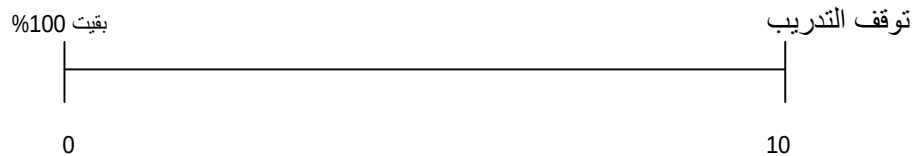
هذا الشهر، وممارسة [رياضة]،

لم تشعر واحدة أو أكثر الألم الجسدي؟



وفي المتوسط، فإن الألم الذي قد انخفضت أنهم جسدياً؟

رفات 100% في وقف حملة



في المتوسط، وهذه الآلام والتي تضطر الى تغيير هذه المناورات المقررة في التدريبات الخاصة بك؟



ارتداء معدات الوقاية

اليوم، هل ارتداء خوذة عند نقل على شفرات بكرة؟

لا ارتدي خوذة

-1-

اليوم، هل ارتداء منصات الكوع للتحرك على ريش بكرة؟

أنا لا ارتدي منصات الكوع

- 1 -

اليوم، هل ارتداء منصات الركبة للمضي قدما الشفرات الدوارة؟

أنا لا ارتدي منصات الركبة

-1-

ارتداء خوذة

-2-

أرتدي منصات الكوع

- 2 -

أرتدي منصات الركبة

-2-

الملحق 3

مقاييس لتقييم العوامل والعمليات المعرفية

نود أن جمع المعلومات عن الرياضة الخاصة بك. قراءة كل من هذه الأسئلة / الاقتراحات. لكل دائرة، سؤال / اقتراح واحد. محاولة الإجابة على جميع الأسئلة / الاقتراحات. تي هنا لا يوجد إجابات صحيحة أو خاطئة. كل استجابة هو شخصي في المقام الأول.

ينظر إلى الضعف

دراسة (2)

هل لديك خطر الاصابة هذا الموسم ممارسة الرياضة الخاصة بك؟

-10- -9- -8- -7- -6- -5- -4- -3- -2- -1- -0-

لا خطورة لا احتمال 50-50 احتمال للتأكد

ما هو احتمال كنت خلال الخطوة التالية في rollerblades إذا كنت لا ترغب في ارتداء معدات الوقاية

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

من المستبعد جدا من المحتمل جدا

الدراسة 4 لا خطر من المستبعد

-5- -4- -3- -2- -1- هل لديك خطر الاصابة هذا الموسم من خلال ممارسة لعبة الركبي؟

لا على الإطلاق تماما

-1- -2- -3- -4- -5- أنت من المحتمل أن يصب عليك هذا الموسم في حين لعب لعبة الركبي؟

أقل من 10% 100%

-1- -2- -3- -4- -5- من حيث النسبة المئوية، ما هو خطر لك هذا الموسم من خلال ممارسة لعبة الركبي؟

أقل بكثير من المحتمل من المحتمل جدا

-1- -2- -3- -4- -5- ما هي فرص التي تضار هذا الموسم مقارنة مع لاعبي الركبي الأخرى في الدوري الخاص بك؟

الدراسة 5 لا خطر من المحتمل

-1- -2- -3- -4- -5- هل لديك خطر الاصابة هذا الموسم من خلال ممارسة رياضة الجودو؟

لا على الإطلاق في تماما

-1- -2- -3- -4- -5- أنت من المحتمل أن يصب عليك هذا الموسم من خلال ممارسة رياضة الجودو؟

أقل من 10% 100%

-1- -2- -3- -4- -5- من حيث النسبة المئوية، ما هو خطر لك هذا الموسم من خلال ممارسة رياضة الجودو؟

أقل بكثير من المحتمل من المحتمل جدا

-1- -2- -3- -4- -5- ما هي المخاطر لكم هذا الموسم مقارنة مع غيرها من الجودو سنك،

وصفك الوزن والمستوى الخاص بك؟

ينظر بخطورة

دراسة (2)

عموما، إصابة فإنها تؤثر تأثيرا سلبيا على حياتك (الرياضية والاجتماعية والأسرية)؟

-10- -9- -8- -7- -6- -5- -4- -3- -2- -1- -0-

لا نتائج نتيجة خطيرة للغاية

الدراسة 3

ومدى خطورة الإصابة في rollerblades إذا لم يكن لارتداء معدات الحماية؟

-7- -6- -5- -4- -3- -2- -1- -0-

ليست خطيرة خطير للغاية

المواقف

أجد أنه من الضروري ارتداء ملابس واقية للمضي قدما rollerblades

-7- -6- -5- -4- -3- -2- -1- -0-

لا على الإطلاق أوافق بشدة

سوف أشعر سخييف اذا كنت ارتداء معدات الحماية على السفر في المستقبل على التزلج على الجليد

-7- -6- -5- -4- -3- -2- -1- -0-

لا على الإطلاق أوافق بشدة

معايير غير موضوعية

المتزلجين أخرى أعتقد أنه من المهم أن أرتدي المعدات الواقية عندما أسافر في التزلج على الجليد

-7- -6- -5- -4- -3- -2- -1- -0-

لا على الإطلاق أوافق بشدة

أقاربي أعتقد أنني يجب أن لا تفعل التزلج انلاين بدون معدات الحماية

-7- -6- -5- -4- -3- -2- -1- -0-

لا على الإطلاق أوافق بشدة

ينظر إلى سلوكية السيطرة

إذا أردت، فإنه من السهل بالنسبة لي لوضع معدات الحماية لممارسة التزلج على الجليد

-0 - -1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

لا على الإطلاق أوافق بشدة

تصورات من خصائص خطر الإصابة

ما هو (ه) لاعب الجيدو (أنت) يمكن القيام به للحد من خطر تعرضهم للإصابة؟

-0 - -1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

ويمكن له / لها لا تفعل انه / انها لا تستطيع القضاء تماما على خطر

ماذا يسيطرون على (1) لاعب الجيدو (أنت) يمكن أن يكون في وقوع ضرر؟

-0 - -1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

أي سيطرة الكثير من سيطرة

عموما، إصابة فإنه يعطل حياتك؟

-0 - -1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

ليس كثيرا كل شيء

في رأيك، بشكل عام، ما هي نسبة احتمال أن إصابة لاعب الجيدو (ه) (أنت) خلال الموسم؟

-0 - -1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

من 10% 100%

الاستدلال المعرفي

هل تعرف شخصا من ليالي (TE) لاعب الجيدو الذين يصابون (ه) S ممارسة الجودو في الآونة الأخيرة؟

-0 - -1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

لا يوجد كثيرا

أخيرا هل كان لديك الفرصة لنرى او نسمع عن لاعب الجيدو إصابات (S) (TE) في وسائل الإعلام؟

-0 - -1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

أبدا كثيرا

في الآونة الأخيرة كنت قد تلقيت معلومات عن الاصابات الرياضية من قبل الأطباء أو الناس في حياتك؟

-0 - -1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

أبدا كثيرا

تبدو لك ق (TE) لاعب الجيدو والتي تميل إلى جرح أنفسهم من خلال ممارسة رياضة الجودو؟

-0 - -1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

لا على الإطلاق الى حد بعيد

نية لارتداء معدات الوقاية

هل تنوي ارتداء معدات الوقاية أثناء الخطوة التالية في الترحلق على الجليد؟

- 0 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

لا على الإطلاق على حد بعيد

الملحق 4

الفرنسية تكيف استبيان استراتيجيات المواجهة

(CSQ-F, Irachabal, Koleck, Rasle, & Bruchon-Schweitzer, 2008)

الى أى مدى يمكنك استخدام الاستراتيجيات المقترحة أدناه لمعالجة الألم الذى قد يشعر به خلال تجريب الخاص بك؟

ملء هذا الاستبيان في الإمكان أكثر عفوية، وهذا سوف يستغرق سوى بضع دقائق.

أبدا	أحيانا	كثيرا ما	كثير من الأحيلين
			1. وأنا أحاول أن المسافة التي كتبها تي حرية تقرير للألم، كما لو كانت في جسد شخص آخر.
			2. وأنا أحاول أن أفكر في شيء لطيف.
			3. انه لامر فظيع وأشعر أنه لن تحصل على أفضل.
			4. أدعو الله أن لا تدوم طويلا.
			5. أنا لا أفكر في الألم.
			6. أحاول عدم التفكير مثل انها جسدي، بل كشيء منفصل عن لي.
			7. أنا لا يلتفت إلى الألم.
			8. أتصرف كما لو أنها لم تكن هناك.
			9. أنا قلق طوال الوقت ما إذا كان هذا يحدث.
			10. أعود بذاكرتي إلى لحظات ممتعة من الماضي.
			11. وأعتقد أن من الناس وأنا أحب أن أكون.
			12. أدعو الله أن الألم يخف.
			13. اعتقد ان الألم هو من جسدي.
			14. ما زلت وكان شيئا لم يحدث.
			15. أنا أفعل شيئا أحب ومشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الموسيقى.
			16. أشعر أنني لم تعد قادرة على تحمل الألم.
			17. أنا لا أعرف ألم.
			18. أنا تعتمد على إيماني بالله.
			19. أشعر غير قادر على الاستمرار.
			20. وأعتقد أن الأشياء أنا أستمتع به.
			21. أتصرف كما لو كان الألم لم يكن جزءا مني.

ملحق 5

مقياس الضمير من النسخة الفرنسية لـ NEO PI-R) Rolland , Parker , & Stumpf , 1998

هذا الاستبيان يحتوي على بيانات 48. قرأ كل واحد بعناية، ثم لكل بند، علامة (الجدول اليمين) مربع التي تصف رأيك (من نختلف بقوة على الاتفاق بقوة). ليس هناك "حق" أو "خاطئة" الأجوبة. وسوف يتحقق الغرض من هذا الاستبيان إذا كنت تصف نفسك، وإذا كنت التعبير عن آرائهم الخاصة بك وأدق ما يمكن.

تأكد من أنك قد أجبت على كافة العناصر (وهذا مهم جدا بالنسبة لنا).

علامة (الجدول اليمين) مربع:

- FD أن نختلف بقوة إذا does're بيان خاطئ تماما أو إذا كنت لا أوافق بشدة.
- الخلاف D إذا كان البيان غير صحيح أو بالأحرى إذا كنت لا توافق.
- لا يوجد لشيء إذا كان البيان قد تكون صحيحة أو خاطئة كما لو كان لديك أي رأي فيما يتعلق بذلك.
- اتفاق على ما اذا كان البيان صحيحا إلى حد ما، أو إذا وافقت.
- كأس الاتحاد الإنجليزي على الموافقة بشدة ما اذا كان البيان صحيحا تماما، أو إذا كنت كنت أوافق بشدة.

FA	A	N	D	FD	
					1 أنا لست من النوع الذي يجعلني تقلق.
					2 أنا نفسي غاضبة في كثير من الأحيان حول الطريقة التي تعامل الناس معي.
					3 ومن النادر أن أشعر بالوحدة أيضا (هـ) و (جنوب شرق).
					4 عندما أتعامل مع أشخاص آخرين، وأنا دائما الرهبة جعل زلة.
					5 أنا نادرا ما تتجاوز في أي شيء.
					6 أشعر في كثير من الأحيان يائس (هـ)، وأريد شخصا آخر حل مشاكلي.
					7 فمن السهل أن يخيفني.
					8 أنا شخص حتى المزاج.
					9 أشعر أحيانا لا قيمة لها تماما.
					10 نادرا ما أشعر بعدم الارتياح عندما أكون مع الناس.
					11 أجد صعوبة كبيرة في مقاومة رغباتي.
					12 أشعر قادرة على التعامل مع أكثر من مشاكلي.
					13 فمن النادر أن أشعر أو القلق (هو).
					14 أنا تتمتع بسمعة جيدة لنوات الدم الحار، وسهلة لغضب مني.
					15 أنا حزين نادرا أو الاكتئاب (هـ).
					16 في بعض الأحيان، خجلت لذلك اردت ان تخفيه.
					17 لدي صعوبة تذكر في مقاومة إغراء.
					18 عندما أكون تحت ضغط حالات صعبة جدا، وأشعر أحيانا وكأنني ذاهب الى الانهيار.
					19 أنا غالبا ما يشعرون بالتوتر (هـ) والجهاز العصبي (غير).
					20 ونحن لا أعتبر نفسي الشخص الذي يمكن والمشبوهة.
					21 . وقد شعرت في بعض الأحيان إحساس عميق بالذنب أو الخطيئة.
					22 ومن لا يزعجني كثيرا إذا كان الناس يسخرون مني أو تدف لي.
					23 عندما أكون أمام الأطباء المفضلة لدي، وأنا أميل إلى وجبة دسمة.
					24 أنا يحافظ على صفاء ذهنه في حالات الطوارئ.
					25 أشعر نادرا بعض المخاوف حول المستقبل.
					26 وكثيرا ما أشعر بالاشمئزاز إلى (هـ) من قبل الشعب أتعامل.
					27 أنا أميل إلى توجيه اللوم لي عندما سارت الامور بشكل سيء.
					28 أشعر في كثير من الأحيان أقل شأنا (هـ) وغيرها.
					29 أعطي نادرا ما تصل النبضات بلدي.
					30 غالبا ما يكون من الصعب بالنسبة لي لاتخاذ قرار.
					31 أنا قلق في كثير من الأحيان عن الأشياء التي يمكن ان تذهب الخطأ.
					32 ويأخذ الكثير لجعل لي مجنون (يكون).
					33 لدي رأي سيئة من نفسي.
					34 أشعر بالراحة في وجود رؤساء بلدي أو غيرها من السلطات.
					35 أكل أحيانا تثير اشمئزازي.

					أقوم به بشكل جيد في حالة الأزمات.	36
					لدي مخاوف أقل من معظم الناس.	37
					لقد حدث ذلك في بعض الأحيان إلى أن أكون مرير (AD) وكامل (ه) من الاستياء.	38
					في بعض الأحيان، تبدو الأمور كنيبة جدا وميؤوس منها.	39
					إذا قلت أو فعلت شيئا خاطئا لشخص ما، أستطيع بالكاد تحمل لمواجهة له مرة أخرى.	40
					أحيانا أفعل أشياء على قوة الدفع التي ندمت بعد ذلك.	41
					وعندما يبدو أن كل شيء على غير ما يرام، وأنا قادرة على اتخاذ حق اتخاذ القرارات.	42
					أفكار الخوف تسلل إلى رأسي أحيانا.	43
					بالنسبة لي، لا يمكن مضايقات حتى الصغيرة أن تكون مزعجة.	44
					وفي كثير من الأحيان عندما تسوء الأمور، وأنا تستسلم وأنا الإستسلام.	45
					عند الناس وأنا أعلم أن تفعل أشياء سخيفة، وأنا بالحرج (ه) بالنسبة لهم.	46
					ما زلت قادرة على الحفاظ على السيطرة على مشاعري.	47
					أنا مستقر عاطفيا جدا.	48

الملحق 6

مقياس العصابية

النسخة الفرنسية من الأجسام القريبة من الأرض PI-R (Rolland , Parker ,)
(& Stumpf , 1998

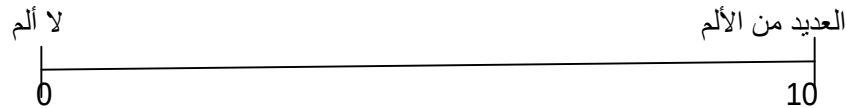
المواقف من الألم

نود جمع المعلومات عن حالتك المادية خلال الشهر الماضي.

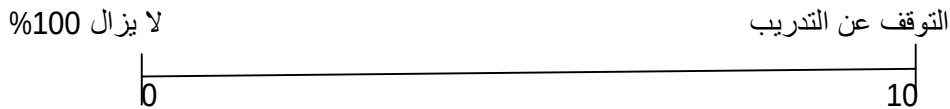
للإجابة على الأسئلة التي تحتاج لوضع نفسك عن طريق وضع سطر واحد فقط (أي الأرقام) في سلسلة متصلة بين 0 و 10 درجة مما يدل على وحدتها التي تنتمي إليها أو لا على سؤال أو بيان، كما في بعد المثال:

هذا الشهر، وممارسة [رياضة]،

لم تشعر واحدة أو أكثر الألم الجسدي؟



وفي المتوسط، فإن الألم الذي قد انخفضت أنهم جسدياً؟



في المتوسط، وهذه الآلام والتي تضطر الى تغيير هذه المناورات المقررة في التدريبات الخاصة بك؟



ارتداء معدات الوقاية

اليوم، هل ارتداء خوذة عند نقل على شفرات بكرة؟

-1-

-2-

ارتدي الخوذة

لا أرتدي الخوذة

اليوم، هل ارتداء منصات الكوع للتحرك على ريش بكرة؟

-1-

-2-

ارتداء منصات الكوع لا أرتدي منصات الكوع

اليوم، هل ارتداء حراس المعصم للتحرك على ريش بكرة؟

-1-

-2-

لا ارتدي حراس المعصم أرتدي حراس المعصم

اليوم، هل ارتداء منصات الركبة للمضي قدما الشفرات الدوارة؟

-1-

-2-

أنا لا ارتدي منصات الركبة أرتدي منصات الركبة

الملحق 7

المادية الجرد الذاتي (ISP, Ninot, Delignières , & Fortes, 2000)

لكل جملة بعناية كل دائرة واحدة بين لي ان هذه "لا على الاطلاق" (1). "قليل جدا" (2). "نوعا ما" (3). •• كفى - (4). وأضاف "الكثير" (5). "كل شيء يجب أن" (6). يجب على كل جملة تحتوي على استجابة.

الحذر! أي جواب هو الصحيح، فمن قبل كل شيء شخصي.

غير ممكن	قليل جدا	قليل	كاف	كثيرا	تماما
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
أنا لي رأي جيد من نفسي -					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
2. عموما أنا راض عن قدراتي البدنية					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
3. لا أستطيع أن تعمل لفترة أطول دون توقف					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
4. أجد معظم الألعاب الرياضية سهلة					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
5. أنا لا أحب بلدي درجة الحموضة مظهر \ ه					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
6. اعتقد انني أقوى من متوسط					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
7. هناك الكثير من الأشياء التي كنت مو أود أن تغيير					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
8. انا سعيد مع ما أنا سوي ق وماذا أستطيع أن تغلق ماديا					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
9. وأود أن تكون جيدة في اختبار التحمل					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
10. وأجد أنني جيدة في جميع الألعاب الرياضية					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
11. لدي متعة هيئة لمراقبة					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
12. وأود أن تكون جيدة في مواجهة					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
13. ويؤسفني أن كثيرا ما فعلت					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
14. وأنا واثق وجهها لوجه لي قيمة المادية					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
15. وأعتقد أن تعمل لفترة أطول دون تعب					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
16. أنا ابلي بلاء حسنا في جميع الألعاب الرياضية					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
17. لا أحد يجد لي جميلة					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
18. تعامل مع الحالات التي تتطلب قوة، وأنا أول من يقدم لي سر \ ق					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
19. أنا بالخجل من نفسي في كثير من الأحيان					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
20. بشكل عام، وأنا فخور من قدراتي الجسدية					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
21. يمكن أن أركض 5 ك م دون توقف					
-1-	-2-	--3--	---4---	---5---	--6--
22. أعمل بشكل جيد في الرياضة					

--6--	---5---	---4---	--3--	-2-	-1-	وأود أن تبقى كما أنا
--6--	---5---	---4---	--3--	-2-	-1-	أنا بخير مع جسدي
--6--	---5---	---4---	--3--	-2-	-1-	وأنا ليست جيدة جدا في أنشطة التحمل مثل ركوب الدراجات أو الجري ملاحظة: في جريئة، والمقترحات الخاصة الشاملة واحترام الذات

الملحق 8

الفرنسية التكيف في الحياة تجارب التوجيه

في نسخته المنقحة (LOT-R , Sultan & Bureau , 1999)

لمقترحات التالية تتعلق سلوكك المعتاد. لكل، يرجى وضع دائرة على رقم بين أنا "توافق تماما" و 4 "بقوة

توافق" اعتمادا على مستواك في الاتفاق أو الاختلاف

لا أوافق تماما			لا أوافق على الإطلاق		
4	3	2	1	في الأوقات المضطربة، وأتوقع أفضل بشكل عام	1
4	3	2	1	فمن السهل بالنسبة لي للاسترخاء	2
4	3	2	1	إذا كان هناك شيء يجب ان تذهب الخطأ بالنسبة لي، وهذا هو الحال	3
4	3	2	1	أنا متفائل دائما حول مستقبلي	4
4	3	2	1	وأنا أقدر أصدقائي	5
4	3	2	1	من المهم أن يبقى لي المحتملة (هـ)	6
4	3	2	1	وأتوقع أن الأمور نادرا ما أذهب في طريقي	7
4	3	2	1	أنا لا تنسيء بسهولة	8
4	3	2	1	وأتوقع أن الأمور جيدة نادرا ما يحدث لي	9
4	3	2	1	على التوازن، وأتوقع أن يحدث هذا لي أكثر من جيدة أشياء سيئة	10

الملحق 9

المادة من دراسة 1:

(a, soumis, Déroche, T., Stephan, Y., Brewer, B. W., & Le Scanff, C.). سلوكيات الألم والخسارة رياضة الوقت المحتسب بدل الضائع: مخاطر دفع من خلال الألم. تقدم تي البريطانية مجلة جرنال للطب الرياضي.

هذا الاستبيان يحتوي على بيانات 48. قرأ كل واحد بعناية، ثم لكل بند، علامة (الجدول اليمين) في المربع الذي يعكس أفضل رأيك (من لا يوافقون بشدة على الاتفاق بقوة). ليس هناك "حق" أو "خاطئة" الأجوبة. وسوف يتحقق الغرض من هذا الاستبيان إذا كنت تصف نفسك، وإذا كنت التعبير عن آرائهم الخاصة بك وأدق ما يمكن. تأكد من أنك قد أجبت على كافة العناصر (وهذا مهم جدا بالنسبة لنا). علامة (الجدول اليمين) مربع:

- FD أن نختلف بقوة إذا كان البيان هو زائف تماما أو إذا كنت لا أوافق بشدة.
- الخلاف D إذا كان البيان غير صحيح أو بالأحرى إذا كنت لا توافق.
- لا يوجد لشيء إذا كان البيان لا تكون صحيحة أو خاطئة كما لو كان لديك أي رأي فيما يتعلق بذلك.
- اتفاق على ما اذا كان البيان صحيحا أو تي بالأحرى إذا وافقت.
- كأس الاتحاد الإنجليزي على الموافقة بشدة ما اذا كان البيان صحيحا تماما هي تي، أو إذا كنت كنت أو اوافق بشدة

FA	A	N	D	FD	
					1 وأنا اعتبر لي (ه) توخي الحذر بلدي وشعوري مشترك.
					2 أنا أفضل أن تبقى الخيارات بدلا من كل شيء خطة مقدما.
					3 وأنا أحاول أن ضمير الوفاء بجميع المهام الموكلة لي.
					4 أنا كسول (ه) وليس طموحا جدا (هو).
					5 أنا الحصول على ما يكفي تماما لتنظيم نفسي أن تفعل أشياء في الوقت المحدد.
					6 وعلى مر السنين لقد جعلت بعض الأشياء الغبية نوعا ما.
					7 أنا لا تأخذ الواجبات المدنية مثل التصويت على محمل الجد.
					8 الحفاظ على أغراض مرتبة ونظيفة.
					9 أنا في بعض الأحيان لا تقي بوعدها لي أم لا على تحمل مسؤولياتي كما اود ان.
					10 لدي مجموعة واضحة من الأهداف وأنا أعمل من أجل تحقيق بطريقة منظمة.
					11 أفقد الكثير من الوقت قبل أن أحصل على عمل.
					12 أنا مناقشة الامور بالتفصيل قبل التوصل إلى قرار.
					13 وأنا أدرك وأنا عادة ما تأخذ قرارات ذكية.
					14 أنا لست منهجي للغاية.
					15 أدفع ديوني على الفور وبالكامل.
					16 عندما أبدأ برنامجا لتحسين الشخصية (الجمباز على سبيل المثال، لا، اذهب على النظام الغذائي أو متابعة سلسلة من النورات، الخ)، وأعطى عادة بعد بضعة أيام.
					17 وأنا الشخص الذي يأتي دائما إلى النهاية الفعلية للعمل.
					18 أنا يحدث لفرصة العمل الأولى، واعتقد في وقت لاحق.
					19 أضع نفسي في كثير من الأحيان في حالات من دون الاستعداد الكامل (ه).
					20 أود أن تبقى كل شيء في مكانه، لأنني أعرف بالضبط أين هي.
					21 أحيانا أنا خداع عندما كنت تلعب وحدها (ه) (على سبيل المثال: عندما لعب منفردا، وعندما جعل نجاحات، وما إلى ذلك).
					22 أنا أعمل بجد لتحقيق أهدافي.
					23 أجد صعوبة في فرض نفسي على القيام بما ينبغي.
					24 قبل العمل، وأعتقد دائما نتيجة ليالي عملي.
					25 أنا فخور (ه) سلامة رأيي.

					26	أنا يبدو لي بأنني لن تكون قادرة على تنظيم نفسي.
					27	عندما تأخذ التزام، يمكنك دائما الاعتماد على مو من خلال الذهاب.
					28	أنا لا أشعر حاجة ماسة لتعزيز.
					29	مرة واحدة ه مشروع معاهدة ستارت، وأنا دائما تقريبا ينتهي.
					30	أفعل أشياء في كثير من الأحيان على ارتجالا.
					31	لم أشعر تنجح تماما في أي شيء.
					32	أنا أميل إلى أن تكون حذرا إلى حد ما (هو) وتطلبا (ه).
					33	لدي المبادئ الأخلاقية وتلتزم ي بصرامة.
					34	واني اسعى الى تحقيق أي شيء أستطيع.
					35	وعندما يصبح من الصعب للغاية المشروع، وأنا أنا لديه ميل لتبدأ من جديد.
					36	ومن النادر أن آخذ قرارات متسعة.
					37	انا المختصة جدا.
					38	أنا لست تنظيف هوسي (ه).
					39	ماذا أفعل، وأنا أحاول أن تفعل ذلك بدقة، حتى انه لم يفعل ذلك مرة أخرى.
					40	اسعى للتحقق في كل شيء افعله.
					41	وينبغي أن يتم هناك القليل من العمل حتى أنه في بعض الأحيان، ببساطة، كل ما أعرفه.
					42	عندما أسافر، أنا إعداد مقما برنامجا مفصلا.
					43	أنا كفاءة وإنتاجية (VE) في عملي.
					44	أقضي الكثير من الوقت في البحث عن الأشياء التي كنت مخطئا أنا الصوف.
					45	وسيجعل لي حقا مريض يغيب يوم واحد العمل.
					46	أقضي وقتا طويلا في العمل، وإهمال الأسرة والأصدقاء والترويج عن النفس.
					47	لدي الكثير من الانضباط الذاتي.
					48	وقبل الإجابة على سؤال، أنا سوف "التفكير مرتين